

MEDINA — Prompt de transition (unité de vérité)

Version du 9 octobre 2026. Ce document prime sur toute passation antérieure. Toute IA qui reprend MEDINA le lit en entier, puis lit CLAUDE.md, docs/collaboration/LEADERSHIP_CLAUDE_2026-10-08.md (sections 7 à 13) et docs/STYLE_REDACTION.md. Elle agit ensuite comme si elle avait conduit le projet depuis le début.

1. Projet et propriétaire

- **MEDINA** est l'atlas de cours de médecine du Dr Vial Tato Djoukang (Neuchâtel), qui prépare l'examen fédéral suisse de médecine humaine.
- **Dépôt** : vialdjoukang-spec/Medina, branche par défaut main.
- **Site** : <https://vialdjoukang-spec.github.io/Medina/> (22 frontends dans fragments/, plus l'accueil).
- **Langue et ton** : français, phrases complètes, densité sans remplissage. Vial dicte souvent : interpréter avec bienveillance.
- **Autorisations** : accord permanent pour les branches, commits, pushes, PR et fusions dans MEDINA, une fois les contrôles passés.

2. Règles non négociables (acceptées)

1. **Rien de mémoire.** Chaque affirmation médicale provient d'une source réellement lue.
2. **Sources** : suisses d'abord (SSI, OFSP, sociétés suisses, Swiss Medical Forum, Suva), puis européennes (ERS, ESC, ESCMID, EAACI, NICE, HAS, AWMF). **Aucune recommandation américaine** ne fonde une conduite ; les essais peuvent être cités comme données.
3. **Médicaments** : information professionnelle suisse via `tools/swissmedic_fi.py`. Signaler tout usage hors indication.
4. **Plan monographique classique**, sans îlot ni tableau consacré au code CIM (le code n'apparaît que dans l'en-tête).
5. **Chaîne de production** : un rédacteur, puis un **relecteur distinct** qui fait deux passes sur quatre dimensions (rédaction, exactitude médicale, exactitude des sources, frontend), corrige et injecte. Codex peut auditer ensuite.
6. **Contrat HTML d'un cours** :
 7. fichiers `chapters/<CODE>/<CODE>_a.html` à `_d.html`, plus `_pop1.html` et `_pop2.html` ;
 8. quatre onglets : Pathologie, Examens, Sciences, Pharmacologie ;
 9. un Pareto à la fin de chaque partie ;
 10. dernier îlot : critères formels (`div.alert`), puis paramètres clés (`div.key`) ;
 11. aucune abréviation sans clé dans `glossary/<code>.py`.
12. **Contentieux entre sources** : la source primaire applicable la plus récente l'emporte, exposée dans une fenêtre liée à un mot vert.
13. **Honnêteté** : une revue par IA n'est jamais une validation médicale humaine, et le cours le dit.
14. **Efficacité avant le volume** : cible indicative de 11 000 à 15 000 mots par cours.
15. **Style visuel** (décision de Vial du 9 octobre 2026) : couleurs **vives et vivantes, rien de plus** ; fonds ivoire, beige et gris interdits.
 - Fondement : Carruthers 2010 (doi:10.1186/1471-2288-10-12), Valdez et Mehrabian 1994 (doi:10.1037//0096-3445.123.4.394) et Lankston 2010 (doi:10.1258/jrsm.2010.100256).
 - Fond ciel clair vers vert printanier ; couvertures en dégradé bleu, lagon, vert et soleil ; cartes blanches à rail coloré.
 - Pas de filigrane, de motif décoratif ni de fond marin.
 - Fichiers : `engine/atlas_v4.css`, `engine/harmonie_v5.css`, `engine/portal_v3.css`.

3. Architecture technique

- **Catalogue** : CIM-10-GM 2024 (source OFS), dans `shell/medina_front.html`. La nosologie complète importée par Codex se trouve dans `nosology/ (fragments/<ID>.json, frequency.json)`.
- **Construction** :
 - `MEDINA_OUT=$PWD/dist python3 build_front.py --all-fragments` construit les 22 frontends (couches `fragment_surface.py` et `engine/`);
 - `python3 build_index.py --fragments-dir dist/fragments --output dist/index.html` construit l'accueil ;
 - la publication sur Pages part automatiquement à chaque push sur main (`.github/workflows/pages.yml`).
- **Enregistrer un cours** :
 - entrée dans `chapters.json` (code, covers, title, integrated) ;
 - entrée dans `organisation/course_groups.json` (owner, scope) ;
 - état dans `organisation/FILE_FRAGMENTS_CLAUDE.json` ;
 - code ajouté à la liste des nouvelles productions dans `tests/audit_sciences.py` ;
 - puis `python3 tools/sceller.py` enregistrer.
- **Contrôles avant toute fusion** :
 - `python3 build_medina.py <CODE>` doit donner 0 abréviation non couverte ;
 - `python3 -m unittest discover -s tests -p 'test_*.py'` (248 tests) ;
 - `python3 tests/audit_fragments.py` ;
 - `MEDINA_OUT=$PWD/dist node tests/verify_fragment_frontends.cjs` (873 contrôles).
- **Jauges** (accueil, fragments, barre latérale) : « Pathologies fréquentes », « Examen fédéral » et « Avancement global ».
- Elles sont calculées sur les **catégories à trois caractères** (`nosologyEngine.gauges`), car les sous-codes sont traités dans le cours de leur catégorie.
- Affichage : « Libellé (n / total) (x %) ».
- **Navigation** : chaque fragment porte le bouton « Accueil MEDINA » (`../index.html`).

4. Travail accompli et accepté

- **Fragment C-01 Cardiologie** : 22 cours (production historique, audits Codex et Claude).
- **Fragment P-02 Pneumologie**, 23 cours injectés et scellés :
 - J45, J44, J40, J18, I26, J09, J96, J90, J86, J93, J84 ;
 - I27, J47, J80, J81, J12, J21, R04, J82, J67, J95, R05 et J60, relus en deux passes ;
 - rapports dans `livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/<CODE>.`
- **Autres cours intégrés** : D84, M06, M32, T78, M31, I71, I80, I83, I70, A41, I51, A53, A54, B24 et B18. Le total est de 55 cours.
- **Nosologie** : Codex a importé la CIM-10-GM complète dans les 22 fragments. Chaque chapitre est visible, vide, « En préparation », avec un plan.
- **Plans des pathologies fréquentes** : 138 plans spécifiques dans `organisation/PLANS_PATHOLOGIES_FREQUENTES.json`, dont 121 injectés dans les leçons vides.
- **Frontend** : style vif unifié, jauges exactes, bouton d'accueil (PR #34 à #38 et #65).

5. Travail en attente (priorités dans l'ordre)

1. **Relectures** : relancer le relecteur distinct pour **R06** (Dyspnée) et **J69** (Pneumopathies d'inhalation), dont les relectures ont été interrompues. Les brouillons sont dans `livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/`. P-02 sera alors complet.
2. **Brouillons achevés, pas encore relus** :
3. K21 — Reflux gastro-œsophagien (G-04) ;
4. E11 — Diabète de type 2 (E-06) ;
5. D50 — Anémie par carence en fer (H-08).
6. **Fragments à produire, dans l'ordre de organisation/FILE_FRAGMENTS_CLAUDE.json** : G-04, E-06, H-08, G-10, M-12, R-14, O-17, O-18, M-19 et E-22, puis les fragments Codex en ordre inverse (M-21 vers I-03). Dans chaque fragment, les pathologies fréquentes passent d'abord.

7. Réserves ouvertes :

- la jauge « Examen fédéral » repose sur une correspondance PROFILES établie par chapitre, trop large (44 catégories sur 45 en pneumologie) ; elle est à affiner catégorie par catégorie ;
- la liste des pathologies fréquentes n'est étayée par l'OFS que pour 7 codes ; les autres sont à valider par une source suisse de fréquence ;
- la complétude en CIM-11 reste à établir ;
- aucun cours n'a été validé par un médecin.

6. Définition de « pathologie fréquente »

- Aucune société savante suisse ou européenne ne fixe de seuil officiel de fréquence.
- Le seul seuil officiel est celui de la **maladie rare** : moins d'une personne sur 2 000 (Europe ; OFSP, Concept national maladies rares).
- Dans MEDINA, une pathologie fréquente est une catégorie non rare retenue dans `nosology/frequency.json`. Elle n'est confirmée que lorsqu'une source de fréquence suisse est citée : OFS, Sentinella ou statistique médicale des hôpitaux.

7. État par fragment (catégories rédigées / total, pathologies fréquentes, examen fédéral)

Fragment	Avancement global	Fréquentes	Examen fédéral
C-01-Cardiologie	22 / 47 (46.81 %)	8 / 8	22 / 43
P-02-Pneumologie	23 / 45 (51.11 %)	5 / 6	22 / 44
G-04-Gastroentérologie et hépatologie	0 / 91 (0.0 %)	0 / 17	0 / 89
N-07-Néphrologie	0 / 33 (0.0 %)	0 / 2	0 / 33
E-06-Endocrinologie et métabolisme	0 / 77 (0.0 %)	0 / 6	0 / 68
H-08-Hématologie	0 / 44 (0.0 %)	0 / 4	0 / 42
I-13-Immunologie et allergologie	4 / 10 (40.0 %)	2 / 2	4 / 7
N-05-Neurologie	0 / 116 (0.0 %)	0 / 9	0 / 104
R-14-Rhumatologie et orthopédie	1 / 117 (0.85 %)	0 / 16	1 / 101
D-16-Dermatologie	0 / 104 (0.0 %)	0 / 9	0 / 97
O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire	0 / 96 (0.0 %)	0 / 11	0 / 96
O-18-Ophthalmologie	0 / 58 (0.0 %)	0 / 6	0 / 53
G-10-Gynécologie et sénologie	0 / 53 (0.0 %)	0 / 9	0 / 47
U-15-Urologie et andrologie	0 / 46 (0.0 %)	0 / 8	0 / 44
O-11-Obstétrique et néonatalogie	0 / 142 (0.0 %)	0 / 7	0 / 141
I-03-Infectiologie	5 / 180 (2.78 %)	2 / 11	5 / 51
M-12-Médecine des âges de la vie	0 / 5 (0.0 %)	0 / 1	0 / 3
M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie	0 / 130 (0.0 %)	0 / 4	0 / 95
O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs	0 / 59 (0.0 %)	0 / 0	0 / 24
D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires	0 / 26 (0.0 %)	0 / 0	0 / 16
M-21-Médecine de premier recours et santé publique	0 / 77 (0.0 %)	0 / 2	0 / 43
E-22-Éthique médicale, droit et communication	0 / 3 (0.0 %)	0 / 0	0 / 3

8. Attentes d'adaptation par type de leçon non traitée

Chaque leçon vide suit le plan monographique de base. Les pathologies fréquentes ont en plus un plan spécifique, décrit ci-dessous et déposé dans `organisation/PLANS_PATHOLOGIES_FREQUENTES.json`. - **Socle commun** : - au début : définition et classification, épidémiologie suisse puis européenne, physiopathologie ; - à la fin : complications et pronostic, prévention et suivi, situations particulières, critères formels du diagnostic, Pareto. - **Ajouts selon le chapitre CIM** :

Chapitre	Ajouts au plan	Difficulté	Exigence propre
I Infections	agent pathogène, diagnostic microbiologique, anti-infectieux, déclaration OFSP, vaccination	élevée	SSI, OFSP, plan de vaccination suisse
II Tumeurs	carcinogénèse, stadification TNM, traitement multimodal, dépistage suisse	très élevée	ESMO, guidelines suisses, colloque pluridisciplinaire
XV et XVI Grossesse, nouveau-né	physiologie, surveillance materno-fœtale, médicaments compatibles	élevée	gynécologie suisse, SSP
XVIII Symptômes (R)	physiologie du symptôme, drapeaux rouges, démarche étagée	moyenne	approche symptomatique, renvois aux cours de maladie
XIX Traumatismes	mécanisme, ABCDE, imagerie, LAA	élevée	Suva, ATLS seulement comme donnée
Autres chapitres (maladies d'organe)	facteurs de risque, anamnèse, examen, examens complémentaires, traitements, urgences	élevée	société suisse de la spécialité, puis européenne

- **Niveau d'exigence** : chaque cours atteint le niveau des cours P-02 relus. Le modèle de rendu est `chapters/J81/`, et le modèle de rapport est `livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J81/rapport_relecture.md`.

9. Méthode de reprise

- **Organisation du travail** :
 - travailler sur une branche `claudio/*` à partir de main ;
 - faire travailler plusieurs rédacteurs en parallèle, un par leçon, chacun avec son relecteur distinct ;
 - enregistrer, sceller, ouvrir une PR, puis fusionner une fois les contrôles verts.
- **Limite hebdomadaire de Vial** : surveillée ; tout fusionner avant d'atteindre 95 %.
- **Fin de chaque livraison** : un tableau de bord (cours, catégories, fragments, contrôles, réserves).

10. Procédure pas à pas pour une leçon (à suivre à la lettre)

1. **Vérifier avant d'écrire**, pour ne pas faire un double :
2. le code ou un code qu'il couvre figure-t-il dans `chapters.json` (champ `covers`) ? exemple : J40 couvre J20, J40, J41 et J42 ;
3. un dossier `livraisons/Livraison Claude/*/travail/<CODE>/` existe-t-il déjà ?
4. la fiche correspondante de l'annexe porte-t-elle une ligne « Brouillon existant » ?
5. Si l'une de ces réponses est oui, ne rien réécrire : relire ou compléter.
6. **Rédaction** dans `livraisons/Livraison Claude/<fragment>/travail/<CODE>/`, jamais directement dans `chapters/`.
7. Suivre le plan de la fiche, et ne traiter qu'en renvoi les cours du même bloc.
8. Les sous-codes de la fiche sont traités dans le cours, sans leçon séparée.
9. **Relecture** par un agent distinct de l'auteur, en deux passes. C'est lui qui injecte dans `chapters/<CODE>/` et `glossary/<code>.py`, avec des ajouts de glossaire conditionnels (`_a`).
10. **Enregistrement** : suivre la section 3, puis faire une PR et fusionner une fois les contrôles verts.

11. Pièges connus (déjà rencontrés : ne pas les reproduire)

- **Clés de glossaire déjà prises**. Des clés génériques existent déjà :
 - ADA signifie adénosine désaminase : écrire `ADA/EASD` ;
 - ALAT signifie alanine aminotransférase : la recommandation sur la fibrose s'écrit `ATS/ERS/JRS/ALAT` ;
 - RECOVERY est l'essai de chirurgie aortique (i35) : écrire « Recovery » pour l'essai COVID ;
 - S2k et AWMF sont dans t78, FFP2 dans r04, CFV, mRESVIA et ISHAM dans j12, ESGE dans le brouillon d50.
 - Toujours vérifier `glossary/*.py` ET les glossaires des dossiers `travail/`, puis utiliser des ajouts conditionnels.
- **Sortie des constructions**. Toujours définir `MEDINA_OUT=$PWD/dist`. Sans cette variable, `build_front.py` écrit dans `/mnt/user-data/outputs` et écrase les sorties d'un autre agent.
- **Erreurs d'environnement, sans rapport avec le cours** :

- `test_preview.py` échoue sur `preview/lesson-core.js` absent ;
- Playwright attend parfois un autre build de Chromium : lancer `/opt/pw-browsers/chromium-1194/*/chrome` par `executable_path` ;
- PubMed répond 203 à travers le proxy : vérifier les PMID par `esummary`.
- **tests/audit_sciences.py** échoue sur I50 dans un clone superficiel : c'est connu. Il faut aussi ajouter chaque nouveau code à sa liste de nouvelles productions.
- **Recommandations américaines déguisées** : la recommandation de 2020 sur la pneumopathie d'hypersensibilité est ATS/JRS/ALAT, pas ERS. Vérifier les sociétés signataires avant de qualifier un texte d'« européen ».
- **Jauges** : elles comptent les catégories, jamais les sous-codes. La jauge Examen fédéral repose sur une correspondance PROFILES établie par chapitre, trop large : elle est à affiner, sans la présenter comme officielle.
- **Push et PR** : chaque push relance les contrôles de la PR. Grouper les instantanés de brouillons, et fusionner dès que tout est vert.
- **Style** : aucun fond ivoire, beige ou gris, aucun motif ni filigrane. Les titres des cours restent rouges, comme le prévoit la règle d'origine.
- **Validation** : jamais « validé » sans médecin. La mention « revue par IA » est obligatoire.

12. Annexe

L'annexe `ANNEXE_FEUILLE_DE_ROUTE.md`, régénérée par `python3 tools/feuille_de_route.py`, contient 1 244 fiches : une par leçon « Examen fédéral », classées par spécialité. Chaque fiche donne : - la priorité (P0 rédigée, P1 fréquente, P2 examen) et l'état ; - le cours couvrant, ou le brouillon existant ; - les situations PROFILES avec leur intitulé ; - les sous-codes à intégrer ; - les renvois du même bloc ; - le plan spécifique numéroté et les livrables.

Régénérer l'annexe après chaque injection.

Annexe — Feuille de route par leçon « Examen fédéral »

Générée par tools/feuille_de_route.py depuis nosology/fragments/*.json, chapters.json, nosology/frequency.json et PROFILES 2017 (nosology/sources/profiles2017.pdf). Une fiche par catégorie CIM-10-GM à trois caractères marquée « Examen fédéral ». Ordre : file de production, puis pathologies fréquentes, puis code. Priorité P0 : déjà rédigée, ne pas réécrire (correction seulement si erreur démontrée). P1 : fréquente et examen fédéral. P2 : examen fédéral. Total : 1244 fiches.

P-02-Pneumologie

44 leçons « Examen fédéral » ; 22 rédigées ; 6 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : Société suisse de pneumologie, Ligue pulmonaire ; ERS.

C34 — Tumeur maligne des bronches et du poumon (P-02-Pneumologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C30-C39 · difficulté **très élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : C34.0 Tumeur maligne: Bronche souche ; C34.1 Tumeur maligne: Lobe supérieur, bronches ou poumon ; C34.2 Tumeur maligne: Lobe moyen, bronches ou poumon ; C34.3 Tumeur maligne: Lobe inférieur, bronches ou poumon ; C34.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des bronches et du poumon ; C34.9 Tumeur maligne: Bronche ou poumon, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C33, C37, C38, C39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C34/C34_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c34.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/C34/.

C33 — Tumeur maligne de la trachée (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C30-C39 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C34, C37, C38, C39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations

particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/C33/C33_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c33.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/C33/.

C37 — Tumeur maligne du thymus (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C30-C39 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C33, C34, C38, C39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C37/C37_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c37.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/C37/.

C38 — Tumeur maligne du cœur, du médiastin et de la plèvre (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C30-C39 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : C38.0 Tumeur maligne: Cœur ; C38.1 Tumeur maligne: Médiastin antérieur ; C38.2 Tumeur maligne: Médiastin postérieur ; C38.3 Tumeur maligne: Médiastin, partie non précisée ; C38.4 Tumeur maligne: Plèvre ; C38.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la plèvre
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C33, C34, C37, C39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C38/C38_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c38.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/C38/.

C39 — Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C30-C39 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : C39.0 Tumeur maligne: Voies respiratoires supérieures, partie non précisée ; C39.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et intrathoraciques ; C39.9 Tumeur maligne: sièges mal définis de l'appareil respiratoire
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C33, C34, C37, C38
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C39/C39_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c39.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/C39/.

C45 — Mésothéliome (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C45-C49 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : C45.0 Mésothéliome de la plèvre ; C45.1 Mésothéliome du péritoine ; C45.2 Mésothéliome du péricarde ; C45.7 Mésothéliome d'autres sièges ; C45.9 Mésothéliome, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C45/C45_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c45.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/C45/.

J68 — Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J60-J70 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : J68.0 Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ; J68.1 Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ; J68.2 Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs ; J68.3 Autres affections respiratoires aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ; J68.4 Affections respiratoires chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ; J68.8 Autres affections respiratoires dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ; J68.9 Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J60, J67, J69, J70
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8.

Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/J68/J68_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j68.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J68/.

J69 — Pneumonie due à des substances solides et liquides (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Brouillon existant** : livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J69 — achevé, en attente du relecteur distinct : **ne pas réécrire**, lancer la relecture.
- **Chapitre CIM X** · bloc J60-J70 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : J69.0 Pneumonie due à des aliments et des vomissements ; J69.1 Pneumonie due à des huiles et des essences ; J69.8 Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J60, J67, J68, J70
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J69/J69_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j69.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J69/.

J70 — Affections respiratoires dues à d'autres agents externes (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J60-J70 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : J70.0 Affections pulmonaires aiguës dues à une irradiation ; J70.1 Affections pulmonaires chroniques et autres dues à une irradiation ; J70.2 Affections pulmonaires interstitielles aiguës, médicamenteuses ; J70.3 Affections pulmonaires interstitielles chroniques, médicamenteuses ; J70.4 Affection pulmonaire interstitielle, médicamenteuse, sans précision ; J70.8 Affections respiratoires dues à d'autres agents externes précisés ; J70.9 Affection respiratoire due à un agent externe, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J60, J67, J68, J69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J70/J70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J70/.

Q32 — Malformations congénitales de la trachée et des bronches (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q30-Q34 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : Q32.0 Trachéomalacie congénitale ; Q32.1 Autres malformations congénitales de la trachée ; Q32.2 Bronchomalacie congénitale ; Q32.3 Sténose bronchique congénitale ; Q32.4 Autres malformations congénitales des bronches
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q33, Q34
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Génétique et conseil génétique → 13. Complications et pronostic → 14. Prévention, dépistage et suivi → 15. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 16. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 17. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q32/Q32_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q32.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/Q32/.

Q33 — Malformations congénitales du poumon (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q30-Q34 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Q33.0 Poumon kystique congénital ; Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire ; Q33.2 Séquestration pulmonaire (congénitale) ; Q33.3 Agénésie du poumon ; Q33.4 Bronchectasie congénitale ; Q33.5 Tissu ectopique intrapulmonaire (congénital) ; Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon ; Q33.8 Autres malformations congénitales du poumon ; Q33.9 Malformation congénitale du poumon, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q32, Q34
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Génétique et conseil génétique → 13. Complications et pronostic → 14. Prévention, dépistage et suivi → 15. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 16. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 17. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q33/Q33_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q33.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/Q33/.

Q34 — Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q30-Q34 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : Q34.0 Anomalie de la plèvre ; Q34.1 Kyste congénital du médiastin ; Q34.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil respiratoire ; Q34.9 Malformation congénitale de l'appareil respiratoire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q32, Q33

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Génétique et conseil génétique → 13. Complications et pronostic → 14. Prévention, dépistage et suivi → 15. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 16. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 17. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q34/Q34_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q34.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/Q34/.

R06 — Anomalies de la respiration (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Brouillon existant** : livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/R06 — achevé, en attente du relecteur distinct : **ne pas réécrire**, lancer la relecture.
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R00-R09 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 41 (change of respiratory pattern), 46 (dyspnoea), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : R06.0 Dyspnée ; R06.1 Stridor ; R06.2 Sifflement ; R06.3 Respiration périodique ; R06.4 Hyperventilation ; R06.5 Respiration par la bouche ; R06.6 Hoquet ; R06.7 Eternuement ; R06.8 Anomalies de la respiration, autres et non précisées
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R04, R05, R07, R09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R06/R06_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r06.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/R06/.

R07 — Douleur au niveau de la gorge et du thorax (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R00-R09 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 35 (sore throat), 44 (chest pain), 51 (parietal chest pain). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : R07.0 Douleur de la gorge ; R07.1 Douleur thoracique respiratoire ; R07.2 Douleur précordiale ; R07.3 Autres douleurs thoraciques ; R07.4 Douleur thoracique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R04, R05, R06, R09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R07/R07_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r07.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/R07/.

R09 — Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R00-R09 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 140 (cyanosis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : R09.0 Asphyxie ; R09.1 Inflammation de la plèvre ; R09.2 Arrêt respiratoire ; R09.3 Expectoration anormale ; R09.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R04, R05, R06, R07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R09/R09_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r09.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/R09/.

S20 — Lésion traumatique superficielle du thorax (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S20-S29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 116 (thoracic injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : S20.0 Contusion du sein ; S20.1 Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées ; S20.2 Contusion du thorax ; S20.3 Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure ; S20.4 Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure ; S20.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax ; S20.8 Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S21, S23, S25, S27, S29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S20/S20_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s20.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/S20/.

S21 — Plaie ouverte du thorax (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S20-S29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 116 (thoracic injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S21.0 Plaie ouverte du sein ; S21.1 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure ; S21.2 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure ; S21.7 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique ; S21.8 Plaie ouverte d'autres parties du thorax ; S21.9 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S20, S23, S25, S27, S29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/S21/S21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/S21/.

S23 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S20-S29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 116 (thoracic injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S23.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal ; S23.1 Luxation d'une vertèbre dorsale ; S23.2 Luxation de parties autres et non précisées du thorax ; S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal ; S23.4 Entorse et foulure des côtes et du sternum ; S23.5 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S20, S21, S25, S27, S29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S23/S23_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s23.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/S23/.

S25 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S20-S29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 116 (thoracic injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : S25.0 Lésion traumatique de l'aorte thoracique ; S25.1 Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière ; S25.2 Lésion traumatique de la veine cave supérieure ; S25.3 Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière ; S25.4 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon ; S25.5 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux ; S25.7 Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax ; S25.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax ; S25.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S20, S21, S23, S27, S29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S25/S25_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s25.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/S25/.

S27 — Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S20-S29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 116 (thoracic injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : S27.0 Pneumothorax traumatique ; S27.1 Hémithorax traumatique ; S27.2 Hémopneumothorax traumatique ; S27.3 Autres lésions traumatiques du poumon ; S27.4 Lésion traumatique des bronches ; S27.5 Lésion traumatique de la trachée

thoracique ; S27.6 Lésion traumatique de la plèvre ; S27.7 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques ; S27.8 Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés ; S27.9 Lésion traumatique d'un organe intrathoracique non précisé

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S20, S21, S23, S25, S29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S27/S27_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s27.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/S27/](#).

S29 — Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S20-S29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 116 (thoracic injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : S29.0 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax ; S29.7 Lésions traumatiques multiples du thorax ; S29.8 Autres lésions traumatiques précisées du thorax ; S29.9 Lésion traumatique du thorax, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S20, S21, S23, S25, S27
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S29/S29_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s29.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/S29/](#).

T27 — Brûlure et corrosion des voies respiratoires (P-02-Pneumologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T26-T28 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée ; T27.1 Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons ; T27.2 Brûlure d'autres parties des voies respiratoires ; T27.3 Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée ; T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée ; T27.5 Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons ; T27.6 Corrosion d'autres parties des voies respiratoires ; T27.7 Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/T27/T27_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/t27.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/T27/](#).

J09 — Grippe (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J09-J18 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J12, J18
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J09/J09_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j09.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J09/.

J18 — Pneumonies de l'adulte (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J09-J18 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : J18.0 Bronchopneumonie, sans précision ; J18.1 Pneumonie lobaire, sans précision ; J18.2 Pneumonie hypostatique, sans précision ; J18.8 Autres pneumonies, micro-organisme non précisé ; J18.9 Pneumonies, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J09, J12
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J18/J18_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j18.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J18/.

J40 — Bronchite (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J40-J47 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J44, J45, J47
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations

particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/J40/J40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J40/.

J44 — Bronchopneumopathie chronique obstructive (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J40-J47 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : J44.0 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures ; J44.1 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision ; J44.8 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées ; J44.9 Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J40, J45, J47
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J44/J44_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j44.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J44/.

J45 — Asthme (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J40-J47 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : J45.0 Asthme à prédominance allergique ; J45.1 Asthme non allergique ; J45.8 Asthme associé ; J45.9 Asthme, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J40, J44, J47
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J45/J45_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j45.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J45/.

I26 — Embolie pulmonaire aiguë (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I26-I28 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 46 (dyspnoea), 206 (acute severe dyspnoea). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (2)** : I26.0 Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu ; I26.9 Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I27
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I26/I26_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i26.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/I26/.

I27 — Hypertension pulmonaire et autres maladies des vaisseaux pulmonaires (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I26-I28 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 46 (dyspnoea), 206 (acute severe dyspnoea). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (5)** : I27.0 Hypertension pulmonaire primitive ; I27.1 Cardiopathie due à cyphoscoliose ; I27.2 Autres hypertensions pulmonaires secondaires ; I27.8 Autres affections cardiopulmonaires précisées ; I27.9 Affection cardiopulmonaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I27/I27_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i27.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/I27/.

J12 — Pneumonies virales et pneumonies d'autres causes (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J09-J18 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (6)** : J12.0 Pneumonie adénovirale ; J12.1 Pneumonie due au virus respiratoire syncytial [VRS] ; J12.2 Pneumonie due aux virus paragrippaux ; J12.3 Pneumonie due au Metapneumovirus humain ; J12.8 Autres pneumonie virales ; J12.9 Pneumonie virale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J09, J18
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/J12/J12_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j12.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J12/.

J21 — Bronchiolite aiguë et infections respiratoires basses non précisées (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J20-J22 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : J21.0 Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [VRS] ; J21.1 Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus humain ; J21.8 Bronchiolite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés ; J21.9 Bronchiolite aiguë, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J21/J21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J21/.

J47 — Bronchectasies (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J40-J47 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J40, J44, J45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J47/J47_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j47.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J47/.

J60 — Pneumoconioses et plaques pleurales (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J60-J70 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea), 49 (painful respiration, wheezing, stridor), 167 (effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J67, J68, J69, J70
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations

particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/J60/J60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J60/.

J67 — Pneumopathies d'hypersensibilité et maladies des poussières organiques (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J60-J70 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : J67.0 Poumon de fermier ; J67.1 Bagasseuse ; J67.2 Poumon des oiseleurs ; J67.3 Subérose ; J67.4 Poumon des malteurs ; J67.5 Poumon des champignonnistes ; J67.6 Poumon des écorceurs d'érables ; J67.7 Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d'humidification de l'air ; J67.8 Alvéolite allergique due à autres poussières organiques ; J67.9 Alvéolite allergique due aux poussières organiques, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J60, J68, J69, J70
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J67/J67_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j67.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J67/.

J80 — Syndrome de détresse respiratoire aiguë (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J80-J84 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 46 (dyspnoea), 206 (acute severe dyspnoea). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (1) : J80.0 Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte [SDRA]
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J81, J82, J84
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J80/J80_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j80.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J80/.

J82 — Éosinophilies pulmonaires (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J80-J84 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J80, J81, J84

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J82/J82_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j82.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J82/.

J84 — Pneumopathies interstitielles diffuses (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J80-J84 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : J84.0 Pneumonies alvéolaires et pariéto-alvéolaires ; J84.1 Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose ; J84.8 Autres affections pulmonaires interstitielles précisées ; J84.9 Affection pulmonaire interstitielle, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J80, J81, J82
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J84/J84_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j84.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J84/.

J86 — Pleurésies purulentes et abcès du poumon (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J85-J86 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 45 (cough, expectoration, haemoptysis), 46 (dyspnoea), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : J86.0 Pyothorax avec fistule ; J86.9 Pyothorax sans fistule
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J86/J86_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j86.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J86/.

J90 — Épanchements pleuraux (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J90-J94 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 46 (dyspnoea), 167 (effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : J93**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J90/J90_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j90.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J90/.

J93 — Pneumothorax (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J90-J94 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 46 (dyspnoea), 167 (effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : J93.0 Pneumothorax spontané avec pression positive ; J93.1 Autres pneumothorax spontanés ; J93.8 Autres pneumothorax ; J93.9 Pneumothorax, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : J90**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J93/J93_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j93.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J93/.

J95 — Complications respiratoires des actes médicaux et autres troubles respiratoires (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J95-J99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 41 (change of respiratory pattern), 46 (dyspnoea). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : J95.0 Fonctionnement défectueux d'un trachéostome ; J95.1 Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale thoracique ; J95.2 Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale non thoracique ; J95.3 Insuffisance pulmonaire chronique consécutive à une intervention chirurgicale ; J95.4 Syndrome de Mendelson ; J95.5 Sténose sous-glottique après des actes médicaux ; J95.8 Autres troubles respiratoires après des actes médicaux, non classés ailleurs ; J95.9 Trouble respiratoire après des actes médicaux, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : J96**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/J95/J95_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j95.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J95/.

J96 — Insuffisance respiratoire aiguë et chronique (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM X** · bloc J95-J99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 46 (dyspnoea), 206 (acute severe dyspnoea). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : J96.0 Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs ; J96.1 Insuffisance respiratoire chronique, non classée ailleurs ; J96.9 Insuffisance respiratoire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J95
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J96/J96_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j96.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/J96/.

R04 — Hémoptysie (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R00-R09 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 45 (cough, expectoration, haemoptysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : R04.0 Epistaxis ; R04.1 Hémorragie de la gorge ; R04.2 Hémoptysie ; R04.8 Hémorragie d'autres parties des voies respiratoires ; R04.9 Hémorragie des voies respiratoires, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R05, R06, R07, R09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R04/R04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/R04/.

R05 — Toux aiguë, subaiguë et chronique (P-02-Pneumologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R00-R09 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 45 (cough, expectoration, haemoptysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R04, R06, R07, R09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles respiratoires → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/R05/R05_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/P-02-Pneumologie/travail/R05/.

G-04-Gastroentérologie et hépatologie

89 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 17 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : SSG (gastroentérologie), SASL (foie) ; UEG, ESGE, EASL, ECCO.

C18 — Tumeur maligne du côlon (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C15-C26 · difficulté **très élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : C18.0 Tumeur maligne: Cæcum ; C18.1 Tumeur maligne: Appendice ; C18.2 Tumeur maligne: Côlon ascendant ; C18.3 Tumeur maligne: Angle droit du côlon [hepatica] ; C18.4 Tumeur maligne: Côlon transverse ; C18.5 Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [splénique] ; C18.6 Tumeur maligne: Côlon descendant ; C18.7 Tumeur maligne: Côlon sigmoïde ; C18.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du côlon ; C18.9 Tumeur maligne: Côlon, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C15, C16, C17, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C18/C18_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c18.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/C18/.

K21 — Reflux gastro-œsophagien (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Brouillon existant** : livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K21 — achevé, en attente du relecteur distinct : **ne pas réécrire**, lancer la relecture.
- **Chapitre CIM XI** · bloc K20-K31 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 47 (heartburn (pyrosis)), 48 (impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation), 52 (abdominal, epigastric pain), 210 (haematemesis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : K21.0 Reflux gastro-œsophagien avec œsophagite ; K21.9 Reflux gastro-œsophagien sans œsophagite
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K20, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/K21/K21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K21/.

K25 — Ulcère de l'estomac (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K20-K31 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 47 (heartburn (pyrosis)), 48 (impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation), 52 (abdominal, epigastric pain), 210 (haematemesis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : K25.0 Ulcère de l'estomac: Aigu avec hémorragie ; K25.1 Ulcère de l'estomac: Aigu avec perforation ; K25.2 Ulcère de l'estomac: Aigu avec hémorragie et perforation ; K25.3 Ulcère de l'estomac: Aigu sans hémorragie ni perforation ; K25.4 Ulcère de l'estomac: Chronique ou non précisé, avec hémorragie ; K25.5 Ulcère de l'estomac: Chronique ou non précisé, avec perforation ; K25.6 Ulcère de l'estomac: Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation ; K25.7 Ulcère de l'estomac: Chronique sans hémorragie ni perforation ; K25.9 Ulcère de l'estomac: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K20, K21, K22, K23, K26, K27, K28, K29, K30, K31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K25/K25_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k25.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K25/.

K29 — Gastrite et duodénite (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K20-K31 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 47 (heartburn (pyrosis)), 48 (impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation), 52 (abdominal, epigastric pain), 210 (haematemesis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : K29.0 Gastrite hémorragique aiguë ; K29.1 Autres gastrites aiguës ; K29.2 Gastrite alcoolique ; K29.3 Gastrite chronique superficielle ; K29.4 Gastrite chronique atrophique ; K29.5 Gastrite chronique, sans précision ; K29.6 Autres gastrites ; K29.7 Gastrite, sans précision ; K29.8 Duodénite ; K29.9 Gastro-duodénite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K30, K31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K29/K29_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k29.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K29/.

K35 — Appendicite aiguë (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XI** · bloc K35-K38 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 203 (acute abdominal, epigastric pain). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : K35.2 Appendicite aiguë avec péritonite généralisée ; K35.3 Appendicite aiguë avec péritonite localisée ; K35.8 Appendicite aiguë, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K36, K37, K38
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K35/K35_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K35/.

K40 — Hernie inguinale (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K40-K46 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 73 (swelling, pain in groin). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : K40.0 Hernie inguinale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène ; K40.1 Hernie inguinale bilatérale, avec gangrène ; K40.2 Hernie inguinale bilatérale, sans occlusion ni gangrène ; K40.3 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène ; K40.4 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène ; K40.9 Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K41, K42, K43, K44, K45, K46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K40/K40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K40/.

K50 — Maladie de Crohn [entérite régionale] (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K50-K52 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 59 (diarrhoea). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : K50.0 Maladie de Crohn de l'intestin grêle ; K50.1 Maladie de Crohn du gros intestin ; K50.8 Autres formes de la maladie de Crohn ; K50.9 Maladie de Crohn, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K51, K52
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/K50/K50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K50/.

K51 — Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse] (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K50-K52 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 59 (diarrhoea). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : K51.0 Pancolite ulcéreuse (chronique) ; K51.2 Rectite ulcéreuse (chronique) ; K51.3 Recto-sigmoïdite ulcéreuse (chronique) ; K51.4 Polypes inflammatoires du côlon ; K51.5 Colite latérale gauche ; K51.8 Autres recto-colites hémorragiques ; K51.9 Recto-colite hémorragique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K50, K52
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K51/K51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K51/.

K52 — Autres gastroentérites et colites non infectieuses (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K50-K52 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 59 (diarrhoea). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : K52.0 Gastroentérite et colite dues à une irradiation ; K52.1 Gastroentérite et colite toxiques ; K52.2 Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires ; K52.3 Colite indéterminée ; K52.8 Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées ; K52.9 Gastroentérite et colite non infectieuses, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K50, K51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K52/K52_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k52.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K52/.

K57 — Maladie diverticulaire de l'intestin (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K55-K64 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 55 (altered defaecation pattern, incontinence, pain), 58 (constipation), 60 (melena, fresh blood, mucus, pus in faeces).

Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : K57.0 Maladie diverticulaire de l'intestin grêle avec perforation et abcès ; K57.1 Maladie diverticulaire de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès ; K57.2 Maladie diverticulaire du côlon avec perforation et abcès ; K57.3 Maladie diverticulaire du côlon sans perforation ni abcès ; K57.4 Maladie diverticulaire de l'intestin grêle et du côlon avec perforation et abcès ; K57.5 Maladie diverticulaire du côlon et de l'intestin grêle sans perforation ni abcès ; K57.8 Maladie diverticulaire de l'intestin, siège non précisé avec perforation et abcès ; K57.9 Maladie diverticulaire de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K55, K56, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K57/K57_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k57.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K57/.

K58 — Syndrome de l'intestin irritable (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K55-K64 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 55 (altered defaecation pattern, incontinence, pain), 58 (constipation), 60 (melena, fresh blood, mucus, pus in faeces).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : K58.1 Syndrome de l'intestin irritable, avec diarrhée prédominante [SII-D] ; K58.2 Syndrome de l'intestin irritable, avec constipation prédominante [SII-C] ; K58.3 Syndrome de l'intestin irritable, avec troubles du transit changeants (mixtes) [SII-M] ; K58.8 Syndrome de l'intestin irritable, autre et non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K55, K56, K57, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K58/K58_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k58.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K58/.

K59 — Autres troubles fonctionnels de l'intestin (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K55-K64 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 55 (altered defaecation pattern, incontinence, pain), 58 (constipation), 60 (melena, fresh blood, mucus, pus in faeces).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : K59.0 Constipation ; K59.1 Diarrhée fonctionnelle ; K59.2 Intestin neurogène, non classé ailleurs ; K59.3 Mégacôlon, non classé ailleurs ; K59.4 Spasme de l'anus ; K59.8 Autres troubles fonctionnels précisés de l'intestin ; K59.9 Trouble fonctionnel de l'intestin, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K55, K56, K57, K58, K60, K61, K62, K63, K64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K59/K59_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k59.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K59/.

K64 — Hémorroïdes et thrombose veineuse périanale (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K55-K64 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 55 (altered defaecation pattern, incontinence, pain), 58 (constipation), 60 (melena, fresh blood, mucus, pus in faeces). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : K64.0 Hémorroïdes du premier degré ; K64.1 Hémorroïdes du deuxième degré ; K64.2 Hémorroïdes du troisième degré ; K64.3 Hémorroïdes du quatrième degré ; K64.4 Cicatrices hémorroïdaires cutanées résiduelles ; K64.5 Thrombose veineuse périanale ; K64.8 Autres hémorroïdes ; K64.9 Hémorroïdes, sans autre précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K64/K64_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k64.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K64/.

K70 — Maladie alcoolique du foie (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K70-K77 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 91 (jaundice (icterus)), 160 (abnormal liver enzymes). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : K70.0 Dégénérescence graisseuse alcoolique du foie ; K70.1 Hépatite alcoolique ; K70.2 Fibrose et sclérose alcooliques du foie ; K70.3 Cirrhose alcoolique du foie ; K70.4 Insuffisance hépatique alcoolique ; K70.9 Maladie alcoolique du foie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K71, K72, K73, K74, K75, K76, K77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K70/K70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K70/.

K76 — Autres maladies du foie (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K70-K77 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 91 (jaundice (icterus)), 160 (abnormal liver enzymes). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : K76.0 Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs ; K76.1 Congestion passive chronique du foie ; K76.2 Nécrose hémorragique centrale du foie ; K76.3 Infarctus hépatique ; K76.4 Péliose hépatique ; K76.5 Maladie veino-occlusive du foie ; K76.6 Hypertension portale ; K76.7 Syndrome hépato-rénal ; K76.8 Autres maladies précisées du foie ; K76.9 Maladie du foie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K70, K71, K72, K73, K74, K75, K77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K76/K76_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k76.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K76/.

K80 — Cholélithiase (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K80-K87 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 91 (jaundice (icterus)), 203 (acute abdominal, epigastric pain), 209 (colic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : K80.0 Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë ; K80.1 Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite ; K80.2 Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite ; K80.3 Calcul des canaux biliaires avec angiocholite ; K80.4 Calcul des canaux biliaires avec cholécystite ; K80.5 Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite ; K80.8 Autres cholélithiases
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K81, K82, K83, K85, K86, K87
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K80/K80_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k80.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K80/.

K85 — Pancréatite aiguë (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K80-K87 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 91 (jaundice (icterus)), 203 (acute abdominal, epigastric pain), 209 (colic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique ; K85.1 Pancréatite aiguë d'origine biliaire ; K85.2 Pancréatite aiguë alcoolique ; K85.3 Pancréatite aiguë médicamenteuse ; K85.8 Autres pancréatites aiguës ; K85.9 Pancréatite aiguë, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K80, K81, K82, K83, K86, K87
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K85/K85_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k85.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K85/.

C15 — Tumeur maligne de l'œsophage (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C15-C26 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : C15.0 Tumeur maligne: Œsophage cervical ; C15.1 Tumeur maligne: Œsophage thoracique ; C15.2 Tumeur maligne: Œsophage abdominal ; C15.3 Tumeur maligne: Tiers supérieur de l'œsophage ; C15.4 Tumeur maligne: Tiers moyen de l'œsophage ; C15.5 Tumeur maligne: Tiers inférieur de l'œsophage ; C15.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œsophage ; C15.9 Tumeur maligne: Œsophage, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C15/C15_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c15.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/C15/.

C16 — Tumeur maligne de l'estomac (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C15-C26 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : C16.0 Tumeur maligne: Cardia ; C16.1 Tumeur maligne: Fundus ; C16.2 Tumeur maligne: Corps de l'estomac ; C16.3 Tumeur maligne: Antre pylorique ; C16.4 Tumeur maligne: Pylore ; C16.5 Tumeur maligne: Petite courbure de l'estomac, sans précision ; C16.6 Tumeur maligne: Grande courbure de l'estomac, sans précision ; C16.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'estomac ; C16.9 Tumeur maligne: Estomac, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C15, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/C16/C16_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c16.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/C16/.

C17 — Tumeur maligne de l'intestin grêle (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C15-C26 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : C17.0 Tumeur maligne: Duodénum ; C17.1 Tumeur maligne: Jéjunum ; C17.2 Tumeur maligne: Iléon ; C17.3 Tumeur maligne: Diverticule de Meckel ; C17.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'intestin grêle ; C17.9 Tumeur maligne: Intestin grêle, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C15, C16, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C17/C17_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c17.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/C17/.

C19 — Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C15-C26 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C15, C16, C17, C18, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C19/C19_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c19.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/C19/.

C20 — Tumeur maligne du rectum (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C15-C26 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C15, C16, C17, C18, C19, C21, C22, C23, C24, C25, C26

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C20/C20_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c20.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/C20/.

C21 — Tumeur maligne de l'anus et du canal anal (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C15-C26 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : C21.0 Tumeur maligne: Anus, sans précision ; C21.1 Tumeur maligne: Canal anal ; C21.2 Tumeur maligne: Zone cloacale ; C21.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C15, C16, C17, C18, C19, C20, C22, C23, C24, C25, C26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C21/C21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/C21/.

C22 — Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C15-C26 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : C22.0 Carcinome hépatocellulaire ; C22.1 Carcinome du canal biliaire intrahépatique ; C22.2 Hépatoblastome ; C22.3 Angiosarcome du foie ; C22.4 Autres sarcomes du foie ; C22.7 Autres carcinomes du foie précisés ; C22.9 Tumeur maligne: Foie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C23, C24, C25, C26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C22/C22_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c22.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/C22/.

C23 — Tumeur maligne de la vésicule biliaire (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C15-C26 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C24, C25, C26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C23/C23_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c23.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/C23/.

C24 — Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C15-C26 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : C24.0 Tumeur maligne: Canal biliaire extra-hépatique ; C24.1 Tumeur maligne: Ampoule de Vater ; C24.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des voies biliaires ; C24.9 Tumeur maligne: Voies biliaires, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C25, C26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C24/C24_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c24.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/C24/.

C25 — Tumeur maligne du pancréas (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C15-C26 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : C25.0 Tumeur maligne: Tête du pancréas ; C25.1 Tumeur maligne: Corps du pancréas ; C25.2 Tumeur maligne: Queue du pancréas ; C25.3 Tumeur maligne: Canal pancréatique ; C25.4 Tumeur maligne: Pancréas endocrine ; C25.7 Tumeur maligne: Autres parties du pancréas ; C25.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du pancréas ; C25.9 Tumeur maligne: Pancréas, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C25/C25_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c25.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/C25/.

C26 — Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C15-C26 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : C26.0 Tumeur maligne: Tractus intestinal, partie non précisée ; C26.1 Tumeur maligne: Rate ; C26.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'appareil digestif ; C26.9 Tumeur maligne: Sièges mal définis de l'appareil digestif
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C26/C26_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c26.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/C26/.

K20 — Œsophagite (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K20-K31 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 47 (heartburn (pyrosis)), 48 (impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation), 52 (abdominal, epigastric pain), 210 (haematemesis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : K20.0 Œsophagite à éosinophiles ; K20.1 Œsophagite radique ; K20.8 Autre œsophagite précisée ; K20.9 Œsophagite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K20/K20_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k20.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K20/.

K22 — Autres maladies de l'œsophage (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K20-K31 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 47 (heartburn (pyrosis)), 48 (impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation), 52 (abdominal, epigastric pain), 210 (haematemesis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : K22.0 Achalasie du cardia ; K22.1 Ulcère de l'œsophage ; K22.2 Obstruction de l'œsophage ; K22.3 Perforation de l'œsophage ; K22.4 Dyskinésie de l'œsophage ; K22.5 Diverticule acquis de l'œsophage ; K22.6 Syndrome de Mallory-Weiss ; K22.7 Endobranchyœsophage [œsophage de Barrett] ; K22.8 Autres maladies précisées de l'œsophage ; K22.9 Maladie de l'œsophage, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K20, K21, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K22/K22_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k22.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K22/.

K23 — Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K20-K31 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 47 (heartburn (pyrosis)), 48 (impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation), 52 (abdominal, epigastric pain), 210 (haematemesis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : K23.0 Œsophagite tuberculeuse ; K23.1 Méga-œsophage au cours de la maladie de Chagas ; K23.8 Atteintes de l'œsophage au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K20, K21, K22, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K23/K23_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k23.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K23/.

K26 — Ulcère du duodénum (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K20-K31 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 47 (heartburn (pyrosis)), 48 (impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation), 52 (abdominal, epigastric pain), 210 (haematemesis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : K26.0 Ulcère du duodénum: Aigu avec hémorragie ; K26.1 Ulcère du duodénum: Aigu avec perforation ; K26.2 Ulcère du duodénum: Aigu avec hémorragie et perforation ; K26.3 Ulcère du duodénum: Aigu sans hémorragie ni perforation ; K26.4 Ulcère du duodénum: Chronique ou non précisé, avec hémorragie ; K26.5 Ulcère du duodénum:

Chronique ou non précisé, avec perforation ; K26.6 Ulcère du duodénum: Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation ; K26.7 Ulcère du duodénum: Chronique sans hémorragie ni perforation ; K26.9 Ulcère du duodénum: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K20, K21, K22, K23, K25, K27, K28, K29, K30, K31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K26/K26_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k26.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K26/.

K27 — Ulcère digestif, de siège non précisé (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K20-K31 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 47 (heartburn (pyrosis)), 48 (impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation), 52 (abdominal, epigastric pain), 210 (haematemesis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : K27.0 Ulcère digestif, de siège non précisé: Aigu avec hémorragie ; K27.1 Ulcère digestif, de siège non précisé: Aigu avec perforation ; K27.2 Ulcère digestif, de siège non précisé: Aigu avec hémorragie et perforation ; K27.3 Ulcère digestif, de siège non précisé: Aigu sans hémorragie ni perforation ; K27.4 Ulcère digestif, de siège non précisé: Chronique ou non précisé, avec hémorragie ; K27.5 Ulcère digestif, de siège non précisé: Chronique ou non précisé, avec perforation ; K27.6 Ulcère digestif, de siège non précisé: Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation ; K27.7 Ulcère digestif, de siège non précisé: Chronique sans hémorragie ni perforation ; K27.9 Ulcère digestif, de siège non précisé: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K28, K29, K30, K31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K27/K27_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k27.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K27/.

K28 — Ulcère gastro-jéjunal (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K20-K31 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 47 (heartburn (pyrosis)), 48 (impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation), 52 (abdominal, epigastric pain), 210 (haematemesis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : K28.0 Ulcère gastro-jéjunal: Aigu avec hémorragie ; K28.1 Ulcère gastro-jéjunal: Aigu avec perforation ; K28.2 Ulcère gastro-jéjunal: Aigu avec hémorragie et perforation ; K28.3 Ulcère gastro-jéjunal: Aigu sans hémorragie ni perforation ; K28.4 Ulcère gastro-jéjunal: Chronique ou non précisé, avec hémorragie ; K28.5 Ulcère gastro-jéjunal: Chronique ou non précisé, avec perforation ; K28.6 Ulcère gastro-jéjunal: Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation ; K28.7 Ulcère gastro-jéjunal: Chronique sans hémorragie ni

perforation ; K28.9 Ulcère gastro-jéjunal: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K29, K30, K31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K28/K28_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k28.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K28/.

K30 — Dyspepsie fonctionnelle (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K20-K31 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 47 (heartburn (pyrosis)), 48 (impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation), 52 (abdominal, epigastric pain), 210 (haematemesis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K30/K30_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K30/.

K31 — Autres maladies de l'estomac et du duodénum (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K20-K31 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 47 (heartburn (pyrosis)), 48 (impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation), 52 (abdominal, epigastric pain), 210 (haematemesis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : K31.0 Dilatation aiguë de l'estomac ; K31.1 Sténose pylorique de l'adulte ; K31.2 Estomac en sablier et sténose de l'estomac ; K31.3 Spasme du pylore, non classé ailleurs ; K31.4 Diverticule gastrique ; K31.5 Obstruction du duodénum ; K31.6 Fistule de l'estomac et du duodénum ; K31.7 Polype de l'estomac et du duodénum ; K31.8 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum ; K31.9 Maladie de l'estomac et du duodénum, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K20, K21, K22, K23, K25, K26, K27, K28, K29, K30
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K31/K31_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k31.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K31/.

K36 — Autres formes d'appendicite (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K35-K38 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 203 (acute abdominal, epigastric pain). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K35, K37, K38
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K36/K36_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k36.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K36/.

K37 — Appendicite, sans précision (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K35-K38 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 203 (acute abdominal, epigastric pain). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K35, K36, K38
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K37/K37_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k37.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K37/.

K38 — Autres maladies de l'appendice (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K35-K38 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 203 (acute abdominal, epigastric pain). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : K38.0 Hyperplasie de l'appendice ; K38.1 Concrétions appendiculaires ; K38.2 Diverticule de l'appendice ; K38.3 Fistule de l'appendice ; K38.8 Autres maladies précisées de l'appendice ; K38.9 Maladie de l'appendice, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K35, K36, K37
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K38/K38_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k38.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K38/.

K41 — Hernie crurale (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XI** · bloc K40-K46 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 73 (swelling, pain in groin). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : K41.0 Hernie crurale bilatérale, avec occlusion, sans gangrène ; K41.1 Hernie crurale bilatérale, avec gangrène ; K41.2 Hernie crurale bilatérale, sans occlusion ni gangrène ; K41.3 Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec occlusion, sans gangrène ; K41.4 Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec gangrène ; K41.9 Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, sans occlusion ni gangrène
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K40, K42, K43, K44, K45, K46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K41/K41_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k41.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K41/.

K42 — Hernie ombilicale (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K40-K46 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 73 (swelling, pain in groin). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : K42.0 Hernie ombilicale avec occlusion, sans gangrène ; K42.1 Hernie ombilicale, avec gangrène ; K42.9 Hernie ombilicale, sans occlusion ni gangrène
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K40, K41, K43, K44, K45, K46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K42/K42_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k42.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K42/.

K43 — Hernie de la paroi abdominale antérieure (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K40-K46 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 73 (swelling, pain in groin). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : K43.0 Hernie incisionnelle avec occlusion, sans gangrène ; K43.1 Hernie incisionnelle avec gangrène ; K43.2 Hernie incisionnelle sans occlusion ni gangrène ; K43.3 Hernie parastomale avec occlusion, sans gangrène ; K43.4 Hernie parastomale, avec gangrène ; K43.5 Hernie parastomale, sans occlusion ni gangrène ; K43.6 Hernies de la paroi abdominale antérieure avec occlusion sans gangrène, autres et non précisées ; K43.7 Hernies de la paroi abdominale antérieure avec gangrène, autres et non précisées ; K43.9 Hernies de la paroi abdominale antérieure sans occlusion ni gangrène, autres et non précisées
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K40, K41, K42, K44, K45, K46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/K43/K43_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k43.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K43/.

K44 — Hernie diaphragmatique (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K40-K46 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 73 (swelling, pain in groin). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : K44.0 Hernie diaphragmatique avec occlusion, sans gangrène ; K44.1 Hernie diaphragmatique, avec gangrène ; K44.9 Hernie diaphragmatique, sans occlusion ni gangrène
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K40, K41, K42, K43, K45, K46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K44/K44_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k44.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K44/.

K45 — Autres hernies abdominales (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K40-K46 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 73 (swelling, pain in groin). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : K45.0 Autres hernies abdominales de siège précisé, avec occlusion, sans gangrène ; K45.1 Autres hernies abdominales précisées, avec gangrène ; K45.8 Autres hernies abdominales précisées, sans occlusion ni gangrène
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K40, K41, K42, K43, K44, K46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K45/K45_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k45.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K45/.

K46 — Hernie abdominale non précisée (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K40-K46 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 73 (swelling, pain in groin). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : K46.0 Hernie abdominale non précisée, avec occlusion, sans gangrène ; K46.1 Hernie abdominale non précisée, avec gangrène ; K46.9 Hernie abdominale non précisée, sans occlusion ni gangrène
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K40, K41, K42, K43, K44, K45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/K46/K46_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k46.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K46/.

K55 — Troubles vasculaires de l'intestin (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K55-K64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 55 (altered defaecation pattern, incontinence, pain), 58 (constipation), 60 (melena, fresh blood, mucus, pus in faeces). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : K55.0 Troubles vasculaires aigus de l'intestin ; K55.1 Troubles vasculaires chroniques de l'intestin ; K55.2 Angiodysplasie du côlon ; K55.3 Angiodysplasie de l'intestin grêle ; K55.8 Autres troubles vasculaires de l'intestin ; K55.9 Trouble vasculaire de l'intestin, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K55/K55_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k55.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K55/.

K56 — Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K55-K64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 55 (altered defaecation pattern, incontinence, pain), 58 (constipation), 60 (melena, fresh blood, mucus, pus in faeces). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : K56.0 Iléus paralytique ; K56.1 Invagination ; K56.2 Volvulus ; K56.3 Iléus biliaire ; K56.4 Autres obstructions de l'intestin ; K56.5 Adhérences de l'intestin [bridges] avec occlusion ; K56.6 Occlusions intestinales, autres et sans précision ; K56.7 Iléus, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K55, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K63, K64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K56/K56_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k56.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K56/.

K60 — Fissure et fistule des régions anale et rectale (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K55-K64 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 55 (altered defaecation pattern, incontinence, pain), 58 (constipation), 60 (melena, fresh blood, mucus, pus in faeces).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : K60.0 Fissure anale aiguë ; K60.1 Fissure anale chronique ; K60.2 Fissure anale, sans précision ; K60.3 Fistule anale ; K60.4 Fistule rectale ; K60.5 Fistule ano-rectale
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K55, K56, K57, K58, K59, K61, K62, K63, K64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K60/K60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K60/.

K61 — Abcès des régions anale et rectale (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K55-K64 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 55 (altered defaecation pattern, incontinence, pain), 58 (constipation), 60 (melena, fresh blood, mucus, pus in faeces).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : K61.0 Abcès anal ; K61.1 Abcès rectal ; K61.2 Abcès ano-rectal ; K61.3 Abcès ischio-rectal ; K61.4 Abcès intrasphinctérien
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K55, K56, K57, K58, K59, K60, K62, K63, K64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K61/K61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K61/.

K62 — Autres maladies de l'anus et du rectum (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K55-K64 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 55 (altered defaecation pattern, incontinence, pain), 58 (constipation), 60 (melena, fresh blood, mucus, pus in faeces).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : K62.0 Polype anal ; K62.1 Polype rectal ; K62.2 Prolapsus anal ; K62.3 Prolapsus rectal ; K62.4 Sténose de l'anus et du rectum ; K62.5 Hémorragie de l'anus et du rectum ; K62.6 Ulcère de l'anus et du rectum ; K62.7 Rectite due à une irradiation ; K62.8 Autres maladies précisées de l'anus et du rectum ; K62.9 Maladie de l'anus et du rectum, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K63, K64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8.

Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/K62/K62_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K62/.

K63 — Autres maladies de l'intestin (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K55-K64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 55 (altered defaecation pattern, incontinence, pain), 58 (constipation), 60 (melena, fresh blood, mucus, pus in faeces).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : K63.0 Abscès de l'intestin ; K63.1 Perforation de l'intestin (non traumatique) ; K63.2 Fistule de l'intestin ; K63.3 Ulcère de l'intestin ; K63.4 Entéroptose ; K63.5 Polype du côlon ; K63.8 Autres maladies précisées de l'intestin ; K63.9 Maladie de l'intestin, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K55, K56, K57, K58, K59, K60, K61, K62, K64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K63/K63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K63/.

K65 — Péritonite (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K65-K67 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 55 (altered defaecation pattern, incontinence, pain), 58 (constipation), 60 (melena, fresh blood, mucus, pus in faeces).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : K65.0 Péritonite aiguë ; K65.8 Autres péritonites ; K65.9 Péritonite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K66, K67
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K65/K65_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k65.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K65/.

K66 — Autres maladies du péritoine (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K65-K67 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 55 (altered defaecation pattern, incontinence, pain), 58 (constipation), 60 (melena, fresh blood, mucus, pus in faeces).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (5)** : K66.0 Adhérences péritonéales ; K66.1 Hémopéritoine ; K66.2 Fibrose rétropéritonéale ; K66.8 Autres maladies précisées du péritoine ; K66.9 Maladie du péritoine, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K65, K67
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K66/K66_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k66.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K66/.

K67 — Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K65-K67 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 55 (altered defaecation pattern, incontinence, pain), 58 (constipation), 60 (melena, fresh blood, mucus, pus in faeces). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (5)** : K67.0 Péritonite à Chlamydia ; K67.1 Péritonite gonococcique ; K67.2 Péritonite syphilitique ; K67.3 Péritonite tuberculeuse ; K67.8 Autres atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K65, K66
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K67/K67_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k67.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K67/.

K71 — Maladie toxique du foie (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K70-K77 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 91 (jaundice (icterus)), 160 (abnormal liver enzymes). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : K71.0 Maladie toxique du foie avec cholestase ; K71.1 Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique ; K71.2 Maladie toxique du foie avec hépatite aiguë ; K71.3 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante ; K71.4 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique lobulaire ; K71.5 Maladie toxique du foie avec hépatite chronique active ; K71.6 Maladie toxique du foie avec hépatite, non classée ailleurs ; K71.7 Maladie toxique du foie avec fibrose et cirrhose du foie ; K71.8 Maladie toxique du foie avec d'autres lésions du foie ; K71.9 Maladie toxique du foie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K70, K72, K73, K74, K75, K76, K77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/K71/K71_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K71/.

K72 — Insuffisance hépatique, non classée ailleurs (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K70-K77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 91 (jaundice (icterus)), 160 (abnormal liver enzymes).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : K72.0 Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë, non classée ailleurs ; K72.1 Insuffisance hépatique chronique, non classée ailleurs ; K72.7 Encéphalopathie hépatique et coma hépatique ; K72.9 Insuffisance hépatique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K70, K71, K73, K74, K75, K76, K77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K72/K72_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k72.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K72/.

K73 — Hépatite chronique, non classée ailleurs (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K70-K77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 91 (jaundice (icterus)), 160 (abnormal liver enzymes).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : K73.0 Hépatite chronique persistante, non classée ailleurs ; K73.1 Hépatite chronique lobulaire, non classée ailleurs ; K73.2 Hépatite chronique active, non classée ailleurs ; K73.8 Autres hépatites chroniques, non classées ailleurs ; K73.9 Hépatite chronique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K70, K71, K72, K74, K75, K76, K77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K73/K73_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k73.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K73/.

K74 — Fibrose et cirrhose du foie (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K70-K77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 91 (jaundice (icterus)), 160 (abnormal liver enzymes).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : K74.0 Fibrose hépatique ; K74.1 Sclérose hépatique ; K74.2 Fibrose hépatique, avec sclérose hépatique ; K74.3 Angiocholite biliaire primitive ; K74.4

Cirrhose biliaire secondaire ; K74.5 Cirrhose biliaire, sans précision ; K74.6 Cirrhoses du foie, autres et sans précision ; K74.7 Stades cliniques de la cirrhose du foie

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K70, K71, K72, K73, K75, K76, K77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K74/K74_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k74.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K74/.

K75 — Autres maladies inflammatoires du foie (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K70-K77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 91 (jaundice (icterus)), 160 (abnormal liver enzymes). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : K75.0 Abscès du foie ; K75.1 Phlébite de la veine porte ; K75.2 Hépatite réactive non spécifique ; K75.3 Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs ; K75.4 Hépatite auto-immune ; K75.8 Autres maladies inflammatoires précisées du foie ; K75.9 Maladie inflammatoire du foie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K70, K71, K72, K73, K74, K76, K77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K75/K75_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k75.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K75/.

K77 — Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K70-K77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 91 (jaundice (icterus)), 160 (abnormal liver enzymes). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : K77.0 Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; K77.1 Atteinte du foie dans la maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte ; K77.2 Atteinte du foie dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ; K77.8 Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K70, K71, K72, K73, K74, K75, K76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K77/K77_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k77.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K77/.

K81 — Cholécystite (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K80-K87 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 91 (jaundice (icterus)), 203 (acute abdominal, epigastric pain), 209 (colic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : K81.0 Cholécystite aiguë ; K81.1 Cholécystite chronique ; K81.8 Autres cholécystites ; K81.9 Cholécystite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K80, K82, K83, K85, K86, K87
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K81/K81_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k81.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K81/.

K82 — Autres maladies de la vésicule biliaire (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K80-K87 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 91 (jaundice (icterus)), 203 (acute abdominal, epigastric pain), 209 (colic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : K82.0 Occlusion de la vésicule biliaire ; K82.1 Hydrocholécyste ; K82.2 Perforation de la vésicule biliaire ; K82.3 Fistule de la vésicule biliaire ; K82.4 Choléstérolose de la vésicule biliaire ; K82.8 Autres maladies précisées de la vésicule biliaire ; K82.9 Maladie de la vésicule biliaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K80, K81, K83, K85, K86, K87
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K82/K82_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k82.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K82/.

K83 — Autres maladies des voies biliaires (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K80-K87 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 91 (jaundice (icterus)), 203 (acute abdominal, epigastric pain), 209 (colic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : K83.0 Angiocholite [cholangite] ; K83.1 Obstruction des voies biliaires ; K83.2 Perforation des voies biliaires ; K83.3 Fistule des voies biliaires ; K83.4 Spasme du sphincter d'Oddi ; K83.5 Kyste biliaire ; K83.8 Autres maladies précisées des voies biliaires ; K83.9 Maladie des voies biliaires, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K80, K81, K82, K85, K86, K87
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8.

Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/K83/K83_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k83.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K83/.

K86 — Autres maladies du pancréas (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K80-K87 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 91 (jaundice (icterus)), 203 (acute abdominal, epigastric pain), 209 (colic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : K86.0 Pancréatite chronique alcoolique ; K86.1 Autres pancréatites chroniques ; K86.2 Kyste du pancréas ; K86.3 Pseudokyste du pancréas ; K86.8 Autres maladies précisées du pancréas ; K86.9 Maladie du pancréas, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K80, K81, K82, K83, K85, K87
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K86/K86_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k86.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K86/.

K87 — Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K80-K87 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain), 91 (jaundice (icterus)), 203 (acute abdominal, epigastric pain), 209 (colic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : K87.0 Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classées ailleurs ; K87.1 Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K80, K81, K82, K83, K85, K86
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K87/K87_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k87.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K87/.

K90 — Malabsorption intestinale (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K90-K93 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 59 (diarrhoea). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : K90.0 Maladie cœliaque ; K90.1 Sprue tropicale ; K90.2 Syndrome de l'anse borgne, non classé ailleurs ; K90.3 Stéatorrhée pancréatique ; K90.4

Malabsorption due à une intolérance, non classée ailleurs ; K90.8 Autres malabsorptions intestinales ; K90.9 Malabsorption intestinale, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K91, K92, K93
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/K90/K90_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/k90.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K90/](#).

K92 — Autres maladies du système digestif (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K90-K93 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 60 (melena, fresh blood, mucus, pus in faeces), 210 (haematemesis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : K92.0 Hématémèse ; K92.1 Méléna ; K92.2 Hémorragie gastro-intestinale, sans précision ; K92.8 Autres maladies précisées du système digestif ; K92.9 Maladie du système digestif, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K90, K91, K93
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/K92/K92_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/k92.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/K92/](#).

Q39 — Malformations congénitales de l'œsophage (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q38-Q45 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Q39.0 Atrésie de l'œsophage, sans fistule ; Q39.1 Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne ; Q39.2 Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie ; Q39.3 Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage ; Q39.4 Ptérygion congénital de l'œsophage ; Q39.5 Dilatation congénitale de l'œsophage ; Q39.6 Diverticule de l'œsophage (congénital) ; Q39.8 Autres malformations congénitales de l'œsophage ; Q39.9 Malformation congénitale de l'œsophage, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Q39/Q39_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q39.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/Q39/.

Q40 — Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q38-Q45 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : Q40.0 Sténose hypertrophique congénitale du pylore ; Q40.1 Hernie hiatale congénitale ; Q40.2 Autres malformations congénitales précisées de l'estomac ; Q40.3 Malformation congénitale de l'estomac, sans précision ; Q40.8 Autres malformations congénitales précisées des voies digestives supérieures ; Q40.9 Malformation congénitale des voies digestives supérieures, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q39, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q40/Q40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/Q40/.

Q41 — Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q38-Q45 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : Q41.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum ; Q41.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum ; Q41.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon ; Q41.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle ; Q41.9 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q39, Q40, Q42, Q43, Q44, Q45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q41/Q41_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q41.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/Q41/.

Q42 — Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q38-Q45 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : Q42.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule ; Q42.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule ; Q42.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule ; Q42.3 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule ; Q42.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon ; Q42.9 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q39, Q40, Q41, Q43, Q44, Q45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q42/Q42_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q42.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/Q42/.

Q43 — Autres malformations congénitales de l'intestin (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q38-Q45 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Q43.0 Diverticule de Meckel ; Q43.1 Maladie de Hirschsprung ; Q43.2 Autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon ; Q43.3 Malformations congénitales de fixation de l'intestin ; Q43.4 Duplication de l'intestin ; Q43.5 Ectopie de l'anus ; Q43.6 Fistule congénitale du rectum et de l'anus ; Q43.7 Persistance du cloaque ; Q43.8 Autres malformations congénitales précisées de l'intestin ; Q43.9 Malformation congénitale de l'intestin, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q39, Q40, Q41, Q42, Q44, Q45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q43/Q43_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q43.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/Q43/.

Q44 — Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q38-Q45 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : Q44.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule biliaire ; Q44.1 Autres malformations congénitales de la vésicule biliaire ; Q44.2 Atrésie des voies biliaires ; Q44.3 Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires ; Q44.4 Kyste du

cholédoque ; Q44.5 Autres malformations congénitales des voies biliaires ; Q44.6 Maladie kystique du foie ; Q44.7 Autres malformations congénitales du foie

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q44/Q44_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q44.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/Q44/.

Q45 — Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q38-Q45 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : Q45.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas ; Q45.1 Pancréas annulaire ; Q45.2 Kyste pancréatique congénital ; Q45.3 Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique ; Q45.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil digestif ; Q45.9 Malformation congénitale de l'appareil digestif, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q45/Q45_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q45.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/Q45/.

R10 — Douleur abdominale et pelvienne (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R10-R19 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 52 (abdominal, epigastric pain). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : R10.0 Syndrome abdominal aigu ; R10.1 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen ; R10.2 Douleur pelvienne et périnéale ; R10.3 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen ; R10.4 Douleurs abdominales, autres et non précisées
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R10/R10_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/R10/.

R11 — Nausées et vomissements (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R10-R19 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 61 (nausea, vomiting). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R10, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R11/R11_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r11.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/R11/.

R12 — Pyrosis (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R10-R19 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 47 (heartburn (pyrosis)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R10, R11, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R12/R12_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r12.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/R12/.

R13 — Dysphagie (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R10-R19 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 48 (impaired or painful passage of food, dysphagia, regurgitation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : R13.0 Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture ; R13.1 Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée ; R13.9 Dysphagies, autres et non précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R10, R11, R12, R14, R15, R16, R17, R18, R19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R13/R13_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r13.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/R13/.

R14 — Flatulence et troubles apparentés (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R10-R19 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 53 (abdominal distension). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R10, R11, R12, R13, R15, R16, R17, R18, R19

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R14/R14_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r14.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/R14/.

R15 — Incontinence des matières fécales (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R10-R19 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 55 (altered defaecation pattern, incontinence, pain), 202 (urinary and faecal incontinence). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R10, R11, R12, R13, R14, R16, R17, R18, R19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R15/R15_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r15.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/R15/.

R16 — Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R10-R19 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 54 (abdominal mass), 167 (effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : R16.0 Hépatomégalie, non classée ailleurs ; R16.1 Splénomégalie, non classée ailleurs ; R16.2 Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R10, R11, R12, R13, R14, R15, R17, R18, R19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R16/R16_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r16.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/R16/.

R17 — Hyperbilirubinémie, avec ou sans ictère, non classée ailleurs (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R10-R19 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 91 (jaundice (icterus)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : R17.0 Hyperbilirubinémie, avec indication d'ictère, non classée ailleurs ; R17.9 Hyperbilirubinémie, sans indication d'ictère, non classée ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R18, R19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux

rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : `chapters/R17/R17_a...d.html`, `_pop1`, `_pop2`, `glossary/r17.py`, rapports auteur et relecture dans `livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/R17/`.

R18 — Ascite (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R10-R19 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 54 (abdominal mass), 167 (effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : `chapters/R18/R18_a...d.html`, `_pop1`, `_pop2`, `glossary/r18.py`, rapports auteur et relecture dans `livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/R18/`.

R19 — Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R10-R19 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 54 (abdominal mass), 167 (effusion detected by ultrasound (abdomen, pleura)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : R19.0 Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes ; R19.1 Bruits abdominaux anormaux ; R19.2 Péristaltisme apparent ; R19.3 Contracture abdominale ; R19.4 Modification du transit intestinal ; R19.5 Autres anomalies des matières fécales ; R19.6 Haleine fétide ; R19.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : `chapters/R19/R19_a...d.html`, `_pop1`, `_pop2`, `glossary/r19.py`, rapports auteur et relecture dans `livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/R19/`.

S30 — Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S30-S39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 106 (abdominal injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S30.0 Contusion des lombes et du bassin ; S30.1 Contusion de la paroi abdominale ; S30.2 Contusion des organes génitaux externes ; S30.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin ; S30.8 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin ; S30.9 Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S31, S36
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S30/S30_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/S30/.

S31 — Plaie ouverte de l'abdomen, des lombes et du bassin (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S30-S39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 106 (abdominal injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : S31.0 Plaie ouverte des lombes et du bassin ; S31.1 Plaie ouverte de la paroi abdominale ; S31.2 Plaie ouverte du pénis ; S31.3 Plaie ouverte du scrotum et des testicules ; S31.4 Plaie ouverte du vagin et de la vulve ; S31.5 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés ; S31.7 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin ; S31.8 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S30, S36
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S31/S31_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s31.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/S31/.

S36 — Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S30-S39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 106 (abdominal injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : S36.0 Lésion traumatique de la rate ; S36.1 Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire ; S36.2 Lésion traumatique du pancréas ; S36.3 Lésion traumatique de l'estomac ; S36.4 Lésion traumatique de l'intestin grêle ; S36.5 Lésion traumatique du côlon ; S36.6 Lésion traumatique du rectum ; S36.7 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux ; S36.8 Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux ; S36.9 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S30, S31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S36/S36_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s36.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/S36/.

T18 — Corps étranger dans les voies digestives (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XIX** · bloc T15-T19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 111 (foreign body). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : T18.0 Corps étranger dans la bouche ; T18.1 Corps étranger dans l'œsophage ; T18.2 Corps étranger dans l'estomac ; T18.3 Corps étranger dans l'intestin grêle ; T18.4 Corps étranger dans le côlon ; T18.5 Corps étranger dans l'anus et le rectum ; T18.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies digestives ; T18.9 Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T18/T18_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t18.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/T18/.

T28 — Brûlure et corrosion d'autres organes internes (G-04-Gastroentérologie et hépatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T26-T28 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx ; T28.1 Brûlure de l'œsophage ; T28.2 Brûlure d'autres parties des voies digestives ; T28.3 Brûlure des organes génito-urinaires internes ; T28.4 Brûlure des organes internes, autres et sans précision ; T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx ; T28.6 Corrosion de l'œsophage ; T28.7 Corrosion d'autres parties des voies digestives ; T28.8 Corrosion des organes génito-urinaires internes ; T28.9 Corrosion des organes internes, autres et sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T28/T28_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t28.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-04-Gastroentérologie et hépatologie/travail/T28/.

E-06-Endocrinologie et métabolisme

68 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 6 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : SSED (endocrinologie et diabétologie) ; EASD, ESE.

E03 — Autres hypothyroïdies (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E00-E07 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 37 (swelling of face, lips, neck; goitre), 163 (abnormal thyroid hormones). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : E03.0 Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus ; E03.1 Hypothyroïdie congénitale, sans goitre ; E03.2 Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits exogènes ; E03.3 Hypothyroïdie post-infectieuse ; E03.4 Atrophie de la thyroïde (acquise) ; E03.5 Coma myxoédémateux ; E03.8 Autres hypothyroïdies précisées ; E03.9 Hypothyroïdie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E00, E01, E02, E04, E05, E06, E07

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E03/E03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E03/.

E04 — Autres goitres non toxiques (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E00-E07 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 37 (swelling of face, lips, neck; goitre), 163 (abnormal thyroid hormones). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : E04.0 Goitre diffus non toxique ; E04.1 Nodule thyroïdien simple non toxique ; E04.2 Goitre multinodulaire non toxique ; E04.8 Autres goitres non toxiques précisés ; E04.9 Goitre non toxique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E00, E01, E02, E03, E05, E06, E07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E04/E04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E04/.

E05 — Thyréotoxique [hyperthyroïdie] (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E00-E07 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 37 (swelling of face, lips, neck; goitre), 163 (abnormal thyroid hormones). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : E05.0 Thyréotoxique avec goitre diffus ; E05.1 Thyréotoxique avec nodule thyroïdien simple ; E05.2 Thyréotoxique avec goitre multinodulaire toxique ; E05.3 Thyréotoxique due à des nodules thyroïdiens ectopiques ; E05.4 Thyréotoxique factice ; E05.5 Crise thyrotoxique aiguë ; E05.8 Autres thyrotoxicoses ; E05.9 Thyrotoxicose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E00, E01, E02, E03, E04, E06, E07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E05/E05_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E05/.

E11 — Diabète sucré, type 2 (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P1

- **État** : vide

- **Brouillon existant** : livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E11 — achevé, en attente du relecteur distinct : **ne pas réécrire**, lancer la relecture.
- **Chapitre CIM IV** · bloc E10-E14 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 3 (excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia)), 158 (abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : E11.0 Diabète sucré, type 2: Avec coma ; E11.1 Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose ; E11.2 Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales ; E11.3 Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires ; E11.4 Diabète sucré, type 2: Avec complications neurologiques ; E11.5 Diabète sucré, type 2: Avec complications vasculaires périphériques ; E11.6 Diabète sucré, type 2: Avec autres complications précisées ; E11.7 Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples ; E11.8 Diabète sucré, type 2: Avec complications non précisées ; E11.9 Diabète sucré, type 2: Sans complication
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E10, E12, E13, E14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E11/E11_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e11.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E11/.

E66 — Obésité (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E65-E68 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 15 (weight gain, obesity). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : E66.0 Obésité due à un excès calorique ; E66.1 Obésité médicamenteuse ; E66.2 Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire ; E66.8 Autres obésités ; E66.9 Obésité, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E65, E67, E68
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E66/E66_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e66.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E66/.

E78 — Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E70-E90 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 162 (abnormal serum lipids). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : E78.0 Hypercholestérolémie essentielle ; E78.1 Hyperglycémie essentielle ; E78.2 Hyperlipidémie mixte ; E78.3 Hyperchylomicronémie ; E78.4 Autres hyperlipidémies ; E78.5 Hyperlipidémie, sans précision ; E78.6 Déficit en lipoprotéines ; E78.8

Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines ; E78.9 Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E77, E79, E80, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E78/E78_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e78.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E78/.

C73 — Tumeur maligne de la thyroïde (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C73-C75 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C74, C75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C73/C73_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c73.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/C73/.

C74 — Tumeur maligne de la surrénale (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C73-C75 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : C74.0 Tumeur maligne: Cortex de la surrénale ; C74.1 Tumeur maligne: Médullosurrénale ; C74.9 Tumeur maligne: Surrénale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C73, C75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C74/C74_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c74.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/C74/.

C75 — Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C73-C75 · difficulté **très élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : C75.0 Tumeur maligne: Parathyroïde ; C75.1 Tumeur maligne: Hypophyse ; C75.2 Tumeur maligne: Tractus cranio-pharyngien ; C75.3 Tumeur maligne: Épiphyse [glande pinéale] ; C75.4 Tumeur maligne: Corpuscule carotidien ; C75.5 Tumeur maligne: Glomus aortique et autres paraganglions ; C75.8 Tumeur maligne: Atteinte pluriglandulaire, sans précision ; C75.9 Tumeur maligne: Glande endocrine, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C73, C74
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C75/C75_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c75.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/C75/.

E00 — Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale (E-06-Endocrinologie et métabolisme) - P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E00-E07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 37 (swelling of face, lips, neck; goitre), 163 (abnormal thyroid hormones). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E00.0 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type neurologique ; E00.1 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type myxœdémateux ; E00.2 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type mixte ; E00.9 Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E00/E00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E00/.

E01 — Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode (E-06-Endocrinologie et métabolisme) - P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E00-E07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 37 (swelling of face, lips, neck; goitre), 163 (abnormal thyroid hormones). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E01.0 Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode ; E01.1 Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence en iode ; E01.2 Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans précision ; E01.8 Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E00, E02, E03, E04, E05, E06, E07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6.

Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/E01/E01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E01/.

E02 — Hypothyroïdie par carence inapparente en iode (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E00-E07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 37 (swelling of face, lips, neck; goitre), 163 (abnormal thyroid hormones). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E00, E01, E03, E04, E05, E06, E07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E02/E02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E02/.

E06 — Thyroïdite (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E00-E07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 37 (swelling of face, lips, neck; goitre), 163 (abnormal thyroid hormones). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : E06.0 Thyroïdite aiguë ; E06.1 Thyroïdite subaiguë ; E06.2 Thyroïdite chronique avec thyroétoxicose transitoire ; E06.3 Thyroïdite auto-immune ; E06.4 Thyroïdite médicamenteuse ; E06.5 Autres thyroïdites chroniques ; E06.9 Thyroïdite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E00, E01, E02, E03, E04, E05, E07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E06/E06_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e06.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E06/.

E07 — Autres affections de la thyroïde (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E00-E07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 37 (swelling of face, lips, neck; goitre), 163 (abnormal thyroid hormones). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E07.0 Hypersécrétion de calcitonine ; E07.1 Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse ; E07.8 Autres affections précisées de la thyroïde ; E07.9 Affection de la thyroïde, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E00, E01, E02, E03, E04, E05, E06

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E07/E07_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e07.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E07/.

E10 — Diabète sucré, type 1 (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E10-E14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 3 (excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia)), 158 (abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : E10.0 Diabète sucré, type 1: Avec coma ; E10.1 Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose ; E10.2 Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales ; E10.3 Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires ; E10.4 Diabète sucré, type 1: Avec complications neurologiques ; E10.5 Diabète sucré, type 1: Avec complications vasculaires périphériques ; E10.6 Diabète sucré, type 1: Avec autres complications précisées ; E10.7 Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples ; E10.8 Diabète sucré, type 1: Avec complications non précisées ; E10.9 Diabète sucré, type 1: Sans complication
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E11, E12, E13, E14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E10/E10_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E10/.

E12 — Diabète sucré de malnutrition (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E10-E14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 3 (excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia)), 158 (abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : E12.0 Diabète sucré de malnutrition: Avec coma ; E12.1 Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose ; E12.2 Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales ; E12.3 Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires ; E12.4 Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques ; E12.5 Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques ; E12.6 Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées ; E12.7 Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples ; E12.8 Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées ; E12.9 Diabète sucré de malnutrition: Sans complication
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E10, E11, E13, E14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/E12/E12_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e12.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E12/.

E13 — Autres diabètes sucrés précisés (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E10-E14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 3 (excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia)), 158 (abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : E13.0 Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma ; E13.1 Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose ; E13.2 Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales ; E13.3 Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires ; E13.4 Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques ; E13.5 Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques ; E13.6 Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées ; E13.7 Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples ; E13.8 Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées ; E13.9 Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E10, E11, E12, E14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E13/E13_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e13.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E13/.

E14 — Diabète sucré, sans précision (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E10-E14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 3 (excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia)), 158 (abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : E14.0 Diabète sucré, sans précision: Avec coma ; E14.1 Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose ; E14.2 Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales ; E14.3 Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires ; E14.4 Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques ; E14.5 Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques ; E14.6 Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées ; E14.7 Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples ; E14.8 Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées ; E14.9 Diabète sucré, sans précision: Sans complication
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E10, E11, E12, E13
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E14/E14_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e14.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E14/.

E20 — Hypoparathyroïdie (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E20.0 Hypoparathyroïdie idiopathique ; E20.1 Pseudohypoparathyroïdie ; E20.8 Autres hypoparathyroïdies ; E20.9 Hypoparathyroïdie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E20/E20_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e20.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E20/.

E21 — Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : E21.0 Hyperparathyroïdie primaire ; E21.1 Hyperparathyroïdie secondaire, non classée ailleurs ; E21.2 Autres hyperparathyroïdies ; E21.3 Hyperparathyroïdie, sans précision ; E21.4 Autres maladies précisées de la glande parathyroïde ; E21.5 Maladie de la glande parathyroïde, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E20, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E21/E21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E21/.

E22 — Hypersécrétion de l'hypophyse (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : E22.0 Acromégalie et gigantisme ; E22.1 Hyperprolactinémie ; E22.2 Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique ; E22.8 Autres hypersécrétions de l'hypophyse ; E22.9 Hypersécrétion de l'hypophyse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/E22/E22_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e22.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E22/.

E23 — Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : E23.0 Hypopituitarisme ; E23.1 Hypopituitarisme médicamenteux ; E23.2 Diabète insipide ; E23.3 Anomalie hypothalamique, non classée ailleurs ; E23.6 Autres anomalies de l'hypophyse ; E23.7 Anomalie de l'hypophyse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E20, E21, E22, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E23/E23_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e23.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E23/.

E24 — Syndrome de Cushing (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : E24.0 Maladie de Cushing hypophyso-dépendante ; E24.1 Syndrome de Nelson ; E24.2 Syndrome de Cushing médicamenteux ; E24.3 Syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH ; E24.4 Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool ; E24.8 Autres syndromes de Cushing ; E24.9 Syndrome de Cushing, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E20, E21, E22, E23, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E24/E24_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e24.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E24/.

E25 — Anomalies génito-surréaliennes (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : E25.0 Anomalies génito-surrénaliennes congénitales liées à un déficit enzymatique ; E25.8 Autres anomalies génito-surrénaliennes ; E25.9 Anomalie génito-surrénalienne, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E20, E21, E22, E23, E24, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E25/E25_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e25.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E25/.

E26 — Hyperaldostéronisme (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E26.0 Hyperaldostéronisme primaire ; E26.1 Hyperaldostéronisme secondaire ; E26.8 Autres hyperaldostéronismes ; E26.9 Hyperaldostéronisme, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E26/E26_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e26.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E26/.

E27 — Autres maladies de la glande surrénale (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : E27.0 Autres hyperfonctionnements corticosurrénaux ; E27.1 Insuffisance corticosurrénale primaire ; E27.2 Crise addisonienne ; E27.3 Insuffisance corticosurrénale médicamenteuse ; E27.4 Insuffisances corticosurrénales, autres et sans précision ; E27.5 Hyperfonctionnement de la médullosurrénale ; E27.8 Autres maladies précisées de la glande surrénale ; E27.9 Maladie de la glande surrénale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E28, E29, E30, E31, E32, E34, E35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/E27/E27_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/e27.py](#), rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E27/.

E28 — Dysfonction ovarienne (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : E28.0 Dysfonction ovarienne: Hyperœstrogénie ; E28.1 Dysfonction ovarienne: Hyperandrogénie ; E28.2 Syndrome ovarien polykystique ; E28.3 Insuffisance ovarienne primaire ; E28.8 Autres dysfonctions ovariennes ; E28.9 Dysfonction ovarienne, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E29, E30, E31, E32, E34, E35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/E28/E28_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/e28.py](#), rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E28/.

E29 — Dysfonction testiculaire (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E29.0 Hyperfonction testiculaire ; E29.1 Hypofonction testiculaire ; E29.8 Autres dysfonctions testiculaires ; E29.9 Dysfonction testiculaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E30, E31, E32, E34, E35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/E29/E29_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/e29.py](#), rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E29/.

E30 — Anomalies de la puberté, non classées ailleurs (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E30.0 Puberté retardée ; E30.1 Puberté précoce ; E30.8 Autres anomalies de la puberté ; E30.9 Anomalie de la puberté, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E31, E32, E34, E35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E30/E30_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E30/.

E31 — Dysfonctionnement pluriglandulaire (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E31.0 Insuffisance pluriglandulaire auto-immune ; E31.1 Hyperfonctionnement pluriglandulaire ; E31.8 Autres dysfonctionnements pluriglandulaires ; E31.9 Dysfonctionnement pluriglandulaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E32, E34, E35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E31/E31_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e31.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E31/.

E32 — Maladies du thymus (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E32.0 Hyperplasie persistante du thymus ; E32.1 Abcès du thymus ; E32.8 Autres maladies du thymus ; E32.9 Maladie du thymus, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E34, E35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E32/E32_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e32.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E32/.

E34 — Autres troubles endocriniens (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : E34.0 Syndrome carcinoïde ; E34.1 Autres hypersécrétions d'hormones intestinales ; E34.2 Sécrétion hormonale ectopique, non classée ailleurs ; E34.3 Insuffisance staturale, non classée ailleurs ; E34.4 Haute stature constitutionnelle ; E34.5 Syndrome de résistance aux androgènes ; E34.8 Autres troubles endocriniens précisés ; E34.9 Anomalie endocrinienne, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E34/E34_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e34.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E34/.

E35 — Anomalies endocriniennes au cours de maladies classées ailleurs (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E20-E35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : E35.0 Anomalies de la glande thyroïde au cours de maladies classées ailleurs ; E35.1 Anomalies de la glande surrénale au cours de maladies classées ailleurs ; E35.8 Anomalies d'autres glandes endocrines au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E34
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E35/E35_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E35/.

E40 — Kwashiorkor (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E40-E46 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E41, E42, E43, E44, E45, E46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/E40/E40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E40/.

E41 — Marasme nutritionnel (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E40-E46 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E40, E42, E43, E44, E45, E46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E41/E41_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e41.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E41/.

E42 — Kwashiorkor avec marasme (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E40-E46 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E40, E41, E43, E44, E45, E46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E42/E42_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e42.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E42/.

E43 — Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E40-E46 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E40, E41, E42, E44, E45, E46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E43/E43_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e43.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E43/.

E44 — Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E40-E46 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : E44.0 Malnutrition protéino-énergétique modérée ; E44.1 Malnutrition protéino-énergétique légère
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E40, E41, E42, E43, E45, E46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E44/E44_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e44.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E44/.

E45 — Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E40-E46 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E40, E41, E42, E43, E44, E46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E45/E45_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e45.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E45/.

E46 — Malnutrition protéino-énergétique, sans précision (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E40-E46 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E40, E41, E42, E43, E44, E45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E46/E46_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e46.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E46/.

E50 — Avitaminose A (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E50-E64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : E50.0 Avitaminose A avec xérosis conjonctival ; E50.1 Avitaminose A avec taches de Bitot et xérosis conjonctival ; E50.2 Avitaminose A avec xérosis cornéen ; E50.3 Avitaminose A avec xérosis et ulcération de la cornée ; E50.4 Avitaminose A avec kératomalacie ; E50.5 Avitaminose A avec héméralopie ; E50.6 Avitaminose A avec cicatrices xérophthalmiques de la cornée ; E50.7 Autres manifestations oculaires de l'avitaminose A ; E50.8 Autres manifestations de l'avitaminose A ; E50.9 Avitaminose A, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E50/E50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E50/.

E51 — Carence en thiamine [carence en vitamine B1] (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E50-E64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E51.1 Bériberi ; E51.2 Encéphalopathie de Wernicke ; E51.8 Autres manifestations de la carence en thiamine ; E51.9 Carence en thiamine, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E50, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E51/E51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E51/.

E52 — Carence en acide nicotinique [pellagre] (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E50-E64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E50, E51, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6.

Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/E52/E52_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e52.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E52/.

E53 — Autres avitaminoses du groupe B (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E50-E64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E53.0 Carence en riboflavine ; E53.1 Carence en pyridoxine ; E53.8 Autres avitaminoses précisées du groupe B ; E53.9 Avitaminose du groupe B, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E50, E51, E52, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E53/E53_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E53/.

E54 — Carence en acide ascorbique (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E50-E64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E50, E51, E52, E53, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E54/E54_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e54.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E54/.

E55 — Carence en vitamine D (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E50-E64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : E55.0 Rachitisme évolutif ; E55.9 Carence en vitamine D, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E50, E51, E52, E53, E54, E56, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E55/E55_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e55.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E55/.

E56 — Autres avitaminoses (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E50-E64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E56.0 Carence en vitamine E ; E56.1 Carence en vitamine K ; E56.8 Carence en autres vitamines ; E56.9 Avitaminose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E50, E51, E52, E53, E54, E55, E58, E59, E60, E61, E63, E64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E56/E56_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e56.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E56/.

E58 — Carence alimentaire en calcium (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E50-E64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E59, E60, E61, E63, E64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E58/E58_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e58.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E58/.

E59 — Carence alimentaire en sélénium (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E50-E64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E60, E61, E63, E64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E59/E59_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e59.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E59/.

E60 — Carence alimentaire en zinc (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E50-E64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E61, E63, E64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E60/E60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E60/.

E61 — Carences en autres éléments nutritionnels (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E50-E64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : E61.0 Carence en cuivre ; E61.1 Carence en fer ; E61.2 Carence en magnésium ; E61.3 Carence en manganèse ; E61.4 Carence en chrome ; E61.5 Carence en molybdène ; E61.6 Carence en vanadium ; E61.7 Carence en plusieurs éléments nutritionnels ; E61.8 Carence en autres éléments nutritionnels précisés ; E61.9 Carence en élément nutritionnel, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E63, E64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E61/E61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E61/.

E63 — Autres carences nutritionnelles (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide

- **Chapitre CIM IV** · bloc E50-E64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E63.0 Carence en acides gras essentiels ; E63.1 Déséquilibre alimentaire ; E63.8 Autres carences nutritionnelles précisées ; E63.9 Carence nutritionnelle, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E63/E63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E63/.

E64 — Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E50-E64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite), 138 (cachexia and malnutrition), 170 (nutritional deficiencies). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : E64.0 Séquelles de malnutrition protéino-énergétique ; E64.1 Séquelles d'avitaminose A ; E64.2 Séquelles d'avitaminose C ; E64.3 Séquelles de rachitisme ; E64.8 Séquelles d'autres carences nutritionnelles ; E64.9 Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E58, E59, E60, E61, E63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E64/E64_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e64.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E64/.

E65 — Adiposité localisée (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E65-E68 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 15 (weight gain, obesity). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E66, E67, E68
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/E65/E65_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e65.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E65/.

E67 — Autres excès d'apport (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E65-E68 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 15 (weight gain, obesity). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : E67.0 Hypervitaminose A ; E67.1 Hypercaroténémie ; E67.2 Syndrome d'hypervitaminose B6 ; E67.3 Hypervitaminose D ; E67.8 Autres excès précisés d'apport
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E65, E66, E68
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E67/E67_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e67.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E67/.

E68 — Séquelles d'excès d'apport (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E65-E68 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 15 (weight gain, obesity). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E65, E66, E67
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E68/E68_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e68.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E68/.

E70 — Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E70-E90 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 264 (suspicion of rare disease). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : E70.0 Phénylcétonurie classique ; E70.1 Autres hyperphénylalaninémies ; E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine ; E70.3 Albinisme ; E70.8 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques ; E70.9 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E71, E72, E73, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/E70/E70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E70/.

E71 — Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E70-E90 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 264 (suspicion of rare disease). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E71.0 Maladie des urines à odeur de sirop d'érable ; E71.1 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée ; E71.2 Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision ; E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E70, E72, E73, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E71/E71_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E71/.

E72 — Autres anomalies du métabolisme des acides aminés (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E70-E90 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 264 (suspicion of rare disease). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : E72.0 Anomalies du transport des acides aminés ; E72.1 Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés ; E72.2 Anomalies du cycle de l'uréogénèse ; E72.3 Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine ; E72.4 Anomalies du métabolisme de l'ornithine ; E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine ; E72.8 Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés ; E72.9 Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E70, E71, E73, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E72/E72_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e72.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E72/.

E73 — Intolérance au lactose (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E70-E90 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 264 (suspicion of rare disease). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (4)** : E73.0 Déficit congénital en lactase ; E73.1 Déficit secondaire en lactase ; E73.8 Autres intolérances au lactose ; E73.9 Intolérance au lactose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E70, E71, E72, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E73/E73_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e73.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E73/.

E74 — Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E70-E90 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 264 (suspicion of rare disease). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : E74.0 Thésaurismose glycogénique ; E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose ; E74.2 Anomalies du métabolisme du galactose ; E74.3 Autres anomalies de l'absorption intestinale des hydrates de carbone ; E74.4 Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la gluconéogenèse ; E74.8 Autres anomalies précisées du métabolisme des hydrates de carbone ; E74.9 Anomalie du métabolisme des hydrates de carbone, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E70, E71, E72, E73, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E74/E74_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e74.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E74/.

E75 — Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E70-E90 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 264 (suspicion of rare disease). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : E75.0 Gangliosidose GM2 ; E75.1 Autres gangliosidoses ; E75.2 Autres sphingolipidoses ; E75.3 Sphingolipidose, sans précision ; E75.4 Lipofuscinose à céréïdes neuronaux ; E75.5 Autres anomalies du stockage des lipides ; E75.6 Anomalie du stockage des lipides, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E70, E71, E72, E73, E74, E76, E77, E78, E79, E80, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/E75/E75_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e75.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E75/.

E76 — Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E70-E90 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 264 (suspicion of rare disease). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : E76.0 Mucopolysaccharidose, type I ; E76.1 Mucopolysaccharidose, type II ; E76.2 Autres mucopolysaccharidoses ; E76.3 Mucopolysaccharidose, sans précision ; E76.8 Autres anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes ; E76.9 Anomalie du métabolisme des glucosaminoglycanes, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E70, E71, E72, E73, E74, E75, E77, E78, E79, E80, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E76/E76_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e76.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E76/.

E77 — Anomalies du métabolisme des glycoprotéines (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E70-E90 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 264 (suspicion of rare disease). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : E77.0 Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux ; E77.1 Défauts de la dégradation des glycoprotéines ; E77.8 Autres anomalies du métabolisme des glycoprotéines ; E77.9 Anomalie du métabolisme des glycoprotéines, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E78, E79, E80, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E77/E77_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e77.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E77/.

E84 — Fibrose kystique (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E70-E90 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 46 (dyspnoea), 189 (feeding and eating issues during infancy, childhood and adolescence). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (4)** : E84.0 Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires ; E84.1 Fibrose kystique avec manifestations intestinales ; E84.8 Fibrose kystique avec autres manifestations ; E84.9 Fibrose kystique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E83, E85, E86, E87, E88, E89, E90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E84/E84_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e84.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E84/.

E85 — Amylose (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E70-E90 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 146 (oedema), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : E85.0 Amylose hérédofamiliale non neuropathique ; E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique ; E85.2 Amylose hérédofamiliale, sans précision ; E85.3 Amylose généralisée secondaire ; E85.4 Amylose limitée à un ou plusieurs organe(s) ; E85.8 Autres amyloses ; E85.9 Amylose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E83, E84, E86, E87, E88, E89, E90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E85/E85_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e85.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E85/.

E86 — Hypovolémie (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IV** · bloc E70-E90 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E83, E84, E85, E87, E88, E89, E90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E86/E86_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e86.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E86/.

E87 — Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques (E-06-Endocrinologie et métabolisme) · P2

- **État** : vide

- **Chapitre CIM IV** · bloc E70-E90 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie ; E87.1 Hypo-osmolarité et hyponatrémie ; E87.2 Acidose ; E87.3 Alcalose ; E87.4 Anomalie mixte de l'équilibre acido-basique ; E87.5 Hyperkaliémie ; E87.6 Hypokaliémie ; E87.7 Surcharge liquidienne ; E87.8 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques, non classés ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E83, E84, E85, E86, E88, E89, E90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/E87/E87_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/e87.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-06-Endocrinologie et métabolisme/travail/E87/.

H-08-Hématologie

42 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 4 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : SSH (hématologie) ; EHA.

D50 — Anémie par carence en fer (H-08-Hématologie) · P1

- **État** : vide
- **Brouillon existant** : livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D50 — achevé, en attente du relecteur distinct : **ne pas réécrire**, lancer la relecture.
- **Chapitre CIM III** · bloc D50-D53 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 147 (pallor), 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : D50.0 Anémie par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique) ; D50.1 Dysphagie sidéropénique ; D50.8 Autres anémies par carence en fer ; D50.9 Anémie par carence en fer, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D51, D52, D53
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D50/D50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D50/.

D64 — Autres anémies (H-08-Hématologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D60-D64 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 147 (pallor), 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : D64.0 Anémie sidéroblastique héréditaire ; D64.1 Anémie sidéroblastique secondaire, due à une maladie ; D64.2 Anémie sidéroblastique secondaire, due à des médicaments et des toxines ; D64.3 Autres anémies sidéroblastiques ; D64.4 Anémie dysérythropoïétique congénitale ; D64.8 Autres anémies précisées ; D64.9 Anémie, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D60, D61, D62, D63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D64/D64_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d64.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D64/.

D68 — Autres anomalies de la coagulation (H-08-Hématologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D65-D69 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 88 (ecchymosis, haematoma, purpura), 152 (abnormal coagulation profile), 174 (thrombopenia, thrombocytosis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : D68.0 Maladie de von Willebrand ; D68.1 Carence héréditaire en facteur XI ; D68.2 Carence héréditaire en autres facteurs de coagulation ; D68.3 Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants et anticorps circulants ; D68.4 Carence acquise en facteur de coagulation ; D68.5 Thrombophilie primaire ; D68.6 Autres thrombophilies ; D68.8 Autres anomalies précisées de la coagulation ; D68.9 Anomalie de la coagulation, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D65, D66, D67, D69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D68/D68_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d68.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D68/.

D69 — Purpura et autres affections hémorragiques (H-08-Hématologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D65-D69 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 88 (ecchymosis, haematoma, purpura), 152 (abnormal coagulation profile), 174 (thrombopenia, thrombocytosis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : D69.0 Purpura allergique ; D69.1 Modifications qualitatives des plaquettes ; D69.2 Autres purpuras non thrombopéniques ; D69.3 Purpura thrombopénique idiopathique ; D69.4 Autres thrombopénies primaires ; D69.5 Thrombopénie secondaire ; D69.6 Thrombopénie, sans précision ; D69.8 Autres affections hémorragiques précisées ; D69.9 Affection hémorragique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D65, D66, D67, D68
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D69/D69_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d69.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D69/.

C77 — Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C76-C80 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : C77.0 Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou ; C77.1 Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques ; C77.2 Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intra-abdominaux ; C77.3 Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur ; C77.4 Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur ; C77.5 Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrapelviens ; C77.8 Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples ; C77.9 Tumeur maligne: Ganglion lymphatique, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C77/C77_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c77.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C77/.

C81 — Lymphome de Hodgkin [lymphogranulomatose maligne] (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C81-C96 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : C81.0 Lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire ; C81.1 Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose nodulaire ; C81.2 Lymphome de Hodgkin (classique) à cellularité mixte ; C81.3 Lymphome de Hodgkin (classique) à déplétion lymphocytaire ; C81.4 Lymphome de Hodgkin (classique) riche en lymphocytes ; C81.7 Autres formes de lymphome de Hodgkin (classique) ; C81.9 Lymphome de Hodgkin, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C81/C81_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c81.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C81/.

C82 — Lymphome folliculaire (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C81-C96 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance

pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : C82.0 Lymphome folliculaire de grade I ; C82.1 Lymphome folliculaire de grade II ; C82.2 Lymphome folliculaire de grade III, sans précision ; C82.3 Lymphome folliculaire de grade IIIa ; C82.4 Lymphome folliculaire de grade IIIb ; C82.5 Lymphome centrofolliculaire diffus ; C82.6 Lymphome centrofolliculaire cutané ; C82.7 Autres formes de lymphome, folliculaire ; C82.9 Lymphome folliculaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C81, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C82/C82_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c82.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C82/.

C83 — Lymphome non folliculaire (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C81-C96 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : C83.0 Lymphome à petites cellules B ; C83.1 Lymphome à cellules du manteau ; C83.3 Lymphome diffus à grandes cellules B ; C83.5 Lymphome lymphoblastique ; C83.7 Lymphome de Burkitt ; C83.8 Autres lymphomes non folliculaires ; C83.9 Lymphome non folliculaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C81, C82, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C83/C83_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c83.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C83/.

C84 — Lymphomes à cellules T/NK matures (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C81-C96 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : C84.0 Mycosis fongoïde ; C84.1 Réticulose de Sézary ; C84.4 Lymphome périphérique à cellules T, non spécifié ; C84.5 Autres lymphomes à cellules T/NK matures ; C84.6 Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif ; C84.7 Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif ; C84.8 Lymphome cutané à cellules T, sans précision ; C84.9 Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C81, C82, C83, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C84/C84_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c84.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C84/.

C85 — Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C81-C96 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : C85.1 Lymphomes à cellules B, sans précision ; C85.2 Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B ; C85.7 Autres types précisés de lymphome non hodgkinien ; C85.9 Lymphome non hodgkinien, non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C81, C82, C83, C84, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C85/C85_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c85.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C85/.

C86 — Autres lymphomes à cellules T/NK spécifiés (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C81-C96 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : C86.0 Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal ; C86.1 Lymphome hépatosplénique à cellules T ; C86.2 Lymphome à cellules T de type entéropathique ; C86.3 Lymphome sous-cutané à cellules T de type panniculite ; C86.4 Lymphome blastique à cellules NK ; C86.5 Lymphome angio-immunoblastique à cellules T ; C86.6 Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 positif
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C81, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C86/C86_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c86.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C86/.

C88 — Maladies immunoprolifératives malignes (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C81-C96 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : C88.0 Macroglobulinémie de Waldenström ; C88.2 Autre maladie des chaînes lourdes ; C88.3 Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle ; C88.4 Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ; C88.7 Autres maladies immunoprolifératives malignes ; C88.9 Maladie immunoproliférative maligne, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C81, C82, C83, C84, C85, C86, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C88/C88_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c88.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C88/.

C90 — Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C81-C96 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : C90.0 Myélome multiple ; C90.1 Leucémie à plasmocytes ; C90.2 Plasmocytome extramédullaire ; C90.3 Plasmocytome solitaire
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C91, C92, C93, C94, C95, C96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C90/C90_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c90.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C90/.

C91 — Leucémie lymphoïde (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C81-C96 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : C91.0 Leucémie lymphoïde aiguë [LLA] ; C91.1 Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B ; C91.3 Leucémie prolymphocytaire à cellules B ; C91.4 Leucémie à tricholeucocytes ; C91.5 Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e))

- au HTLV-1) ; C91.6 Leucémie prolymphocytaire à cellules T ; C91.7 Autres leucémies lymphoïdes ; C91.8 LLA-B à cellules matures de type Burkitt ; C91.9 Leucémie lymphoïde, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C92, C93, C94, C95, C96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C91/C91_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c91.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C91/.

C92 — Leucémie myéloïde (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C81-C96 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : C92.0 Leucémie myéloblastique aiguë [LMA] ; C92.1 Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL positive ; C92.2 Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ABL négative ; C92.3 Sarcome myéloïde ; C92.4 Leucémie promyélocytaire aiguë ; C92.5 Leucémie myélomonocytaire aiguë ; C92.6 Leucémie myéloïde aiguë avec anomalie 11q23 ; C92.7 Autres leucémies myéloïdes ; C92.8 Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie multilinéaire ; C92.9 Leucémie myéloïde, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C93, C94, C95, C96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C92/C92_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c92.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C92/.

C93 — Leucémie monocytaire (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C81-C96 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : C93.0 Leucémie monoblastique/monocytaire aiguë ; C93.1 Leucémie myélomonocytaire chronique ; C93.3 Leucémie myélomonocytaire juvénile ; C93.7 Autres leucémies monocytaires ; C93.9 Leucémie monocytaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C94, C95, C96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/C93/C93_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/c93.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C93/](#).

C94 — Autres leucémies à cellules précisées (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C81-C96 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : C94.0 Polyglobulie primitive aiguë et érythroleucose ; C94.2 Leucémie aiguë à mégacaryocytes ; C94.3 Leucémie à mastocytes ; C94.4 Panmyélose aiguë avec myélofibrose ; C94.6 Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classifiable ; C94.7 Autres leucémies précisées ; C94.8 Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC]
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C95, C96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/C94/C94_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/c94.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C94/](#).

C95 — Leucémie à cellules non précisées (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C81-C96 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : C95.0 Leucémie aiguë à cellules non précisées ; C95.1 Leucémie chronique à cellules non précisées ; C95.7 Autres leucémies à cellules non précisées ; C95.8 Leucémie, réfractaire au traitement d'induction standard ; C95.9 Leucémie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/C95/C95_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/c95.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C95/](#).

C96 — Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C81-C96 · difficulté **très élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : C96.0 Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] ; C96.2 Tumeur maligne à mastocytes ; C96.4 Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires) ; C96.5 Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et unisystémique ; C96.6 Histiocytose unifocale à cellules de Langerhans ; C96.7 Autres tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés ; C96.8 Sarcome histiocytaire ; C96.9 Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C81, C82, C83, C84, C85, C86, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C96/C96_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c96.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/C96/.

D51 — Anémie par carence en vitamine B12 (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D50-D53 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 147 (pallor), 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : D51.0 Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en facteur intrinsèque ; D51.1 Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption sélective de la vitamine B12 avec protéinurie ; D51.2 Carence en transcobalamine II ; D51.3 Autres anémies par carence alimentaire en vitamine B12 ; D51.8 Autres anémies par carence en vitamine B12 ; D51.9 Anémie par carence en vitamine B12, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D50, D52, D53
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D51/D51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D51/.

D52 — Anémie par carence en acide folique (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D50-D53 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 147 (pallor), 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : D52.0 Anémie par carence alimentaire en acide folique ; D52.1 Anémie par carence en acide folique due à des médicaments ; D52.8 Autres anémies par carence en acide folique ; D52.9 Anémie par carence en acide folique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D50, D51, D53
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8.

Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/D52/D52_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d52.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D52/.

D53 — Autres anémies nutritionnelles (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D50-D53 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 147 (pallor), 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : D53.0 Anémie par carence en protéines ; D53.1 Autres anémies mégaloblastiques, non classées ailleurs ; D53.2 Anémie scorbutique ; D53.8 Autres anémies nutritionnelles précisées ; D53.9 Anémie nutritionnelle, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D50, D51, D52
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D53/D53_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D53/.

D55 — Anémie due à des anomalies enzymatiques (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D55-D59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 147 (pallor), 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : D55.0 Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] ; D55.1 Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du glutathion ; D55.2 Anémie due à des anomalies des enzymes glycolytiques ; D55.3 Anémie due à des anomalies du métabolisme des nucléotides ; D55.8 Autres anémies dues à des anomalies enzymatiques ; D55.9 Anémie due à des anomalies enzymatiques, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D56, D57, D58, D59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D55/D55_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d55.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D55/.

D56 — Thalassémie (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D55-D59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 147 (pallor), 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : D56.0 Alpha-thalassémie ; D56.1 Bêta-thalassémie ; D56.2 Delta-bêta-thalassémie ; D56.3 Trait thalassémique ; D56.4 Persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF] ; D56.8 Autres thalassémies ; D56.9 Thalassémie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D55, D57, D58, D59

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D56/D56_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d56.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D56/.

D57 — Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D55-D59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 147 (pallor), 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : D57.0 Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises ; D57.1 Anémie à hématies falciformes sans crises ; D57.2 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes doubles ; D57.3 Trait de la maladie des hématies falciformes [drépanocytaire] ; D57.8 Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires]
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D55, D56, D58, D59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D57/D57_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d57.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D57/.

D58 — Autres anémies hémolytiques héréditaires (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D55-D59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 147 (pallor), 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : D58.0 Sphérocytose héréditaire ; D58.1 Elliptocytose héréditaire ; D58.2 Autres hémoglobinoopathies ; D58.8 Autres anémies hémolytiques héréditaires précisées ; D58.9 Anémie hémolytique héréditaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D55, D56, D57, D59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D58/D58_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d58.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D58/.

D59 — Anémie hémolytique acquise (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D55-D59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 147 (pallor), 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (9)** : D59.0 Anémie hémolytique auto-immune, due à des médicaments ; D59.1 Autres anémies hémolytiques auto-immunes ; D59.2 Anémie hémolytique non auto-immune, due à des médicaments ; D59.3 Syndrome hémolytique urémique ; D59.4 Autres anémies hémolytiques non auto-immunes ; D59.5 Hémoglobinurie nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] ; D59.6 Hémoglobinurie due à une hémolyse relevant d'autres causes externes ; D59.8 Autres anémies hémolytiques acquises ; D59.9 Anémie hémolytique acquise, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D55, D56, D57, D58
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D59/D59_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d59.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D59/.

D60 — Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure [érythroblastopénie] (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D60-D64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 147 (pallor), 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (4)** : D60.0 Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, chronique ; D60.1 Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, transitoire ; D60.8 Autres aplasies médullaires [anémie aplastique] acquises pures ; D60.9 Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D61, D62, D63, D64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D60/D60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D60/.

D61 — Autres anémies aplastiques (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D60-D64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 147 (pallor), 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (6)** : D61.0 Anémies aplastiques constitutionnelle ; D61.1 Anémies aplastiques médicamenteuse ; D61.2 Anémies aplastiques due à d'autres agents externes ; D61.3 Anémies aplastiques idiopathique ; D61.8 Autres anémies aplastiques précisées ; D61.9 Anémies aplastiques, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D60, D62, D63, D64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/D61/D61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D61/.

D62 — Anémie posthémorragique aiguë (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D60-D64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 147 (pallor), 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D60, D61, D63, D64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D62/D62_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D62/.

D63 — Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D60-D64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 147 (pallor), 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (2)** : D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales ; D63.8 Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D60, D61, D62, D64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D63/D63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D63/.

D65 — Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D65-D69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 88 (ecchymosis, haematoma, purpura), 152 (abnormal coagulation profile), 174 (thrombopenia, thrombocytosis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (4)** : D65.0 Afibrinogénémie acquise ; D65.1 Coagulation intravasculaire disséminée ; D65.2 Hémorragie fibrinolytique acquise ; D65.9 Syndrome de défibrination, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D66, D67, D68, D69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/D65/D65_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d65.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D65/.

D66 — Carence héréditaire en facteur VIII (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D65-D69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 88 (ecchymosis, haematoma, purpura), 152 (abnormal coagulation profile), 174 (thrombopenia, thrombocytosis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D65, D67, D68, D69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D66/D66_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d66.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D66/.

D67 — Carence héréditaire en facteur IX (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D65-D69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 88 (ecchymosis, haematoma, purpura), 152 (abnormal coagulation profile), 174 (thrombopenia, thrombocytosis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D65, D66, D68, D69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D67/D67_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d67.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D67/.

D70 — Agranulocytose et neutropénie (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D70-D77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 154 (abnormal leukocyte count), 171 (polycythaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : D70.0 Agranulocytose et neutropénie congénitale ; D70.1 Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament ; D70.3 Autre agranulocytose ; D70.5 Neutropénie cyclique ; D70.6 Autre neutropénie ; D70.7 Neutropénie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D71, D72, D73, D74, D75, D76, D77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D70/D70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D70/.

D71 — Anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D70-D77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 154 (abnormal leukocyte count), 171 (polycythaemia).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D70, D72, D73, D74, D75, D76, D77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D71/D71_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D71/.

D72 — Autres anomalies des leucocytes (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D70-D77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 154 (abnormal leukocyte count), 171 (polycythaemia).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : D72.0 Anomalies génétiques des leucocytes ; D72.1 Eosinophilie ; D72.8 Autres anomalies précisées des leucocytes ; D72.9 Anomalie des leucocytes, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D70, D71, D73, D74, D75, D76, D77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D72/D72_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d72.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D72/.

D73 — Maladies de la rate (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D70-D77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 154 (abnormal leukocyte count), 171 (polycythaemia).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : D73.0 Hyposplénisme ; D73.1 Hypersplénisme ; D73.2 Splénomégalie congestive chronique ; D73.3 Abscès de la rate ; D73.4 Kyste de la rate ; D73.5 Infarctus de la rate ; D73.8 Autres maladies de la rate ; D73.9 Maladie de la rate, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D70, D71, D72, D74, D75, D76, D77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/D73/D73_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d73.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D73/.

D74 — Méthémoglobinémie (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D70-D77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 154 (abnormal leukocyte count), 171 (polycythaemia).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : D74.0 Méthémoglobinémie congénitale ; D74.8 Autres méthémoglobinémies ; D74.9 Méthémoglobinémie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D70, D71, D72, D73, D75, D76, D77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D74/D74_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d74.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D74/.

D75 — Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D70-D77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 154 (abnormal leukocyte count), 171 (polycythaemia).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : D75.0 Érythrocytose familiale ; D75.1 Polycythémie secondaire ; D75.8 Autres maladies précisées du sang et des organes hématopoïétiques ; D75.9 Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D70, D71, D72, D73, D74, D76, D77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D75/D75_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d75.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D75/.

D76 — Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D70-D77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 154 (abnormal leukocyte count), 171 (polycythaemia).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : D76.1 Lymphohistiocytose hémophagocytaire ; D76.2 Syndrome hémophagocytaire associé à une infection ; D76.3 Autres syndromes histiocytaires ; D76.4 Syndrome de libération de cytokines [cytokine release syndrome]
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D70, D71, D72, D73, D74, D75, D77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6.

Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/D76/D76_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d76.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D76/.

D77 — Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques au cours de maladies classées ailleurs (H-08-Hématologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D70-D77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 154 (abnormal leukocyte count), 171 (polycythaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D70, D71, D72, D73, D74, D75, D76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D77/D77_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d77.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/H-08-Hématologie/travail/D77/.

G-10-Gynécologie et sénologie

47 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 9 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : gynécologie suisse (SGGG) ; ESGO, ESHRE.

C50 — Tumeurs malignes du sein (G-10-Gynécologie et sénologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C50-C50 · difficulté **très élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : C50.0 Tumeur maligne: Mamelon et aréole ; C50.1 Tumeur maligne: Partie centrale du sein ; C50.2 Tumeur maligne: Quadrant supéro-interne du sein ; C50.3 Tumeur maligne: Quadrant inféro-interne du sein ; C50.4 Tumeur maligne: Quadrant supéro-externe du sein ; C50.5 Tumeur maligne: Quadrant inféro-externe du sein ; C50.6 Tumeur maligne: Prolongement axillaire du sein ; C50.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du sein ; C50.9 Tumeur maligne: Sein, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C50/C50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/C50/.

N60 — Dysplasies mammaires bénignes (G-10-Gynécologie et sénologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N60-N64 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 42 (changes of breast size, breast lump, breast discharge). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : N60.0 Kyste solitaire du sein ; N60.1 Mastopathie kystique diffuse ; N60.2 Adénofibrose du sein ; N60.3 Fibrosclérose du sein ; N60.4 Ectasie des canaux galactophores ; N60.8 Autres dysplasies mammaires bénignes ; N60.9 Dysplasie mammaire bénigne, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N61, N62, N63, N64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N60/N60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N60/.

N70 — Salpingite et ovarite (G-10-Gynécologie et sénologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N70-N77 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 68 (pelvic pain), 80 (vaginal discharge), 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : N70.0 Salpingite et ovarite aiguës ; N70.1 Salpingite et ovarite chroniques ; N70.9 Salpingite et ovarite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N70/N70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N70/.

N76 — Autres inflammations du vagin et de la vulve (G-10-Gynécologie et sénologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N70-N77 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 68 (pelvic pain), 80 (vaginal discharge), 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : N76.0 Vaginite aiguë ; N76.1 Vaginite subaiguë et chronique ; N76.2 Vulvite aiguë ; N76.3 Vulvite subaiguë et chronique ; N76.4 Abscess de la vulve ; N76.5 Ulcération du vagin ; N76.6 Ulcération de la vulve ; N76.8 Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N77

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/N76/N76_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/n76.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N76/](#).

N80 — Endométriose (G-10-Gynécologie et sénologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : N80.0 Endométriose de l'utérus ; N80.1 Endométriose de l'ovaire ; N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope ; N80.3 Endométriose du péritoine pelvien ; N80.4 Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin ; N80.5 Endométriose de l'intestin ; N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée ; N80.8 Autres endométrioses ; N80.9 Endométriose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/N80/N80_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/n80.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N80/](#).

N81 — Prolapsus génital (G-10-Gynécologie et sénologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : N81.0 Urétrécèle chez la femme ; N81.1 Cystocèle ; N81.2 Prolapsus utéro-vaginal partiel ; N81.3 Prolapsus utéro-vaginal complet ; N81.4 Prolapsus utéro-vaginal, sans précision ; N81.5 Entérocèle vaginale ; N81.6 Rectocèle ; N81.8 Autres prolapsus génitaux ; N81.9 Prolapsus génital, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/N81/N81_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/n81.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N81/](#).

N92 — Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie (G-10-Gynécologie et sénologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : N92.0 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier ; N92.1 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier ; N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté ; N92.3 Saignements de l'ovulation ; N92.4 Saignements abondants de la préménopause ; N92.5 Autres irrégularités menstruelles précisées ; N92.6 Irrégularités menstruelles, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N93, N94, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/N92/N92_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/n92.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N92/](#).

N94 — Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel (G-10-Gynécologie et sénologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : N94.0 Douleurs intermenstruelles ; N94.1 Dyspareunie ; N94.2 Vaginisme ; N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle ; N94.4 Disménorrhée primaire ; N94.5 Disménorrhée secondaire ; N94.6 Disménorrhée, sans précision ; N94.8 Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel ; N94.9 Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/N94/N94_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n94.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N94/.

N95 — Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause (G-10-Gynécologie et sénologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : N95.0 Saignements post-ménopausiques ; N95.1 Troubles de la ménopause et du climatère féminin ; N95.2 Vaginite atrophique post-ménopausique ; N95.3 Troubles au cours d'une ménopause artificielle ; N95.8 Autres troubles précisés de la ménopause et de la périménopause ; N95.9 Trouble de la ménopause et de la périménopause, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N95/N95_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n95.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N95/.

C51 — Tumeur maligne de la vulve (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C51-C58 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : C51.0 Tumeur maligne: Grande lèvre ; C51.1 Tumeur maligne: Petite lèvre ; C51.2 Tumeur maligne: Clitoris ; C51.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vulve ; C51.9 Tumeur maligne: Vulve, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C51/C51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/C51/.

C52 — Tumeur maligne du vagin (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C51-C58 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance

pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C51, C53, C54, C55, C56, C57, C58
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C52/C52_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c52.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/C52/.

C53 — Tumeur maligne du col de l'utérus (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C51-C58 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : C53.0 Tumeur maligne: Endocol ; C53.1 Tumeur maligne: Exocol ; C53.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du col de l'utérus ; C53.9 Tumeur maligne: Col de l'utérus, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C51, C52, C54, C55, C56, C57, C58
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C53/C53_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/C53/.

C54 — Tumeur maligne du corps de l'utérus (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C51-C58 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : C54.0 Tumeur maligne: Isthme de l'utérus ; C54.1 Tumeur maligne: Endomètre ; C54.2 Tumeur maligne: Myomètre ; C54.3 Tumeur maligne: Fond de l'utérus ; C54.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du corps de l'utérus ; C54.9 Tumeur maligne: Corps de l'utérus, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C51, C52, C53, C55, C56, C57, C58
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C54/C54_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c54.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/C54/.

C55 — Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C51-C58 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C51, C52, C53, C54, C56, C57, C58
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C55/C55_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c55.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/C55/.

C56 — Tumeur maligne de l'ovaire (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C51-C58 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C51, C52, C53, C54, C55, C57, C58
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C56/C56_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c56.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/C56/.

C57 — Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C51-C58 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : C57.0 Tumeur maligne: Trompe de Fallope ; C57.1 Tumeur maligne: Ligament large ; C57.2 Tumeur maligne: Ligament rond ; C57.3 Tumeur maligne: Paramètre ; C57.4 Tumeur maligne: Annexes de l'utérus, sans précision ; C57.7 Tumeur maligne: Autres organes génitaux de la femme précisés ; C57.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la femme ; C57.9 Tumeur maligne: Organe génital de la femme, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C51, C52, C53, C54, C55, C56, C58
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage

organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/C57/C57_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c57.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/C57/.

C58 — Tumeur maligne du placenta (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C51-C58 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C58/C58_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c58.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/C58/.

N61 — Affections inflammatoires du sein (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N60-N64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 42 (changes of breast size, breast lump, breast discharge). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N60, N62, N63, N64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N61/N61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N61/.

N62 — Hypertrophie mammaire (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N60-N64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 42 (changes of breast size, breast lump, breast discharge). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N60, N61, N63, N64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/N62/N62_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N62/.

N63 — Tuméfaction mammaire, sans précision (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N60-N64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 42 (changes of breast size, breast lump, breast discharge). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N60, N61, N62, N64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N63/N63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N63/.

N64 — Autres affections du sein (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N60-N64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 42 (changes of breast size, breast lump, breast discharge). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : N64.0 Fissure et fistule du mamelon ; N64.1 Cystostéatonecrose du sein ; N64.2 Atrophie mammaire ; N64.3 Galactorrhée sans relation avec un accouchement ; N64.4 Mastodynie ; N64.5 Autres signes et symptômes observés au niveau du sein ; N64.8 Autres affections précisées du sein ; N64.9 Affection du sein, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N60, N61, N62, N63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N64/N64_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n64.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N64/.

N71 — Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N70-N77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 68 (pelvic pain), 80 (vaginal discharge), 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : N71.0 Affection inflammatoire aiguë de l'utérus, à l'exclusion du col ; N71.1 Affection inflammatoire chronique de l'utérus, à l'exclusion du col ; N71.9 Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision, à l'exclusion du col
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N70, N72, N73, N74, N75, N76, N77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/N71/N71_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N71/.

N72 — Affections inflammatoires du col de l'utérus (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N70-N77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 68 (pelvic pain), 80 (vaginal discharge), 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N70, N71, N73, N74, N75, N76, N77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N72/N72_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n72.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N72/.

N73 — Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N70-N77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 68 (pelvic pain), 80 (vaginal discharge), 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : N73.0 Paramétrite et phlegmon pelvien aigu ; N73.1 Paramétrite et phlegmon pelvien chroniques ; N73.2 Paramétrite et phlegmon pelvien, sans précision ; N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme ; N73.4 Pelvipéritonite chronique chez la femme ; N73.5 Pelvipéritonite chez la femme, sans précision ; N73.6 Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme ; N73.8 Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme ; N73.9 Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N70, N71, N72, N74, N75, N76, N77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N73/N73_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n73.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N73/.

N74 — Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N70-N77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 68 (pelvic pain), 80 (vaginal discharge), 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (6)** : N74.0 Tuberculose du col de l'utérus ; N74.1 Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme ; N74.2 Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme ; N74.3 Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme ; N74.4 Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia de la femme ; N74.8 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N70, N71, N72, N73, N75, N76, N77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N74/N74_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n74.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N74/.

N75 — Affection de la glande de Bartholin (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N70-N77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 68 (pelvic pain), 80 (vaginal discharge), 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (4)** : N75.0 Kyste de la glande de Bartholin ; N75.1 Abscess de la glande de Bartholin ; N75.8 Autres affections de la glande de Bartholin ; N75.9 Affection de la glande de Bartholin, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N70, N71, N72, N73, N74, N76, N77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N75/N75_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n75.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N75/.

N77 — Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N70-N77 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 68 (pelvic pain), 80 (vaginal discharge), 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (4)** : N77.0 Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; N77.1 Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; N77.2 Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ; N77.8 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/N77/N77_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/n77.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N77/](#).

N82 — Fistules de l'appareil génital de la femme (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : N82.0 Fistule vésico-vaginale ; N82.1 Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme ; N82.2 Fistule du vagin à l'intestin grêle ; N82.3 Fistule du vagin au côlon ; N82.4 Autres fistules intestino-génitales chez la femme ; N82.5 Fistule génito-cutanée chez la femme ; N82.8 Autres fistules de l'appareil génital de la femme ; N82.9 Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/N82/N82_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/n82.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N82/](#).

N83 — Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : N83.0 Kyste folliculaire de l'ovaire ; N83.1 Kyste du corps jaune ; N83.2 Kystes de l'ovaire, autres et sans précision ; N83.3 Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope ; N83.4 Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope ; N83.5 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope ; N83.6 Hématosalpinx ; N83.7 Hématome du ligament large ; N83.8 Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large ; N83.9 Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/N83/N83_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/n83.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N83/](#).

N84 — Polype de l'appareil génital de la femme (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : N84.0 Polype du corps de l'utérus ; N84.1 Polype du col de l'utérus ; N84.2 Polype du vagin ; N84.3 Polype de la vulve ; N84.8 Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme ; N84.9 Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N84/N84_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n84.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N84/.

N85 — Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : N85.0 Hyperplasie glandulaire de l'endomètre ; N85.1 Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre ; N85.2 Hypertrophie de l'utérus ; N85.3 Subinvolution de l'utérus ; N85.4 Malposition de l'utérus ; N85.5 Inversion de l'utérus ; N85.6 Synéchie utérine ; N85.7 Hématométrie ; N85.8 Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus ; N85.9 Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N84, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N85/N85_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n85.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N85/.

N86 — Érosion et ectropion du col de l'utérus (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79

(vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N84, N85, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N86/N86_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n86.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N86/.

N87 — Dysplasie du col de l'utérus (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : N87.0 Dysplasie légère du col de l'utérus ; N87.1 Dysplasie moyenne du col de l'utérus ; N87.2 Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs ; N87.9 Dysplasie du col de l'utérus, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N87/N87_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n87.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N87/.

N88 — Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : N88.0 Leucoplasie du col de l'utérus ; N88.1 Déchirure ancienne du col de l'utérus ; N88.2 Rétrécissement et sténose du col de l'utérus ; N88.3 Béance du col de l'utérus ; N88.4 Allongement hypertrophique du col de l'utérus ; N88.8 Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus ; N88.9 Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8.

Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/N88/N88_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n88.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N88/.

N89 — Autres affections non inflammatoires du vagin (G-10-Gynécologie et sénologie) - P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : N89.0 Dysplasie légère du vagin ; N89.1 Dysplasie moyenne du vagin ; N89.2 Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs ; N89.3 Dysplasie du vagin, sans précision ; N89.4 Leucoplasie du vagin ; N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin ; N89.6 Anneau hyménal serré ; N89.7 Hématocolpos ; N89.8 Autres affections non inflammatoires précisées du vagin ; N89.9 Affection non inflammatoire du vagin, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N89/N89_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n89.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N89/.

N90 — Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée (G-10-Gynécologie et sénologie) - P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : N90.0 Dysplasie légère de la vulve ; N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve ; N90.2 Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs ; N90.3 Dysplasie de la vulve, sans précision ; N90.4 Leucoplasie de la vulve ; N90.5 Atrophie de la vulve ; N90.6 Hypertrophie de la vulve ; N90.7 Kyste de la vulve ; N90.8 Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée ; N90.9 Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/N90/N90_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n90.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N90/.

N91 — Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : N91.0 Aménorrhée primaire ; N91.1 Aménorrhée secondaire ; N91.2 Aménorrhée, sans précision ; N91.3 Oligoménorrhée primaire ; N91.4 Oligoménorrhée secondaire ; N91.5 Oligoménorrhée, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N92, N93, N94, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N91/N91_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n91.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N91/.

N93 — Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : N93.0 Saignements post-coïtaux et de contact ; N93.8 Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin ; N93.9 Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N94, N95, N96, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N93/N93_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n93.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N93/.

N96 — Avortements à répétition (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N97, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N96/N96_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n96.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N96/.

N97 — Stérilité de la femme (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : N97.0 Stérilité associée à une anovulation ; N97.1 Stérilité d'origine tubaire ; N97.2 Stérilité d'origine utérine ; N97.3 Stérilité d'origine cervicale ; N97.4 Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme ; N97.8 Stérilité de la femme d'autres origines ; N97.9 Stérilité de la femme, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N97/N97_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n97.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N97/.

N98 — Complications de la fécondation artificielle (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N80-N98 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation), 66 (menstrual symptoms: disorders of menstruation, painful menstruation,), 67 (pelvic mass), 68 (pelvic pain), 74 (symptoms related to menopause), 78 (uterine prolapse, pelvic relaxation), 79 (vaginal bleeding). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : N98.0 Infection associée à l'insémination artificielle ; N98.1 Hyperstimulation des ovaires ; N98.2 Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après fécondation in vitro ; N98.3 Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d'embryon ; N98.8 Autres complications de la fécondation artificielle ; N98.9 Complication de la fécondation artificielle, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N91, N92, N93, N94, N95, N96, N97
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N98/N98_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n98.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/N98/.

Q50 — Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q50-Q56 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : Q50.0 Absence congénitale d'ovaire(s) ; Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement ; Q50.2 Torsion congénitale de l'ovaire ; Q50.3 Autres malformations congénitales de l'ovaire ; Q50.4 Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope ; Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large ; Q50.6 Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q51, Q52
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q50/Q50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/Q50/.

Q51 — Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q50-Q56 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Q51.0 Agénésie et aplasie de l'utérus ; Q51.1 Utérus double avec duplication du col et du vagin ; Q51.2 Autres duplications de l'utérus ; Q51.3 Utérus bicorne ; Q51.4 Utérus unicorne ; Q51.5 Agénésie et aplasie du col de l'utérus ; Q51.6 Kyste embryonnaire du col de l'utérus ; Q51.7 Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire ; Q51.8 Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus ; Q51.9 Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q50, Q52
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14.

Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Q51/Q51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/Q51/.

Q52 — Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q50-Q56 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Q52.0 Absence congénitale de vagin ; Q52.1 Dédoublage du vagin ; Q52.2 Fistule recto-vaginale congénitale ; Q52.3 Imperforation de l'hymen ; Q52.4 Autres malformations congénitales du vagin ; Q52.5 Fusion de la vulve ; Q52.6 Malformation congénitale du clitoris ; Q52.7 Autres malformations congénitales de la vulve ; Q52.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme ; Q52.9 Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q50, Q51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q52/Q52_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q52.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/Q52/.

Q83 — Malformations congénitales du sein (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q80-Q89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : Q83.0 Absence congénitale de sein avec absence de mamelon ; Q83.1 Sein surnuméraire ; Q83.2 Absence de mamelon (congénitale) ; Q83.3 Mamelon accessoire ; Q83.8 Autres malformations congénitales du sein ; Q83.9 Malformation congénitale du sein, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q83/Q83_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q83.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/Q83/.

Z30 — Prise en charge d'une contraception (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z30-Z39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 69 (request for contraception, emergency contraception). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de

l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : Z30.0 Conseils et avis généraux concernant la contraception ; Z30.1 Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) ; Z30.2 Stérilisation ; Z30.3 Extraction cataméniale ; Z30.4 Surveillance de contraceptifs ; Z30.5 Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) ; Z30.8 Autres prises en charge d'une contraception ; Z30.9 Prise en charge d'une contraception, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z30/Z30_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/Z30/.

Z31 — Mesures procréatives (G-10-Gynécologie et sénologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z30-Z39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 65 (issues related to conception, e.g. infertility and sterilisation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Z31.0 Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation ; Z31.1 Insémination artificielle ; Z31.2 Fécondation in vitro ; Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée ; Z31.4 Recherches et tests en vue d'une procréation ; Z31.5 Conseil génétique ; Z31.6 Conseils et avis généraux en matière de procréation ; Z31.8 Autres mesures procréatives ; Z31.9 Mesure procréative, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z30
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z31/Z31_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z31.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/G-10-Gynécologie et sénologie/travail/Z31/.

M-12-Médecine des âges de la vie

3 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 1 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : Pédiatrie suisse, Société professionnelle suisse de gériatrie ; EuGMS.

R54 — Sénilité (M-12-Médecine des âges de la vie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 197 (functional impairment (cognition, sensory and motor)), 201 (progressively dependent patient). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi

→ 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/R54/R54_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r54.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-12-Médecine des âges de la vie/travail/R54/.

Z54 — Convalescence (M-12-Médecine des âges de la vie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z40-Z54 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 197 (functional impairment (cognition, sensory and motor)), 201 (progressively dependent patient). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : Z54.0 Convalescence après intervention chirurgicale ; Z54.1 Convalescence après radiothérapie ; Z54.2 Convalescence après chimiothérapie ; Z54.3 Convalescence après psychothérapie ; Z54.4 Convalescence après traitement d'une fracture ; Z54.7 Convalescence après traitements combinés ; Z54.8 Convalescence après un autre traitement ; Z54.9 Convalescence après un traitement non précisé
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z54/Z54_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z54.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-12-Médecine des âges de la vie/travail/Z54/.

Z74 — Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins (M-12-Médecine des âges de la vie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z70-Z76 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 197 (functional impairment (cognition, sensory and motor)), 201 (progressively dependent patient). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : Z74.0 Difficultés liées à: dépendance due à une mobilité restreinte ; Z74.1 Difficultés liées à: besoin d'assistance et de soins d'hygiène ; Z74.2 Difficultés liées à: besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ; Z74.3 Difficultés liées à: Besoin d'une surveillance permanente ; Z74.8 Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins ; Z74.9 Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z74/Z74_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z74.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-12-Médecine des âges de la vie/travail/Z74/.

R-14-Rhumatologie et orthopédie

101 leçons « Examen fédéral » ; 1 rédigées ; 16 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : Société suisse de rhumatologie, Swiss Orthopaedics ; EULAR.

M10 — Goutte (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XIII** · bloc M05-M14 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : M10.0 Goutte idiopathique ; M10.1 Goutte saturnine ; M10.2 Goutte médicamenteuse ; M10.3 Goutte due à une altération de la fonction rénale ; M10.4 Autre goutte secondaire ; M10.9 Goutte, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M06, M07, M08, M09, M11, M12, M13, M14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M10/M10_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M10/.

M15 — Polyarthrose (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M15-M19 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée ; M15.1 Nodosités d'Heberden (avec arthropathie) ; M15.2 Nodosités de Bouchard (avec arthropathie) ; M15.3 Arthrose secondaire multiple ; M15.4 (Ostéo)arthrose érosive ; M15.8 Autres polyarthroses ; M15.9 Polyarthrose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M16, M17, M18, M19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M15/M15_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m15.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M15/.

M16 — Coxarthrose [arthrose de la hanche] (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M15-M19 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : M16.0 Coxarthrose primaire, bilatérale ; M16.1 Autres coxarthroses primaires ; M16.2 Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale ; M16.3 Autres coxarthroses dysplasiques ; M16.4 Coxarthrose post-traumatique, bilatérale ; M16.5 Autres coxarthroses post-traumatiques ; M16.6 Autres coxarthroses secondaires, bilatérales ; M16.7 Autres coxarthroses secondaires ; M16.9 Coxarthrose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M15, M17, M18, M19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6.

Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/M16/M16_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m16.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M16/.

M17 — Gonarthrose [arthrose du genou] (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M15-M19 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M17.0 Gonarthrose primaire, bilatérale ; M17.1 Autres gonarthroses primaires ; M17.2 Gonarthrose post-traumatique, bilatérale ; M17.3 Autres gonarthroses post-traumatiques ; M17.4 Autres gonarthroses secondaires, bilatérales ; M17.5 Autres gonarthroses secondaires ; M17.9 Gonarthrose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M15, M16, M18, M19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M17/M17_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m17.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M17/.

M19 — Autres arthroses (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M15-M19 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : M19.0 Arthrose primaire d'autres articulations ; M19.1 Arthrose post-traumatique d'autres articulations ; M19.2 Autres arthroses secondaires ; M19.8 Autres arthroses précisées ; M19.9 Arthrose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M15, M16, M17, M18
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M19/M19_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m19.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M19/.

M25 — Autres affections articulaires, non classées ailleurs (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M20-M25 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)

- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : M25.0 Hémarthrose ; M25.1 Fistule articulaire ; M25.2 Hyperlaxité articulaire ; M25.3 Autres instabilités articulaires ; M25.4 Épanchement articulaire ; M25.5 Douleur articulaire ; M25.6 Raideur articulaire, non classée ailleurs ; M25.7 Ostéophyte ; M25.8 Autres affections articulaires précisées ; M25.9 Affection articulaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M20, M21, M22, M23, M24
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M25/M25_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m25.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M25/.

M54 — Dorsalgies (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M50-M54 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 81 (abnormal posture and back deformities), 82 (back pain), 83 (deformities of skeleton and joints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : M54.0 Panniculite affectant le cou et le dos ; M54.1 Radiculopathie ; M54.2 Cervicalgie ; M54.3 Sciatique ; M54.4 Lumbago avec sciatique ; M54.5 Lombalgie basse ; M54.6 Rachialgies dorsales ; M54.8 Autres dorsalgies ; M54.9 Dorsalgie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M50, M51, M53
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M54/M54_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m54.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M54/.

M65 — Synovite et ténosynovite (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M65-M68 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M65.0 Abscess of the tendon ; M65.1 Autres (téno)synovites infectieuses ; M65.2 Tendinite calcifiante ; M65.3 Doigt «à ressort» ; M65.4 Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain] ; M65.8 Autres synovites et ténosynovites ; M65.9 Synovite et ténosynovite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M66, M67, M68
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/M65/M65_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m65.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M65/.

M75 — Lésions de l'épaule (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M70-M79 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : M75.0 Capsulite rétractile de l'épaule ; M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs ; M75.2 Tendinite du muscle biceps brachial ; M75.3 Tendinite calcifiante de l'épaule ; M75.4 Syndrome d'empiètement de l'épaule ; M75.5 Bursite de l'épaule ; M75.6 Lésion du labrum dans l'atteinte dégénérative de l'articulation de l'épaule ; M75.8 Autres lésions de l'épaule ; M75.9 Lésion de l'épaule, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M70, M71, M72, M73, M76, M77, M79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M75/M75_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m75.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M75/.

M81 — Ostéoporose sans fracture pathologique (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M80-M85 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 169 (low bone density). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : M81.0 Ostéoporose post-ménopausique ; M81.1 Ostéoporose après ovariectomie ; M81.2 Ostéoporose d'inactivité ; M81.3 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale ; M81.4 Ostéoporose médicamenteuse ; M81.5 Ostéoporose idiopathique ; M81.6 Ostéoporose localisée [Lequesne] ; M81.8 Autres ostéoporoses ; M81.9 Ostéoporose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M80, M82, M83, M84, M85
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M81/M81_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m81.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M81/.

S52 — Fracture de l'avant-bras (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S50-S59 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)

- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : S52.0 Fracture de la partie supérieure du cubitus ; S52.1 Fracture de l'extrémité supérieure du radius ; S52.2 Fracture de la diaphyse du cubitus ; S52.3 Fracture de la diaphyse du radius ; S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale ; S52.5 Fracture de l'extrémité inférieure du radius ; S52.6 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius, combinée ; S52.7 Fractures multiples de l'avant-bras ; S52.8 Fracture d'autres parties de l'avant-bras ; S52.9 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S53, S56
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S52/S52_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s52.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S52/.

S62 — Fracture au niveau du poignet et de la main (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S60-S69 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : S62.0 Fracture de l'os scaphoïde de la main ; S62.1 Fracture d'autre(s) os du carpe ; S62.2 Fracture du premier métacarpien ; S62.3 Fracture d'un autre os du métacarpe ; S62.4 Fractures multiples des métacarpiens ; S62.5 Fracture du pouce ; S62.6 Fracture d'un autre doigt ; S62.7 Fractures multiples de doigts ; S62.8 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S63, S66
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S62/S62_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S62/.

S72 — Fracture du fémur (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S70-S79 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : S72.0 Fracture du col du fémur ; S72.1 Fracture du trochanter ; S72.2 Fracture sous-trochantérienne ; S72.3 Fracture de la diaphyse fémorale ; S72.4 Fracture de l'extrémité inférieure du fémur ; S72.7 Fractures multiples du fémur ; S72.8 Fracture d'autres parties du fémur ; S72.9 Fracture du fémur, partie non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S73, S76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et

bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/S72/S72_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s72.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S72/.

S82 — Fracture de la jambe, y compris la cheville (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S80-S89 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : S82.0 Fracture de la rotule ; S82.1 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia ; S82.2 Fracture de la diaphyse du tibia ; S82.3 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia ; S82.4 Fracture du péroné seul ; S82.5 Fracture de la malléole interne ; S82.6 Fracture de la malléole externe ; S82.7 Fractures multiples de la jambe ; S82.8 Fractures d'autres parties de la jambe ; S82.9 Fracture de la jambe, partie non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S83, S86
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S82/S82_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s82.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S82/.

S92 — Fracture du pied, sauf la cheville (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S90-S99 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : S92.0 Fracture du calcanéum ; S92.1 Fracture de l'astragale ; S92.2 Fracture d'autres os du tarse ; S92.3 Fracture d'os du métatarse ; S92.4 Fracture du gros orteil ; S92.5 Fracture d'un autre orteil ; S92.7 Fractures multiples du pied ; S92.9 Fracture du pied, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S93, S96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S92/S92_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s92.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S92/.

S93 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S90-S99 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)

- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : S93.0 Luxation de la cheville ; S93.1 Luxation d'un (des) orteil(s) ; S93.2 Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied ; S93.3 Luxation de parties autres et non précisées du pied ; S93.4 Entorse et foulure de la cheville ; S93.5 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s) ; S93.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S92, S96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S93/S93_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s93.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S93/.

C40 — Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C40-C41 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : C40.0 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: Omoplate et os longs du membre supérieur ; C40.1 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: Os courts du membre supérieur ; C40.2 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: Os longs du membre inférieur ; C40.3 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: Os courts du membre inférieur ; C40.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire des membres ; C40.9 Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire d'un membre, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C41
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C40/C40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/C40/.

C41 — Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C40-C41 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : C41.0 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: Os du crâne et de la face ; C41.1 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: Mandibule ; C41.2 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: Rachis ; C41.3 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire: Côtes, sternum et clavicule ; C41.4 Tumeur maligne des os et du cartilage

articulaire: Pelvis ; C41.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage articulaire ; C41.9 Tumeur maligne: Os et cartilage articulaire, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : C40**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C41/C41_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c41.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/C41/.

M00 — Arthrites à bactéries pyogènes (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M00-M03 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : M00.0 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques ; M00.1 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques ; M00.2 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques ; M00.8 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées ; M00.9 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : M01, M02, M03**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M00/M00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M00/.

M01 — Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M00-M03 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : M01.0 Arthrite méningococcique ; M01.1 Arthrite tuberculeuse ; M01.2 Arthrite au cours de la maladie de Lyme ; M01.3 Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs ; M01.4 Arthrite au cours de la rubéole ; M01.5 Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs ; M01.6 Arthrite au cours de mycoses ; M01.8 Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : M00, M02, M03**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M01/M01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M01/.

M02 — Arthrites réactionnelles (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M00-M03 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : M02.0 Arthrite après dérivation intestinale ; M02.1 Arthrite post-dysentérique ; M02.2 Arthrite post-vaccinale ; M02.3 Syndrome oculo-urétéro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter] ; M02.8 Autres arthrites réactionnelles ; M02.9 Arthrite réactionnelle, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M00, M01, M03
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M02/M02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M02/.

M03 — Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M00-M03 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : M03.0 Arthrite post-méningococcique ; M03.1 Arthrite syphilitique post-infectieuse ; M03.2 Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs ; M03.6 Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M00, M01, M02
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M03/M03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M03/.

M07 — Arthrites psoriasiques et entéropathiques (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M05-M14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M07.0 Arthrite psoriasique distale interphalangienne ; M07.1 Arthrite mutilante ; M07.2 Spondylite psoriasique ; M07.3 Autres arthrites psoriasiques ; M07.4 Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] ; M07.5 Arthrite au cours de colite ulcéreuse ; M07.6 Autres arthrites entéropathiques
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M06, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6.

Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/M07/M07_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m07.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M07/.

M08 — Arthrites juvéniles (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M05-M14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : M08.0 Polyarthrite chronique juvénile, type adulte ; M08.1 Spondylarthrite ankylosante juvénile ; M08.2 Arthrite chronique juvénile avec début systémique ; M08.3 Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme polyarticulaire ; M08.4 Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- articulaire ; M08.7 Vasculite au cours d'arthrite juvénile ; M08.8 Autres arthrites juvéniles ; M08.9 Arthrite juvénile, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M06, M07, M09, M10, M11, M12, M13, M14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M08/M08_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m08.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M08/.

M09 — Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M05-M14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : M09.0 Arthrite juvénile au cours de psoriasis ; M09.1 Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] ; M09.2 Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse ; M09.8 Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M06, M07, M08, M10, M11, M12, M13, M14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M09/M09_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m09.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M09/.

M11 — Autres arthropathies dues à des microcristaux (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M05-M14 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : M11.0 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite ; M11.1 Chondrocalcinose familiale ; M11.2 Autre chondrocalcinose ; M11.8 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés ; M11.9 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M06, M07, M08, M09, M10, M12, M13, M14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M11/M11_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m11.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M11/.

M12 — Autres arthropathies spécifiques (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M05-M14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M12.0 Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud] ; M12.1 Maladie de Kaschin-Beck ; M12.2 Synovite villonodulaire (pigmentaire) ; M12.3 Rhumatisme palindromique ; M12.4 Hydarthrose intermittente ; M12.5 Arthropathie traumatique ; M12.8 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M12/M12_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m12.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M12/.

M13 — Autres arthrites (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M05-M14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : M13.0 Polyarthrite, sans précision ; M13.1 Monoarthrite, non classée ailleurs ; M13.8 Autres arthrites précisées ; M13.9 Arthrite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M13/M13_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m13.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M13/.

M14 — Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M05-M14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : M14.0 Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires ; M14.1 Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs ; M14.2 Arthropathie diabétique ; M14.3 Dermato-arthrite lipoïde ; M14.4 Arthropathie au cours d'amylose ; M14.5 Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ; M14.6 Arthropathie neuropathique ; M14.8 Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M14/M14_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m14.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M14/.

M18 — Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M15-M19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M18.0 Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale ; M18.1 Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne ; M18.2 Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale ; M18.3 Autres arthroses post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne ; M18.4 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale ; M18.5 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne ; M18.9 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M15, M16, M17, M19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M18/M18_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m18.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M18/.

M20 — Déformations acquises des doigts et des orteils (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M20-M25 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M20.0 Déformation de(s) doigt(s) ; M20.1 Hallux valgus (acquis) ; M20.2 Hallux rigidus ; M20.3 Autres déformations (acquises) du gros orteil ; M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis) ; M20.5 Autres déformations (acquises) d'(es) orteil(s) ; M20.6 Déformation acquise(s) d'(es) orteil(s), sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M21, M22, M23, M24, M25
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M20/M20_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m20.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M20/.

M21 — Autres déformations acquises des membres (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M20-M25 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : M21.0 Déformation en valgus, non classée ailleurs ; M21.1 Déformation en varus, non classée ailleurs ; M21.2 Déformation en flexion ; M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis) ; M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis) ; M21.5 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e) ; M21.6 Autres déformations acquises de la cheville et du pied ; M21.7 Inégalité des membres (acquise) ; M21.8 Autres déformations précisées des membres ; M21.9 Déformation acquise d'un membre, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M20, M22, M23, M24, M25
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M21/M21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M21/.

M22 — Lésion de la rotule (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M20-M25 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M22.0 Luxation récidivante de la rotule ; M22.1 Subluxation récidivante de la rotule ; M22.2 Maladies fémoro-patellaires ; M22.3 Autres lésions de la rotule ; M22.4 Rotule chondromalacique ; M22.8 Autres maladies de la rotule ; M22.9 Maladie de la rotule, sans autre précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M20, M21, M23, M24, M25
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/M22/M22_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m22.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M22/.

M23 — Lésion interne du genou (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M20-M25 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : M23.0 Kyste du ménisque ; M23.1 Ménisque discoïde (congénital) ; M23.2 Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien ; M23.3 Autres atteintes du ménisque ; M23.4 Souris intra-articulaire du genou ; M23.5 Instabilité chronique du genou ; M23.6 Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou ; M23.8 Autres lésions internes du genou ; M23.9 Lésion interne du genou, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M20, M21, M22, M24, M25
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M23/M23_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m23.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M23/.

M24 — Autres affections articulaires spécifiques (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M20-M25 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : M24.0 Souris intra-articulaire ; M24.1 Autres atteintes du cartilage articulaire ; M24.2 Lésion ligamentaire ; M24.3 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs ; M24.4 Luxation et subluxation articulaires récidivantes ; M24.5 Raideur articulaire par contracture ; M24.6 Ankylose articulaire ; M24.7 Protrusion acétabulaire ; M24.8 Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs ; M24.9 Affection articulaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M20, M21, M22, M23, M25
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M24/M24_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m24.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M24/.

M33 — Dermato-polymyosite (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M30-M36 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility), 168 (elevated biomarkers of inflammation). Correspondance pédagogique, non officielle :

chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : M33.0 Dermatomyosite juvénile ; M33.1 Autres dermatomyosites ; M33.2 Polymyosite ; M33.9 Dermato-polymyosite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M34, M35, M36
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M33/M33_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m33.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M33/.

M34 — Sclérose systémique (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M30-M36 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility), 168 (elevated biomarkers of inflammation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : M34.0 Sclérose systémique progressive ; M34.1 Syndrome CR(E)ST ; M34.2 Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques ; M34.8 Autres formes de sclérose systémique ; M34.9 Sclérose systémique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M33, M35, M36
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M34/M34_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m34.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M34/.

M35 — Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M30-M36 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility), 168 (elevated biomarkers of inflammation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : M35.0 Syndrome de Gougerot-Sjögren ; M35.1 Autres formes de passage ; M35.2 Syndrome de Behçet ; M35.3 Polymyalgie rhumatismale ; M35.4 Fasciite disséminée (à éosinophiles) ; M35.5 Fibrosclérose multiple ; M35.6 Panniculite récidivante [Weber-Christian] ; M35.7 Syndrome d'hypermobilité ; M35.8 Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif ; M35.9 Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M33, M34, M36
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M35/M35_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M35/.

M36 — Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M30-M36 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility), 168 (elevated biomarkers of inflammation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M36.0 Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales ; M36.1 Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs ; M36.2 Arthropathie hémophilique ; M36.3 Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs ; M36.4 Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs ; M36.5 Atteinte du tissu conjonctif dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ; M36.8 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M33, M34, M35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M36/M36_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m36.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M36/.

M40 — Cyphose et lordose (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M40-M43 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 81 (abnormal posture and back deformities), 82 (back pain), 83 (deformities of skeleton and joints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : M40.0 Cyphose posturale ; M40.1 Autres cyphoses secondaires ; M40.2 Cyphoses autres et non précisées ; M40.3 Syndrome du dos plat ; M40.4 Autres lordoses ; M40.5 Lordose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M41, M42, M43
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M40/M40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M40/.

M41 — Scoliose (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M40-M43 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 81 (abnormal posture and back deformities), 82 (back pain), 83 (deformities of skeleton and joints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : M41.0 Scoliose idiopathique infantile ; M41.1 Scoliose juvénile idiopathique ; M41.2 Autres scolioses idiopathiques ; M41.3 Scoliose par anomalie dorsale ; M41.4 Scoliose neuromusculaire ; M41.5 Autres formes de scoliose secondaire ; M41.8 Autres formes de scoliose ; M41.9 Scoliose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M40, M42, M43

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M41/M41_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m41.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M41/.

M42 — Ostéochondrite vertébrale (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M40-M43 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 81 (abnormal posture and back deformities), 82 (back pain), 83 (deformities of skeleton and joints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : M42.0 Ostéochondrite vertébrale juvénile ; M42.1 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte ; M42.9 Ostéochondrite vertébrale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M40, M41, M43
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M42/M42_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m42.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M42/.

M43 — Autres dorsopathies avec déformation (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M40-M43 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 81 (abnormal posture and back deformities), 82 (back pain), 83 (deformities of skeleton and joints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : M43.0 Spondylolyse ; M43.1 Spondylolisthésis ; M43.2 Autres soudures vertébrales ; M43.3 Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec myélopathie ; M43.4 Autres subluxations atloïdo-axoïdiennes récidivantes ; M43.5 Autres subluxations vertébrales récidivantes ; M43.6 Torticolis ; M43.8 Autres dorsopathies avec déformation précisées ; M43.9 Dorsopathie avec déformation, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M40, M41, M42
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M43/M43_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m43.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M43/.

M45 — Spondylarthrite ankylosante (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M45-M49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 81 (abnormal posture and back deformities), 82 (back pain), 83 (deformities of skeleton and joints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se

retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (1) : M45.0 Spondylite ankylosante
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M46, M47, M48, M49
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M45/M45_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m45.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M45/.

M46 — Autres spondylopathies inflammatoires (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M45-M49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 81 (abnormal posture and back deformities), 82 (back pain), 83 (deformities of skeleton and joints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : M46.0 Enthésopathie spinale ; M46.1 Sacro-iliéite, non classée ailleurs ; M46.2 Ostéomyélite vertébrale ; M46.3 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral ; M46.4 Discite, sans précision ; M46.5 Autres spondylopathies infectieuses ; M46.8 Autres spondylopathies inflammatoires précisées ; M46.9 Spondylopathie inflammatoire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M45, M47, M48, M49
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M46/M46_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m46.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M46/.

M47 — Spondylarthrose (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M45-M49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 81 (abnormal posture and back deformities), 82 (back pain), 83 (deformities of skeleton and joints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : M47.0 Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure ; M47.1 Autres spondylarthroses avec myélopathie ; M47.2 Autres spondylarthroses avec radiculopathie ; M47.8 Autres spondylarthroses ; M47.9 Spondylarthrose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M45, M46, M48, M49
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M47/M47_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m47.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M47/.

M48 — Autres spondylopathies (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M45-M49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 81 (abnormal posture and back deformities), 82 (back pain), 83 (deformities of skeleton and joints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : M48.0 Rétrécissement du canal médullaire ; M48.1 Hyperostose ankylosante [Forestier] ; M48.2 Arthrose interépineuse [Maladie de Bastrup] ; M48.3 Spondylopathie traumatique ; M48.4 Fracture vertébrale de fatigue ; M48.5 Tassement vertébral, non classé ailleurs ; M48.8 Autres spondylopathies précisées ; M48.9 Spondylopathie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M45, M46, M47, M49
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M48/M48_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m48.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M48/.

M49 — Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M45-M49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 81 (abnormal posture and back deformities), 82 (back pain), 83 (deformities of skeleton and joints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M49.0 Tuberculose vertébrale ; M49.1 Spondylite au cours de brucellose ; M49.2 Spondylite due à une infection intestinale bactérienne ; M49.3 Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; M49.4 Spondylopathie neurologique ; M49.5 Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs ; M49.8 Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M45, M46, M47, M48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M49/M49_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m49.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M49/.

M50 — Atteintes des disques cervicaux (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M50-M54 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 81 (abnormal posture and back deformities), 82 (back pain), 83 (deformities of skeleton and joints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : M50.0 Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie ; M50.1 Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie ; M50.2 Autre hernie d'un disque cervical ; M50.3 Autre détérioration d'un disque cervical ; M50.8 Autres atteintes d'un disque cervical ; M50.9 Atteinte d'un disque cervical, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M51, M53, M54

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M50/M50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M50/.

M51 — Atteintes d'autres disques intervertébraux (R-14-Rhumatologie et orthopédie) - P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M50-M54 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 81 (abnormal posture and back deformities), 82 (back pain), 83 (deformities of skeleton and joints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M51.0 Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie ; M51.1 Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie ; M51.2 Hernie d'un autre disque intervertébral précisé ; M51.3 Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé ; M51.4 Nodules de Schmorl ; M51.8 Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral ; M51.9 Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M50, M53, M54
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M51/M51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M51/.

M53 — Autres dorsopathies, non classées ailleurs (R-14-Rhumatologie et orthopédie) - P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M50-M54 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 81 (abnormal posture and back deformities), 82 (back pain), 83 (deformities of skeleton and joints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : M53.0 Syndrome cervico-céphalique ; M53.1 Syndrome cervico-brachial ; M53.2 Instabilités vertébrales ; M53.3 Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs ; M53.8 Autres dorsopathies précisées ; M53.9 Dorsopathie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M50, M51, M54
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M53/M53_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M53/.

M60 — Myosite (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M60-M63 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : M60.0 Myosite infectieuse ; M60.1 Myosite interstitielle ; M60.2 Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs ; M60.8 Autres myosites ; M60.9 Myosite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M61, M62, M63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M60/M60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M60/.

M61 — Calcification et ossification de muscles (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M60-M63 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M61.0 Myosite ossifiante traumatique ; M61.1 Myosite ossifiante progressive ; M61.2 Calcification et ossification paralytiques d'un muscle ; M61.3 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures ; M61.4 Autres calcifications de muscles ; M61.5 Autres ossifications d'un muscle ; M61.9 Calcification et ossification d'un muscle, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M60, M62, M63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M61/M61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M61/.

M62 — Autres atteintes musculaires (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M60-M63 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : M62.0 Diastasis musculaire ; M62.1 Autres déchirures musculaires (non traumatiques) ; M62.2 Infarctissement ischémique musculaire (non traumatique) ; M62.3 Syndrome d'immobilité (paraplégique) ; M62.4 Contracture musculaire ; M62.5 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs ; M62.6 Foulure musculaire ; M62.8 Autres atteintes musculaires précisées ; M62.9 Atteinte musculaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M60, M61, M63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6.

Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/M62/M62_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M62/.

M63 — Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M60-M63 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : M63.0 Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs ; M63.1 Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs ; M63.2 Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs ; M63.3 Myosite au cours de sarcoïdose ; M63.8 Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M60, M61, M62
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M63/M63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M63/.

M66 — Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M65-M68 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : M66.0 Déchirure d'un kyste poplité ; M66.1 Déchirure de la synoviale ; M66.2 Déchirure spontanée des tendons extenseurs ; M66.3 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs ; M66.4 Déchirure spontanée d'autres tendons ; M66.5 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M65, M67, M68
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M66/M66_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m66.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M66/.

M67 — Autres atteintes de la synoviale et du tendon (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M65-M68 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M67.0 Brièveté du tendon d'Achille (acquise) ; M67.1 Autres rétractions tendineuses (gaine) ; M67.2 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs ; M67.3 Synovite transitoire ; M67.4 Kyste ; M67.8 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon ; M67.9 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M65, M66, M68
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M67/M67_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m67.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M67/.

M68 — Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M65-M68 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : M68.0 Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs ; M68.8 Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M65, M66, M67
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M68/M68_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m68.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M68/.

M70 — Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M70-M79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : M70.0 Ténosynovite sèche de la main et du poignet ; M70.1 Bursite de la main ; M70.2 Bursite olécrânienne ; M70.3 Autres bursites du coude ; M70.4 Bursite prépatellaire ; M70.5 Autres bursites du genou ; M70.6 Bursite trochantérienne ; M70.7 Autres bursites de la hanche ; M70.8 Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive ; M70.9 Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M71, M72, M73, M75, M76, M77, M79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/M70/M70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M70/.

M71 — Autres affections des bourses séreuses (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M70-M79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : M71.0 Abscesses des bourses séreuses ; M71.1 Autres bursites infectieuses ; M71.2 Kyste synovial poplité [Baker] ; M71.3 Autres kystes des bourses séreuses ; M71.4 Dépôts calciques dans une bourse séreuse ; M71.5 Autres bursites, non classées ailleurs ; M71.8 Autres affections des bourses séreuses précisées ; M71.9 Affections des bourses séreuses, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M70, M72, M73, M75, M76, M77, M79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M71/M71_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M71/.

M72 — Affections fibroblastiques (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M70-M79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M72.0 Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] ; M72.1 Coussinet des phalanges [Knuckle pads] ; M72.2 Fibromatose de l'aponévrose plantaire ; M72.4 Fibromatose pseudo-sarcomateuse ; M72.6 Fasciite nécrosante ; M72.8 Autres affections fibroblastiques ; M72.9 Affection fibroblastique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M70, M71, M73, M75, M76, M77, M79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M72/M72_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m72.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M72/.

M73 — Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M70-M79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de

l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : M73.0 Bursite gonococcique ; M73.1 Bursite syphilitique ; M73.8 Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M70, M71, M72, M75, M76, M77, M79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M73/M73_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m73.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M73/.

M76 — Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M70-M79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : M76.0 Tendinite de la région fessière ; M76.1 Tendinite du psoas ; M76.2 Exostose de la crête iliaque ; M76.3 Syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale] ; M76.4 Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] ; M76.5 Tendinite rotulienne ; M76.6 Tendinite du tendon d'Achille ; M76.7 Tendinite péronière ; M76.8 Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied ; M76.9 Enthésopathie du membre inférieur, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M70, M71, M72, M73, M75, M77, M79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M76/M76_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m76.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M76/.

M77 — Autres enthésopathies (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M70-M79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : M77.0 Apophysite interne du coude ; M77.1 Epicondylite ; M77.2 Périarthrite du poignet ; M77.3 Exostose calcanéenne ; M77.4 Métatarsalgie ; M77.5 Autres enthésopathies du pied ; M77.8 Autres enthésopathies, non classées ailleurs ; M77.9 Enthésopathie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M70, M71, M72, M73, M75, M76, M79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/M77/M77_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m77.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M77/.

M79 — Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M70-M79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 84 (myalgia), 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : M79.0 Rhumatisme, sans précision ; M79.1 Myalgie ; M79.2 Névralgie et névrite, sans précision ; M79.3 Panniculite, sans précision ; M79.4 Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa] ; M79.5 Corps étranger résiduel dans un tissu mou ; M79.6 Douleur au niveau d'un membre ; M79.7 Fibromyalgie ; M79.8 Autres affections précisées des tissus mous ; M79.9 Affection des tissus mous, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M70, M71, M72, M73, M75, M76, M77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M79/M79_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m79.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M79/.

M80 — Ostéoporose avec fracture pathologique (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M80-M85 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 169 (low bone density). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : M80.0 Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique ; M80.1 Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique ; M80.2 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique ; M80.3 Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique ; M80.4 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique ; M80.5 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique ; M80.8 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique ; M80.9 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M81, M82, M83, M84, M85
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M80/M80_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m80.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M80/.

M82 — Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M80-M85 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 169 (low bone density). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : M82.0 Ostéoporose au cours de myélomatose multiple ; M82.1 Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes ; M82.8 Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M80, M81, M83, M84, M85
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M82/M82_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m82.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M82/.

M83 — Ostéomalacie de l'adulte (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M80-M85 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 169 (low bone density). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : M83.0 Ostéomalacie puerpérale ; M83.1 Ostéomalacie sénile ; M83.2 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption ; M83.3 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition ; M83.4 Maladie osseuse due à l'aluminium ; M83.5 Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte ; M83.8 Autres ostéomalacies de l'adulte ; M83.9 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M80, M81, M82, M84, M85
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M83/M83_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m83.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M83/.

M84 — Anomalie de la continuité osseuse (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M80-M85 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 169 (low bone density). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M84.0 Fracture mal consolidée ; M84.1 Fracture non consolidée [pseudarthrose] ; M84.2 Retard de consolidation d'une fracture ; M84.3 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs ; M84.4 Fracture pathologique, non classée ailleurs ; M84.8 Autres anomalies de la continuité osseuse ; M84.9 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M80, M81, M82, M83, M85
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M84/M84_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m84.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M84/.

M85 — Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M80-M85 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 169 (low bone density). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : M85.0 Dysplasie fibreuse (localisée) ; M85.1 Ostéose fluorée ; M85.2 Hyperostose du crâne ; M85.3 Ostéite condensante ; M85.4 Kyste solitaire des os ; M85.5 Kyste anévrysmal des os ; M85.6 Autres kystes osseux ; M85.8 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses ; M85.9 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M80, M81, M82, M83, M84
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M85/M85_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m85.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M85/.

Q65 — Anomalies morphologiques congénitales de la hanche (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Q65.0 Luxation congénitale de la hanche, unilatérale ; Q65.1 Luxation congénitale de la hanche, bilatérale ; Q65.2 Luxation congénitale de la hanche, sans précision ; Q65.3 Subluxation congénitale de la hanche, unilatérale ; Q65.4 Subluxation congénitale de la hanche, bilatérale ; Q65.5 Subluxation congénitale de la hanche, sans précision ; Q65.6 Hanche instable (congénitale) ; Q65.8 Autres malformations congénitales de la hanche ; Q65.9 Malformation congénitale de la hanche, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q65/Q65_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q65.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q65/.

Q66 — Anomalies morphologiques congénitales du pied (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : Q66.0 Pied bot varus équin ; Q66.1 Pied bot talus varus ; Q66.2 Metatarsus varus ; Q66.3 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en varus ; Q66.4 Pied bot talus valgus ; Q66.5 Pied plat congénital ; Q66.6 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en valgus ; Q66.7 Pied creux ; Q66.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied ; Q66.9 Anomalie morphologique congénitale du pied, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q65, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q66/Q66_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q66.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q66/.

Q67 — Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (9)** : Q67.0 Asymétrie faciale ; Q67.1 Anomalie morphologique faciale par compression ; Q67.2 Dolichocéphalie ; Q67.3 Plagiocéphalie ; Q67.4 Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la mâchoire ; Q67.5 Anomalie morphologique congénitale du rachis ; Q67.6 Thorax en entonnoir congénital ; Q67.7 Thorax en carène congénital ; Q67.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du thorax
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q65, Q66, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q67/Q67_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q67.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q67/.

Q68 — Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : Q68.0 Anomalie morphologique congénitale des muscles sterno-cléido-mastoïdiens ; Q68.1 Anomalie morphologique congénitale de la main ; Q68.2 Anomalie morphologique congénitale du genou ; Q68.3 Incurvation congénitale du fémur ; Q68.4 Incurvation congénitale du tibia et du péroné ; Q68.5 Incurvation congénitale des os longs du membre inférieur, sans précision ; Q68.8 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles précisées

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q65, Q66, Q67, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q68/Q68_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q68.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q68/.

Q69 — Polydactylie (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s) ; Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s) ; Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s) ; Q69.9 Polydactylie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q65, Q66, Q67, Q68, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q69/Q69_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q69.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q69/.

Q70 — Syndactylie (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : Q70.0 Coalescence des doigts ; Q70.1 Palmure des doigts ; Q70.2 Coalescence des orteils ; Q70.3 Palmure des orteils ; Q70.4 Polysyndactylie ; Q70.9 Syndactylie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q70/Q70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q70/.

Q71 — Raccourcissement du membre supérieur (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Q71.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s) ; Q71.1 Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente ; Q71.2 Absence congénitale de l'avant-bras et de la main ; Q71.3 Absence congénitale de la main et de(s) doigt(s) ; Q71.4 Raccourcissement longitudinal du radius ; Q71.5 Raccourcissement longitudinal du cubitus ; Q71.6 Main en pince de homard ; Q71.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) supérieur(s) ; Q71.9 Raccourcissement du membre supérieur, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q71/Q71_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q71/.

Q72 — Raccourcissement du membre inférieur (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Q72.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s) ; Q72.1 Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent ; Q72.2 Absence congénitale de la jambe et du pied ; Q72.3 Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s) ; Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur ; Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia ; Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné ; Q72.7 Pied bifide ; Q72.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s) ; Q72.9 Raccourcissement du membre inférieur, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q72/Q72_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q72.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q72/.

Q73 — Raccourcissement d'un membre non précisé (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : Q73.0 Absence congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s) ; Q73.1 Phocomélie, membre(s) non précisé(s) ; Q73.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) non précisé(s)
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q73/Q73_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q73.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q73/.

Q74 — Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : Q74.0 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire ; Q74.1 Malformation congénitale du genou ; Q74.2 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne ; Q74.3 Arthrogrypose congénitale multiple ; Q74.8 Autres malformations congénitales précisées d'un (des) membre(s) ; Q74.9 Malformation congénitale non précisée d'un (des) membre(s)
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q74/Q74_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q74.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q74/.

Q75 — Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : Q75.0 Craniosynostose ; Q75.1 Dysostose cranio-faciale ; Q75.2 Hypertélorisme ; Q75.3 Macrocéphalie ; Q75.4 Dysostose mandibulo-faciale ; Q75.5

Dysostose oculo-mandibulaire ; Q75.8 Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face ; Q75.9 Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q76, Q77, Q78, Q79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q75/Q75_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q75.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q75/.

Q76 — Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Q76.0 Spina bifida occulta ; Q76.1 Syndrome de Klippel-Feil ; Q76.2 Spondylolisthésis et spondylodèse congénitaux ; Q76.3 Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale ; Q76.4 Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose ; Q76.5 Côte cervicale ; Q76.6 Autres malformations congénitales des côtes ; Q76.7 Anomalies congénitales du sternum ; Q76.8 Autres malformations congénitales du thorax osseux ; Q76.9 Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q77, Q78, Q79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q76/Q76_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q76.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q76/.

Q77 — Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Q77.0 Achondrogénésie ; Q77.1 Insuffisance staturale thanatophore ; Q77.2 Syndrome des côtes courtes ; Q77.3 Chondrodysplasie ponctuée ; Q77.4 Achondroplasie ; Q77.5 Dysplasie diastrophique ; Q77.6 Dysplasie chondroectodermique ; Q77.7 Dysplasie spondylo-épiphysaire ; Q77.8 Autres ostéochondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis ; Q77.9 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q78, Q79

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q77/Q77_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q77.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q77/.

Q78 — Autres ostéocondrodysplasies (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Q78.0 Ostéogenèse imparfaite ; Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de Jaffe-Lichtenstein] ; Q78.2 Ostéopétrose ; Q78.3 Dysplasie diaphysaire progressive ; Q78.4 Enchondromatose ; Q78.5 Dysplasie métaphysaire ; Q78.6 Exostoses multiples congénitales ; Q78.8 Autres ostéocondrodysplasies précisées ; Q78.9 Ostéocondrodysplasie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q78/Q78_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q78.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q78/.

Q79 — Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q65-Q79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Q79.0 Hernie diaphragmatique congénitale ; Q79.1 Autres malformations congénitales du diaphragme ; Q79.2 Exomphale ; Q79.3 Gastroschisis ; Q79.4 Aplasie congénitale de la musculature abdominale ; Q79.5 Autres malformations congénitales de la paroi abdominale ; Q79.6 Syndrome d'Ehlers-Danlos ; Q79.8 Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles ; Q79.9 Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des muscles, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14.

Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Q79/Q79_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q79.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/Q79/.

S12 — Fracture du cou (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S10-S19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 115 (spine injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S12.0 Fracture de la première vertèbre cervicale ; S12.1 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale ; S12.2 Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées ; S12.7 Fractures multiples des vertèbres cervicales ; S12.8 Fracture d'autres parties du cou ; S12.9 Fracture du cou, partie non précisée
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S12/S12_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s12.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S12/.

S22 — Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S20-S29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 116 (thoracic injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : S22.0 Fracture d'une vertèbre dorsale ; S22.1 Fractures multiples du rachis dorsal ; S22.2 Fracture du sternum ; S22.3 Fracture de côte ; S22.4 Fractures multiples de côtes ; S22.5 Volet costal ; S22.8 Fractures d'autres parties des os du thorax ; S22.9 Fracture des os du thorax, partie non précisée
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S22/S22_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s22.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S22/.

S32 — Fracture du rachis lombaire et du bassin (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S30-S39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 106 (abdominal injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : S32.0 Fracture d'une vertèbre lombaire ; S32.1 Fracture du sacrum ; S32.2 Fracture du coccyx ; S32.3 Fracture de l'ilion ; S32.4 Fracture de l'acétabulum ; S32.5 Fracture du pubis ; S32.7 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin ; S32.8 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi

→ 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/S32/S32_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s32.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S32/](#).

S42 — Fracture de l'épaule et du bras (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S40-S49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : S42.0 Fracture de la clavicule ; S42.1 Fracture de l'omoplate ; S42.2 Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus ; S42.3 Fracture de la diaphyse de l'humérus ; S42.4 Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus ; S42.7 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus ; S42.8 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras ; S42.9 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S43, S46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S42/S42_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s42.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S42/](#).

S43 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S40-S49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : S43.0 Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno-humérale] ; S43.1 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire ; S43.2 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire ; S43.3 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire ; S43.4 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule ; S43.5 Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire ; S43.6 Entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire ; S43.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S42, S46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S43/S43_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s43.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S43/](#).

S46 — Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S40-S49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : S46.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des rotateurs ; S46.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon du chef long du biceps brachial ; S46.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon d'autres parties du biceps brachial ; S46.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon du triceps ; S46.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras ; S46.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras ; S46.9 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du bras
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S42, S43
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S46/S46_a.m.d.html, _pop1, _pop2, glossary/s46.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S46/.

S53 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S50-S59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (5)** : S53.0 Luxation de la tête radiale ; S53.1 Luxation de partie autre et non précisée du coude ; S53.2 Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude ; S53.3 Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude ; S53.4 Entorse et foulure du coude
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S52, S56
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S53/S53_a.m.d.html, _pop1, _pop2, glossary/s53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S53/.

S56 — Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S50-S59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (8)** : S56.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras ; S56.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ; S56.2 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras ; S56.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras ; S56.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras ; S56.5 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras ; S56.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras ; S56.8 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S52, S53

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S56/S56_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s56.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S56/.

S63 — Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S60-S69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : S63.0 Luxation du poignet ; S63.1 Luxation du doigt ; S63.2 Luxations multiples des doigts ; S63.3 Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe ; S63.4 Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne ; S63.5 Entorse et foulure du poignet ; S63.6 Entorse et foulure de doigt(s) ; S63.7 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S62, S66
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S63/S63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S63/.

S66 — Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S60-S69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : S66.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main ; S66.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main ; S66.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main ; S66.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main ; S66.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main ; S66.5 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main ; S66.6 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main ; S66.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main ; S66.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main ; S66.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau du poignet et de la main
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S62, S63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi

→ 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/S66/S66_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s66.py](#), rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S66/.

S73 — Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S70-S79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : S73.0 Luxation de la hanche ; S73.1 Entorse et foulure de la hanche
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S72, S76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S73/S73_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s73.py](#), rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S73/.

S76 — Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S70-S79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S76.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche ; S76.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps ; S76.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse ; S76.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse ; S76.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse ; S76.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la hanche et de la cuisse
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S72, S73
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S76/S76_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s76.py](#), rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S76/.

S83 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S80-S89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : S83.0 Luxation de la rotule ; S83.1 Luxation du genou ; S83.2 Déchirure récente d'un ménisque ; S83.3 Déchirure récente du cartilage articulaire du genou ;

S83.4 Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe) ; S83.5 Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur) ; S83.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou ; S83.7 Lésion traumatique de multiples parties du genou

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S82, S86
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S83/S83_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s83.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S83/](#).

S86 — Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S80-S89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : S86.0 Lésion traumatique du tendon d'Achille ; S86.1 Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe ; S86.2 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe ; S86.3 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe ; S86.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe ; S86.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe ; S86.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S82, S83
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S86/S86_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s86.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S86/](#).

S96 — Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S90-S99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S96.0 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied ; S96.1 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied ; S96.2 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied ; S96.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied ; S96.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied ; S96.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S92, S93
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi

→ 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/S96/S96_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s96.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/S96/.

M06 — Polyarthrite rhumatoïde (R-14-Rhumatologie et orthopédie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M05-M14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative ; M06.1 Maladie de Still survenant chez l'adulte ; M06.2 Bursite rhumatoïde ; M06.3 Nodule rhumatoïde ; M06.4 Polyarthropathie inflammatoire ; M06.8 Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées ; M06.9 Polyarthrite rhumatoïde, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M06/M06_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m06.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/R-14-Rhumatologie et orthopédie/travail/M06/.

O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire

96 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 11 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : Société suisse d'ORL, SSO (médecine dentaire) ; EAORL-HNS.

H60 — Otite externe (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H60-H62 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 24 (discharge from ear), 26 (earache), 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : H60.0 Abscess of the external ear ; H60.1 Cellulitis of the external ear ; H60.2 Malignant external otitis ; H60.3 Other external otitis infections ; H60.4 Cholesteatoma of the external ear ; H60.5 Acute external otitis, non-infectious ; H60.8 Other external otitis ; H60.9 External otitis, unspecified
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H61, H62
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H60/H60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H60/.

H61 — Autres affections de l'oreille externe (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H60-H62 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 24 (discharge from ear), 26 (earache), 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : H61.0 Périchondrite de l'oreille externe ; H61.1 Affections non infectieuses du pavillon de l'oreille ; H61.2 Bouchon de cérumen ; H61.3 Sténose acquise du conduit auditif externe ; H61.8 Autres affections précisées de l'oreille externe ; H61.9 Affection de l'oreille externe, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H60, H62
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H61/H61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H61/.

H65 — Otite moyenne non suppurée (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H65-H75 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 24 (discharge from ear), 26 (earache), 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë ; H65.1 Autres otites moyennes aiguës, non suppurées ; H65.2 Otite moyenne séreuse chronique ; H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique ; H65.4 Autres otites moyennes chroniques, non suppurées ; H65.9 Otite moyenne non suppurée, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H65/H65_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h65.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H65/.

H66 — Otite moyenne suppurée et sans précision (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H65-H75 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 24 (discharge from ear), 26 (earache), 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (6)** : H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée ; H66.1 Otite moyenne suppurée chronique tubo-tympanique ; H66.2 Otite moyenne chronique attico-antrale suppurée ; H66.3 Autres otites moyennes suppurées chroniques ; H66.4 Otite moyenne suppurée, sans précision ; H66.9 Otite moyenne, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H65, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H66/H66_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h66.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H66/.

H81 — Atteintes des fonctions vestibulaires (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H80-H83 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus), 100 (dizziness, vertigo). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : H81.0 Maladie de Ménière ; H81.1 Vertige bénin paroxystique ; H81.2 Neuronite vestibulaire ; H81.3 Autres vertiges périphériques ; H81.4 Vertige d'origine centrale ; H81.8 Autres atteintes des fonctions vestibulaires ; H81.9 Atteinte des fonctions vestibulaires, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H80, H82, H83
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H81/H81_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h81.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H81/.

H90 — Surdit  de transmission et neurosensorielle (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H90-H95 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus), 100 (dizziness, vertigo). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (9)** : H90.0 Surdit  bilat rale de transmission ; H90.1 Surdit  unilat rale de transmission sans alt ration de l'audition de l'autre oreille ; H90.2 Surdit  de transmission, sans pr cision ; H90.3 Surdit  neurosensorielle bilat rale ; H90.4 Surdit  neurosensorielle unilat rale sans alt ration de l'audition de l'autre oreille ; H90.5 Surdit  neurosensorielle, sans pr cision ; H90.6 Surdit  bilat rale mixte de transmission et neurosensorielle ; H90.7 Surdit  unilat rale mixte de transmission et neurosensorielle sans alt ration de l'audition de l'autre oreille ; H90.8 Surdit  mixte de transmission et neurosensorielle, sans pr cision
- **M me bloc (renvois, ne pas red velopper)** : H91, H92, H93, H94, H95

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H90/H90_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h90.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H90/.

H91 — Autres pertes de l'audition (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H90-H95 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus), 100 (dizziness, vertigo). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : H91.0 Perte de l'audition par ototoxicité ; H91.1 Presbycusie ; H91.2 Surdit  brusque idiopathique ; H91.3 Surdi-mutité, non classée ailleurs ; H91.8 Autres pertes précisées de l'audition ; H91.9 Perte de l'audition, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H90, H92, H93, H94, H95
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H91/H91_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h91.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H91/.

J00 — Rhinopharyngite aigu  [rhume banal] (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J00-J06 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J01, J02, J03, J04, J05, J06
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J00/J00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J00/.

J01 — Sinusite aiguë (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J00-J06 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : J01.0 Sinusite maxillaire aiguë ; J01.1 Sinusite frontale aiguë ; J01.2 Sinusite ethmoïdale aiguë ; J01.3 Sinusite sphénoïdale aiguë ; J01.4 Pansinusite aiguë ; J01.8 Autres sinusites aiguës ; J01.9 Sinusite aiguë, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J00, J02, J03, J04, J05, J06
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J01/J01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J01/.

J02 — Pharyngite aiguë (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J00-J06 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : J02.0 Pharyngite à streptocoques ; J02.8 Pharyngite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés ; J02.9 Pharyngite aiguë, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J00, J01, J03, J04, J05, J06
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J02/J02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J02/.

J03 — Amygdalite aiguë (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J00-J06 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : J03.0 Amygdalite à streptocoques ; J03.8 Amygdalite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés ; J03.9 Amygdalite aiguë, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J00, J01, J02, J04, J05, J06
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J03/J03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J03/.

C00 — Tumeur maligne de la lèvre (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : C00.0 Tumeur maligne: Lèvre supérieure, bord libre ; C00.1 Tumeur maligne: Lèvre inférieure, bord libre ; C00.2 Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, bord libre ; C00.3 Tumeur maligne: Lèvre supérieure, face interne ; C00.4 Tumeur maligne: Lèvre inférieure, face interne ; C00.5 Tumeur maligne: Lèvre, sans précision, face interne ; C00.6 Tumeur maligne: Commissure des lèvres ; C00.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre ; C00.9 Tumeur maligne: Lèvre, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C00/C00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C00/.

C01 — Tumeur maligne de la base de la langue (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C00, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/C01/C01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C01/.

C02 — Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : C02.0 Tumeur maligne: Face dorsale de la langue ; C02.1 Tumeur maligne: Pointe et bords latéraux de la langue ; C02.2 Tumeur maligne: Face inférieure de la langue ; C02.3 Tumeur maligne: Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision ; C02.4 Tumeur maligne: Amygdale linguale ; C02.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la langue ; C02.9 Tumeur maligne: Langue, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C00, C01, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C02/C02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C02/.

C03 — Tumeur maligne de la gencive (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : C03.0 Tumeur maligne: Gencive supérieure ; C03.1 Tumeur maligne: Gencive inférieure ; C03.9 Tumeur maligne: Gencive, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C00, C01, C02, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C03/C03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C03/.

C04 — Tumeur maligne du plancher de la bouche (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : C04.0 Tumeur maligne: Plancher antérieur de la bouche ; C04.1 Tumeur maligne: Plancher latéral de la bouche ; C04.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du plancher de la bouche ; C04.9 Tumeur maligne: Plancher de la bouche, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C00, C01, C02, C03, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C04/C04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C04/.

C05 — Tumeur maligne du palais (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : C05.0 Tumeur maligne: Voûte palatine ; C05.1 Tumeur maligne: Voile du palais ; C05.2 Tumeur maligne: Luette ; C05.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du palais ; C05.9 Tumeur maligne: Palais, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C00, C01, C02, C03, C04, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C05/C05_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C05/.

C06 — Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance

pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : C06.0 Tumeur maligne: Muqueuse de la joue ; C06.1 Tumeur maligne: Vestibule de la bouche ; C06.2 Tumeur maligne: Région rétromolaire ; C06.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées ; C06.9 Tumeur maligne: Bouche, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C06/C06_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c06.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C06/.

C07 — Tumeur maligne de la glande parotide (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C07/C07_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c07.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C07/.

C08 — Tumeur maligne des glandes salivaires principales, autres et non précisées (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : C08.0 Tumeur maligne: Glande sous-mandibulaire ; C08.1 Tumeur maligne: Glande sublinguale ; C08.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires principales ; C08.9 Tumeur maligne: Glande salivaire principale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C09, C10, C11, C12, C13, C14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et

facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/C08/C08_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c08.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C08/.

C09 — Tumeur maligne de l'amygdale (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) • P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** : bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : C09.0 Tumeur maligne: Fosse amygdalienne ; C09.1 Tumeur maligne: Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) ; C09.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'amygdale ; C09.9 Tumeur maligne: Amygdale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C10, C11, C12, C13, C14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C09/C09_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c09.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C09/.

C10 — Tumeur maligne de l'oropharynx (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) • P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** : bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : C10.0 Tumeur maligne: Sillon glosso-épiglottique ; C10.1 Tumeur maligne: Face antérieure de l'épiglotte ; C10.2 Tumeur maligne: Paroi latérale de l'oropharynx ; C10.3 Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'oropharynx ; C10.4 Tumeur maligne: Fente branchiale ; C10.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx ; C10.9 Tumeur maligne: Oropharynx, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C11, C12, C13, C14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C10/C10_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-

C11 — Tumeur maligne du rhinopharynx (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) - P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : C11.0 Tumeur maligne: Paroi supérieure du rhinopharynx ; C11.1 Tumeur maligne: Paroi postérieure du rhinopharynx ; C11.2 Tumeur maligne: Paroi latérale du rhinopharynx ; C11.3 Tumeur maligne: Paroi antérieure du rhinopharynx ; C11.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de rhinopharynx ; C11.9 Tumeur maligne: Rhinopharynx, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C12, C13, C14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C11/C11_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c11.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C11/.

C12 — Tumeur maligne du sinus piriforme (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) - P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C13, C14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C12/C12_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c12.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C12/.

C13 — Tumeur maligne de l'hypopharynx (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) - P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance

pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : C13.0 Tumeur maligne: Région rétro-cricoïdienne ; C13.1 Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé ; C13.2 Tumeur maligne: Paroi postérieure de l'hypopharynx ; C13.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'hypopharynx ; C13.9 Tumeur maligne: Hypopharynx, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C13/C13_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c13.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C13/.

C14 — Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C00-C14 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : C14.0 Tumeur maligne: Pharynx, sans précision ; C14.2 Tumeur maligne: Anneau de Waldeyer ; C14.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C14/C14_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c14.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C14/.

C30 — Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C30-C39 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : C30.0 Tumeur maligne: Fosses nasales ; C30.1 Tumeur maligne: Oreille moyenne
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C31, C32
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes

d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/C30/C30_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C30/.

C31 — Tumeur maligne des sinus de la face (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C30-C39 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : C31.0 Tumeur maligne: Sinus maxillaire ; C31.1 Tumeur maligne: Sinus ethmoïdal ; C31.2 Tumeur maligne: Sinus frontal ; C31.3 Tumeur maligne: Sinus sphénoïdal ; C31.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des sinus de la face ; C31.9 Tumeur maligne: Sinus de la face, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C30, C32
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C31/C31_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c31.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C31/.

C32 — Tumeur maligne du larynx (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C30-C39 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : C32.0 Tumeur maligne: Glotte ; C32.1 Tumeur maligne: Etage sus-glottique ; C32.2 Tumeur maligne: Etage sous-glottique ; C32.3 Tumeur maligne: Cartilage laryngé ; C32.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du larynx ; C32.9 Tumeur maligne: Larynx, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C30, C31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C32/C32_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c32.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/C32/.

H62 — Affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H60-H62 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 24 (discharge from ear), 26 (earache), 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : H62.0 Otite externe au cours de maladies bactériennes classées ailleurs ; H62.1 Otite externe au cours de maladies virales classées ailleurs ; H62.2 Otite externe au cours de mycoses ; H62.3 Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; H62.4 Otite externe au cours d'autres maladies classées ailleurs ; H62.8 Autres affections de l'oreille externe au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H60, H61
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H62/H62_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H62/.

H67 — Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H65-H75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 24 (discharge from ear), 26 (earache), 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : H67.0 Otite moyenne au cours de maladies bactériennes classées ailleurs ; H67.1 Otite moyenne au cours de maladies virales classées ailleurs ; H67.8 Otite moyenne au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H65, H66, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H67/H67_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h67.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H67/.

H68 — Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H65-H75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 24 (discharge from ear), 26 (earache), 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : H68.0 Salpingite de la trompe d'Eustache ; H68.1 Obstruction de la trompe d'Eustache
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H65, H66, H67, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H68/H68_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h68.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H68/.

H69 — Autres affections de la trompe d'Eustache (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H65-H75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 24 (discharge from ear), 26 (earache), 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : H69.0 Distension de la trompe d'Eustache ; H69.8 Autres affections précisées de la trompe d'Eustache ; H69.9 Affection de la trompe d'Eustache, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H65, H66, H67, H68, H70, H71, H72, H73, H74, H75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H69/H69_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h69.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H69/.

H70 — Mastoïdite et affections apparentées (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H65-H75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 24 (discharge from ear), 26 (earache), 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : H70.0 Mastoïdite aiguë ; H70.1 Mastoïdite chronique ; H70.2 Apexite [pétrosite] ; H70.8 Autres mastoïdites et affections apparentées ; H70.9 Mastoïdite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H65, H66, H67, H68, H69, H71, H72, H73, H74, H75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H70/H70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H70/.

H71 — Cholestéatome de l'oreille moyenne (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H65-H75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 24 (discharge from ear), 26 (earache), 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H65, H66, H67, H68, H69, H70, H72, H73, H74, H75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H71/H71_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H71/.

H72 — Perforation du tympan (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H65-H75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 24 (discharge from ear), 26 (earache), 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : H72.0 Perforation centrale du tympan ; H72.1 Perforation du tympan, partie attique ; H72.2 Autres perforations marginales du tympan ; H72.8 Autres perforations du tympan ; H72.9 Perforation du tympan, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H73, H74, H75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H72/H72_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h72.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H72/.

H73 — Autres affections du tympan (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H65-H75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 24 (discharge from ear), 26 (earache), 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : H73.0 Myringite aiguë ; H73.1 Myringite chronique ; H73.8 Autres affections précisées du tympan ; H73.9 Affection du tympan, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H74, H75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/H73/H73_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/h73.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H73/](#).

H74 — Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H65-H75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 24 (discharge from ear), 26 (earache), 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : H74.0 Tympanosclérose ; H74.1 Maladie adhésive de l'oreille moyenne ; H74.2 Dissociation et dislocation des osselets ; H74.3 Autres anomalies acquises des osselets ; H74.4 Polype de l'oreille moyenne ; H74.8 Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde ; H74.9 Affection de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/H74/H74_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/h74.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H74/](#).

H75 — Autres affections de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H65-H75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 24 (discharge from ear), 26 (earache), 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : H75.0 Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; H75.8 Autres affections précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/H75/H75_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/h75.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H75/](#).

H80 — Otosclérose (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H80-H83 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus), 100 (dizziness, vertigo). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : H80.0 Otosclérose intéressant la fenêtre ovale, non oblitérante ; H80.1 Otosclérose intéressant la fenêtre ovale, oblitérante ; H80.2 Otosclérose cochléaire ; H80.8 Autres otoscléroses ; H80.9 Otosclérose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H81, H82, H83
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H80/H80_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h80.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H80/.

H82 — Syndromes vertigineux au cours de maladies classées ailleurs (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H80-H83 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus), 100 (dizziness, vertigo). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H80, H81, H83
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H82/H82_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h82.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H82/.

H83 — Autres maladies de l'oreille interne (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H80-H83 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus), 100 (dizziness, vertigo). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : H83.0 Labyrinthite ; H83.1 Fistule labyrinthique ; H83.2 Troubles des fonctions labyrinthiques ; H83.3 Conséquences du bruit sur l'oreille interne ; H83.8 Autres maladies précisées de l'oreille interne ; H83.9 Maladie de l'oreille interne, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H80, H81, H82
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/H83/H83_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h83.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H83/.

H92 — Otalgie et écoulement par l'oreille (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H90-H95 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus), 100 (dizziness, vertigo). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : H92.0 Otalgie ; H92.1 Otorrhée ; H92.2 Otorragie
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H90, H91, H93, H94, H95
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H92/H92_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h92.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H92/.

H93 — Autres affections de l'oreille, non classées ailleurs (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H90-H95 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus), 100 (dizziness, vertigo). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : H93.0 Affections vasculaires et dégénératives de l'oreille ; H93.1 Acouphènes ; H93.2 Autres perceptions auditives anormales ; H93.3 Affections du nerf auditif [nerf crânien VIII] ; H93.8 Autres affections précisées de l'oreille ; H93.9 Affection de l'oreille, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H90, H91, H92, H94, H95
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H93/H93_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h93.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H93/.

H94 — Autres affections de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H90-H95 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus), 100 (dizziness, vertigo). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : H94.0 Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; H94.8

Autres affections précisées de l'oreille au cours de maladies classées ailleurs

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H90, H91, H92, H93, H95
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H94/H94_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h94.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H94/.

H95 — Affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes médicaux, non classées ailleurs (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VIII** · bloc H90-H95 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 28 (hearing impairment: hyper- and hypoacusis, deafness, whistling, tinnitus), 100 (dizziness, vertigo). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : H95.0 Cholestéatome récidivant après mastoïdectomie ; H95.1 Autres affections survenant après mastoïdectomie ; H95.8 Autres affections de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes médicaux ; H95.9 Affection de l'oreille et de l'apophyse mastoïde après des actes médicaux, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H90, H91, H92, H93, H94
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H95/H95_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h95.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/H95/.

J04 — Laryngite et trachéite aiguës (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J00-J06 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : J04.0 Laryngite aiguë ; J04.1 Trachéite aiguë ; J04.2 Laryngo-trachéite aiguë
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J00, J01, J02, J03, J05, J06
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J04/J04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-

J05 — Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J00-J06 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup] ; J05.1 Epiglottite aiguë
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J00, J01, J02, J03, J04, J06
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J05/J05_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J05/.

J06 — Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J00-J06 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : J06.0 Laryngo-pharyngite aiguë ; J06.8 Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples ; J06.9 Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J00, J01, J02, J03, J04, J05
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J06/J06_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j06.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J06/.

J30 — Rhinopathie allergique et vasomotrice (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J30-J39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (5)** : J30.0 Rhinopathie vasomotrice ; J30.1 Rhinopathie allergique due au pollen ; J30.2 Autres rhinopathies allergiques saisonnières ; J30.3 Autres rhinopathie allergiques ; J30.4 Rhinopathie allergique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J30/J30_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J30/.

J31 — Rhinite, rhinopharyngite et pharyngite chroniques (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J30-J39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (3)** : J31.0 Rhinite chronique ; J31.1 Rhinopharyngite chronique ; J31.2 Pharyngite chronique
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J30, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J31/J31_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j31.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J31/.

J32 — Sinusite chronique (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J30-J39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : J32.0 Sinusite maxillaire chronique ; J32.1 Sinusite frontale chronique ; J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique ; J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique ; J32.4 Pansinusite chronique ; J32.8 Autres sinusites chroniques ; J32.9 Sinusite chronique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J30, J31, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/J32/J32_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j32.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J32/.

J33 — Polype nasal (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J30-J39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : J33.0 Polype des fosses nasales ; J33.1 Polyposse rhino-sinusienne déformante ; J33.8 Autres polypes des sinus ; J33.9 Polype nasal, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J30, J31, J32, J34, J35, J36, J37, J38, J39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J33/J33_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j33.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J33/.

J34 — Autres maladies du nez et des sinus du nez (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J30-J39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : J34.0 Abscess, furuncle and anthrax of the nose ; J34.1 Cyst and mucocoele of the nose and the sinuses of the nose ; J34.2 Deviation of the nasal septum ; J34.3 Hypertrophy of the turbinates of the nose ; J34.8 Other specified diseases of the nose and the sinuses of the nose
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J30, J31, J32, J33, J35, J36, J37, J38, J39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J34/J34_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j34.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J34/.

J35 — Maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J30-J39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor).

Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : J35.0 Amygdalite chronique ; J35.1 Hypertrophie des amygdales ; J35.2 Hypertrophie des végétations adénoïdes ; J35.3 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes ; J35.8 Autres maladies chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes ; J35.9 Maladie chronique des amygdales et des végétations adénoïdes, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J30, J31, J32, J33, J34, J36, J37, J38, J39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J35/J35_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J35/.

J36 — Abcès périamygdalien (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J30-J39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J30, J31, J32, J33, J34, J35, J37, J38, J39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J36/J36_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j36.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J36/.

J37 — Laryngite et laryngo-trachéite chroniques (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J30-J39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : J37.0 Laryngite chronique ; J37.1 Laryngo-trachéite chronique
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J38, J39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/J37/J37_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j37.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J37/.

J38 — Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J30-J39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : J38.0 Paralysie des cordes vocales et du larynx ; J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx ; J38.2 Nodules des cordes vocales ; J38.3 Autres maladies des cordes vocales ; J38.4 Œdème du larynx ; J38.5 Spasme laryngé ; J38.6 Sténose du larynx ; J38.7 Autres maladies du larynx
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J38/J38_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j38.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J38/.

J39 — Autres maladies des voies respiratoires supérieures (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM X** · bloc J30-J39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 30 (nasal discharge), 31 (nasal obstruction), 35 (sore throat), 49 (painful respiration, wheezing, stridor). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : J39.0 Abcès parapharyngé et rétropharyngé ; J39.1 Autres abcès du pharynx ; J39.2 Autres maladies du pharynx ; J39.3 Réaction d'hypersensibilité des voies respiratoires supérieures, localisation non précisée ; J39.8 Autres maladies des voies respiratoires supérieures précisées ; J39.9 Maladie des voies respiratoires supérieures, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/J39/J39_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/j39.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/J39/.

K00 — Troubles de l'odontogénèse (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : K00.0 Anodontie ; K00.1 Dents surnuméraires ; K00.2 Anomalies de volume et de forme des dents ; K00.3 Dents tachetées ; K00.4 Troubles de la formation des dents ; K00.5 Anomalies héréditaires de la structure dentaire, non classées ailleurs ; K00.6 Troubles de l'éruption dentaire ; K00.7 Syndrome d'éruption dentaire ; K00.8 Autres troubles de l'odontogénèse ; K00.9 Troubles de l'odontogénèse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K00/K00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K00/.

K01 — Dents incluses et enclavées (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : K01.0 Dents incluses ; K01.1 Dents enclavées
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K00, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K01/K01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K01/.

K02 — Caries dentaires (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : K02.0 Carie limitée à l'émail ; K02.1 Carie de la dentine ; K02.2 Carie du ciment ; K02.3 Carie dentaire stabilisée ; K02.4 Odontoclasie ; K02.5 Carie avec exposition de la pulpe ; K02.8 Autres caries dentaires ; K02.9 Carie dentaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K00, K01, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6.

Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/K02/K02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K02/.

K03 — Autres maladies des tissus dentaires durs (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : K03.0 Attrition excessive des dents ; K03.1 Abrasion des dents ; K03.2 Érosion des dents ; K03.3 Résorption pathologique des dents ; K03.4 Hypercémentose ; K03.5 Ankylose dentaire ; K03.6 Dépôts [accrétions] sur les dents ; K03.7 Modification de la teinte des tissus dentaires durs après l'éruption ; K03.8 Autres maladies précisées des tissus dentaires durs ; K03.9 Maladie des tissus dentaires durs, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K00, K01, K02, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K03/K03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K03/.

K04 — Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : K04.0 Pulpite ; K04.1 Nécrose pulpaire ; K04.2 Dégénérescence pulpaire ; K04.3 Formation anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe ; K04.4 Périodontite apicale aiguë d'origine pulpaire ; K04.5 Périodontite apicale chronique ; K04.6 Abscès périapical avec fistule ; K04.7 Abscès périapical sans fistule ; K04.8 Kyste radiculaire ; K04.9 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux, autres et sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K00, K01, K02, K03, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/K04/K04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K04/.

K05 — Gingivite et maladies périodontales (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : K05.0 Gingivite aiguë ; K05.1 Gingivite chronique ; K05.2 Périodontite aiguë ; K05.3 Périodontite chronique ; K05.4 Parodontose ; K05.5 Autres maladies périodontales ; K05.6 Maladie périodontale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K00, K01, K02, K03, K04, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K05/K05_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K05/.

K06 — Autres affections de la gencive et de la crête alvéolaire édentée (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : K06.0 Rétraction gingivale ; K06.1 Hyperplasie gingivale ; K06.2 Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, associées à un traumatisme ; K06.8 Autres affections précisées de la gencive et de la crête alvéolaire édentée ; K06.9 Affection de la gencive et de la crête alvéolaire édentée, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K06/K06_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k06.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K06/.

K07 — Anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : K07.0 Anomalies importantes de dimension des mâchoires ; K07.1 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne ; K07.2 Anomalies de rapport entre les arcades dentaires ; K07.3 Malposition des dents ; K07.4 Malocclusion, sans précision ; K07.5 Anomalies dento-faciales fonctionnelles ; K07.6 Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire ; K07.8 Autres anomalies dento-faciales ; K07.9 Anomalie dento-faciale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K07/K07_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k07.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K07/.

K08 — Autres affections des dents et du parodonte (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : K08.0 Exfoliation dentaire due à des causes générales ; K08.1 Perte de dents consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée ; K08.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée ; K08.3 Racine dentaire laissée en place ; K08.8 Autres affections précisées des dents et du parodonte ; K08.9 Affection des dents et du parodonte, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K09, K10, K11, K12, K13, K14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K08/K08_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k08.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K08/.

K09 — Kystes de la région buccale, non classés ailleurs (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : K09.0 Kystes dentaires liés au développement (odontogènes) ; K09.1 Kystes de la région buccale non liés au développement dentaire ; K09.2

Autres kystes de la mâchoire ; K09.8 Autres kystes de la région buccale, non classés ailleurs ; K09.9 Kyste de la région buccale, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K10, K11, K12, K13, K14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K09/K09_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k09.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K09/.

K10 — Autres maladies des mâchoires (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : K10.0 Maladies liées au développement des mâchoires ; K10.1 Granulome à cellules géantes, central ; K10.2 Affections inflammatoires des mâchoires ; K10.3 Alvéolite des mâchoires ; K10.8 Autres maladies précisées des mâchoires ; K10.9 Maladie des mâchoires, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K11, K12, K13, K14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K10/K10_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K10/.

K11 — Maladies des glandes salivaires (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : K11.0 Atrophie des glandes salivaires ; K11.1 Hypertrophie des glandes salivaires ; K11.2 Sialoadénite ; K11.3 Abscès des glandes salivaires ; K11.4 Fistule des glandes salivaires ; K11.5 Sialolithiase ; K11.6 Mucocèle des glandes salivaires ; K11.7 Troubles de la sécrétion salivaire ; K11.8 Autres maladies des glandes salivaires ; K11.9 Maladie des glandes salivaires, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K12, K13, K14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8.

Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/K11/K11_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k11.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-0to-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K11/.

K12 — Stomatites et affections apparentées (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : K12.0 Aphtes buccaux récidivants ; K12.1 Autres formes de stomatite ; K12.2 Phlegmon et abcès de la bouche ; K12.3 Mucosite orale (ulcéreuse)
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K13, K14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K12/K12_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k12.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-0to-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K12/.

K13 — Autres maladies des lèvres et de la muqueuse buccale (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : K13.0 Maladies des lèvres ; K13.1 Morsure de la joue et de la lèvre ; K13.2 Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium buccal, y compris la langue ; K13.3 Tricholeucoplasie ; K13.4 Granulome et lésions pseudo-granulomateuses de la muqueuse buccale ; K13.5 Fibrose sous-muqueuse de la bouche ; K13.6 Hyperplasie inflammatoire de la muqueuse buccale ; K13.7 Lésions de la muqueuse buccale, autres et sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K13/K13_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k13.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-0to-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K13/.

K14 — Maladies de la langue (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XI** · bloc K00-K14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 25 (dryness, pain, mass in mouth or throat, oral lesions), 27 (facial, jaw or tooth pain, trismus). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : K14.0 Glossite ; K14.1 Langue géographique ; K14.2 Glossite losangique médiane ; K14.3 Hypertrophie des papilles linguales ; K14.4 Atrophie des papilles de la langue ; K14.5 Langue plicaturée ; K14.6 Glossodynie ; K14.8 Autres maladies de la langue ; K14.9 Maladie de la langue, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : K00, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/K14/K14_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/k14.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/K14/.

Q16 — Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q10-Q18 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : Q16.0 Absence congénitale du pavillon de l'oreille ; Q16.1 Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe) ; Q16.2 Absence de trompe d'Eustache ; Q16.3 Malformation congénitale des osselets ; Q16.4 Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne ; Q16.5 Malformation congénitale de l'oreille interne ; Q16.9 Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q17, Q18
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q16/Q16_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q16.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/Q16/.

Q17 — Autres malformations congénitales de l'oreille (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q10-Q18 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (8)** : Q17.0 Pavillon surnuméraire ; Q17.1 Macrotye ; Q17.2 Microtye ; Q17.3 Autres déformations de l'oreille ; Q17.4 Anomalie de position de l'oreille ; Q17.5 Oeilles proéminentes ; Q17.8 Autres malformations congénitales précisées de l'oreille ; Q17.9 Malformation congénitale de l'oreille, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q16, Q18
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q17/Q17_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q17.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-0to-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/Q17/.

Q18 — Autres malformations congénitales de la face et du cou (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q10-Q18 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : Q18.0 Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale ; Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires ; Q18.2 Autres malformations d'origine branchiale ; Q18.3 Cou palmé ; Q18.4 Macrostomie ; Q18.5 Microstomie ; Q18.6 Macrocheilie ; Q18.7 Microcheilie ; Q18.8 Autres malformations congénitales précisées de la face et du cou ; Q18.9 Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q16, Q17
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q18/Q18_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q18.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-0to-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/Q18/.

Q30 — Malformations congénitales du nez (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q30-Q34 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (6)** : Q30.0 Atrésie des choanes ; Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez ; Q30.2 Fissure, échancrure et fente nasales ; Q30.3 Perforation congénitale de la cloison nasale ; Q30.8 Autres malformations congénitales du nez ; Q30.9 Malformation congénitale du nez, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6.

Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Q30/Q30_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/Q30/.

Q31 — Malformations congénitales du larynx (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q30-Q34 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : Q31.0 Ptérygion du larynx ; Q31.1 Sténose sous-glottique congénitale ; Q31.2 Hypoplasie du larynx ; Q31.3 Laryngocèle ; Q31.5 Laryngomalacie congénitale ; Q31.8 Autres malformations congénitales du larynx ; Q31.9 Malformation congénitale du larynx, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q30
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q31/Q31_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q31.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/Q31/.

Q35 — Fente palatine (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q35-Q37 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : Q35.1 Fente de la voûte du palais ; Q35.3 Fente du voile du palais ; Q35.5 Fente de la voûte et du voile du palais ; Q35.7 Fente de la luette ; Q35.9 Fente du palais, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q36, Q37
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q35/Q35_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/Q35/.

Q36 — Fente labiale (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q35-Q37 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : Q36.0 Fente labiale bilatérale ; Q36.1 Fente labiale médiane ; Q36.9 Fente labiale unilatérale
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q35, Q37
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q36/Q36_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q36.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/Q36/.

Q37 — Fente labio-palatine (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q35-Q37 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : Q37.0 Fente de la voûte du palais avec fente labiale bilatérale ; Q37.1 Fente de la voûte du palais avec fente labiale unilatérale ; Q37.2 Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale ; Q37.3 Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale ; Q37.4 Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale bilatérale ; Q37.5 Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale unilatérale ; Q37.8 Fente palatine, sans précision, avec fente labiale bilatérale ; Q37.9 Fente palatine, sans précision, avec fente labiale unilatérale
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q35, Q36
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q37/Q37_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q37.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/Q37/.

Q38 — Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q38-Q45 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Q38.0 Malformations congénitales des lèvres, non classées ailleurs ; Q38.1 Ankyloglossie ; Q38.2 Macroglossie (congénitale) ; Q38.3 Autres

malformations congénitales de la langue ; Q38.4 Malformations congénitales des glandes et des canaux salivaires ; Q38.5 Malformations congénitales du palais, non classées ailleurs ; Q38.6 Autres malformations congénitales de la bouche ; Q38.7 Poche pharyngée ; Q38.8 Autres malformations congénitales du pharynx

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q38/Q38_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q38.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/Q38/.

S00 — Lésion traumatique superficielle de la tête (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S00-S09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 112 (head and brain injuries and trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : S00.0 Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu ; S00.1 Contusion de la paupière et de la région périoculaire ; S00.2 Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région périoculaire ; S00.3 Blessure superficielle du nez ; S00.4 Blessure superficielle de l'oreille ; S00.5 Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale ; S00.7 Blessures superficielles multiples de la tête ; S00.8 Blessure superficielle d'autres parties de la tête ; S00.9 Blessure superficielle de la tête, partie non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S01, S02, S03, S07, S08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S00/S00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/S00/.

S01 — Plaie ouverte de la tête (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S00-S09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 112 (head and brain injuries and trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : S01.0 Plaie ouverte du cuir chevelu ; S01.1 Plaie ouverte de la paupière et de la région périoculaire ; S01.2 Plaie ouverte du nez ; S01.3 Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif ; S01.4 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire ; S01.5 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale ; S01.7 Plaies ouvertes multiples de la tête ; S01.8 Plaie ouverte d'autres parties de la tête ; S01.9 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S00, S02, S03, S07, S08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail,

assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/S01/S01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/S01/.

S02 — Fracture du crâne et des os de la face (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S00-S09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 112 (head and brain injuries and trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : S02.0 Fracture de la voûte du crâne ; S02.1 Fracture de la base du crâne ; S02.2 Fracture des os du nez ; S02.3 Fracture du plancher de l'orbite ; S02.4 Fracture des os maxillaires et maxillaires ; S02.5 Fracture dentaire ; S02.6 Fracture du maxillaire inférieur ; S02.7 Fractures multiples du crâne et des os de la face ; S02.8 Fractures d'autres os du crâne et de la face ; S02.9 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S00, S01, S03, S07, S08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S02/S02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/S02/.

S03 — Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S00-S09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 112 (head and brain injuries and trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S03.0 Luxation de la mâchoire ; S03.1 Luxation de la cloison du nez ; S03.2 Luxation dentaire ; S03.3 Luxation de parties autres et non précisées de la tête ; S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire ; S03.5 Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la tête
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S00, S01, S02, S07, S08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S03/S03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/S03/.

S07 — Écrasement de la tête (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S00-S09 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 112 (head and brain injuries and trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : S07.0 Écrasement de la face ; S07.1 Écrasement du crâne ; S07.8 Écrasement d'autres parties de la tête ; S07.9 Écrasement de la tête, partie non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S00, S01, S02, S03, S08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S07/S07_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s07.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/S07/.

S08 — Amputation traumatique d'une partie de la tête (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S00-S09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 112 (head and brain injuries and trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : S08.0 Arrachement du cuir chevelu ; S08.1 Amputation traumatique de l'oreille ; S08.8 Amputation traumatique d'autres parties de la tête ; S08.9 Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S00, S01, S02, S03, S07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S08/S08_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s08.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/S08/.

S10 — Lésion traumatique superficielle du cou (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S10-S19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 115 (spine injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : S10.0 Contusion de la gorge ; S10.1 Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision ; S10.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du cou ; S10.8 Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou ; S10.9 Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S11, S13, S15, S16
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/S10/S10_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/S10/.

S11 — Plaie ouverte du cou (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S10-S19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 115 (spine injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S11.0 Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée ; S11.1 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde ; S11.2 Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical ; S11.7 Plaies ouvertes multiples du cou ; S11.8 Plaie ouverte d'autres parties du cou ; S11.9 Plaie ouverte du cou, partie non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S10, S13, S15, S16
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S11/S11_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s11.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/S11/.

S13 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S10-S19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 115 (spine injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : S13.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical ; S13.1 Luxation d'une vertèbre cervicale ; S13.2 Luxations de parties autres et non précisées du cou ; S13.3 Luxations multiples du cou ; S13.4 Entorse et foulure du rachis cervical ; S13.5 Entorse et foulure de la région thyroïdienne ; S13.6 Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties autres et non précisées du cou
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S10, S11, S15, S16
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S13/S13_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s13.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/S13/.

S15 — Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S10-S19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 115 (spine injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : S15.0 Lésion traumatique de la carotide ; S15.1 Lésion traumatique de l'artère vertébrale ; S15.2 Lésion traumatique de la veine jugulaire externe ; S15.3 Lésion traumatique de la veine jugulaire interne ; S15.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux

sanguins au niveau du cou ; S15.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou ; S15.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au niveau du cou

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S10, S11, S13, S16
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S15/S15_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s15.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/S15/.

S16 — Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S10-S19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 115 (spine injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S10, S11, S13, S15
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S16/S16_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s16.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/S16/.

T16 — Corps étranger dans l'oreille (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T15-T19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 111 (foreign body). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T17
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T16/T16_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t16.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/T16/.

T17 — Corps étranger dans les voies respiratoires (O-17-Oto-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T15-T19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 111 (foreign body). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal ; T17.1 Corps étranger dans une narine ; T17.2 Corps étranger dans le pharynx ; T17.3 Corps étranger dans le larynx ; T17.4 Corps étranger dans la trachée ; T17.5 Corps étranger dans les bronches ; T17.8

Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires ; T17.9 Corps étranger dans les voies respiratoires, partie non précisée

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : T16**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T17/T17_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t17.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-17-0to-rhino-laryngologie et médecine bucco-dentaire/travail/T17/.

O-18-Ophtalmologie

53 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 6 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : Société suisse d'ophtalmologie ; EURETINA, EGS.

H00 — Orgelet et chalazion (O-18-Ophtalmologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H00-H06 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : H00.0 Orgelet et autres inflammations profondes de la paupière ; H00.1 Chalazion
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : H01, H02, H03, H04, H05, H06**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H00/H00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H00/.

H10 — Conjonctivite (O-18-Ophtalmologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H10-H13 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : H10.0 Conjonctivite mucopurulente ; H10.1 Conjonctivite atopique aiguë ; H10.2 Autres conjonctivites aiguës ; H10.3 Conjonctivite aiguë, sans précision ; H10.4 Conjonctivite chronique ; H10.5 Blépharo-conjonctivite ; H10.8 Autres conjonctivites ; H10.9 Conjonctivite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : H11, H13**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/H10/H10_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H10/.

H25 — Cataracte sénile (O-18-Ophtalmologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H25-H28 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : H25.0 Cataracte incipiente sénile ; H25.1 Cataracte sénile nucléaire ; H25.2 Cataracte sénile, de type Morgagni ; H25.8 Autres cataractes séniles ; H25.9 Cataracte sénile, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H26, H27, H28
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H25/H25_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h25.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H25/.

H26 — Autres cataractes (O-18-Ophtalmologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H25-H28 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : H26.0 Cataracte infantile, juvénile et présénile ; H26.1 Cataracte traumatique ; H26.2 Cataracte compliquée ; H26.3 Cataracte médicamenteuse ; H26.4 Séquelles de cataracte ; H26.8 Autres cataractes précisées ; H26.9 Cataracte, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H25, H27, H28
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H26/H26_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h26.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H26/.

H40 — Glaucome (O-18-Ophtalmologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H40-H42 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour).

Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : H40.0 Glaucome limite ; H40.1 Glaucome primitif à angle ouvert ; H40.2 Glaucome primitif à angle étroit ; H40.3 Glaucome secondaire à un traumatisme oculaire ; H40.4 Glaucome secondaire à une inflammation de l'œil ; H40.5 Glaucome secondaire à d'autres affections oculaires ; H40.6 Glaucome médicamenteux ; H40.8 Autres glaucomes ; H40.9 Glaucome, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H42
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H40/H40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H40/.

H52 — Vices de réfraction et troubles de l'accommodation (O-18-Ophtalmologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H49-H52 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 17 (abnormal eye movements), 36 (squint (strabismus)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : H52.0 Hypermétropie ; H52.1 Myopie ; H52.2 Astigmatisme ; H52.3 Anisométrie et anisiconie ; H52.4 Presbytie ; H52.5 Troubles de l'accommodation ; H52.6 Autres vices de réfraction ; H52.7 Vice de réfraction, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H49, H50, H51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H52/H52_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h52.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H52/.

C69 — Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C69-C72 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : C69.0 Tumeur maligne: Conjonctive ; C69.1 Tumeur maligne: Cornée ; C69.2 Tumeur maligne: Rétine ; C69.3 Tumeur maligne: Choroïde ; C69.4 Tumeur maligne: Corps ciliaire ; C69.5 Tumeur maligne: Glande lacrymale et canal lacrymal ; C69.6 Tumeur maligne: Orbite ; C69.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses annexes ; C69.9 Tumeur maligne: Œil, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage

organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/C69/C69_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c69.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/C69/.

H01 — Autres inflammations de la paupière (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H00-H06 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : H01.0 Blépharite ; H01.1 Dermatoses non infectieuses de la paupière ; H01.8 Autres inflammations précisées de la paupière ; H01.9 Inflammation de la paupière, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H00, H02, H03, H04, H05, H06
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H01/H01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H01/.

H02 — Autres affections des paupières (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H00-H06 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : H02.0 Entropion et trichiasis de la paupière ; H02.1 Ectropion palpébral ; H02.2 Lagophtalmie ; H02.3 Blépharochalasis ; H02.4 Ptosis de la paupière ; H02.5 Autres troubles affectant la fonction palpébrale ; H02.6 Xanthélasma de la paupière ; H02.7 Autres affections dégénératives des paupières et de la région périoculaire ; H02.8 Autres affections précisées des paupières ; H02.9 Affection des paupières, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H00, H01, H03, H04, H05, H06
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H02/H02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H02/.

H03 — Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H00-H06 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : H03.0 Infection parasitaire de la paupière au cours de maladies classées ailleurs ; H03.1 Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs ; H03.8 Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H00, H01, H02, H04, H05, H06
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H03/H03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H03/.

H04 — Affections de l'appareil lacrymal (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H00-H06 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : H04.0 Dacryoadénite ; H04.1 Autres affections des glandes lacrymales ; H04.2 Epiphora ; H04.3 Inflammation aiguë et sans précision des voies lacrymales ; H04.4 Inflammation chronique des voies lacrymales ; H04.5 Sténose et insuffisance des voies lacrymales ; H04.6 Autres lésions des voies lacrymales ; H04.8 Autres affections de l'appareil lacrymal ; H04.9 Affection de l'appareil lacrymal, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H00, H01, H02, H03, H05, H06
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H04/H04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H04/.

H05 — Affections de l'orbite (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H00-H06 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : H05.0 Inflammation aiguë de l'orbite ; H05.1 Affections inflammatoires chroniques de l'orbite ; H05.2 Exophtalmie ; H05.3 Déformation de l'orbite ; H05.4 Enophtalmie ; H05.5 Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite ; H05.8 Autres affections de l'orbite ; H05.9 Affection de l'orbite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H00, H01, H02, H03, H04, H06
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H05/H05_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H05/.

H06 — Affections de l'appareil lacrymal et de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H00-H06 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : H06.0 Affections de l'appareil lacrymal au cours de maladies classées ailleurs ; H06.1 Infection parasitaire de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs ; H06.2 Exophtalmie thyrotoïdique ; H06.3 Autres affections de l'orbite au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H00, H01, H02, H03, H04, H05
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H06/H06_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h06.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H06/.

H11 — Autres affections de la conjonctive (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H10-H13 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : H11.0 Ptérygion ; H11.1 Dépôts et affections dégénératives de la conjonctive ; H11.2 Cicatrices de la conjonctive ; H11.3 Hémorragie conjonctivale ; H11.4 Autres troubles vasculaires et kystes de la conjonctive ; H11.8 Autres affections précisées de la conjonctive ; H11.9 Affection de la conjonctive, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H10, H13
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H11/H11_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h11.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H11/.

H13 — Affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H10-H13 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : H13.0 Parasitose filarienne de la conjonctive ; H13.1 Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; H13.2 Conjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs ; H13.3 Pemphigoïde oculaire ; H13.8 Autres affections de la conjonctive au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H10, H11

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H13/H13_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h13.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H13/.

H15 — Affections de la sclérotique (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H15-H22 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : H15.0 Sclérite ; H15.1 Episclérite ; H15.8 Autres affections de la sclérotique ; H15.9 Affection de la sclérotique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H15/H15_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h15.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H15/.

H16 — Kératite (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H15-H22 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : H16.0 Ulcère de la cornée ; H16.1 Autres kératites superficielles sans conjonctivite ; H16.2 Kératoconjonctivite ; H16.3 Kératite interstitielle et profonde ; H16.4 Néovascularisation cornéenne ; H16.8 Autres kératites ; H16.9 Kératite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H15, H17, H18, H19, H20, H21, H22
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H16/H16_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h16.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H16/.

H17 — Cicatrices et opacités cornéennes (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H15-H22 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (4)** : H17.0 Leucome adhérent ; H17.1 Autres opacités cornéennes centrales ; H17.8 Autres cicatrices et opacités cornéennes ; H17.9 Cicatrice et opacité cornéennes, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H15, H16, H18, H19, H20, H21, H22
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H17/H17_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h17.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H17/.

H18 — Autres affections de la cornée (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H15-H22 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : H18.0 Pigmentation et dépôts cornéens ; H18.1 Kératopathie bulleuse ; H18.2 Autre œdème de la cornée ; H18.3 Lésions des membranes cornéennes ; H18.4 Dégénérescence de la cornée ; H18.5 Dystrophies cornéennes héréditaires ; H18.6 Kératocône ; H18.7 Autres déformations de la cornée ; H18.8 Autres affections précisées de la cornée ; H18.9 Affection de la cornée, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H15, H16, H17, H19, H20, H21, H22
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H18/H18_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h18.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H18/.

H19 — Affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H15-H22 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (5)** : H19.0 Sclérite et épisclérite au cours de maladies classées ailleurs ; H19.1 Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de l'herpès ; H19.2 Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; H19.3 Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies classées ailleurs ; H19.8 Autres affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H15, H16, H17, H18, H20, H21, H22
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/H19/H19_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h19.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H19/.

H20 — Iridocyclite (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H15-H22 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : H20.0 Iridocyclite aiguë et subaiguë ; H20.1 Iridocyclite chronique ; H20.2 Iridocyclite due aux lentilles de contact ; H20.8 Autres iridocyclites ; H20.9 Iridocyclite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H15, H16, H17, H18, H19, H21, H22
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H20/H20_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h20.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H20/.

H21 — Autres affections de l'iris et du corps ciliaire (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H15-H22 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : H21.0 Hyphéma ; H21.1 Autres affections vasculaires de l'iris et du corps ciliaire ; H21.2 Affections dégénératives de l'iris et du corps ciliaire ; H21.3 Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil ; H21.4 Membranes pupillaires ; H21.5 Autres adhérences et perturbations de l'iris et du corps ciliaire ; H21.8 Autres affections précisées de l'iris et du corps ciliaire ; H21.9 Affection de l'iris et du corps ciliaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H15, H16, H17, H18, H19, H20, H22
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H21/H21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H21/.

H22 — Affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H15-H22 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 33 (painful, red, itchy eyes; eye discharge), 38 (swelling of the eyelid). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : H22.0 Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; H22.1 Iridocyclite au cours d'autres maladies classées ailleurs ; H22.8 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H22/H22_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h22.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H22/.

H27 — Autres affections du cristallin (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H25-H28 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : H27.0 Aphakie ; H27.1 Luxation du cristallin ; H27.8 Autres affections précisées du cristallin ; H27.9 Affection du cristallin, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H25, H26, H28
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H27/H27_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h27.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H27/.

H28 — Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H25-H28 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : H28.0 Cataracte diabétique ; H28.1 Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ; H28.2 Cataracte au cours d'autres maladies classées ailleurs ; H28.8 Autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H25, H26, H27
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H28/H28_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h28.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H28/.

H30 — Choriorétinite (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H30-H36 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : H30.0 Chorioretinite en foyer ; H30.1 Chorioretinite disséminée ; H30.2 Cyclite postérieure ; H30.8 Autres chorioretinites ; H30.9 Chorioretinite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H31, H32, H33, H34, H35, H36
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H30/H30_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H30/.

H31 — Autres affections de la choroïde (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H30-H36 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : H31.0 Cicatrices chorioretiniennes ; H31.1 Dégénérescence choroïdienne ; H31.2 Dystrophie héréditaire de la choroïde ; H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde ; H31.4 Décollement de la choroïde ; H31.8 Autres affections précisées de la choroïde ; H31.9 Affection de la choroïde, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H30, H32, H33, H34, H35, H36
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H31/H31_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h31.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H31/.

H32 — Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H30-H36 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : H32.0 Affections chorioretiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; H32.8 Autres affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H30, H31, H33, H34, H35, H36
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/H32/H32_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h32.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H32/.

H33 — Décollement et déchirure de la rétine (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H30-H36 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : H33.0 Décollement de la rétine avec déchirure rétinienne ; H33.1 Rétinoschisis et kystes rétinien ; H33.2 Décollement séreux de la rétine ; H33.3 Déchirures rétinien sans décollement ; H33.4 Décollement par traction de la rétine ; H33.5 Autres décollements rétinien
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H30, H31, H32, H34, H35, H36
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H33/H33_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h33.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H33/.

H34 — Occlusions vasculaires rétinien (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H30-H36 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : H34.0 Occlusion transitoire de l'artère de la rétine ; H34.1 Occlusion de l'artère centrale de la rétine ; H34.2 Autres occlusions de l'artère de la rétine ; H34.8 Autres occlusions vasculaires rétinien ; H34.9 Occlusion vasculaire rétinienne, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H30, H31, H32, H33, H35, H36
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H34/H34_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h34.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H34/.

H35 — Autres affections rétinien (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H30-H36 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour).

Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : H35.0 Autres rétinopathies et altérations vasculaires rétiniennes ; H35.1 Rétinopathie de la prématurité ; H35.2 Autres rétinopathies proliférantes ; H35.3 Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur ; H35.4 Dégénérescence rétinienne périphérique ; H35.5 Dystrophie rétinienne héréditaire ; H35.6 Hémorragie rétinienne ; H35.7 Décollement des couches de la rétine ; H35.8 Autres affections rétiniennes précisées ; H35.9 Affection rétinienne, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H30, H31, H32, H33, H34, H36
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H35/H35_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H35/.

H36 — Affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H30-H36 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : H36.0 Rétinopathie diabétique ; H36.8 Autres affections rétiniennes au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H30, H31, H32, H33, H34, H35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H36/H36_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h36.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H36/.

H42 — Glaucome au cours de maladies classées ailleurs (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H40-H42 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : H42.0 Glaucome au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ; H42.8 Glaucome au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H40
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/H42/H42_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h42.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H42/.

H43 — Affections du corps vitré (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H43-H45 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : H43.0 Prolapsus du corps vitré ; H43.1 Hémorragie du corps vitré ; H43.2 Opacités cristallines du corps vitré ; H43.3 Autres opacités du corps vitré ; H43.8 Autres affections du corps vitré ; H43.9 Affection du corps vitré, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H44, H45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H43/H43_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h43.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H43/.

H44 — Affections du globe oculaire (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H43-H45 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : H44.0 Endophtalmie purulente ; H44.1 Autres endophtalmies ; H44.2 Myopie dégénérative ; H44.3 Autres affections dégénératives du globe oculaire ; H44.4 Hypotonie de l'œil ; H44.5 Dégénérescence du globe oculaire ; H44.6 Rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger magnétique ; H44.7 Rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger non magnétique ; H44.8 Autres affections du globe oculaire ; H44.9 Affection du globe oculaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H43, H45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H44/H44_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h44.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H44/.

H45 — Affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H43-H45 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour).

Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : H45.0 Hémorragie du corps vitré au cours de maladies classées ailleurs ; H45.1 Endophtalmie au cours de maladies classées ailleurs ; H45.8 Autres affections du corps vitré et du globe oculaire au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H43, H44
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H45/H45_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h45.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H45/.

H46 — Névrite optique (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H46-H48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H47, H48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H46/H46_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h46.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H46/.

H47 — Autres affections du nerf [II] et des voies optiques (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H46-H48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : H47.0 Affections du nerf optique, non classées ailleurs ; H47.1 Œdème papillaire, sans précision ; H47.2 Atrophie optique ; H47.3 Autres affections de la papille optique ; H47.4 Affections du chiasma optique ; H47.5 Affections des autres voies optiques ; H47.6 Affections du cortex visuel ; H47.7 Affection des voies optiques, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H46, H48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H47/H47_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h47.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H47/.

H48 — Affections du nerf [II] et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H46-H48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : H48.0 Atrophie optique au cours de maladies classées ailleurs ; H48.1 Névrite rétrobulbaire au cours de maladies classées ailleurs ; H48.8 Autres affections du nerf et des voies optiques au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H46, H47
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H48/H48_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h48.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H48/.

H49 — Strabisme paralytique (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H49-H52 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 17 (abnormal eye movements), 36 (squint (strabismus)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : H49.0 Paralysie du nerf moteur oculaire commun (III) ; H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV) ; H49.2 Paralysie du nerf moteur oculaire externe (VI) ; H49.3 Ophtalmoplégie totale (externe) ; H49.4 Ophtalmoplégie externe progressive ; H49.8 Autres strabismes paralytiques ; H49.9 Strabisme paralytique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H50, H51, H52
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H49/H49_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h49.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H49/.

H50 — Autres strabismes (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H49-H52 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 17 (abnormal eye movements), 36 (squint (strabismus)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : H50.0 Strabisme convergent concomitant ; H50.1 Strabisme divergent concomitant ; H50.2 Strabisme vertical ; H50.3 Hétérotropie intermittente ; H50.4 Hétérotropies, autres et sans précision ; H50.5 Hétérophorie ; H50.6 Strabisme mécanique ; H50.8 Autres strabismes précisés ; H50.9 Strabisme, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H49, H51, H52

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H50/H50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H50/.

H51 — Autres anomalies des mouvements binoculaires (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H49-H52 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 17 (abnormal eye movements), 36 (squint (strabismus)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : H51.0 Paralysie de la conjugaison du regard ; H51.1 Excès et insuffisance de convergence ; H51.2 Ophtalmoplégie internucléaire ; H51.8 Autres anomalies précisées des mouvements binoculaires ; H51.9 Anomalie des mouvements binoculaires, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H49, H50, H52
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H51/H51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H51/.

H53 — Troubles de la vision (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H53-H54 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : H53.0 Amblyopie ex anopsia ; H53.1 Troubles subjectifs de la vision ; H53.2 Diplopie ; H53.3 Autres troubles de la vision binoculaire ; H53.4 Anomalies du champ visuel ; H53.5 Troubles de la vision des couleurs ; H53.6 Cécité nocturne ; H53.8 Autres troubles de la vision ; H53.9 Trouble de la vision, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H54
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H53/H53_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H53/.

H54 — Cécité et baisse de la vision (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VII** · bloc H53-H54 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 18 (acute and gradual loss of vision (acute, slow, temporary, partial)), 39 (visual disturbances, photophobia, light flashes, floating objects, diplopia, colour). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : H54.0 Cécité et forte baisse de la vision binoculaire ; H54.1 Atteinte sévère de la vision binoculaire ; H54.2 Atteinte modérée de la vision binoculaire ; H54.3 Atteinte légère de la vision binoculaire ; H54.4 Cécité et forte baisse de la vision monoculaire ; H54.5 Atteinte sévère de la vision monoculaire ; H54.6 Atteinte moyennement sévère de la vision monoculaire ; H54.9 Atteinte de la vision (binoculaire) non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : H53
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/H54/H54_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/h54.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/H54/.

Q10 — Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q10-Q18 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : Q10.0 Ptosis congénital ; Q10.1 Ectropion congénital ; Q10.2 Entropion congénital ; Q10.3 Autres malformations congénitales des paupières ; Q10.4 Absence et agénésie de l'appareil lacrymal ; Q10.5 Sténose ou rétrécissement congénital du canal lacrymal ; Q10.6 Autres malformations congénitales de l'appareil lacrymal ; Q10.7 Malformation congénitale de l'orbite
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q11, Q12, Q13, Q14, Q15
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q10/Q10_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/Q10/.

Q11 — Anophtalmie, microphthalmie et macrophtalmie (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q10-Q18 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : Q11.0 Œil kystique [cystic eyeball] ; Q11.1 Autres formes d'anophtalmie ; Q11.2 Microphthalmie ; Q11.3 Macrophtalmie
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q10, Q12, Q13, Q14, Q15
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8.

Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Q11/Q11_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q11.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/Q11/.

Q12 — Malformations congénitales du cristallin (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q10-Q18 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : Q12.0 Cataracte congénitale ; Q12.1 Luxation congénitale du cristallin ; Q12.2 Colobome du cristallin ; Q12.3 Aphakie congénitale ; Q12.4 Sphérophakie ; Q12.8 Autres malformations congénitales du cristallin ; Q12.9 Malformation congénitale du cristallin, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q10, Q11, Q13, Q14, Q15
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q12/Q12_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q12.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/Q12/.

Q13 — Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q10-Q18 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : Q13.0 Colobome de l'iris ; Q13.1 Absence d'iris ; Q13.2 Autres malformations congénitales de l'iris ; Q13.3 Opacité congénitale de la cornée ; Q13.4 Autres malformations congénitales de la cornée ; Q13.5 Sclérotique bleue ; Q13.8 Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil ; Q13.9 Malformation congénitale de la chambre antérieure de l'œil, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q10, Q11, Q12, Q14, Q15
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q13/Q13_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q13.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/Q13/.

Q14 — Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q10-Q18 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré ; Q14.1 Malformation congénitale de la rétine ; Q14.2 Malformation congénitale de la papille optique ; Q14.3 Malformation congénitale de la choroïde ; Q14.8 Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil ; Q14.9 Malformation congénitale de la chambre postérieure de l'œil, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q10, Q11, Q12, Q13, Q15
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q14/Q14_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q14.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/Q14/.

Q15 — Autres malformations congénitales de l'œil (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q10-Q18 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : Q15.0 Glaucome congénital ; Q15.8 Autres malformations congénitales précisées de l'œil ; Q15.9 Malformation congénitale de l'œil, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q10, Q11, Q12, Q13, Q14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q15/Q15_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q15.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/Q15/.

S05 — Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S00-S09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 112 (head and brain injuries and trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : S05.0 Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps étranger ; S05.1 Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite ; S05.2 Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire ; S05.3 Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intraoculaire ; S05.4 Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger ; S05.5 Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger

; S05.6 Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger ; S05.7 Arrachement de l'œil ; S05.8 Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite ; S05.9 Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite, non précisée

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S05/S05_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/S05/.

T15 — Corps étranger dans la partie externe de l'œil (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T15-T19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 111 (foreign body). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : T15.0 Corps étranger dans la cornée ; T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival ; T15.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans la partie externe de l'œil ; T15.9 Corps étranger dans la partie externe de l'œil, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T15/T15_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t15.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/T15/.

T26 — Brûlure et corrosion limitées à l'œil et ses annexes (O-18-Ophtalmologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T26-T28 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T26.0 Brûlure de la paupière et de la région périoculaire ; T26.1 Brûlure de la cornée et du sac conjonctival ; T26.2 Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire ; T26.3 Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes ; T26.4 Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée ; T26.5 Corrosion de la paupière et de la région périoculaire ; T26.6 Corrosion de la cornée et du sac conjonctival ; T26.7 Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire ; T26.8 Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes ; T26.9 Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T26/T26_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t26.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-18-Ophtalmologie/travail/T26/.

M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie

95 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 4 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : SSMUS (urgence), Tox Info Suisse, Suva ; ERC.

T14 — Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T08-T14 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T14.0 Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non précisée ; T14.1 Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée ; T14.2 Fracture d'une partie du corps non précisée ; T14.3 Luxation, entorse et foulure d'une partie du corps non précisée ; T14.4 Lésion traumatique de nerf(s) d'une partie du corps non précisée ; T14.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée ; T14.6 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du corps non précisée ; T14.7 Écrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée ; T14.8 Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée ; T14.9 Lésion traumatique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T08, T09, T10, T11, T12, T13
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T14/T14_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t14.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T14/.

T39 — Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatismaux (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : T39.0 Intoxication: Salicylés ; T39.1 Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol ; T39.2 Intoxication: Dérivés pyrazolés ; T39.3 Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] ; T39.4 Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs ; T39.8 Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs ; T39.9 Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T36, T37, T38, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T39/T39_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t39.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T39/.

T40 — Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P1

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T40.0 Intoxication: Opium ; T40.1 Intoxication: Héroïne ; T40.2 Intoxication: Autres opioïdes ; T40.3 Intoxication: Méthadone ; T40.4 Intoxication: Autres narcotiques synthétiques ; T40.5 Intoxication: Cocaïne ; T40.6 Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision ; T40.7 Intoxication: Cannabis (dérivés) ; T40.8 Intoxication: Lysergide [LSD] ; T40.9 Intoxication: Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T36, T37, T38, T39, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T40/T40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T40/.

T50 — Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T50.0 Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes ; T50.1 Intoxication: Diurétiques de l'anse ; T50.2 Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ; T50.3 Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique ; T50.4 Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique ; T50.5 Intoxication: Anorexigènes ; T50.6 Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs ; T50.7 Intoxication: Analeptiques et antagonistes des opiacés ; T50.8 Intoxication: Agents de diagnostic ; T50.9 Intoxication: Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T50/T50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T50/.

S09 — Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S00-S09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 112 (head and brain injuries and trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un

quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S09.0 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non classée ailleurs ; S09.1 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête ; S09.2 Rupture traumatique du tympan ; S09.7 Lésions traumatiques multiples de la tête ; S09.8 Autres lésions traumatiques précisées de la tête ; S09.9 Lésion traumatique de la tête, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S09/S09_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s09.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S09/.

S17 — Écrasement du cou (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S10-S19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 115 (spine injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S17.0 Écrasement du larynx et de la trachée ; S17.8 Écrasement d'autres parties du cou ; S17.9 Écrasement du cou, partie non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S18, S19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S17/S17_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s17.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S17/.

S18 — Amputation traumatique au niveau du cou (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S10-S19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 115 (spine injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S17, S19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S18/S18_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s18.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S18/.

S19 — Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S10-S19 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 115 (spine injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S19.7 Lésions traumatiques multiples du cou ; S19.8 Autres lésions traumatiques précisées du cou ; S19.9 Lésion traumatique du cou, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S17, S18
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S19/S19_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s19.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S19/.

S28 — Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S20-S29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 116 (thoracic injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : S28.0 Écrasement du thorax ; S28.1 Amputation traumatique d'une partie du thorax
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S28/S28_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s28.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S28/.

S33 — Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S30-S39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 106 (abdominal injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : S33.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire ; S33.1 Luxation d'une vertèbre lombaire ; S33.2 Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne ; S33.3 Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin ; S33.4 Rupture traumatique de la symphyse pubienne ; S33.5 Entorse et foulure du rachis lombaire ; S33.6 Entorse et foulure de l'articulation sacro-iliaque ; S33.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S38, S39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S33/S33_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s33.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S33/.

S38 — Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S30-S39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 106 (abdominal injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : S38.0 Écrasement des organes génitaux externes ; S38.1 Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin ; S38.2 Amputation traumatique des organes génitaux externes ; S38.3 Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S33, S39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S38/S38_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s38.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S38/.

S39 — Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S30-S39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 106 (abdominal injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : S39.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin ; S39.6 Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s) ; S39.7 Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin ; S39.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin ; S39.9 Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S33, S38
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S39/S39_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s39.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S39/.

S40 — Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S40-S49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : S40.0 Contusion de l'épaule et du bras ; S40.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'épaule et du bras ; S40.8 Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras ; S40.9 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S47, S48, S49

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S40/S40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S40/.

S47 — Écrasement de l'épaule et du bras (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S40-S49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S40, S48, S49
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S47/S47_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s47.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S47/.

S48 — Amputation traumatique de l'épaule et du bras (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S40-S49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S48.0 Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule ; S48.1 Amputation traumatique entre l'épaule et le coude ; S48.9 Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S40, S47, S49
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S48/S48_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s48.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S48/.

S49 — Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S40-S49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S49.7 Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras ; S49.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras ; S49.9 Lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S40, S47, S48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S49/S49_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s49.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S49/.

S50 — Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S50-S59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : S50.0 Contusion du coude ; S50.1 Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras ; S50.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'avant-bras ; S50.8 Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras ; S50.9 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S57, S58, S59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S50/S50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S50/.

S57 — Écrasement de l'avant-bras (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S50-S59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S57.0 Écrasement du coude ; S57.8 Écrasement d'autres parties de l'avant-bras ; S57.9 Écrasement de l'avant-bras, partie non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S50, S58, S59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S57/S57_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s57.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S57/.

S58 — Amputation traumatique de l'avant-bras (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S50-S59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S58.0 Amputation traumatique à dans l'articulation du coude ; S58.1 Amputation traumatique entre le coude et le poignet ; S58.9 Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S50, S57, S59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S58/S58_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s58.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S58/.

S59 — Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S50-S59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S59.7 Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras ; S59.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'avant-bras ; S59.9 Lésion traumatique de l'avant-bras, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S50, S57, S58
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S59/S59_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s59.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S59/.

S60 — Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S60-S69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S60.0 Contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle ; S60.1 Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle ; S60.2 Contusion d'autres parties du poignet et de la main ; S60.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du poignet et de la main ; S60.8 Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main ; S60.9 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S67, S68, S69

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S60/S60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S60/.

S67 — Écrasement du poignet et de la main (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S60-S69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : S67.0 Écrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s) ; S67.8 Écrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S60, S68, S69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S67/S67_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s67.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S67/.

S68 — Amputation traumatique du poignet et de la main (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S60-S69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : S68.0 Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle) ; S68.1 Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle) ; S68.2 Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète) (partielle) ; S68.3 Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main ; S68.4 Amputation traumatique de la main au niveau du poignet ; S68.8 Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la main ; S68.9 Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S60, S67, S69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S68/S68_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s68.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S68/.

S69 — Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S60-S69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S69.7 Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main ; S69.8 Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main ; S69.9 Lésion traumatique du poignet et de la main, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S60, S67, S68
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S69/S69_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s69.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S69/.

S70 — Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S70-S79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : S70.0 Contusion de la hanche ; S70.1 Contusion de la cuisse ; S70.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la hanche et de la cuisse ; S70.8 Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse ; S70.9 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S77, S78, S79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S70/S70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S70/.

S77 — Écrasement de la hanche et de la cuisse (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S70-S79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S77.0 Écrasement de la hanche ; S77.1 Écrasement de la cuisse ; S77.2 Écrasement de la hanche et de la cuisse
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S70, S78, S79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail,

assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/S77/S77_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s77.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S77/](#).

S78 — Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S70-S79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S78.0 Amputation traumatique de l'articulation de la hanche ; S78.1 Amputation traumatique entre la hanche et le genou ; S78.9 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S70, S77, S79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S78/S78_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s78.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S78/](#).

S79 — Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S70-S79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S79.7 Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse ; S79.8 Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la cuisse ; S79.9 Lésion traumatique de la hanche et de la cuisse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S70, S77, S78
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S79/S79_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s79.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S79/](#).

S80 — Lésion traumatique superficielle de la jambe (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S80-S89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (5)** : S80.0 Contusion du genou ; S80.1 Contusion de parties autres et non précisées de la jambe ; S80.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe ; S80.8 Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe ; S80.9 Lésion traumatique superficielle de la jambe, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S87, S88, S89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S80/S80_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s80.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S80/.

S87 — Écrasement de la jambe (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S80-S89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (2)** : S87.0 Écrasement du genou ; S87.8 Écrasement de parties autres et non précisées de la jambe
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S80, S88, S89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S87/S87_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s87.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S87/.

S88 — Amputation traumatique de la jambe (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S80-S89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (3)** : S88.0 Amputation traumatique au niveau du genou ; S88.1 Amputation traumatique entre le genou et la cheville ; S88.9 Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S80, S87, S89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S88/S88_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s88.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S88/.

S89 — Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S80-S89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S89.7 Lésions traumatiques multiples de la jambe ; S89.8 Autres lésions traumatiques précisées de la jambe ; S89.9 Lésion traumatique de la jambe, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S80, S87, S88
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S89/S89_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s89.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S89/.

S90 — Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S90-S99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : S90.0 Contusion de la cheville ; S90.1 Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle ; S90.2 Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle ; S90.3 Contusion de parties autres et non précisées du pied ; S90.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la cheville et du pied ; S90.8 Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied ; S90.9 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S97, S98, S99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S90/S90_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s90.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S90/.

S97 — Écrasement de la cheville et du pied (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S90-S99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S97.0 Écrasement de la cheville ; S97.1 Écrasement d'un (des) orteil(s) ; S97.8 Écrasement d'autres parties de la cheville et du pied
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S90, S98, S99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et

bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/S97/S97_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s97.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S97/.

S98 — Amputation traumatique de la cheville et du pied (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S90-S99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : S98.0 Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville ; S98.1 Amputation traumatique d'un orteil ; S98.2 Amputation traumatique de deux orteils ou plus ; S98.3 Amputation traumatique d'autres parties du pied ; S98.4 Amputation traumatique du pied, niveau non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S90, S97, S99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S98/S98_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s98.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S98/.

S99 — Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S90-S99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S99.7 Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied ; S99.8 Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied ; S99.9 Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S90, S97, S98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S99/S99_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s99.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/S99/.

T00 — Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T00-T07 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : T00.0 Lésions traumatiques superficielles de la tête avec lésions traumatiques superficielles du cou ; T00.1 Lésions traumatiques superficielles du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin ; T00.2 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) ; T00.3 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) ; T00.6 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membres(s) inférieur(s) ; T00.8 Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres associations de parties du corps ; T00.9 Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T00/T00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T00/.

T01 — Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T00-T07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : T01.0 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou ; T01.1 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin ; T01.2 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) ; T01.3 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) ; T01.6 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s) ; T01.8 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps ; T01.9 Plaies ouvertes multiples, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T00, T02, T03, T04, T05, T06, T07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T01/T01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T01/.

T02 — Fractures de plusieurs parties du corps (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T00-T07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : T02.0 Fractures de la tête avec fractures du cou ; T02.1 Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin ; T02.2 Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur ; T02.3 Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur ; T02.4

Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs ; T02.5 Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs ; T02.6 Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ; T02.7 Fractures du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membre(s), ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ; T02.8 Fractures avec d'autres associations de parties du corps ; T02.9 Fractures multiples, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T00, T01, T03, T04, T05, T06, T07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T02/T02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T02/.

T03 — Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T00-T07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : T03.0 Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et foulures du cou ; T03.1 Luxations, entorses et foulures du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ; T03.2 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) ; T03.3 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) ; T03.4 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ; T03.8 Luxations, entorses et foulures avec d'autres associations de parties du corps ; T03.9 Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T00, T01, T02, T04, T05, T06, T07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T03/T03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T03/.

T04 — Écrasements de plusieurs parties du corps (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T00-T07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : T04.0 Écrasement de la tête avec écrasement du cou ; T04.1 Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ; T04.2 Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) ; T04.3 Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s) ; T04.4 Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ; T04.7 Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du

thorax, du bassin et de(s) membre(s) ; T04.8 Écrasement d'autres associations de parties du corps ; T04.9 Écrasements multiples, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T00, T01, T02, T03, T05, T06, T07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T04/T04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T04/.

T05 — Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T00-T07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : T05.0 Amputation traumatique des deux mains ; T05.1 Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la main] ; T05.2 Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout niveau] ; T05.3 Amputation traumatique des deux pieds ; T05.4 Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le pied] ; T05.5 Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau] ; T05.6 Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau] ; T05.8 Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps ; T05.9 Amputations traumatiques multiples, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T00, T01, T02, T03, T04, T06, T07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T05/T05_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T05/.

T06 — Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T00-T07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : T06.0 Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou ; T06.1 Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps ; T06.2 Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps ; T06.3 Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps ; T06.4 Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs parties du corps ; T06.5 Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et intra-abdominaux ou des organes intrathoraciques et pelviens ; T06.8 Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du corps
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T00, T01, T02, T03, T04, T05, T07

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T06/T06_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t06.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T06/.

T07 — Lésions traumatiques multiples, sans précision (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T00-T07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T00, T01, T02, T03, T04, T05, T06
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T07/T07_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t07.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T07/.

T08 — Fracture du rachis, niveau non précisé (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T08-T14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : T08.0 Fracture du rachis, niveau non précisé: fermée ou SAI ; T08.1 Fracture du rachis, niveau non précisé: ouverte
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T09, T10, T11, T12, T13, T14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T08/T08_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t08.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T08/.

T09 — Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T08-T14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (9)** : T09.0 Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé ; T09.1 Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé ; T09.2 Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du tronc ; T09.3 Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé ; T09.4 Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés ; T09.5 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du tronc ; T09.6 Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé ; T09.8 Autres lésions traumatiques précisées du tronc, niveau non précisé ; T09.9 Lésion traumatique non précisée du tronc, niveau non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T08, T10, T11, T12, T13, T14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T09/T09_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t09.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T09/.

T10 — Fracture du membre supérieur, niveau non précisé (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T08-T14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (2)** : T10.0 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé: fracture ou SAI ; T10.1 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé: ouverte
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T08, T09, T11, T12, T13, T14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T10/T10_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T10/.

T11 — Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T08-T14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (9)** : T11.0 Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau non précisé ; T11.1 Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé ; T11.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre supérieur, niveau non précisé ; T11.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre supérieur, niveau non précisé ; T11.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé ; T11.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre supérieur, niveau non précisé ; T11.6 Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non précisé ; T11.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur, niveau non précisé ; T11.9 Lésion traumatique non précisée du membre supérieur, niveau non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T08, T09, T10, T12, T13, T14

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T11/T11_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t11.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T11/.

T12 — Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T08-T14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : T12.0 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé: fermée ou SAI ; T12.1 Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé: ouverte
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T08, T09, T10, T11, T13, T14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T12/T12_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t12.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T12/.

T13 — Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T08-T14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 108 (contusion, soft tissue bruising), 114 (laceration, closed or open wound), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : T13.0 Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé ; T13.1 Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé ; T13.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre inférieur, niveau non précisé ; T13.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur, niveau non précisé ; T13.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé ; T13.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre inférieur, niveau non précisé ; T13.6 Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé ; T13.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur, niveau non précisé ; T13.9 Lésion traumatique non précisée du membre inférieur, niveau non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T08, T09, T10, T11, T12, T14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T13/T13_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t13.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T13/.

T36 — Intoxication par antibiotiques systémiques (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T36.0 Intoxication: Pénicillines ; T36.1 Intoxication: Céphalosporines et autres bêtalactamines ; T36.2 Intoxication: Groupe du chloramphénicol ; T36.3 Intoxication: Macrolides ; T36.4 Intoxication: Tétracyclines ; T36.5 Intoxication: Aminosides ; T36.6 Intoxication: Rifamycines ; T36.7 Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale ; T36.8 Intoxication: Autres antibiotiques systémiques ; T36.9 Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T36/T36_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t36.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T36/.

T37 — Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : T37.0 Intoxication: Sulfamides ; T37.1 Intoxication: Antimycobactériens ; T37.2 Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang ; T37.3 Intoxication: Autres antiprotozoaires ; T37.4 Intoxication: Anthelminthiques ; T37.5 Intoxication: Antiviraux ; T37.8 Intoxication: Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés ; T37.9 Intoxication: Anti-infectieux et antiparasitaire systémiques, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T36, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T37/T37_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t37.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T37/.

T38 — Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle :

chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T38.0 Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues synthétiques ; T38.1 Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés ; T38.2 Intoxication: Anti-thyroïdiens ; T38.3 Intoxication: Insuline et hypoglycémifiants oraux [antidiabétiques] ; T38.4 Intoxication: Contraceptifs oraux ; T38.5 Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs ; T38.6 Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs ; T38.7 Intoxication: Androgènes et autres anabolisants ; T38.8 Intoxication: Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision ; T38.9 Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T36, T37, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T38/T38_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t38.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T38/.

T41 — Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : T41.0 Intoxication: Anesthésiques gazeux ; T41.1 Intoxication: Anesthésiques intraveineux ; T41.2 Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans précision ; T41.3 Intoxication: Anesthésiques locaux ; T41.4 Intoxication: Anesthésique, sans précision ; T41.5 Intoxication: Gaz thérapeutiques
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T36, T37, T38, T39, T40, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T41/T41_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t41.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T41/.

T42 — Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et antiparkinsoniens (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : T42.0 Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne ; T42.1 Intoxication: Iminostilbènes ; T42.2 Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones ; T42.3 Intoxication: Barbituriques ; T42.4 Intoxication: Benzodiazépines ; T42.5 Intoxication: Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs ; T42.6 Intoxication: Autres anti-épileptiques,

sédatifs et hypnotiques ; T42.7 Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision ; T42.8 Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T42/T42_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t42.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T42/.

T43 — Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : T43.0 Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques ; T43.1 Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase ; T43.2 Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés ; T43.3 Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine ; T43.4 Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène ; T43.5 Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés ; T43.6 Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d'abus ; T43.8 Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs ; T43.9 Intoxication: Médicament psychotrope, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T43/T43_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t43.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T43/.

T44 — Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T44.0 Intoxication: Anticholinestérasiques ; T44.1 Intoxication: Autres parasympathomimétiques [cholinergiques] ; T44.2 Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs ; T44.3 Intoxication: Autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ; T44.4 Intoxication: Agents principalement alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs ; T44.5 Intoxication: Agents principalement bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs ; T44.6 Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs ; T44.7 Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs ; T44.8 Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non

classés ailleurs ; T44.9 Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T45, T46, T47, T48, T49, T50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T44/T44_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t44.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T44/.

T45 — Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T45.0 Intoxication: Médicaments antiallergiques et antiémétiques ; T45.1 Intoxication: Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs ; T45.2 Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs ; T45.3 Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs ; T45.4 Intoxication: Fer et ses composés ; T45.5 Intoxication: Anticoagulants ; T45.6 Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse ; T45.7 Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants ; T45.8 Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques ; T45.9 Intoxication: Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T46, T47, T48, T49, T50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T45/T45_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t45.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T45/.

T46 — Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T46.0 Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire ; T46.1 Intoxication: Inhibiteurs calciques ; T46.2 Intoxication: Autres antiarythmiques, non classés ailleurs ; T46.3 Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs ; T46.4 Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion ; T46.5 Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs ; T46.6 Intoxication: Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants ; T46.7 Intoxication: Vasodilatateurs périphériques ; T46.8 Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants ; T46.9 Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T47, T48, T49, T50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T46/T46_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t46.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T46/.

T47 — Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T47.0 Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H2 ; T47.1 Intoxication: Autres antiacides et antiscrétroires gastriques ; T47.2 Intoxication: Laxatifs stimulants ; T47.3 Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques ; T47.4 Intoxication: Autres laxatifs ; T47.5 Intoxication: Médicaments facilitant la digestion ; T47.6 Intoxication: Antidiarrhéiques ; T47.7 Intoxication: Emétiques ; T47.8 Intoxication: Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal ; T47.9 Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T48, T49, T50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T47/T47_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t47.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T47/.

T48 — Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : T48.0 Intoxication: Ocytotoxiques ; T48.1 Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuromusculaires] ; T48.2 Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision ; T48.3 Intoxication: Antitussifs ; T48.4 Intoxication: Expectorants ; T48.5 Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume banal] ; T48.6 Intoxication: Antiasthmatiques, non classés ailleurs ; T48.7 Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T49, T50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et

bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/T48/T48_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t48.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T48/.

T49 — Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T36-T50 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T49.0 Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ; T49.1 Intoxication: Antiprurigineux ; T49.2 Intoxication: Astringents et détergents locaux ; T49.3 Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs ; T49.4 Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires ; T49.5 Intoxication: Médicaments et préparations ophtalmologiques ; T49.6 Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie ; T49.7 Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique ; T49.8 Intoxication: Autres topiques ; T49.9 Intoxication: Topique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T49/T49_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t49.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T49/.

T51 — Effet toxique de l'alcool (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : T51.0 Effet toxique: Ethanol ; T51.1 Effet toxique: Méthanol ; T51.2 Effet toxique: 2-Propanol ; T51.3 Effet toxique: Huile de fusel ; T51.8 Effet toxique: Autres alcools ; T51.9 Effet toxique: Alcool, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/T51/T51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T51/.

T52 — Effet toxique de solvants organiques (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : T52.0 Effet toxique: Produits dérivés du pétrole ; T52.1 Effet toxique: Benzène ; T52.2 Effet toxique: Homologues du benzène ; T52.3 Effet toxique: Glycols ; T52.4 Effet toxique: Cétones ; T52.8 Effet toxique: Autres solvants organiques ; T52.9 Effet toxique: Solvant organique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T51, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T52/T52_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t52.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T52/.

T53 — Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : T53.0 Effet toxique: Tétrachlorure de carbone ; T53.1 Effet toxique: Chloroforme ; T53.2 Effet toxique: Trichloréthylène ; T53.3 Effet toxique: Tétrachloréthylène ; T53.4 Effet toxique: Dichlorométhane ; T53.5 Effet toxique: Chlorofluorocarbures ; T53.6 Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques ; T53.7 Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques ; T53.9 Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T51, T52, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T53/T53_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T53/.

T54 — Effet toxique de substances corrosives (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : T54.0 Effet toxique: Phénol et homologues du phénol ; T54.1 Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs ; T54.2 Effet toxique: Acides corrosifs et substances similaires ; T54.3 Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances similaires ; T54.9 Effet toxique: Substance corrosive, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T51, T52, T53, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T54/T54_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t54.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T54/.

T55 — Effet toxique de savons et détergents (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T51, T52, T53, T54, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T55/T55_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t55.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T55/.

T56 — Effet toxique des métaux (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T56.0 Effet toxique: Plomb et ses composés ; T56.1 Effet toxique: Mercure et ses composés ; T56.2 Effet toxique: Chrome et ses composés ; T56.3 Effet toxique: Cadmium et ses composés ; T56.4 Effet toxique: Cuivre et ses composés ; T56.5 Effet toxique: Zinc et ses composés ; T56.6 Effet toxique: Etain et ses composés ; T56.7 Effet toxique: Béryllium et ses composés ; T56.8 Effet toxique: Autres métaux ; T56.9 Effet toxique: Métal, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T51, T52, T53, T54, T55, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail,

assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/T56/T56_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t56.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T56/.

T57 — Effet toxique d'autres substances non organiques (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : T57.0 Effet toxique: Arsenic et ses composés ; T57.1 Effet toxique: Phosphore et ses composés ; T57.2 Effet toxique: Manganèse et ses composés ; T57.3 Effet toxique: Cyanure d'hydrogène ; T57.8 Effet toxique: Autres substances non organiques précisées ; T57.9 Effet toxique: Substance non organique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T51, T52, T53, T54, T55, T56, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T57/T57_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t57.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T57/.

T58 — Effet toxique du monoxyde de carbone (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T58/T58_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t58.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T58/.

T59 — Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : T59.0 Effet toxique: Oxydes d'azote ; T59.1 Effet toxique: Dioxyde de soufre ; T59.2 Effet toxique: Formaldéhyde ; T59.3 Effet toxique: Gaz lacrymogène ; T59.4 Effet toxique: Chlore gazeux ; T59.5 Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène ; T59.6 Effet toxique: Sulfure d'hydrogène ; T59.7 Effet toxique: Dioxyde de carbone ; T59.8 Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées précisés ; T59.9 Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T60, T61, T62, T63, T64, T65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T59/T59_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t59.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T59/.

T60 — Effet toxique de pesticides (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : T60.0 Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et carbamates ; T60.1 Effet toxique: Insecticides halogénés ; T60.2 Effet toxique: autres insecticides et insecticides sans autre précision ; T60.3 Effet toxique: Herbicides et fongicides ; T60.4 Effet toxique: Rodenticides ; T60.8 Effet toxique: Autres pesticides ; T60.9 Effet toxique: Pesticide, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T61, T62, T63, T64, T65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T60/T60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T60/.

T61 — Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (5)** : T61.0 Ciguatera ; T61.1 Intoxication par poissons scombridés ; T61.2 Autres intoxications par poissons et coquillages ; T61.8 Effets toxiques d'autres fruits de mer ; T61.9 Effets toxiques d'un fruit de mer non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T62, T63, T64, T65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail,

assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/T61/T61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T61/.

T62 — Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : T62.0 Effet toxique: Champignons ingérés ; T62.1 Effet toxique: Baies ingérées ; T62.2 Effet toxique: Autres (parties de) plantes ingérées ; T62.8 Effet toxique: Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments ; T62.9 Effet toxique: Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T63, T64, T65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T62/T62_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T62/.

T63 — Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : T63.0 Effet toxique: Venin de serpent ; T63.1 Effet toxique: Venin d'autres reptiles ; T63.2 Effet toxique: Venin de scorpion ; T63.3 Effet toxique: Venin d'araignée ; T63.4 Effet toxique: Venin d'autres arthropodes ; T63.5 Effet toxique d'un contact avec des poissons ; T63.6 Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins ; T63.8 Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux ; T63.9 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T64, T65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T63/T63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T63/.

T64 — Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T64/T64_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t64.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T64/.

T65 — Effet toxique de substances autres et non précisées (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T51-T65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 211 (intoxication, poisoning), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : T65.0 Effet toxique: Cyanures ; T65.1 Effet toxique: Strychnine et ses sels ; T65.2 Effet toxique: Tabac et nicotine ; T65.3 Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues ; T65.4 Effet toxique: Sulfure de carbone ; T65.5 Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques ; T65.6 Effet toxique: Peintures et teintures, non classées ailleurs ; T65.8 Effets toxiques d'autres substances précisées ; T65.9 Effet toxique d'une substance, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T65/T65_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t65.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T65/.

T66 — Effets de rayonnements, sans précision (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T66-T78 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 110 (drowning or near drowning), 211 (intoxication, poisoning). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T67, T68, T69, T70, T71, T73, T74, T75, T76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi

→ 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/T66/T66_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/t66.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T66/](#).

T67 — Effets de la chaleur et de la lumière (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T66-T78 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 110 (drowning or near drowning), 211 (intoxication, poisoning). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T67.0 Coup de chaleur et insolation ; T67.1 Syncope due à la chaleur ; T67.2 Crampes dues à la chaleur ; T67.3 Épuisement dû à la chaleur avec perte hydrique ; T67.4 Épuisement dû à la chaleur avec perte de sel ; T67.5 Épuisement dû à la chaleur, sans précision ; T67.6 Fatigue transitoire due à la chaleur ; T67.7 Œdème dû à la chaleur ; T67.8 Autres effets de la chaleur et de la lumière ; T67.9 Effet de la chaleur et de la lumière, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T66, T68, T69, T70, T71, T73, T74, T75, T76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/T67/T67_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/t67.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T67/](#).

T68 — Hypothermie (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T66-T78 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 110 (drowning or near drowning), 211 (intoxication, poisoning). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T66, T67, T69, T70, T71, T73, T74, T75, T76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/T68/T68_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/t68.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T68/](#).

T69 — Autres effets d'une baisse de la température (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T66-T78 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 110 (drowning or near drowning), 211 (intoxication, poisoning). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : T69.0 Main et pied d'immersion ; T69.1 Engelures ; T69.8 Autres effets précisés d'une baisse de la température ; T69.9 Effet d'une baisse de la température, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T66, T67, T68, T70, T71, T73, T74, T75, T76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T69/T69_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t69.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T69/.

T70 — Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T66-T78 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 110 (drowning or near drowning), 211 (intoxication, poisoning). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : T70.0 Barotraumatisme de l'oreille ; T70.1 Barotraumatisme des sinus ; T70.2 Effets de l'altitude, autres et non précisés ; T70.3 Maladie des caissons [maladie de la décompression] ; T70.4 Effets des fluides à haute pression ; T70.8 Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau ; T70.9 Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T66, T67, T68, T69, T71, T73, T74, T75, T76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T70/T70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T70/.

T71 — Asphyxie (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T66-T78 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 110 (drowning or near drowning), 211 (intoxication, poisoning). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T66, T67, T68, T69, T70, T73, T74, T75, T76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T71/T71_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T71/.

T73 — Effets d'autres privations (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T66-T78 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 110 (drowning or near drowning), 211 (intoxication, poisoning). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : T73.0 Effets de la faim ; T73.1 Effets de la soif ; T73.2 Épuisement dû aux éléments ; T73.3 Épuisement dû à un effort intensif ; T73.8 Autres effets dus à une privation ; T73.9 Effet dû à une privation, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T66, T67, T68, T69, T70, T71, T74, T75, T76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T73/T73_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t73.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T73/.

T74 — Syndromes dus à de mauvais traitements (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T66-T78 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 110 (drowning or near drowning), 211 (intoxication, poisoning). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : T74.0 Délaissement et abandon ; T74.1 Sévices physiques ; T74.2 Sévices sexuels ; T74.3 Sévices psychologiques ; T74.8 Autres syndromes dus à de mauvais traitements ; T74.9 Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T66, T67, T68, T69, T70, T71, T73, T75, T76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T74/T74_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t74.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T74/.

T75 — Effets d'autres causes externes (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T66-T78 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 110 (drowning or near drowning), 211 (intoxication, poisoning). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : T75.0 Effets de la foudre ; T75.1 Noyade et submersion non mortelle ; T75.2 Effets des vibrations ; T75.3 Cinétose ; T75.4 Effets du courant électrique ; T75.8 Autres effets précisés d'autres causes externes
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T66, T67, T68, T69, T70, T71, T73, T74, T76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/T75/T75_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t75.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T75/.

T80 — Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T80-T88 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 250 (nosocomial infection), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : T80.0 Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ; T80.1 Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ; T80.2 Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ; T80.3 Réaction d'incompatibilité ABO ; T80.4 Réaction d'incompatibilité Rh ; T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum ; T80.6 Autres réactions sériques ; T80.8 Autres complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ; T80.9 Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T81, T82, T83, T84, T85, T86, T87, T88
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T80/T80_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t80.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T80/.

T81 — Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T80-T88 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 250 (nosocomial infection), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T81.0 Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ; T81.1 Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs ; T81.2 Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ; T81.3 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs ; T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs ; T81.5 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ; T81.6 Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ; T81.7 Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ; T81.8 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ; T81.9 Complication non précisée d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T80, T82, T83, T84, T85, T86, T87, T88
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/T81/T81_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t81.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T81/.

T82 — Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T80-T88 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 250 (nosocomial infection), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T82.0 Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque ; T82.1 Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique ; T82.2 Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque ; T82.3 Complication mécanique d'autres greffes vasculaires ; T82.4 Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse ; T82.5 Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires ; T82.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque ; T82.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ; T82.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ; T82.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T80, T81, T83, T84, T85, T86, T87, T88
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T82/T82_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t82.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T82/.

T83 — Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T80-T88 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 250 (nosocomial infection), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : T83.0 Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure) ; T83.1 Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires ; T83.2 Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire ; T83.3 Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif ; T83.4 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital ; T83.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire ; T83.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital ; T83.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire ; T83.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T80, T81, T82, T84, T85, T86, T87, T88
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/T83/T83_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t83.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T83/.

T84 — Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T80-T88 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 250 (nosocomial infection), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T84.0 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne ; T84.1 Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre ; T84.2 Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os ; T84.3 Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os ; T84.4 Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes ; T84.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne ; T84.6 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation] ; T84.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes ; T84.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes ; T84.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T80, T81, T82, T83, T85, T86, T87, T88
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T84/T84_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t84.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T84/.

T85 — Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T80-T88 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 250 (nosocomial infection), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T85.0 Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication) ; T85.1 Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux ; T85.2 Complication mécanique d'une lentille intraoculaire ; T85.3 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires ; T85.4 Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires ; T85.5 Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux ; T85.6 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés ; T85.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes ; T85.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes internes, non classées ailleurs ; T85.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T80, T81, T82, T83, T84, T86, T87, T88
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/T85/T85_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t85.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T85/.

T86 — Échec et rejet d'organes et de tissus greffés (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T80-T88 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 250 (nosocomial infection), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : T86.0 Échec d'un transplant de cellules souches hématopoïétiques et maladie du greffon contre l'hôte ; T86.1 Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de rein ; T86.2 Échec et rejet d'une greffe de cœur ; T86.3 Échec et rejet d'une greffe cœur-poumon ; T86.4 Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de foie ; T86.5 Échec et rejet d'une greffe de peau ; T86.8 Échec et rejet d'autres organes et tissus greffés ; T86.9 Échec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T80, T81, T82, T83, T84, T85, T87, T88
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T86/T86_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t86.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T86/.

T87 — Complications propres à une réimplantation et une amputation (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T80-T88 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 250 (nosocomial infection), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : T87.0 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur ; T87.1 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur ; T87.2 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps ; T87.3 Névrome sur moignon d'amputation ; T87.4 Infection d'un moignon d'amputation ; T87.5 Nécrose d'un moignon d'amputation ; T87.6 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T80, T81, T82, T83, T84, T85, T86, T88
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T87/T87_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t87.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T87/.

T88 — Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T80-T88 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 250 (nosocomial infection), 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T88.0 Infection consécutive à vaccination ; T88.1 Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs ; T88.2 Choc anesthésique ; T88.3 Hyperthermie maligne due à une anesthésie ; T88.4 Échec ou difficulté d'intubation ; T88.5 Autres complications consécutives à une anesthésie ; T88.6 Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ; T88.7 Effet indésirable d'un médicament, sans précision ; T88.8 Autres complications précisées de soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs ; T88.9 Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T80, T81, T82, T83, T84, T85, T86, T87
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T88/T88_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t88.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-19-Médecine d'urgence, traumatologie et toxicologie/travail/T88/.

E-22-Éthique médicale, droit et communication

3 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 0 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : ASSM (directives éthiques), FMH, droit fédéral (Fedlex).

Z02 — Examen médical et prise de contact à des fins administratives (E-22-Éthique médicale, droit et communication) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z00-Z13 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 258 (request for certificate, attestation or expertise by patients and insurers). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z04
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z02/Z02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-22-Éthique médicale, droit et communication/travail/Z02/.

Z04 — Examen et mise en observation pour d'autres raisons (E-22-Éthique médicale, droit et communication) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z00-Z13 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 258 (request for certificate, attestation or expertise by patients and insurers). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : Z04.1 Examen et mise en observation après un accident de transport ; Z04.2 Examen et mise en observation après un accident du travail ; Z04.3 Examen et mise en observation après un autre accident ; Z04.5 Examen et mise en observation après d'autres

blessures dues à une agression ; Z04.8 Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées ; Z04.9 Examen et mise en observation pour une raison non précisée

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : Z02**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z04/Z04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-22-Éthique médicale, droit et communication/travail/Z04/.

Z53 — Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués (E-22-Éthique médicale, droit et communication) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z40-Z54 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 251 (obtain informed consent for a procedure), 252 (patient refusing treatment). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z53/Z53_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/E-22-Éthique médicale, droit et communication/travail/Z53/.

M-21-Médecine de premier recours et santé publique

43 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 2 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : mediX, SSMIG, OFSP ; WONCA Europe.

R50 — Fièvre d'origine autre et inconnue (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : R50.2 Fièvre due à des médicaments [Drug fever] ; R50.8 Autres fièvres précisées ; R50.9 Fièvre, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R51, R52, R53, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R68, R69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R50/R50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R50/.

R53 — Malaise et fatigue (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM** XVIII · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 4 (fatigue, tiredness). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R50, R51, R52, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R68, R69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R53/R53_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R53/.

R51 — Céphalée (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM** XVIII · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 101 (headache). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R50, R52, R53, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R68, R69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R51/R51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R51/.

R52 — Douleur, non classée ailleurs (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM** XVIII · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 10 (pain of all types). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : R52.0 Douleur aiguë ; R52.1 Douleur chronique irréductible ; R52.2 Autres douleurs chroniques ; R52.9 Douleur, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R50, R51, R53, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R68, R69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R52/R52_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r52.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R52/.

R55 — Syncope et collapsus (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 149 (transient loss of consciousness, syncope), 217 (syncope, loss of consciousness). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R50, R51, R52, R53, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R68, R69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R55/R55_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r55.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R55/.

R56 — Convulsions, non classées ailleurs (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 105 (twitches, convulsion, seizure), 219 (seizures). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : R56.0 Convulsions fébriles ; R56.8 Convulsions, autres et non précisées
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R50, R51, R52, R53, R55, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R68, R69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R56/R56_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r56.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R56/.

R57 — Choc, non classé ailleurs (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 214 (severe hypertension, severe hypotension). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : R57.0 Choc cardiogénique ; R57.1 Choc hypovolémique ; R57.2 Choc septique ; R57.8 Autres chocs ; R57.9 Choc, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R50, R51, R52, R53, R55, R56, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R68, R69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi

→ 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/R57/R57_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r57.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R57/.

R58 — Hémorragie, non classée ailleurs (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 215 (severe acute blood loss). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R50, R51, R52, R53, R55, R56, R57, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R68, R69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R58/R58_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r58.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R58/.

R59 — Adénopathies (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 2 (enlarged lymph nodes (lymphadenopathy)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : R59.0 Adénopathies localisées ; R59.1 Adénopathies généralisées ; R59.9 Adénopathie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R50, R51, R52, R53, R55, R56, R57, R58, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R68, R69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R59/R59_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r59.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R59/.

R60 — Œdème, non classé ailleurs (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 12 (swelling, oedema (diffuse or local)), 146 (oedema). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : R60.0 Œdème localisé ; R60.1 Œdème généralisé ; R60.9 Œdème, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R50, R51, R52, R53, R55, R56, R57, R58, R59, R61, R62, R63, R64, R65, R68, R69

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R60/R60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R60/.

R61 — Hyperhidrose (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 1 (abnormal perspiration). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : R61.0 Hyperhidrose localisée ; R61.1 Hyperhidrose généralisée ; R61.9 Hyperhidrose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R50, R51, R52, R53, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R62, R63, R64, R65, R68, R69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R61/R61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R61/.

R62 — Retard du développement physiologique (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 184 (abnormal growth and puberty (slowing or acceleration), failure to thrive), 188 (developmental delay). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : R62.0 Maturation retardée ; R62.8 Autres retards du développement physiologique ; R62.9 Retard du développement physiologique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R50, R51, R52, R53, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R63, R64, R65, R68, R69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R62/R62_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R62/.

R63 — Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 3 (excessive thirst, excessive fluid intake (polydipsia)), 15 (weight gain, obesity), 16 (weight loss, malnutrition, loss of appetite). Correspondance pédagogique, non

officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : R63.0 Anorexie ; R63.1 Polydipsie ; R63.2 Polyphagie ; R63.3 Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée ; R63.4 Perte de poids anormale ; R63.5 Prise de poids anormale ; R63.6 Prise insuffisante de nourriture et de boisson ; R63.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R50, R51, R52, R53, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R64, R65, R68, R69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R63/R63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R63/.

R64 — Cachexie (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 138 (cachexia and malnutrition). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R50, R51, R52, R53, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R65, R68, R69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R64/R64_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r64.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R64/.

R68 — Autres symptômes et signes généraux (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R50-R69 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 5 (feeling of illness). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : R68.0 Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante ; R68.1 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson ; R68.2 Sécheresse de la bouche, sans précision ; R68.3 Hippocratisme digital ; R68.8 Autres symptômes et signes généraux précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R50, R51, R52, R53, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R68/R68_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r68.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R68/.

R95 — Syndrome de la mort subite du nourrisson (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R95-R99 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 191 (infant death). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : R95.0 Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie ; R95.9 Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R96, R98, R99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R95/R95_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r95.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R95/.

R96 — Autre mort subite de cause inconnue (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R95-R99 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 14 (unexpected or sudden death). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : R96.0 Mort instantanée ; R96.1 Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R95, R98, R99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R96/R96_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r96.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/R96/.

Z00 — Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z00-Z13 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 224 (request for check-up, health examination, radiologic and laboratory procedures). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : Z00.0 Examen médical général ; Z00.1 Examen de routine de l'enfant ; Z00.2 Examen à la période de croissance rapide de l'enfance ; Z00.3 Examen de l'adolescent en cours de croissance ; Z00.4 Examen psychiatrique général, non classé ailleurs ; Z00.5 Examen d'un donneur éventuel d'organe et de tissu ; Z00.6 Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique ; Z00.8 Autres examens généraux
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z03, Z09, Z10, Z11, Z13
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Z00/Z00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z00/.

Z10 — Examen général de routine d'une sous-population définie (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z00-Z13 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 224 (request for check-up, health examination, radiologic and laboratory procedures). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z00, Z03, Z09, Z11, Z13
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z10/Z10_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z10/.

Z11 — Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z00-Z13 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 225 (screening for asymptomatic conditions), 226 (shared assessment of risks and benefits of screening and treating asymptomatic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z00, Z03, Z09, Z10, Z13
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z11/Z11_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z11.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z11/.

Z13 — Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z00-Z13 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 225 (screening for asymptomatic conditions), 226 (shared assessment of risks and benefits of screening and treating asymptomatic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Z13.0 Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ; Z13.1

Examen spécial de dépistage de diabète sucré ; Z13.2 Examen spécial de dépistage des troubles de la nutrition ; Z13.4 Examen spécial de dépistage de certains troubles du développement de l'enfance ; Z13.5 Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des oreilles ; Z13.6 Examen spécial de dépistage des affections cardio-vasculaires ; Z13.7 Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies chromosomiques ; Z13.8 Examen spécial de dépistage d'autres maladies précisées ; Z13.9 Examen spécial de dépistage, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z00, Z03, Z09, Z10, Z11
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z13/Z13_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z13.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z13/.

Z23 — Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z20-Z29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 187 (child immunisation), 222 (immunization plan). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Z23.0 Nécessité d'une vaccination contre le choléra seul ; Z23.1 Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde-paratyphoïde seule [TAB] ; Z23.2 Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [BCG] ; Z23.3 Nécessité d'une vaccination contre la peste ; Z23.4 Nécessité d'une vaccination contre la tularémie ; Z23.5 Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul ; Z23.6 Nécessité d'une vaccination contre la diphtérie seule ; Z23.7 Nécessité d'une vaccination contre la coqueluche seule ; Z23.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies bactériennes uniques
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z23/Z23_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z23.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z23/.

Z24 — Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z20-Z29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 187 (child immunisation), 222 (immunization plan). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : Z24.0 Nécessité d'une vaccination contre la poliomyélite ; Z24.1 Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les arthropodes ; Z24.2 Nécessité d'une vaccination contre la rage ; Z24.3 Nécessité d'une vaccination contre la fièvre jaune ; Z24.4 Nécessité d'une vaccination contre la rougeole seule ; Z24.5 Nécessité d'une vaccination contre la rubéole seule ; Z24.6 Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite virale

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z23, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z24/Z24_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z24.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z24/.

Z25 — Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z20-Z29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 187 (child immunisation), 222 (immunization plan). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : Z25.0 Nécessité d'une vaccination contre les oreillons seuls ; Z25.1 Nécessité d'une vaccination contre la grippe ; Z25.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques précisées
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z23, Z24, Z26, Z27, Z28, Z29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z25/Z25_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z25.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z25/.

Z26 — Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z20-Z29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 187 (child immunisation), 222 (immunization plan). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : Z26.0 Nécessité d'une vaccination contre la leishmaniose ; Z26.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques précisées ; Z26.9 Nécessité d'une vaccination contre une maladie infectieuse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z23, Z24, Z25, Z27, Z28, Z29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z26/Z26_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z26.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z26/.

Z27 — Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z20-Z29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 187 (child immunisation), 222 (immunization plan). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : Z27.0 Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-paratyphoïde [choléra + TAB] ; Z27.1 Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCQ] ; Z27.2 Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCQ + TAB] ; Z27.3 Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCQ + polio] ; Z27.4 Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [ROR] ; Z27.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres associations de maladies infectieuses ; Z27.9 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z23, Z24, Z25, Z26, Z28, Z29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z27/Z27_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z27.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z27/.

Z28 — Vaccination non faite (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z20-Z29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 187 (child immunisation), 222 (immunization plan). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z28/Z28_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z28.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z28/.

Z50 — Soins impliquant une rééducation (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z40-Z54 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 255 (physical and psychosocial inpatient and outpatient rehabilitation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Z50.0 Rééducation des cardiaques ; Z50.1 Autres thérapies physiques ; Z50.2 Sevrage d'alcool ; Z50.3 Rééducation des drogués et après abus de médicaments ; Z50.4 Psychothérapie, non classée ailleurs ; Z50.5 Traitement logopédique

[rééducation de la voix, de la parole et du langage] ; Z50.6 Education de la vision [orthoptique] ; Z50.7 Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs ; Z50.8 Soins impliquant d'autres moyens de rééducation ; Z50.9 Soin impliquant une rééducation, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z40, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z48, Z52
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/Z50/Z50_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/z50.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z50/](#).

Z52 — Donneurs d'organes et de tissus (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z40-Z54 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 261 (request for information related to organ donation, transplantation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Z52.0 Donneur de sang ; Z52.1 Donneur de peau ; Z52.2 Donneur d'os ; Z52.3 Donneur de moelle osseuse ; Z52.4 Donneur de rein ; Z52.5 Donneur de cornée ; Z52.6 Donneur de foie ; Z52.7 Donneur de cœur ; Z52.8 Donneur d'autres organes et tissus ; Z52.9 Donneur d'organe ou de tissu non précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z40, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z48, Z50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/Z52/Z52_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/z52.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z52/](#).

Z55 — Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z55-Z65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 233 (absenteeism (school, work)), 235 (domestic violence, sexual abuse, rape), 238 (issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family), 241 (problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Z55/Z55_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z55.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z55/.

Z56 — Difficultés liées à l'emploi et au chômage (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z55-Z65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 233 (absenteeism (school, work)), 235 (domestic violence, sexual abuse, rape), 238 (issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family), 241 (problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z55, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z56/Z56_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z56.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z56/.

Z57 — Exposition professionnelle à des facteurs de risque (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z55-Z65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 233 (absenteeism (school, work)), 235 (domestic violence, sexual abuse, rape), 238 (issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family), 241 (problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z55, Z56, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z57/Z57_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z57.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z57/.

Z58 — Difficultés liées à l'environnement physique (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z55-Z65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 233 (absenteeism (school, work)), 235 (domestic violence, sexual abuse, rape), 238 (issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family), 241 (problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z55, Z56, Z57, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z58/Z58_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z58.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z58/.

Z59 — Difficultés liées au logement et aux conditions économiques (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z55-Z65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 233 (absenteeism (school, work)), 235 (domestic violence, sexual abuse, rape), 238 (issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family), 241 (problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z55, Z56, Z57, Z58, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z59/Z59_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z59.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z59/.

Z60 — Difficultés liées à l'environnement social (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z55-Z65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 233 (absenteeism (school, work)), 235 (domestic violence, sexual abuse, rape), 238 (issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family), 241 (problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z60/Z60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z60/.

Z61 — Difficultés liées à une enfance malheureuse (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z55-Z65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 233 (absenteeism (school, work)), 235 (domestic violence, sexual abuse, rape), 238 (issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family), 241 (problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z62, Z63, Z64, Z65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z61/Z61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z61/.

Z62 — Autres difficultés liées à l'éducation (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z55-Z65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 233 (absenteeism (school, work)), 235 (domestic violence, sexual abuse, rape), 238 (issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family), 241 (problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z63, Z64, Z65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z62/Z62_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z62/.

Z63 — Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z55-Z65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 233 (absenteeism (school, work)), 235 (domestic violence, sexual abuse, rape), 238 (issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family), 241 (problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z64, Z65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Z63/Z63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z63/.

Z64 — Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z55-Z65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 233 (absenteeism (school, work)), 235 (domestic violence, sexual abuse, rape), 238 (issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family), 241 (problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : Z64.0 Difficultés liées à une grossesse non désirée ; Z64.1 Difficultés liées à une multiparité ; Z64.8 Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z64/Z64_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z64.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z64/.

Z65 — Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z55-Z65 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 233 (absenteeism (school, work)), 235 (domestic violence, sexual abuse, rape), 238 (issues related to family life such as divorce, single parent and reconstructed family), 241 (problems related to work conditions, burnout, unemployment, financial problems). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z65/Z65_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z65.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z65/.

Z71 — Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z70-Z76 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 223 (promotion of healthy life style), 244 (dietary counselling), 256 (poor adherence to treatment). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se

retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z70, Z72, Z73, Z75, Z76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z71/Z71_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z71/.

Z72 — Difficultés liées au mode de vie (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z70-Z76 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 223 (promotion of healthy life style), 244 (dietary counselling), 256 (poor adherence to treatment). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : Z72.0 Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues ; Z72.8 Autres difficultés liées au mode de vie ; Z72.9 Difficulté liée au mode de vie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z70, Z71, Z73, Z75, Z76
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z72/Z72_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z72.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z72/.

Z94 — Status post greffe d'organe et de tissu (M-21-Médecine de premier recours et santé publique) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z80-Z99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 261 (request for information related to organ donation, transplantation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Z94.0 Status post greffe de rein ; Z94.1 Status post greffe du cœur ; Z94.2 Status post greffe de poumon ; Z94.3 Status post greffe de cœur et poumon ; Z94.4 Status post greffe de foie ; Z94.5 Status post greffe de peau ; Z94.6 Status post greffe osseuse ; Z94.7 Status post greffe de cornée ; Z94.8 Status post d'autre greffe d'organe ou de tissu ; Z94.9 Status post greffe d'organe ou de tissu, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z81, Z82, Z83, Z84, Z86, Z87, Z90, Z91, Z92, Z93, Z96, Z97, Z98, Z99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/Z94/Z94_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/z94.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/M-21-Médecine de premier recours et santé publique/travail/Z94/](#).

D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires

16 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 0 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : Swiss Medical Forum, sociétés de radiologie et de médecine de laboratoire ; ESR.

R70 — Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R70-R79 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 168 (elevated biomarkers of inflammation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : R70.0 Accélération de la vitesse de sédimentation ; R70.1 Viscosité plasmatique anormale
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/R70/R70_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/r70.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R70/](#).

R71 — Anomalies des globules rouges (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R70-R79 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 165 (anaemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R70, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/R71/R71_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/r71.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R71/](#).

R72 — Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R70-R79 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 154 (abnormal leukocyte count). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R70, R71, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8.

Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : `chapters/R72/R72_a...d.html`, `_pop1`, `_pop2`, `glossary/r72.py`, rapports auteur et relecture dans `livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R72/`.

R73 — Augmentation de la glycémie (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R70-R79 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 158 (abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : R73.0 Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose ; R73.9 Hyperglycémie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R70, R71, R72, R74, R75, R76, R77, R78, R79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : `chapters/R73/R73_a...d.html`, `_pop1`, `_pop2`, `glossary/r73.py`, rapports auteur et relecture dans `livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R73/`.

R74 — Anomalies des taux d'enzymes sériques (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R70-R79 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 151 (abnormal cardiac enzymes), 160 (abnormal liver enzymes). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : R74.0 Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase ; R74.8 Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques ; R74.9 Anomalie du taux d'un enzyme sérique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R70, R71, R72, R73, R75, R76, R77, R78, R79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : `chapters/R74/R74_a...d.html`, `_pop1`, `_pop2`, `glossary/r74.py`, rapports auteur et relecture dans `livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R74/`.

R77 — Autres anomalies des protéines plasmatiques (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R70-R79 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 172 (proteinemia, albuminemia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : R77.0 Anomalie de l'albumine ; R77.1 Anomalie de la globuline ; R77.2 Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine ; R77.8 Autres anomalies précisées des protéines

plasmatiques ; R77.9 Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R78, R79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R77/R77_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r77.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R77/.

R79 — Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R70-R79 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 156 (abnormal electrolytes), 162 (abnormal serum lipids). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang ; R79.8 Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du sang ; R79.9 Résultat anormal des examens chimiques du sang, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R79/R79_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r79.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R79/.

R80 — Protéinurie isolée (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R80-R82 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R81, R82
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R80/R80_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r80.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R80/.

R81 — Glycosurie (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R80-R82 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 158 (abnormal glycaemia and markers of glycaemia homeostasis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R80, R82

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/R81/R81_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/r81.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R81/](#).

R82 — Autres résultats anormaux de l'examen des urines (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R80-R82 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 164 (abnormal urine sediment). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : R82.0 Chylurie ; R82.1 Myoglobulinurie ; R82.2 Biliurie ; R82.3 Hémoglobulinurie ; R82.4 Acétonurie ; R82.5 Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques ; R82.6 Taux anormal dans les urines de substances d'origine principalement non médicinale ; R82.7 Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines ; R82.8 Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines ; R82.9 Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R80, R81
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/R82/R82_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/r82.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R82/](#).

R85 — Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R83-R89 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 157 (abnormal faecal analyses, occult blood, parasites). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : R85.0 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale: Taux anormal d'enzymes ; R85.1 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale: Taux anormal d'hormones ; R85.2 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale: Taux anormal de drogues, autres substances médicamenteuses ou biologiquement actives ; R85.3 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale: Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale ; R85.4 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale: Résultats immunologiques anormaux ; R85.5 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale: Résultats microbiologiques anormaux ; R85.6 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale: Résultats cytologiques anormaux ; R85.7 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale: Résultats histologiques anormaux ; R85.8 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale: Autres résultats anormaux ; R85.9 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale: Résultat anormal, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R83, R84, R86, R87, R89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : `chapters/R85/R85_a...d.html`, `_pop1`, `_pop2`, `glossary/r85.py`, rapports auteur et relecture dans `livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R85/`.

R90 — Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R90-R94 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 153 (abnormal X-rays of abdomen, chest and skeleton). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : R90.0 Lésion intracrânienne ; R90.8 Autres résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R91, R92, R93, R94
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : `chapters/R90/R90_a...d.html`, `_pop1`, `_pop2`, `glossary/r90.py`, rapports auteur et relecture dans `livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R90/`.

R91 — Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R90-R94 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 153 (abnormal X-rays of abdomen, chest and skeleton). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R90, R92, R93, R94
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : `chapters/R91/R91_a...d.html`, `_pop1`, `_pop2`, `glossary/r91.py`, rapports auteur et relecture dans `livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R91/`.

R92 — Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R90-R94 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 153 (abnormal X-rays of abdomen, chest and skeleton). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R90, R91, R93, R94
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R92/R92_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r92.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R92/.

R93 — Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R90-R94 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 153 (abnormal X-rays of abdomen, chest and skeleton). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : R93.0 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la tête, non classés ailleurs ; R93.1 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la circulation coronaire ; R93.2 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies biliaires ; R93.3 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies digestives ; R93.4 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire ; R93.5 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal ; R93.6 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique des membres ; R93.7 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système ostéo-musculaire ; R93.8 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps précisées
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R90, R91, R92, R94
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R93/R93_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r93.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/R93/.

Z01 — Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté (D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z00-Z13 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 224 (request for check-up, health examination, radiologic and laboratory procedures). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Z01.0 Examen des yeux et de la vision ; Z01.1 Examen des oreilles et de l'audition ; Z01.2 Examen dentaire ; Z01.3 Mesure de la tension artérielle ; Z01.4 Examen gynécologique (de routine) (général) ; Z01.5 Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation ; Z01.6 Examen radiologique, non classé ailleurs ; Z01.7 Examens de laboratoire ; Z01.8 Autres examens spéciaux précisés ; Z01.9 Examen spécial, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Z01/Z01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-20-Diagnostic clinique et examens complémentaires/travail/Z01/.

D-16-Dermatologie

97 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 9 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : Société suisse de dermatologie et vénéréologie ; EADV, EDF.

L03 — Phlegmon (D-16-Dermatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L00-L08 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : L03.0 Phlegmon des doigts et des orteils ; L03.1 Phlegmon d'autres parties d'un membre ; L03.2 Phlegmon de la face ; L03.3 Phlegmon du tronc ; L03.8 Phlegmon d'autres localisations ; L03.9 Phlegmon, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L00, L01, L02, L04, L05, L08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L03/L03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L03/.

L20 — Dermite atopique [endogène] (D-16-Dermatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L20-L30 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : L20.0 Prurigo de Besnier ; L20.8 Autres dermites atopiques [endogène] ; L20.9 Dermite atopique (endogène), sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L20/L20_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l20.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L20/.

L21 — Dermite séborrhéique (D-16-Dermatologie) · P1

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XII** · bloc L20-L30 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : L21.0 Séborrhée de la tête ; L21.1 Dermite séborrhéique infantile ; L21.8 Autres dermites séborrhéiques ; L21.9 Dermite séborrhéique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L20, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L21/L21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L21/.

L23 — Dermite allergique de contact (D-16-Dermatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L20-L30 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : L23.0 Dermite allergique de contact due aux métaux ; L23.1 Dermite allergique de contact due aux adhésifs ; L23.2 Dermite allergique de contact due aux cosmétiques ; L23.3 Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau ; L23.4 Dermite allergique de contact due aux teintures ; L23.5 Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques ; L23.6 Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau ; L23.7 Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments ; L23.8 Dermite allergique de contact due à d'autres agents ; L23.9 Dermite allergique de contact, cause non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L20, L21, L22, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L23/L23_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l23.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L23/.

L30 — Autres dermites (D-16-Dermatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L20-L30 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : L30.0 Dermite nummulaire ; L30.1 Dyshidrose [pompholyx] ; L30.2 Autosensibilisation cutanée ; L30.3 Dermite eczématoïde ; L30.4 Intertrigo érythémateux ; L30.5 Pityriasis alba ; L30.8 Autres dermites précisées ; L30.9 Dermite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L30/L30_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L30/.

L40 — Psoriasis (D-16-Dermatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L40-L45 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : L40.0 Psoriasis vulgaris ; L40.1 Psoriasis pustuleuse généralisé ; L40.2 Acrodermatite continue de Hallopeau ; L40.3 Pustulose palmaire et plantaire ; L40.4 Psoriasis en goutte ; L40.5 Psoriasis arthropathique ; L40.7 Degré de gravité du psoriasis ; L40.8 Autres psoriasis ; L40.9 Psoriasis, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L41, L42, L43, L44, L45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L40/L40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L40/.

L50 — Urticaire (D-16-Dermatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L50-L54 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : L50.0 Urticaire allergique ; L50.1 Urticaire idiopathique ; L50.2 Urticaire provoquée par le froid et la chaleur ; L50.3 Dermographisme ; L50.4 Urticaire provoquée par vibration ; L50.5 Urticaire cholinergique ; L50.6 Urticaire de contact ; L50.8 Autres formes d'urticaire ; L50.9 Urticaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L51, L52, L53, L54
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L50/L50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L50/.

L70 — Acné (D-16-Dermatologie) · P1

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XII** · bloc L60-L75 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 92 (lack or loss of hair, excess hair), 94 (nail complaints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : L70.0 Acné vulgaire ; L70.1 Acné conglobata ; L70.2 Acné varioliforme ; L70.3 Acné tropicale ; L70.4 Acné infantile ; L70.5 Acné excoriée ; L70.8 Autres formes d'acné ; L70.9 Acné, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L71, L72, L73, L74, L75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L70/L70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L70/.

L82 — Kératose séborrhéique (D-16-Dermatologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L82/L82_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L82.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L82/.

C43 — Mélanome malin de la peau (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C43-C44 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : C43.0 Mélanome malin de la lèvre ; C43.1 Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus ; C43.2 Mélanome malin de l'oreille et du conduit auditif externe ; C43.3 Mélanome malin de la face, parties autres et non précisées ; C43.4 Mélanome malin du cuir chevelu et du cou ; C43.5 Mélanome malin du tronc ; C43.6 Mélanome malin du membre supérieur, y compris l'épaule ; C43.7 Mélanome malin du membre inférieur, y compris la hanche ; C43.8 Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la peau ; C43.9 Mélanome malin de la peau, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C44

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C43/C43_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c43.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/C43/.

C44 — Autres tumeurs malignes de la peau (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C43-C44 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : C44.0 Tumeur maligne: Face cutanée de la lèvre ; C44.1 Tumeur maligne: Peau de la paupière, y compris le canthus ; C44.2 Tumeur maligne: Peau de l'oreille et du conduit auditif externe ; C44.3 Tumeur maligne: Peau de la face, parties autres et non précisées ; C44.4 Tumeur maligne: Peau du cuir chevelu et du cou ; C44.5 Tumeur maligne: Peau du tronc ; C44.6 Tumeur maligne: Peau du membre supérieur, y compris l'épaule ; C44.7 Tumeur maligne: Peau du membre inférieur, y compris la hanche ; C44.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la peau ; C44.9 Tumeur maligne de la peau, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C43
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C44/C44_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c44.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/C44/.

C46 — Sarcome de Kaposi [Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum] (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C45-C49 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau ; C46.1 Sarcome de Kaposi des tissus mous ; C46.2 Sarcome de Kaposi du palais ; C46.3 Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques ; C46.7 Sarcome de Kaposi d'autres sièges ; C46.8 Sarcome de Kaposi d'organes multiples ; C46.9 Sarcome de Kaposi, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C46/C46_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c46.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/C46/.

L00 — Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (D-16-Dermatologie)

· P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L00-L08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : L00.0 Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle ; L00.1 Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L01, L02, L03, L04, L05, L08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L00/L00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L00/.

L01 — Impétigo (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L00-L08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : L01.0 Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation] ; L01.1 Impétiginisation d'autres dermatoses
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L00, L02, L03, L04, L05, L08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L01/L01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L01/.

L02 — Abcès cutané, furoncle et anthrax (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L00-L08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : L02.0 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face ; L02.1 Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou ; L02.2 Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc ; L02.3 Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse ; L02.4 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre ; L02.8 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations ; L02.9 Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L00, L01, L03, L04, L05, L08

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L02/L02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L02/.

L04 — Lymphadénite aiguë (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L00-L08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : L04.0 Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou ; L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc ; L04.2 Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur ; L04.3 Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur ; L04.8 Lymphadénite aiguë d'autres localisations ; L04.9 Lymphadénite aiguë, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L00, L01, L02, L03, L05, L08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L04/L04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L04/.

L05 — Sinus pilonidal (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L00-L08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : L05.0 Sinus pilonidal avec abcès ; L05.9 Sinus pilonidal sans abcès
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L00, L01, L02, L03, L04, L08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L05/L05_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L05/.

L08 — Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L00-L08 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : L08.0 Pyodermite ; L08.1 Érythrasma ; L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ; L08.9 Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L00, L01, L02, L03, L04, L05
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L08/L08_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l08.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L08/.

L10 — Pemphigus (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L10-L14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : L10.0 Pemphigus vulgaire ; L10.1 Pemphigus végétant ; L10.2 Pemphigus foliacé ; L10.3 Pemphigus brésilien [fogo selvagem] ; L10.4 Pemphigus érythémateux ; L10.5 Pemphigus médicamenteux ; L10.8 Autres formes de pemphigus ; L10.9 Pemphigus, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L11, L12, L13, L14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L10/L10_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L10/.

L11 — Autres acantholyses (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L10-L14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : L11.0 Kératose folliculaire acquise ; L11.1 Dermatose acantholytique transitoire [Grover] ; L11.8 Autres formes précisées d'acantholyse ; L11.9 Acantholyse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L10, L12, L13, L14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/L11/L11_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l11.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L11/.

L12 — Pemphigoïde (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L10-L14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : L12.0 Pemphigoïde bulleux ; L12.1 Pemphigoïde cicatriciel ; L12.2 Maladie chronique bulleuse de l'enfance ; L12.3 Epidermolyse bulleuse acquise ; L12.8 Autres pemphigoïdes ; L12.9 Pemphigoïde, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L10, L11, L13, L14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L12/L12_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l12.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L12/.

L13 — Autres dermatoses bulleuses (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L10-L14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : L13.0 Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq] ; L13.1 Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] ; L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées ; L13.9 Dermatose bulleuse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L10, L11, L12, L14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L13/L13_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l13.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L13/.

L14 — Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L10-L14 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L10, L11, L12, L13
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/L14/L14_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l14.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L14/.

L22 — Dermite fessière du nourrisson (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L20-L30 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L20, L21, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L22/L22_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l22.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L22/.

L24 — Dermite irritante de contact (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L20-L30 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : L24.0 Dermite irritante de contact due aux détergents ; L24.1 Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses ; L24.2 Dermite irritante de contact due aux solvants ; L24.3 Dermite irritante de contact due aux cosmétiques ; L24.4 Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau ; L24.5 Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques ; L24.6 Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau ; L24.7 Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments ; L24.8 Dermite irritante de contact due à d'autres agents ; L24.9 Dermite irritante de contact, cause non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L20, L21, L22, L23, L25, L26, L27, L28, L29, L30
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L24/L24_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l24.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L24/.

L25 — Dermite de contact, sans précision (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L20-L30 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : L25.0 Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques ; L25.1 Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau ; L25.2 Dermite de contact, sans précision, due aux teintures ; L25.3 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques ; L25.4 Dermite de contact, sans précision, due à des

aliments en contact avec la peau ; L25.5 Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments ; L25.8 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents ; L25.9 Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L20, L21, L22, L23, L24, L26, L27, L28, L29, L30
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L25/L25_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l25.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L25/.

L26 — Dermite exfoliatrice (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L20-L30 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L20, L21, L22, L23, L24, L25, L27, L28, L29, L30
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L26/L26_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l26.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L26/.

L27 — Dermite due à des substances prises par voie interne (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L20-L30 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : L27.0 Éruption généralisée due à des médicaments ; L27.1 Éruption localisée due à des médicaments ; L27.2 Dermite due à l'ingestion d'aliments ; L27.8 Dermite due à d'autres substances prises par voie interne ; L27.9 Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L28, L29, L30
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L27/L27_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l27.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L27/.

L28 — Lichen simplex chronique et prurigo (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L20-L30 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : L28.0 Lichen simplex chronique [Vidal] ; L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde ; L28.2 Autres formes de prurigo
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L29, L30
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L28/L28_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L28.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L28/.

L29 — Prurit (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L20-L30 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : L29.0 Prurit anal ; L29.1 Prurit scrotal ; L29.2 Prurit vulvaire ; L29.3 Prurit ano-génital, sans précision ; L29.8 Autres prurits ; L29.9 Prurit, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L30
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L29/L29_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L29.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L29/.

L41 — Parapsoriasis (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L40-L45 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : L41.0 Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann] ; L41.1 Pityriasis lichénoïde chronique ; L41.3 Parapsoriasis à petites plaques ; L41.4 Parapsoriasis à grandes plaques ; L41.5 Parapsoriasis rétifforme ; L41.8 Autres parapsoriasis ; L41.9 Parapsoriasis, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L40, L42, L43, L44, L45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L41/L41_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L41.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L41/.

L42 — Pityriasis rosé de Gibert (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L40-L45 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L40, L41, L43, L44, L45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L42/L42_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L42.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L42/.

L43 — Lichen plan (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L40-L45 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : L43.0 Lichen plan hypertrophique ; L43.1 Lichen plan bulleux ; L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse ; L43.3 Lichen plan subaigu (actif) ; L43.8 Autres lichens plans ; L43.9 Lichen plan, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L40, L41, L42, L44, L45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L43/L43_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L43.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L43/.

L44 — Autres lésions papulo-squameuses (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L40-L45 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : L44.0 Pityriasis rubra pilaire ; L44.1 Lichen nitidus ; L44.2 Lichen strié ; L44.3 Lichen ruber moniliforme ; L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] ; L44.8 Autres lésions papulo-squameuses précisées ; L44.9 Lésion papulo-squameuse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L40, L41, L42, L43, L45
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/L44/L44_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L44.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L44/.

L45 — Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L40-L45 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L40, L41, L42, L43, L44
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L45/L45_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L45.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L45/.

L51 — Érythème polymorphe (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L50-L54 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : L51.0 Érythème polymorphe non bulleux ; L51.1 Érythème polymorphe bulleux ; L51.2 Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] ; L51.8 Autres formes d'érythème polymorphe ; L51.9 Érythème polymorphe, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L50, L52, L53, L54
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L51/L51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L51/.

L52 — Érythème noueux (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L50-L54 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L50, L51, L53, L54
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/L52/L52_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L52.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L52/.

L53 — Autres formes d'érythème (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L50-L54 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : L53.0 Érythème toxique ; L53.1 Érythème annulaire centrifuge ; L53.2 Érythème marginé discoïde de Besnier ; L53.3 Autres formes d'érythème figuré chronique ; L53.8 Autres formes précisées d'érythème ; L53.9 Érythème, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L50, L51, L52, L54
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L53/L53_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L53/.

L54 — Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L50-L54 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 9 (itching), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : L54.0 Érythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu ; L54.8 Érythème au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L50, L51, L52, L53
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L54/L54_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L54.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L54/.

L60 — Maladies des ongles (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L60-L75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 92 (lack or loss of hair, excess hair), 94 (nail complaints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : L60.0 Ongle incarné ; L60.1 Onycholyse ; L60.2 Onychogrypose [Onychogryphose] ; L60.3 Dystrophie des ongles ; L60.4 Lignes de Beau ; L60.5 Syndrome des ongles jaunes ; L60.8 Autres maladies des ongles ; L60.9 Maladie des ongles, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L74, L75

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L60/L60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L60/.

L62 — Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L60-L75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 92 (lack or loss of hair, excess hair), 94 (nail complaints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : L62.0 Pachydermopériostose avec ongle hippocratique ; L62.8 Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L60, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L62/L62_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L62/.

L63 — Pelade en plaques (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L60-L75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 92 (lack or loss of hair, excess hair), 94 (nail complaints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : L63.0 Alopecie totale ; L63.1 Pelade généralisée ; L63.2 Ophiasis ; L63.8 Autres formes de pelade ; L63.9 Pelade, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L60, L62, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L63/L63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L63/.

L64 — Alopecie androgénique (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L60-L75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 92 (lack or loss of hair, excess hair), 94 (nail complaints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de

l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : L64.0 Alopécie androgénique médicamenteuse ; L64.8 Autres formes d'alopecie androgénique ; L64.9 Alopecie androgénique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L60, L62, L63, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L64/L64_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l64.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L64/.

L65 — Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L60-L75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 92 (lack or loss of hair, excess hair), 94 (nail complaints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : L65.0 Tégogène ; L65.1 Anagène ; L65.2 Alopecie mucineuse de Pinkus ; L65.8 Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux ; L65.9 Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L60, L62, L63, L64, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L65/L65_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l65.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L65/.

L66 — Alopecie cicatricielle (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L60-L75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 92 (lack or loss of hair, excess hair), 94 (nail complaints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : L66.0 Pseudo-pelade [de Brocq] ; L66.1 Lichen plano-pilaire ; L66.2 Folliculite décalvante ; L66.3 Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann] ; L66.4 Atrophoderma vermiciforme ; L66.8 Autres formes d'alopecie cicatricielle ; L66.9 Alopecie cicatricielle, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L60, L62, L63, L64, L65, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/L66/L66_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l66.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L66/.

L67 — Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L60-L75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 92 (lack or loss of hair, excess hair), 94 (nail complaints).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : L67.0 Trichorrhexie noueuse ; L67.1 Anomalies de la couleur des cheveux ; L67.8 Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires ; L67.9 Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L68, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L67/L67_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l67.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L67/.

L68 — Hypertrichose (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L60-L75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 92 (lack or loss of hair, excess hair), 94 (nail complaints).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : L68.0 Hirsutisme ; L68.1 Hypertrichose lanugineuse acquise ; L68.2 Hypertrichose localisée ; L68.3 Polytrichie ; L68.8 Autres formes d'hypertrichose ; L68.9 Hypertrichose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L70, L71, L72, L73, L74, L75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L68/L68_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l68.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L68/.

L71 — Acné rosacée (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L60-L75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 92 (lack or loss of hair, excess hair), 94 (nail complaints).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : L71.0 Dermite périore ; L71.1 Rhinophyma ; L71.8 Autres formes d'acné rosacée ; L71.9 Acné rosacée, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L72, L73, L74, L75

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L71/L71_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L71/.

L72 — Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L60-L75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 92 (lack or loss of hair, excess hair), 94 (nail complaints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : L72.0 Kyste épidermique ; L72.1 Kyste sébacé ; L72.2 Stéatocystose multiple ; L72.8 Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ; L72.9 Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L73, L74, L75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L72/L72_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L72.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L72/.

L73 — Autres affections folliculaires (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L60-L75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 92 (lack or loss of hair, excess hair), 94 (nail complaints). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : L73.0 Acné chéloïde [Folliculite sclerotisans nuchae] ; L73.1 Pseudofolliculite de la barbe ; L73.2 Hidrosadénite suppurée ; L73.8 Autres formes précisées d'affections folliculaires ; L73.9 Affection folliculaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L74, L75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L73/L73_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L73.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L73/.

L74 — Affections des glandes sudoripares exocrines (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L60-L75 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 92 (lack or loss of hair, excess hair), 94 (nail complaints).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : L74.0 Miliaire rouge ; L74.1 Miliaire cristalline ; L74.2 Miliaire profonde ; L74.3 Miliaire, sans précision ; L74.4 Anhidrose ; L74.8 Autres affections des glandes sudoripares exocrines ; L74.9 Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L74/L74_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L74.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L74/.

L75 — Affections des glandes sudoripares apocrines (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L60-L75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 92 (lack or loss of hair, excess hair), 94 (nail complaints).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : L75.0 Bromhidrose ; L75.1 Chromhidrose ; L75.2 Miliaire apocrine ; L75.8 Autres affections des glandes sudoripares apocrines ; L75.9 Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L60, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L70, L71, L72, L73, L74
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L75/L75_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L75.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L75/.

L80 — Vitiligo (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/L80/L80_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l80.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L80/.

L81 — Autres anomalies de la pigmentation (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : L81.0 Hyperpigmentation post-inflammatoire ; L81.1 Chloasma [Mélasme] ; L81.2 Taches de rousseur ; L81.3 Taches café au lait ; L81.4 Autres hyperpigmentations par la mélanine ; L81.5 Leucodermie, non classée ailleurs ; L81.6 Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine ; L81.7 Dermatose purpurique pigmentée ; L81.8 Autres anomalies précisées de la pigmentation ; L81.9 Anomalie de la pigmentation, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L81/L81_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l81.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L81/.

L83 — Acanthosis nigricans (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L83/L83_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l83.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L83/.

L84 — Cors et callosités (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L97, L98, L99

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L84/L84_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l84.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L84/.

L85 — Autres épaissements de l'épiderme (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : L85.0 Ichtyose acquise ; L85.1 Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise ; L85.2 Kératose ponctuée (palmaire et plantaire) ; L85.3 Xérosis cutané ; L85.8 Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme ; L85.9 Epaississement de l'épiderme, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L84, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L85/L85_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l85.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L85/.

L86 — Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L84, L85, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L86/L86_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l86.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L86/.

L87 — Anomalies de l'élimination transépidermique (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the

skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : L87.0 Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] ; L87.1 Collagénome perforant verruciforme ; L87.2 Elastome perforant serpigneux ; L87.8 Autres anomalies de l'élimination transépidermique ; L87.9 Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L87/L87_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l87.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L87/.

L88 — Pyodermite gangréneuse (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L88/L88_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l88.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L88/.

L89 — Ulcère de décubitus et zone de pression (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa), 200 (pressure ulcers). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : L89.0 Ulcère de décubitus, stade 1 ; L89.1 Ulcère de décubitus, stade 2 ; L89.2 Ulcère de décubitus, stade 3 ; L89.3 Ulcère de décubitus, stade 4 ; L89.9 Ulcère de décubitus, stade non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/L89/L89_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l89.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L89/.

L90 — Affections atrophiques de la peau (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : L90.0 Lichen scléreux et atrophique ; L90.1 Anétodermie de Schweninger-Buzzi ; L90.2 Anétodermie de Jadassohn-Pellizzari ; L90.3 Atrophodermie de Pasini et Pierini ; L90.4 Acrodermatite chronique atrophique ; L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées ; L90.6 Stries atrophiques ; L90.8 Autres affections atrophiques de la peau ; L90.9 Affection atrophique de la peau, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L91, L92, L93, L94, L95, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L90/L90_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l90.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L90/.

L91 — Affections hypertrophiques de la peau (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : L91.0 Cicatrice hypertrophique ; L91.8 Autres affections hypertrophiques de la peau ; L91.9 Affection hypertrophique de la peau, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L92, L93, L94, L95, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L91/L91_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/l91.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L91/.

L92 — Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (6)** : L92.0 Granulome annulaire ; L92.1 Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs ; L92.2 Granulome éosinophile facial ; L92.3 Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger ; L92.8 Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ; L92.9 Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L93, L94, L95, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L92/L92_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L92.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L92/.

L93 — Lupus érythémateux (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (3)** : L93.0 Lupus érythémateux chronique discoïde ; L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu ; L93.2 Autres lupus érythémateux localisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L94, L95, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L93/L93_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L93.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L93/.

L94 — Autres affections localisées du tissu conjonctif (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (9)** : L94.0 Sclérodermie localisée [morphée] ; L94.1 Sclérodermie linéaire ; L94.2 Calcinose cutanée ; L94.3 Sclérodactylie ; L94.4 Papules de Gottron ; L94.5 Poikilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire] ; L94.6 Ainhum ; L94.8 Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif ; L94.9 Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L95, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/L94/L94_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L94.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L94/.

L95 — Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : L95.0 Vascularite livédoïde ; L95.1 Erythema elevatum diutinum ; L95.8 Autres vascularites limitées à la peau ; L95.9 Vascularite limitée à la peau, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L97, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L95/L95_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L95.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L95/.

L97 — Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L98, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L97/L97_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L97.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L97/.

L98 — Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : L98.0 Granulome pyogénique ; L98.1 Dermite factice ; L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet] ; L98.3 Phlegmon à éosinophiles [Wells] ; L98.4 Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs ; L98.5 Mucinoïse cutanée ; L98.6 Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ; L98.7 Peau et tissu sous-cutané excédentaire et flasque ; L98.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ; L98.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L97, L99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L98/L98_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L98.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L98/.

L99 — Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XII** · bloc L80-L99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 90 (infected wound, delayed wound healing, skin ulcers), 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : L99.0 Amylose cutanée ; L99.1 Atteinte de la peau dans la maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte ; L99.2 Atteinte de la peau dans la maladie chronique de rejet greffe-contre-hôte ; L99.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L97, L98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/L99/L99_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/L99.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/L99/.

Q80 — Ichtyose congénitale (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q80-Q89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : Q80.0 Ichtyose vulgaire ; Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X ; Q80.2 Ichtyose lamellaire ; Q80.3 Érythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale ; Q80.4 Fœtus Arlequin ; Q80.8 Autres ichtyoses congénitales ; Q80.9 Ichtyose congénitale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q81, Q82, Q84
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8.

Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Q80/Q80_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q80.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/Q80/.

Q81 — Epidermolyse bulleuse (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q80-Q89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : Q81.0 Epidermolyse bulleuse simple ; Q81.1 Epidermolyse bulleuse létale ; Q81.2 Epidermolyse bulleuse dystrophique ; Q81.8 Autres épidermolyses bulleuses ; Q81.9 Epidermolyse bulleuse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q80, Q82, Q84
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q81/Q81_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q81.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/Q81/.

Q82 — Autres malformations congénitales de la peau (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q80-Q89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : Q82.0 Lymphœdème héréditaire ; Q82.1 Xeroderma pigmentosum ; Q82.2 Mastocytose (congénitale) ; Q82.3 Incontinentia pigmenti ; Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique) ; Q82.5 Nævus congénital non néoplasique ; Q82.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau ; Q82.9 Malformation congénitale de la peau, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q80, Q81, Q84
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q82/Q82_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q82.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/Q82/.

Q84 — Autres malformations congénitales de la peau et des phanères (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q80-Q89 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Q84.0 Alopecie congénitale ; Q84.1 Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs ; Q84.2 Autres anomalies congénitales des cheveux ; Q84.3 Anonychie ; Q84.4 Leuconychie congénitale ; Q84.5 Hypertrophie des ongles (congénitale) ; Q84.6 Autres malformations congénitales des ongles ; Q84.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères ; Q84.9 Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q80, Q81, Q82
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q84/Q84_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q84.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/Q84/.

R20 — Troubles de la sensibilité cutanée (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R20-R23 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : R20.0 Anesthésie cutanée ; R20.1 Hypoesthésie cutanée ; R20.2 Paresthésie cutanée ; R20.3 Hyperesthésie ; R20.8 Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R21, R22, R23
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R20/R20_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r20.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/R20/.

R21 — Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R20-R23 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R20, R22, R23
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R21/R21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/R21/.

R22 — Autres tumeurs et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R20-R23 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 2 (enlarged lymph nodes (lymphadenopathy)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : R22.0 Tumeur et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau de la tête ; R22.1 Tumeur et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du cou ; R22.2 Tumeur et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du tronc ; R22.3 Tumeur et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre supérieur ; R22.4 Tumeur et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre inférieur ; R22.7 Tumeur et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sièges multiples ; R22.9 Tumeur et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R20, R21, R23
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R22/R22_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r22.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/R22/.

R23 — Autres modifications de la peau (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R20-R23 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 93 (macules, papules, pustules, blisters, ulcers and abscess, bullae, thickening, ne-), 95 (redness of the skin (localized or diffuse) and/or mucosa). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : R23.0 Cyanose ; R23.1 Pâleur ; R23.2 Rougeur ; R23.3 Ecchymoses spontanées ; R23.4 Modifications du tissu cutané ; R23.8 Modifications de la peau, autres et non précisées
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R20, R21, R22
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R23/R23_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r23.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/R23/.

S41 — Plaie ouverte de l'épaule et du bras (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S40-S49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : S41.0 Plaie ouverte de l'épaule ; S41.1 Plaie ouverte du bras ; S41.7 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras ; S41.8 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S41/S41_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s41.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/S41/.

S51 — Plaie ouverte de l'avant-bras (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S50-S59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : S51.0 Plaie ouverte du coude ; S51.7 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras ; S51.8 Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras ; S51.9 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S51/S51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/S51/.

S61 — Plaie ouverte du poignet et de la main (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S60-S69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : S61.0 Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle ; S61.1 Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle ; S61.7 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main ; S61.8 Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main ; S61.9 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S61/S61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/S61/.

S71 — Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S70-S79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : S71.0 Plaie ouverte de la hanche ; S71.1 Plaie ouverte de la cuisse ; S71.7 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse ; S71.8 Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S71/S71_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s71.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/S71/](#).

S81 — Plaie ouverte de la jambe (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S80-S89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : S81.0 Plaie ouverte du genou ; S81.7 Plaies ouvertes multiples de la jambe ; S81.8 Plaie ouverte d'autres parties de la jambe ; S81.9 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S81/S81_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s81.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/S81/](#).

S91 — Plaie ouverte de la cheville et du pied (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S90-S99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S91.0 Plaie ouverte de la cheville ; S91.1 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle ; S91.2 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle ; S91.3 Plaie ouverte d'autres parties du pied ; S91.7 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied ; S91.8 Plaie ouverte d'autre partie de la malléole et du pied
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S91/S91_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s91.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/S91/](#).

T20 — Brûlure et corrosion de la tête et du cou (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T20-T25 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : T20.0 Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé ; T20.1 Brûlure du premier degré de la tête et du cou ; T20.2 Brûlure du second degré de la tête et du cou ; T20.3 Brûlure du troisième degré de la tête et du cou ; T20.4 Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé ; T20.5 Corrosion du premier degré de la tête et du cou ; T20.6 Corrosion du second degré de la tête et du cou ; T20.7 Corrosion du troisième degré de la tête et du cou

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T21, T22, T23, T24, T25
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T20/T20_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t20.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/T20/.

T21 — Brûlure et corrosion du tronc (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T20-T25 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T21.0 Brûlure du tronc, degré non précisé ; T21.1 Brûlure du premier degré du tronc ; T21.2 Brûlure du tronc de degré 2a ; T21.3 Brûlure du troisième degré du tronc ; T21.4 Corrosion du tronc, degré non précisé ; T21.5 Corrosion du premier degré du tronc ; T21.6 Corrosion du tronc de degré 2a ; T21.7 Corrosion du troisième degré du tronc ; T21.8 Brûlure du tronc degré 2b ; T21.9 Corrosion du tronc degré 2b
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T20, T22, T23, T24, T25
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T21/T21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/T21/.

T22 — Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T20-T25 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T22.0 Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé ; T22.1 Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ; T22.2 Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a ; T22.3 Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ; T22.4 Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé ; T22.5 Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ; T22.6 Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a ; T22.7 Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ; T22.8 Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b ; T22.9 Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T20, T21, T23, T24, T25
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T22/T22_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t22.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/T22/.

T23 — Brûlure et corrosion du poignet et de la main (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T20-T25 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : T23.0 Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé ; T23.1 Brûlure du premier degré du poignet et de la main ; T23.2 Brûlure du second degré du poignet et de la main ; T23.3 Brûlure du troisième degré du poignet et de la main ; T23.4 Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé ; T23.5 Corrosion du premier degré du poignet et de la main ; T23.6 Corrosion du second degré du poignet et de la main ; T23.7 Corrosion du troisième degré du poignet et de la main
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T20, T21, T22, T24, T25
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T23/T23_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t23.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/T23/.

T24 — Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T20-T25 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : T24.0 Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé ; T24.1 Brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ; T24.2 Brûlure du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ; T24.3 Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ; T24.4 Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé ; T24.5 Corrosion du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ; T24.6 Corrosion du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ; T24.7 Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T20, T21, T22, T23, T25
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T24/T24_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t24.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/T24/.

T25 — Brûlure et corrosion de la cheville et du pied (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T20-T25 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : T25.0 Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé ; T25.1 Brûlure du premier degré de la cheville et du pied ; T25.2 Brûlure du second degré de la cheville et du pied ; T25.3 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied ; T25.4 Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé ; T25.5 Corrosion du premier degré de la cheville et du pied ; T25.6 Corrosion du second degré de la cheville et du pied ; T25.7 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T20, T21, T22, T23, T24
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T25/T25_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t25.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/T25/.

T29 — Brûlures et corrosions de parties multiples du corps (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T29-T32 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : T29.0 Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé ; T29.1 Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le premier degré ; T29.2 Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le second degré ; T29.3 Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée ; T29.4 Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé ; T29.5 Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le premier degré ; T29.6 Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le second degré ; T29.7 Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T30, T31, T32
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T29/T29_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t29.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/T29/.

T30 — Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T29-T32 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : T30.0 Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé ; T30.1 Brûlure du premier degré, partie du corps non précisée ; T30.2 Brûlure du second degré, partie du corps non précisée ; T30.3 Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée ; T30.4 Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé ; T30.5 Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée ; T30.6 Corrosion du second degré, partie du corps non précisée ; T30.7 Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T29, T31, T32
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T30/T30_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/T30/.

T31 — Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T29-T32 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T31.0 Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps ; T31.1 Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps ; T31.2 Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps ; T31.3 Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps ; T31.4 Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps ; T31.5 Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps ; T31.6 Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps ; T31.7 Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps ; T31.8 Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps ; T31.9 Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T29, T30, T32
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T31/T31_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t31.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/T31/.

T32 — Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T29-T32 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T32.0 Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps ; T32.1 Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps ; T32.2 Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps ; T32.3 Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps ; T32.4 Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps ; T32.5 Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps ; T32.6 Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps ; T32.7 Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps ; T32.8 Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps ; T32.9 Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T29, T30, T31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T32/T32_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t32.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/T32/.

T33 — Gelure superficielle (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T33-T35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T33.0 Gelure superficielle de la tête ; T33.1 Gelure superficielle du cou ; T33.2 Gelure superficielle du thorax ; T33.3 Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin ; T33.4 Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras ; T33.5 Gelure superficielle du poignet et de la main ; T33.6 Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse

; T33.7 Gelure superficielle du genou et de la jambe ; T33.8 Gelure superficielle de la cheville et du pied ; T33.9 Gelure superficielle de localisations autres et non précisées

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T34, T35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T33/T33_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t33.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/T33/.

T34 — Gelure avec nécrose des tissus (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T33-T35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : T34.0 Gelure de la tête, avec nécrose des tissus ; T34.1 Gelure du cou, avec nécrose des tissus ; T34.2 Gelure du thorax, avec nécrose des tissus ; T34.3 Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus ; T34.4 Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus ; T34.5 Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus ; T34.6 Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus ; T34.7 Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus ; T34.8 Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus ; T34.9 Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T33, T35
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T34/T34_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t34.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/T34/.

T35 — Gelure de parties multiples du corps et sans précision (D-16-Dermatologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T33-T35 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 107 (burn, cold injury), 208 (burn). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : T35.0 Gelure superficielle de parties multiples du corps ; T35.1 Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus ; T35.2 Gelure de la tête et du cou, sans précision ; T35.3 Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision ; T35.4 Gelure du membre supérieur, sans précision ; T35.5 Gelure du membre inférieur, sans précision ; T35.6 Gelure de parties multiples du corps, sans précision ; T35.7 Gelure, sans précision, de localisation non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : T33, T34
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T35/T35_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/D-16-Dermatologie/travail/T35/.

U-15-Urologie et andrologie

44 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 8 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : Société suisse d'urologie ; EAU.

C61 — Tumeur maligne de la prostate (U-15-Urologie et andrologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C60-C63 · difficulté **très élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C60, C62, C63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C61/C61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/C61/.

N20 — Calcul du rein et de l'uretère (U-15-Urologie et andrologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N20-N23 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 209 (colic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : N20.0 Calcul du rein ; N20.1 Calcul de l'uretère ; N20.2 Calcul du rein avec calcul de l'uretère ; N20.9 Calcul urinaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N21, N22, N23
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N20/N20_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n20.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N20/.

N30 — Cystite (U-15-Urologie et andrologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N30-N39 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : N30.0 Cystite aiguë ; N30.1 Cystite interstitielle (chronique) ; N30.2 Autres cystites chroniques ; N30.3 Trigonite ; N30.4 Cystite due à une irradiation ; N30.8 Autres cystites ; N30.9 Cystite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N30/N30_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N30/.

N39 — Autres affections de l'appareil urinaire (U-15-Urologie et andrologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N30-N39 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : N39.0 Infection des voies urinaires, siège non précisé ; N39.1 Protéinurie persistante, sans précision ; N39.2 Protéinurie orthostatique, sans précision ; N39.3 Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress] ; N39.4 Autres formes d'incontinence urinaire précisées ; N39.8 Autres affections précisées de l'appareil urinaire ; N39.9 Affection de l'appareil urinaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N37
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N39/N39_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n39.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N39/.

N40 — Hyperplasie de la prostate (U-15-Urologie et andrologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N40-N51 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 71 (scrotal pain, swelling, mass), 72 (sexual complaints and dysfunction), 75 (urethral discharge), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N40/N40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N40/.

N41 — Affections inflammatoires de la prostate (U-15-Urologie et andrologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N40-N51 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)

- **Situations PROFILES 2017** : 71 (scrotal pain, swelling, mass), 72 (sexual complaints and dysfunction), 75 (urethral discharge), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : N41.0 Prostatite aiguë ; N41.1 Prostatite chronique ; N41.2 Abscess de la prostate ; N41.3 Prostatite-cystite ; N41.8 Autres affections inflammatoires de la prostate ; N41.9 Affection inflammatoire de la prostate, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N40, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N41/N41_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n41.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N41/.

N43 — Hydrocèle et spermatocele (U-15-Urologie et andrologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N40-N51 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 71 (scrotal pain, swelling, mass), 72 (sexual complaints and dysfunction), 75 (urethral discharge), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : N43.0 Hydrocèle enkystée ; N43.1 Hydrocèle infectée ; N43.2 Autres hydrocèles ; N43.3 Hydrocèle, sans précision ; N43.4 Spermatocele
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N40, N41, N42, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N43/N43_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n43.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N43/.

N45 — Orchite et épididymite (U-15-Urologie et andrologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N40-N51 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 71 (scrotal pain, swelling, mass), 72 (sexual complaints and dysfunction), 75 (urethral discharge), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : N45.0 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès ; N45.9 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, sans abcès
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N40, N41, N42, N43, N44, N46, N47, N48, N49, N50, N51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/N45/N45_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n45.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N45/.

C60 — Tumeur maligne de la verge (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C60-C63 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : C60.0 Tumeur maligne: Prépuce ; C60.1 Tumeur maligne: Gland ; C60.2 Tumeur maligne: Corps de la verge ; C60.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la verge ; C60.9 Tumeur maligne: Verge, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C61, C62, C63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C60/C60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/C60/.

C62 — Tumeur maligne du testicule (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C60-C63 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : C62.0 Tumeur maligne: Cryptorchidie ; C62.1 Tumeur maligne: Testicule descendu ; C62.9 Tumeur maligne: Testicule, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C60, C61, C63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C62/C62_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/C62/.

C63 — Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C60-C63 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : C63.0 Tumeur maligne: Épидidyme ; C63.1 Tumeur maligne: Cordon spermatique ; C63.2 Tumeur maligne: Scrotum ; C63.7 Tumeur maligne: Autres

organes génitaux de l'homme précisés ; C63.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l'homme ; C63.9 Tumeur maligne: Organe génital de l'homme, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C60, C61, C62
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C63/C63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/C63/.

C67 — Tumeur maligne de la vessie (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C64-C68 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : C67.0 Tumeur maligne: Trigone de la vessie ; C67.1 Tumeur maligne: Dôme de la vessie ; C67.2 Tumeur maligne: Paroi latérale de la vessie ; C67.3 Tumeur maligne: Paroi antérieure de la vessie ; C67.4 Tumeur maligne: Paroi postérieure de la vessie ; C67.5 Tumeur maligne: Col vésical ; C67.6 Tumeur maligne: Orifice urétéral ; C67.7 Tumeur maligne: Ouraque ; C67.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de la vessie ; C67.9 Tumeur maligne: Vessie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C68
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C67/C67_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c67.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/C67/.

C68 — Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C64-C68 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : C68.0 Tumeur maligne: Urètre ; C68.1 Tumeur maligne: Glande urétrale ; C68.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes urinaires ; C68.9 Tumeur maligne: Organe urinaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C67
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/C68/C68_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c68.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/C68/.

N21 — Calcul des voies urinaires inférieures (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N20-N23 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 209 (colic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : N21.0 Calcul de la vessie ; N21.1 Calcul de l'urètre ; N21.8 Autres calculs des voies urinaires inférieures ; N21.9 Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N20, N22, N23
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N21/N21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N21/.

N22 — Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N20-N23 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 209 (colic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : N22.0 Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] ; N22.8 Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N20, N21, N23
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N22/N22_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n22.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N22/.

N23 — Colique néphrétique, sans précision (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N20-N23 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 209 (colic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N20, N21, N22
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/N23/N23_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n23.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N23/.

N31 — Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N30-N39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : N31.0 Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs ; N31.1 Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs ; N31.2 Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs ; N31.8 Autres dysfonctionnements neuromusculaires de la vessie ; N31.9 Dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N30, N32, N33, N34, N35, N36, N37, N39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N31/N31_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n31.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N31/.

N32 — Autres affections de la vessie (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N30-N39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : N32.0 Obstruction du col de la vessie ; N32.1 Fistule vésico-intestinale ; N32.2 Fistule vésicale, non classée ailleurs ; N32.3 Diverticule de la vessie ; N32.4 Rupture de la vessie, non traumatique ; N32.8 Autres affections précisées de la vessie ; N32.9 Affection de la vessie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N30, N31, N33, N34, N35, N36, N37, N39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N32/N32_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n32.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N32/.

N33 — Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N30-N39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (2)** : N33.0 Cystite tuberculeuse ; N33.8 Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N30, N31, N32, N34, N35, N36, N37, N39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N33/N33_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n33.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N33/.

N34 — Urétrite et syndrome urétral (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N30-N39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (4)** : N34.0 Abscès urétral ; N34.1 Urétrite non spécifique ; N34.2 Autres urétrites ; N34.3 Syndrome urétral, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N30, N31, N32, N33, N35, N36, N37, N39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N34/N34_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n34.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N34/.

N35 — Rétrécissement urétral (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N30-N39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (4)** : N35.0 Rétrécissement urétral post-traumatique ; N35.1 Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs ; N35.8 Autres rétrécissements urétraux ; N35.9 Rétrécissement urétral, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N30, N31, N32, N33, N34, N36, N37, N39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N35/N35_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N35/.

N36 — Autres affections de l'urètre (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N30-N39 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : N36.0 Fistule urétrale ; N36.1 Diverticule urétral ; N36.2 Caroncule urétrale ; N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale ; N36.8 Autres affections précisées de l'urètre ; N36.9 Affection de l'urètre, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N37, N39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N36/N36_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n36.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N36/.

N37 — Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N30-N39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : N37.0 Urétrite au cours de maladies classées ailleurs ; N37.8 Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N37/N37_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n37.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N37/.

N42 — Autres affections de la prostate (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N40-N51 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 71 (scrotal pain, swelling, mass), 72 (sexual complaints and dysfunction), 75 (urethral discharge), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : N42.0 Calcul de la prostate ; N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques ; N42.2 Atrophie de la prostate ; N42.3 Dysplasie de la prostate ; N42.8 Autres affections précisées de la prostate ; N42.9 Affection de la prostate, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N40, N41, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/N42/N42_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n42.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N42/.

N44 — Torsion du testicule et torsion hydatide (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N40-N51 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 71 (scrotal pain, swelling, mass), 72 (sexual complaints and dysfunction), 75 (urethral discharge), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (2)** : N44.0 Torsion du testicule ; N44.1 Torsion hydatide
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N40, N41, N42, N43, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N44/N44_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n44.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N44/.

N46 — Stérilité, chez l'homme (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N40-N51 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 71 (scrotal pain, swelling, mass), 72 (sexual complaints and dysfunction), 75 (urethral discharge), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N40, N41, N42, N43, N44, N45, N47, N48, N49, N50, N51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N46/N46_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n46.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N46/.

N47 — Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N40-N51 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 71 (scrotal pain, swelling, mass), 72 (sexual complaints and dysfunction), 75 (urethral discharge), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N48, N49, N50, N51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/N47/N47_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n47.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N47/.

N48 — Autres affections de la verge (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N40-N51 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 71 (scrotal pain, swelling, mass), 72 (sexual complaints and dysfunction), 75 (urethral discharge), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : N48.0 Leucoplasie de la verge ; N48.1 Balano-posthite ; N48.2 Autres affections inflammatoires de la verge ; N48.3 Priapisme ; N48.4 Impuissance d'origine organique ; N48.5 Ulcère de la verge ; N48.6 Induration plastique des corps caverneux ; N48.8 Autres affections précisées de la verge ; N48.9 Affection de la verge, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N49, N50, N51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N48/N48_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n48.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N48/.

N49 — Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N40-N51 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 71 (scrotal pain, swelling, mass), 72 (sexual complaints and dysfunction), 75 (urethral discharge), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : N49.0 Affections inflammatoires des vésicules séminales ; N49.1 Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent ; N49.2 Affections inflammatoires du scrotum ; N49.8 Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme ; N49.9 Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N50, N51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N49/N49_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n49.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N49/.

N50 — Autres affections des organes génitaux de l'homme (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N40-N51 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 71 (scrotal pain, swelling, mass), 72 (sexual complaints and dysfunction), 75 (urethral discharge), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (4)** : N50.0 Atrophie du testicule ; N50.1 Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme ; N50.8 Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme ; N50.9 Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N50/N50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N50/.

N51 — Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs (U-15-Urologie et andrologie) • P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** • bloc N40-N51 • difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 71 (scrotal pain, swelling, mass), 72 (sexual complaints and dysfunction), 75 (urethral discharge), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (4)** : N51.0 Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs ; N51.1 Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs ; N51.2 Balanite au cours de maladies classées ailleurs ; N51.8 Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N51/N51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/N51/.

Q53 — Cryptorchidie (U-15-Urologie et andrologie) • P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** • bloc Q50-Q56 • difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (4)** : Q53.0 Testicule en situation anormale ; Q53.1 Cryptorchidie unilatérale ; Q53.2 Cryptorchidie bilatérale ; Q53.9 Cryptorchidie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q54, Q55, Q56
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Q53/Q53_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/Q53/.

Q54 — Hypospadias (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q50-Q56 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : Q54.0 Hypospadias balanique ; Q54.1 Hypospadias pénien ; Q54.2 Hypospadias pénoscrotal ; Q54.3 Hypospadias périnéal ; Q54.4 Chordée congénitale ; Q54.8 Autres hypospadias ; Q54.9 Hypospadias, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q53, Q55, Q56
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q54/Q54_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q54.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/Q54/.

Q55 — Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q50-Q56 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Q55.0 Absence et aplasie du testicule ; Q55.1 Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum ; Q55.2 Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum ; Q55.3 Atrésie du canal déférent ; Q55.4 Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate ; Q55.5 Absence et aplasie congénitales du pénis ; Q55.6 Autres malformations congénitales du pénis ; Q55.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme ; Q55.9 Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q53, Q54, Q56
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q55/Q55_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q55.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/Q55/.

Q56 — Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q50-Q56 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : Q56.0 Hermaphrodisme, non classé ailleurs ; Q56.1 Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs ; Q56.2 Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs ; Q56.3 Pseudo-hermaphrodisme, sans précision ; Q56.4 Sexe indéterminé, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q53, Q54, Q55
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q56/Q56_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q56.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/Q56/.

Q64 — Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q60-Q64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Q64.0 Épispadias ; Q64.1 Exstrophie vésicale ; Q64.2 Valvules urétrales postérieures congénitales ; Q64.3 Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col vésical ; Q64.4 Malformation de l'ouraque ; Q64.5 Absence congénitale de la vessie et de l'urètre ; Q64.6 Diverticule congénital de la vessie ; Q64.7 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre ; Q64.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire ; Q64.9 Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q64/Q64_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q64.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/Q64/.

R30 — Douleur à la miction (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R30-R39 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 75 (urethral discharge), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : R30.0 Dysurie ; R30.1 Ténésme vésical ; R30.9 Miction douloureuse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R31, R32, R33, R34, R35, R36, R39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi

→ 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/R30/R30_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/R30/.

R31 — Hématurie, sans précision (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM** XVIII · bloc R30-R39 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 75 (urethral discharge), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R30, R32, R33, R34, R35, R36, R39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R31/R31_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r31.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/R31/.

R32 — Incontinence urinaire, sans précision (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM** XVIII · bloc R30-R39 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 75 (urethral discharge), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R30, R31, R33, R34, R35, R36, R39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R32/R32_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r32.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/R32/.

R33 — Rétention d'urine (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM** XVIII · bloc R30-R39 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 75 (urethral discharge), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R30, R31, R32, R34, R35, R36, R39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R33/R33_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r33.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/R33/.

R34 — Anurie et oligurie (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R30-R39 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 75 (urethral discharge), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R30, R31, R32, R33, R35, R36, R39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R34/R34_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r34.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/R34/.

R35 — Polyurie, pollakiurie et nycturie (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R30-R39 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 75 (urethral discharge), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : R35.0 Polyurie ; R35.1 Pollakiurie ; R35.2 Nycturie
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R30, R31, R32, R33, R34, R36, R39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R35/R35_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/R35/.

R36 — Écoulement urétral (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R30-R39 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 75 (urethral discharge), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R30, R31, R32, R33, R34, R35, R39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R36/R36_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r36.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/R36/.

T19 — Corps étranger dans les voies génito-urinaires (U-15-Urologie et andrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T15-T19 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 111 (foreign body). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : T19.0 Corps étranger dans l'urètre ; T19.1 Corps étranger dans la vessie ; T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin ; T19.3 Corps étranger dans l'utérus [toute partie] ; T19.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires ; T19.9 Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T19/T19_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t19.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/U-15-Urologie et andrologie/travail/T19/.

I-13-Immunologie et allergologie

7 leçons « Examen fédéral » ; 4 rédigées ; 2 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : SSAI (allergologie et immunologie) ; EAACI.

D86 — Sarcoïdose (I-13-Immunologie et allergologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D80-D90 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 247 (immunocompromised patient). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : D86.0 Sarcoïdose du poumon ; D86.1 Sarcoïdose des ganglions lymphatiques ; D86.2 Sarcoïdose du poumon avec sarcoïdose des ganglions lymphatiques ; D86.3 Sarcoïdose de la peau ; D86.8 Sarcoïdose de localisations autres et associées ; D86.9 Sarcoïdose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D84, D89, D90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D86/D86_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d86.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-13-Immunologie et allergologie/travail/D86/.

D89 — Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs (I-13-Immunologie et allergologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM III** · bloc D80-D90 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 247 (immunocompromised patient). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale ; D89.1 Cryoglobulinémie ; D89.2 Hypergammaglobulinémie, sans précision ; D89.3 Syndrome d'immunoreconstitution ; D89.8 Autres anomalies précisées du système immunitaire, non classées ailleurs ; D89.9 Anomalie du système immunitaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D84, D86, D90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/D89/D89_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d89.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-13-Immunologie et allergologie/travail/D89/.

Z88 — Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques (I-13-Immunologie et allergologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z80-Z99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 263 (suspicion of drug intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Z88.0 Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline ; Z88.1 Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques ; Z88.2 Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides ; Z88.3 Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux ; Z88.4 Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques ; Z88.5 Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques ; Z88.6 Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques ; Z88.7 Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin ; Z88.8 Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques ; Z88.9 Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z88/Z88_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z88.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-13-Immunologie et allergologie/travail/Z88/.

D84 — Déficits immunitaires (I-13-Immunologie et allergologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM III** · bloc D80-D90 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 247 (immunocompromised patient). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : D84.0 Anomalie de la fonction lymphocytaire antigène-1 (LFA-1) ; D84.1 Déficit du complément ; D84.8 Autres déficits immunitaires précisés ; D84.9 Déficit immunitaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : D86, D89, D90
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/D84/D84_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/d84.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-13-Immunologie et allergologie/travail/D84/.

T78 — Anaphylaxie et allergies (I-13-Immunologie et allergologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM XIX** · bloc T66-T78 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 37 (swelling of face, lips, neck; goitre), 49 (painful respiration, wheezing, stridor), 87 (changes in oral, genital or perianal mucosa), 263 (suspicion of drug

intolerance or interaction (including complementary medicine)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : T78.0 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire ; T78.1 Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs ; T78.2 Choc anaphylactique, sans précision ; T78.3 Œdème angioneurotique ; T78.4 Allergie, sans précision ; T78.8 Autres effets indésirables, non classés ailleurs ; T78.9 Effet indésirable, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/T78/T78_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/t78.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-13-Immunologie et allergologie/travail/T78/.

M31 — Vascularites systémiques (I-13-Immunologie et allergologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M30-M36 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility), 168 (elevated biomarkers of inflammation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (9)** : M31.0 Angéite d'hypersensibilité ; M31.1 Microangiopathie thrombotique ; M31.3 Granulomatose avec polyangéite ; M31.4 Syndrome de la crosse aortique [Takayasu] ; M31.5 Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale ; M31.6 Autres artérites à cellules géantes ; M31.7 Micropolyangéite microscopique ; M31.8 Autres vasculopathies nécrosantes précisées ; M31.9 Vasculopathie nécrosante, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M32
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M31/M31_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m31.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-13-Immunologie et allergologie/travail/M31/.

M32 — Lupus érythémateux systémique (I-13-Immunologie et allergologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM XIII** · bloc M30-M36 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 86 (swollen or painful joints, morning stiffness, reduction of joint motility), 168 (elevated biomarkers of inflammation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (4)** : M32.0 Lupus érythémateux disséminé médicamenteux ; M32.1 Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils ; M32.8 Autres formes de lupus érythémateux disséminé ; M32.9 Lupus érythémateux disséminé, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : M31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/M32/M32_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/m32.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-13-Immunologie et allergologie/travail/M32/.

O-11-Obstétrique et néonatalogie

141 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 7 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : gynécologie suisse, Société suisse de néonatalogie ; FIGO comme donnée.

003 — Avortement spontané (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O00-O08 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 79 (vaginal bleeding), 182 (request for abortion), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : O03.0 Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens ; O03.1 Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère ; O03.2 Avortement spontané: Incomplet, compliqué d'une embolie ; O03.3 Avortement spontané: Incomplet, avec complications autres et non précisées ; O03.4 Avortement spontané: Incomplet, sans complication ; O03.5 Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens ; O03.6 Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère ; O03.7 Avortement spontané: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie ; O03.8 Avortement spontané: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées ; O03.9 Avortement spontané: Complet ou sans précision, sans complication
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O00, O01, O02, O04, O05, O06, O07, O08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/003/003_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/O-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/003/.

014 — Prééclampsie (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O10-O16 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : O14.0 Prééclampsie légère à modérée ; O14.1 Prééclampsie sévère ; O14.2 Syndrome HELLP ; O14.9 Prééclampsie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O10, O11, O12, O13, O15, O16
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/014/014_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o14.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/O-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/014/.

024 — Diabète sucré au cours de la grossesse (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P1

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XV** · bloc O20-O29 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : O24.0 Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1 ; O24.1 Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2 ; O24.2 Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition ; O24.3 Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, sans précision ; O24.4 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse ; O24.9 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O20, O21, O22, O23, O25, O26, O28, O29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/024/024_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o24.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/024/.

O80 — Accouchement unique et spontané (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O80-O82 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 176 (basic care in normal delivery and childbed), 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O81, O82
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/080/080_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o80.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/080/.

P07 — Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P05-P08 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : P07.0 Poids extrêmement faible à la naissance ; P07.1 Autres poids faibles à la naissance ; P07.2 Immaturité extrême ; P07.3 Autres enfants nés avant terme
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P05, P08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10.

Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/P07/P07_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p07.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P07/.

P22 — Détresse respiratoire du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P20-P29 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : P22.0 Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né ; P22.1 Tachypnée transitoire du nouveau-né ; P22.8 Autres détresses respiratoires du nouveau-né ; P22.9 Détresse respiratoire du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P20, P21, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P22/P22_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p22.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P22/.

P59 — Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P50-P61 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : P59.0 Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme ; P59.1 Syndrome de la «bile épaisse» ; P59.2 Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision ; P59.3 Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation ; P59.8 Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées ; P59.9 Ictère néonatal, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P60, P61
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P59/P59_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p59.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P59/.

O00 — Grossesse extra-utérine (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O00-O08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 79 (vaginal bleeding), 182 (request for abortion), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : O00.0 Grossesse abdominale ; O00.1 Grossesse tubaire ; O00.2 Grossesse ovarienne ; O00.8 Autres grossesses extra-utérines ; O00.9 Grossesse extra-

utérine, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/000/000_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/000/.

O01 — Môle hydatiforme (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O00-O08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 79 (vaginal bleeding), 182 (request for abortion), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : O01.0 Môle hydatiforme classique ; O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle ; O01.9 Môle hydatiforme, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O00, O02, O03, O04, O05, O06, O07, O08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/001/001_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/001/.

O02 — Autres produits anormaux de la conception (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O00-O08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 79 (vaginal bleeding), 182 (request for abortion), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : O02.0 Œuf clair et môle non hydatiforme ; O02.1 Rétention d'un fœtus mort in utero ; O02.8 Autres produits anormaux de la conception, précisés ; O02.9 Produit anormal de la conception, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O00, O01, O03, O04, O05, O06, O07, O08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/002/002_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/002/.

O04 — Avortement médical (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O00-O08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 79 (vaginal bleeding), 182 (request for abortion), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : 004.0 Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens ; 004.1 Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère ; 004.2 Avortement médical: Incomplet, compliqué d'une embolie ; 004.3 Avortement médical: Incomplet, avec complications autres et non précisées ; 004.4 Avortement médical: Incomplet, sans complication ; 004.5 Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens ; 004.6 Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère ; 004.7 Avortement médical: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie ; 004.8 Avortement médical: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées ; 004.9 Avortement médical: Complet ou sans précision, sans complication
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : 000, 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/004/004_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/004/.

005 — Autres formes d'avortement (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc 000-008 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 79 (vaginal bleeding), 182 (request for abortion), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : 005.0 Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens ; 005.1 Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère ; 005.2 Autres formes d'avortement: Incomplet, compliqué d'une embolie ; 005.3 Autres formes d'avortement: Incomplet, avec complications autres et non précisées ; 005.4 Autres formes d'avortement: Incomplet, sans complication ; 005.5 Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens ; 005.6 Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère ; 005.7 Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie ; 005.8 Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées ; 005.9 Autres formes d'avortement: Complet ou sans précision, sans complication
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : 000, 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/005/005_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/005/.

006 — Avortement, sans précision (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc 000-008 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 79 (vaginal bleeding), 182 (request for abortion), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : 006.0 Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens ; 006.1 Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère ; 006.2 Avortement, sans précision: Incomplet, compliqué d'une embolie ; 006.3 Avortement, sans précision: Incomplet, avec

complications autres et non précisées ; O06.4 Avortement, sans précision: Incomplet, sans complication ; O06.5 Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens ; O06.6 Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère ; O06.7 Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie ; O06.8 Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées ; O06.9 Avortement, sans précision: Complet ou sans précision, sans complication

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O00, O01, O02, O03, O04, O05, O07, O08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/006/006_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o06.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/006/.

O07 — Échec d'une tentative d'avortement (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O00-O08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 79 (vaginal bleeding), 182 (request for abortion), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : O07.0 Échec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens ; O07.1 Échec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère ; O07.2 Échec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie ; O07.3 Échec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées ; O07.4 Échec d'une tentative d'avortement médical, sans complication ; O07.5 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens ; O07.6 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère ; O07.7 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie ; O07.8 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées ; O07.9 Échecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O00, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/007/007_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o07.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/007/.

O08 — Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O00-O08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 79 (vaginal bleeding), 182 (request for abortion), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : O08.0 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ; O08.1 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ; O08.2 Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ; O08.3 Choc

consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ; O08.4 Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ; O08.5 Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ; O08.6 Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ; O08.7 Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ; O08.8 Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ; O08.9 Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) :** O00, O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07
- **Plan :** 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables :** chapters/008/008_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o08.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/008/.

O10 — Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O-11-Obstétrique et néonatalogie) - P2

- **État :** vide
- **Chapitre CIM XV :** bloc O10-O16 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017 :** 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (6) :** O10.0 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O10.1 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O10.2 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O10.3 Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O10.4 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O10.9 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) :** O11, O12, O13, O14, O15, O16
- **Plan :** 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables :** chapters/010/010_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/010/.

O11 — Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée (O-11-Obstétrique et néonatalogie) - P2

- **État :** vide
- **Chapitre CIM XV :** bloc O10-O16 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017 :** 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) :** O10, O12, O13, O14, O15, O16
- **Plan :** 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments

compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/011/011_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/o11.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/011/](#).

012 — Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O10-O16 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : O12.0 Œdème gestationnel ; O12.1 Protéinurie gestationnelle ; O12.2 Œdème gestationnel avec protéinurie
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O10, O11, O13, O14, O15, O16
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/012/012_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/o12.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/012/](#).

013 — Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse] (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O10-O16 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O10, O11, O12, O14, O15, O16
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/013/013_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/o13.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/013/](#).

015 — Eclampsie (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O10-O16 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : O15.0 Eclampsie au cours de la grossesse ; O15.1 Eclampsie au cours du travail ; O15.2 Eclampsie au cours de la puerpéralité ; O15.9 Eclampsie, sans précision quant à la période
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O10, O11, O12, O13, O14, O16

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/015/015_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o15.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/015/.

O16 — Hypertension de la mère, sans précision (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O10-O16 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O10, O11, O12, O13, O14, O15
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/016/016_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o16.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/016/.

O20 — Hémorragie du début de la grossesse (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O20-O29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : O20.0 Menace d'avortement ; O20.8 Autres hémorragies du début de la grossesse ; O20.9 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/020/020_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o20.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/020/.

O21 — Vomissements incoercibles au cours de la grossesse (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O20-O29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : O21.0 Hyperémèse gravidique bénigne ; O21.1 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques ; O21.2 Vomissements tardifs de la grossesse ;

O21.8 Autres vomissements compliquant la grossesse ; O21.9 Vomissements de la grossesse, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O20, O22, O23, O24, O25, O26, O28, O29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/O21/O21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/O21/.

O22 — Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O20-O29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (8)** : O22.0 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse ; O22.1 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse ; O22.2 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse ; O22.3 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse ; O22.4 Hémorroïdes au cours de la grossesse ; O22.5 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse ; O22.8 Autres complications veineuses de la grossesse ; O22.9 Complication veineuse de la grossesse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O20, O21, O23, O24, O25, O26, O28, O29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/O22/O22_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o22.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/O22/.

O23 — Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O20-O29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : O23.0 Infections rénales au cours de la grossesse ; O23.1 Infections vésicales au cours de la grossesse ; O23.2 Infections urétrales au cours de la grossesse ; O23.3 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse ; O23.4 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse ; O23.5 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse ; O23.9 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O20, O21, O22, O24, O25, O26, O28, O29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et

suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/023/023_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o23.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/023/.

O25 — Malnutrition au cours de la grossesse (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O20-O29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O20, O21, O22, O23, O24, O26, O28, O29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/025/025_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o25.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/025/.

O26 — Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O20-O29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : O26.0 Prise de poids excessive au cours de la grossesse ; O26.1 Faible prise de poids au cours de la grossesse ; O26.2 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition ; O26.3 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse ; O26.4 Herpes gestationis ; O26.5 Syndrome d'hypotension maternelle ; O26.6 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ; O26.7 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ; O26.8 Autres affections précisées liées à la grossesse ; O26.9 Affection liée à la grossesse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O20, O21, O22, O23, O24, O25, O28, O29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/026/026_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o26.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/026/.

O28 — Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O20-O29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (8)** : O28.0 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ; O28.1 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ; O28.2 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ; O28.3 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ; O28.4 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ; O28.5 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ; O28.8 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ; O28.9 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/028/028_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o28.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/028/.

O29 — Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse (O-11-Obstétrique et néonatalogie) - P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O20-O29 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (9)** : O29.0 Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse ; O29.1 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse ; O29.2 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse ; O29.3 Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse ; O29.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse ; O29.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse ; O29.6 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse ; O29.8 Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse ; O29.9 Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O20, O21, O22, O23, O24, O25, O26, O28
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/029/029_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o29.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/029/.

O30 — Grossesse multiple (O-11-Obstétrique et néonatalogie) - P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (5)** : O30.0 Jumeaux ; O30.1 Triplés ; O30.2 Quadruplés ; O30.8 Autres grossesses multiples ; O30.9 Grossesse multiple, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42, O43, O44, O45, O46, O47, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/030/030_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/030/.

O31 — Complications spécifiques à une grossesse multiple (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : O31.0 Fœtus papyracé ; O31.1 Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus ; O31.2 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus ; O31.8 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42, O43, O44, O45, O46, O47, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/031/031_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o31.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/031/.

O32 — Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : O32.0 Soins maternels pour position instable ; O32.1 Soins maternels pour présentation du siège ; O32.2 Soins maternels pour position transverse et oblique ; O32.3 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton ; O32.4 Soins maternels pour tête haute à terme ; O32.5 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus ; O32.6 Soins maternels pour présentation complexe ; O32.8 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus ; O32.9 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O31, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42, O43, O44, O45, O46, O47, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/032/032_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o32.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/032/.

O33 — Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : O33.0 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère ; O33.1 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci ; O33.2 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel ; O33.3 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur ; O33.4 Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale ; O33.5 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros ; O33.6 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale ; O33.7 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus ; O33.8 Soins maternels pour disproportion d'autres origines ; O33.9 Soins maternels pour disproportion, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O31, O32, O34, O35, O36, O40, O41, O42, O43, O44, O45, O46, O47, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/033/033_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o33.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/033/.

O34 — Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : O34.0 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus ; O34.1 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus ; O34.2 Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure ; O34.3 Soins maternels pour béance du col ; O34.4 Soins maternels pour d'autres anomalies du col ; O34.5 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide ; O34.6 Soins maternels pour anomalies du vagin ; O34.7 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée ; O34.8 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens ; O34.9 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O31, O32, O33, O35, O36, O40, O41, O42, O43, O44, O45, O46, O47, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/034/034_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o34.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/034/.

O35 — Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales, connues ou présumées (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : O35.0 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus ; O35.1 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus ; O35.2 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus ; O35.3 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère ; O35.4 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel ; O35.5 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses ; O35.6 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation ; O35.7 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique ; O35.8 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées) ; O35.9 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O31, O32, O33, O34, O36, O40, O41, O42, O43, O44, O45, O46, O47, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/035/035_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/035/.

O36 — Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : O36.0 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh ; O36.1 Soins maternels pour une autre iso-immunisation ; O36.2 Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire ; O36.3 Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale ; O36.4 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus ; O36.5 Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus ; O36.6 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus ; O36.7 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable ; O36.8 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus ; O36.9 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O31, O32, O33, O34, O35, O40, O41, O42, O43, O44, O45, O46, O47, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/036/036_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o36.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/036/.

O40 — Hydramnios (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O41, O42, O43, O44, O45, O46, O47, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/040/040_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/040/.

O41 — Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : O41.0 Oligoamnios ; O41.1 Infection du sac amniotique et des membranes ; O41.8 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes ; O41.9 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O42, O43, O44, O45, O46, O47, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/041/041_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o41.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/041/.

O42 — Rupture prématurée des membranes (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : O42.0 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures ; O42.1 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures ; O42.2 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement ; O42.9 Rupture prématurée des membranes, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O43, O44, O45, O46, O47, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments

compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/042/042_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o42.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/042/.

O43 — Anomalies du placenta (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : O43.0 Syndromes de transfusion placentaire ; O43.1 Malformation du placenta ; O43.2 Adhérence pathologique du placenta ; O43.8 Autres anomalies du placenta ; O43.9 Anomalie du placenta, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42, O44, O45, O46, O47, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/043/043_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o43.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/043/.

O44 — Placenta praevia (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : O44.0 Placenta praevia et descente du placenta sans hémorragie (actuelle) ; O44.1 Placenta praevia et descente du placenta avec hémorragie actuelle
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42, O43, O45, O46, O47, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/044/044_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o44.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/044/.

O45 — Décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : O45.0 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation ; O45.8 Autres décollements prématurés du placenta ; O45.9 Décollement prématuré du placenta, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42, O43, O44, O46, O47, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/045/045_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o45.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/045/.

O46 — Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : O46.0 Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation ; O46.8 Autres hémorragies précédant l'accouchement ; O46.9 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42, O43, O44, O45, O47, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/046/046_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o46.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/046/.

O47 — Faux travail (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : O47.0 Faux travail avant 37 semaines entières de gestation ; O47.1 Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation ; O47.9 Faux travail, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42, O43, O44, O45, O46, O48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/047/047_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o47.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/047/.

O48 — Grossesse prolongée (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O30-O48 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O40, O41, O42, O43, O44, O45, O46, O47
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/048/048_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o48.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/048/.

O60 — Travail prématuré avec accouchement (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : O60.0 Travail prématuré sans accouchement ; O60.1 Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré ; O60.2 Travail prématuré avec accouchement à terme ; O60.3 Accouchement prématuré sans travail spontané
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O72, O73, O74, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/060/060_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/060/.

O61 — Échec du déclenchement du travail (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : O61.0 Échec du déclenchement médical du travail ; O61.1 Échec du déclenchement instrumental du travail ; O61.8 Autres échecs du déclenchement du travail ; O61.9 Échec du déclenchement du travail, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O72, O73, O74, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et

suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/061/061_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/061/.

O62 — Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : O62.0 Contractions initiales insuffisantes ; O62.1 Inertie utérine secondaire ; O62.2 Autres formes d'inertie utérine ; O62.3 Travail trop rapide ; O62.4 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées ; O62.8 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail ; O62.9 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O61, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O72, O73, O74, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/062/062_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/062/.

O63 — Travail prolongé (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : O63.0 Prolongation de la première période [dilatation] ; O63.1 Prolongation de la deuxième période [expulsion] ; O63.2 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. ; O63.9 Travail prolongé, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O61, O62, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O72, O73, O74, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/063/063_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/063/.

O64 — Dystocie due à une position et une présentation anormales du fœtus (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of

pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : O64.0 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus ; O64.1 Dystocie due à une présentation du siège ; O64.2 Dystocie due à une présentation de la face ; O64.3 Dystocie due à une présentation du front ; O64.4 Dystocie due à une présentation de l'épaule ; O64.5 Dystocie due à une présentation complexe ; O64.8 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales ; O64.9 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O61, O62, O63, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O72, O73, O74, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/064/064_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o64.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/064/.

O65 — Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : O65.0 Dystocie due à une déformation pelvienne ; O65.1 Dystocie due à un bassin généralement rétréci ; O65.2 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur ; O65.3 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne ; O65.4 Dystocie due à une disproportion fœto-pelvienne, sans précision ; O65.5 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère ; O65.8 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère ; O65.9 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O61, O62, O63, O64, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O72, O73, O74, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/065/065_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o65.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/065/.

O66 — Autres dystocies (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : O66.0 Dystocie due à une dystocie des épaules ; O66.1 Dystocie gémellaire ; O66.2 Dystocie due à un fœtus anormalement gros ; O66.3 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales ; O66.4 Échec de l'épreuve de travail, sans précision ; O66.5 Échec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision ; O66.8 Autres dystocies précisées ; O66.9 Dystocie, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O61, O62, O63, O64, O65, O67, O68, O69, O70, O71, O72, O73, O74, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/066/066_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o66.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/066/.

O67 — Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : O67.0 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation ; O67.8 Autres hémorragies pendant l'accouchement ; O67.9 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O68, O69, O70, O71, O72, O73, O74, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/067/067_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o67.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/067/.

O68 — Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : O68.0 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus ; O68.1 Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique ; O68.2 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique ; O68.3 Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale ; O68.8 Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale ; O68.9 Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O69, O70, O71, O72, O73, O74, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/068/068_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o68.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/068/.

O69 — Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : O69.0 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon ; O69.1 Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression ; O69.2 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon ; O69.3 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon ; O69.4 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon ; O69.5 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon ; O69.8 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical ; O69.9 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O70, O71, O72, O73, O74, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/069/069_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o69.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/069/.

O70 — Déchirure obstétricale du périnée (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : O70.0 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré ; O70.1 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré ; O70.2 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré ; O70.3 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré ; O70.9 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O71, O72, O73, O74, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/070/070_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/070/.

O71 — Autres traumatismes obstétricaux (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : O71.0 Rupture de l'utérus avant le début du travail ; O71.1 Rupture de l'utérus pendant le travail ; O71.2 Inversion post-partum de l'utérus ; O71.3 Déchirure obstétricale du col de l'utérus ; O71.4 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée ; O71.5 Autres lésions obstétricales des organes pelviens ; O71.6 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens ; O71.7 Hématome pelvien d'origine obstétricale ; O71.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés ; O71.9 Traumatisme obstétrical, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O72, O73, O74, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/071/071_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/071/.

O72 — Hémorragie du post-partum (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : O72.0 Hémorragie de la délivrance (troisième période) ; O72.1 Autres hémorragies immédiates du post-partum ; O72.2 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire ; O72.3 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O73, O74, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/072/072_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o72.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/072/.

O73 — Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : O73.0 Rétention du placenta sans hémorragie ; O73.1 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O72, O74, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage →

5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/073/073_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/o73.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/073/](#).

074 — Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : 074.0 Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement ; 074.1 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement ; 074.2 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement ; 074.3 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement ; 074.4 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement ; 074.5 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement ; 074.6 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement ; 074.7 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement ; 074.8 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement ; 074.9 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O72, O73, O75
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/074/074_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/o74.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/074/](#).

075 — Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O60-O75 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : 075.0 Épuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement ; 075.1 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement ; 075.2 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs ; 075.3 Autres infections au cours du travail ; 075.4 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ; 075.5 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes ; 075.6 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes ; 075.7 Accouchement par voie vaginale après une césarienne ; 075.8 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement ; 075.9 Complication du travail et de l'accouchement, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O72, O73, O74

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/075/075_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/o75.py](#), rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/075/.

O81 — Accouchement unique par forceps et ventouse (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O80-O82 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 176 (basic care in normal delivery and childbed), 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O80, O82
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/081/081_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/o81.py](#), rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/081/.

O82 — Accouchement unique par césarienne (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O80-O82 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 176 (basic care in normal delivery and childbed), 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O80, O81
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/082/082_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/o82.py](#), rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/082/.

O85 — Fièvre puerpérale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O85-O92 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O86, O87, O88, O89, O90, O91, O92
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et

suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/085/085_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/o85.py](#), rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/085/.

086 — Autres infections puerpérales (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O85-O92 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : O86.0 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale ; O86.1 Autres infections des voies génitales, après accouchement ; O86.2 Infection des voies urinaires, après accouchement ; O86.3 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement ; O86.4 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement ; O86.8 Autres infections puerpérales précisées
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O85, O87, O88, O89, O90, O91, O92
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/086/086_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/o86.py](#), rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/086/.

087 — Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la puerpéralité (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O85-O92 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : O87.0 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité ; O87.1 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité ; O87.2 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité ; O87.3 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité ; O87.8 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité ; O87.9 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O85, O86, O88, O89, O90, O91, O92
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/087/087_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/o87.py](#), rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/087/.

088 — Embolie obstétricale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O85-O92 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of

pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : O88.0 Embolie gazeuse obstétricale ; O88.1 Embolie amniotique ; O88.2 Embolie obstétricale par caillot sanguin ; O88.3 Embolie pyohémique et septique, obstétricale ; O88.8 Autres embolies obstétricales
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O85, O86, O87, O89, O90, O91, O92
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/088/088_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o88.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/088/.

O89 — Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O85-O92 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : O89.0 Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité ; O89.1 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité ; O89.2 Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité ; O89.3 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité ; O89.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité ; O89.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité ; O89.6 Échec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité ; O89.8 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité ; O89.9 Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O85, O86, O87, O88, O90, O91, O92
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/089/089_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o89.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/089/.

O90 — Complications puerpérales, non classées ailleurs (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O85-O92 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : O90.0 Rupture d'une suture de césarienne ; O90.1 Rupture d'une suture obstétricale du périnée ; O90.2 Hématome d'une plaie obstétricale ; O90.3 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité ; O90.4 Insuffisance rénale aiguë du post-partum ; O90.5 Thyroïdite du post-partum ; O90.8 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs ; O90.9 Complication puerpérale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O85, O86, O87, O88, O89, O91, O92

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/090/090_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o90.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/090/.

091 — Infections mammaires associées à l'accouchement (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O85-O92 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : O91.0 Infection du mamelon associée à l'accouchement ; O91.1 Abscess du sein associé à l'accouchement ; O91.2 Mastite non purulente associée à l'accouchement
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O85, O86, O87, O88, O89, O90, O92
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/091/091_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o91.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/091/.

092 — Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O85-O92 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : O92.0 Invagination du mamelon associée à l'accouchement ; O92.1 Crevasses du mamelon associées à l'accouchement ; O92.2 Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision ; O92.3 Agalactie ; O92.4 Hypogalactie ; O92.5 Suppression de la lactation ; O92.6 Galactorrhée ; O92.7 Anomalies de la lactation, autres et sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O85, O86, O87, O88, O89, O90, O91
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/092/092_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o92.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/092/.

094 — Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XV** · bloc O94-O99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O95, O96, O97, O98, O99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/094/094_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o94.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/094/.

O95 — Mort d'origine obstétricale de cause non précisée (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O94-O99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O94, O96, O97, O98, O99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/095/095_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o95.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/095/.

O96 — Mort d'origine obstétricale survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O94-O99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : O96.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ; O96.1 Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ; O96.9 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O94, O95, O97, O98, O99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/096/096_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o96.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/096/.

O97 — Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O94-O99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : O97.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale ; O97.1 Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale ; O97.9 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O94, O95, O96, O98, O99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/097/097_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o97.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/097/.

O98 — Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O94-O99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : O98.0 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O98.1 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O98.2 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O98.3 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O98.4 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O98.5 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O98.6 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O98.7 Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O98.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O98.9 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O94, O95, O96, O97, O99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/098/098_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o98.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/098/.

O99 — Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XV** · bloc O94-O99 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 178 (maternal problems during pregnancy, fever, oedema, hypertension, premature labour), 179 (problems related to delivery), 181 (process and basic care of pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : O99.0 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O99.1 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O99.2 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O99.3 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O99.4 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O99.5 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O99.6 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O99.7 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ; O99.8 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : O94, O95, O96, O97, O98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie de la grossesse concernée → 4. Présentation clinique et dépistage → 5. Surveillance materno-fœtale → 6. Prise en charge (gynécologie suisse) → 7. Médicaments compatibles grossesse et allaitement → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/099/099_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/o99.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/099/.

P00 — Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P00-P04 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 190 (fetal problems during pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : P00.0 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère ; P00.1 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère ; P00.2 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère ; P00.3 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de la mère ; P00.4 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère ; P00.5 Fœtus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère ; P00.6 Fœtus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère ; P00.7 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère, non classées ailleurs ; P00.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles ; P00.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P01, P02, P03, P04
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P00/P00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P00/.

P01 — Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XVI** · bloc P00-P04 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 190 (fetal problems during pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : P01.0 Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du col ; P01.1 Fœtus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes ; P01.2 Fœtus et nouveau-né affectés par un oligoamnios ; P01.3 Fœtus et nouveau-né affectés par un hydramnios ; P01.4 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse extra-utérine ; P01.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple ; P01.6 Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère ; P01.7 Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail ; P01.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications de la grossesse chez la mère ; P01.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la grossesse chez la mère, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P00, P02, P03, P04
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P01/P01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P01/.

P02 — Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P00-P04 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 190 (fetal problems during pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : P02.0 Fœtus et nouveau-né affectés par placenta praevia ; P02.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires ; P02.2 Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision ; P02.3 Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire ; P02.4 Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical ; P02.5 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical ; P02.6 Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans précision ; P02.7 Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amnionite ; P02.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes ; P02.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P00, P01, P03, P04
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P02/P02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P02/.

P03 — Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P00-P04 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 190 (fetal problems during pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (9)** : P03.0 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège ; P03.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ; P03.2 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps ; P03.3 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse] ; P03.4 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne ; P03.5 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité ; P03.6 Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus ; P03.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement ; P03.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P00, P01, P02, P04
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P03/P03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P03/.

P04 — Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P00-P04 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 190 (fetal problems during pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (9)** : P04.0 Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ; P04.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère ; P04.2 Fœtus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère ; P04.3 Fœtus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère ; P04.4 Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère ; P04.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles ; P04.6 Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement ; P04.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels ; P04.9 Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P00, P01, P02, P03
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P04/P04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P04/.

P05 — Retard de croissance et malnutrition du fœtus (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P05-P08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (4)** : P05.0 Faible poids pour l'âge gestationnel ; P05.1 Petite taille pour l'âge gestationnel ; P05.2 Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel ; P05.9 Croissance lente du fœtus, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P07, P08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P05/P05_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P05/.

P08 — Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P05-P08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : P08.0 Enfant exceptionnellement gros ; P08.1 Autres enfants gros pour l'âge gestationnel ; P08.2 Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P05, P07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P08/P08_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p08.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P08/.

P10 — Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P10-P15 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : P10.0 Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical ; P10.1 Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical ; P10.2 Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical ; P10.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical ; P10.4 Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical ; P10.8 Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical ; P10.9 Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P11, P12, P13, P14, P15
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P10/P10_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P10/.

P11 — Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P10-P15 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : P11.0 Œdème cérébral dû à un traumatisme obstétrical ; P11.1 Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical ; P11.2 Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical ; P11.3 Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [nerf crânien VII] ; P11.4 Lésion des autres nerfs crâniens due à un traumatisme obstétrical ; P11.5 Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical ; P11.9 Lésion du système nerveux central due à un traumatisme obstétrical, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P10, P12, P13, P14, P15
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P11/P11_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p11.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P11/.

P12 — Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P10-P15 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : P12.0 Céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical ; P12.1 Hématome en chignon dû à un traumatisme obstétrical ; P12.2 Hémorragie épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical ; P12.3 Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical ; P12.4 Lésion du cuir chevelu liée à une surveillance électronique continue ; P12.8 Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical ; P12.9 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P10, P11, P13, P14, P15
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P12/P12_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p12.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P12/.

P13 — Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P10-P15 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : P13.0 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical ; P13.1 Autres lésions du crâne dues à un traumatisme obstétrical ; P13.2 Lésion du

fémur due à un traumatisme obstétrical ; P13.3 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical ; P13.4 Fracture de la clavicule due à un traumatisme obstétrical ; P13.8 Lésions d'autres parties du squelette dues à un traumatisme obstétrical ; P13.9 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P10, P11, P12, P14, P15
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P13/P13_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p13.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P13/.

P14 — Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P10-P15 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : P14.0 Paralysie de Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical ; P14.1 Paralysie de Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical ; P14.2 Paralysie du nerf phrénique due à un traumatisme obstétrical ; P14.3 Autres lésions du plexus brachial dues à un traumatisme obstétrical ; P14.8 Lésions d'autres parties du système nerveux périphérique dues à un traumatisme obstétrical ; P14.9 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P10, P11, P12, P13, P15
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P14/P14_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p14.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P14/.

P15 — Autres traumatismes obstétricaux (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P10-P15 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : P15.0 Traumatisme obstétrical du foie ; P15.1 Traumatisme obstétrical de la rate ; P15.2 Lésion sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme obstétrical ; P15.3 Lésion de l'œil due à un traumatisme obstétrical ; P15.4 Lésion faciale due à un traumatisme obstétrical ; P15.5 Lésion des organes génitaux externes due à un traumatisme obstétrical ; P15.6 Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical ; P15.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés ; P15.9 Traumatisme obstétrical, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P10, P11, P12, P13, P14
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/P15/P15_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p15.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P15/.

P20 — Hypoxie intra-utérine (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P20-P29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : P20.0 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du travail ; P20.1 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l'accouchement ; P20.9 Hypoxie intra-utérine, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P20/P20_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p20.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P20/.

P21 — Asphyxie obstétricale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P20-P29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : P21.0 Asphyxie obstétricale grave ; P21.1 Asphyxie obstétricale légère ou modérée ; P21.9 Asphyxie obstétricale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P20, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P21/P21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P21/.

P23 — Pneumonie congénitale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P20-P29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : P23.0 Pneumonie congénitale due à un agent viral ; P23.1 Pneumonie congénitale à Chlamydia ; P23.2 Pneumonie congénitale à staphylocoques ; P23.3 Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B ; P23.4 Pneumonie congénitale à Escherichia coli ; P23.5 Pneumonie congénitale à Pseudomonas ; P23.6 Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens ; P23.8 Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes ; P23.9 Pneumonie congénitale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P20, P21, P22, P24, P25, P26, P27, P28, P29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8.

Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/P23/P23_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p23.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P23/.

P24 — Syndromes néonataux d'aspiration (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P20-P29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : P24.0 Aspiration néonatale de méconium ; P24.1 Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus ; P24.2 Aspiration néonatale de sang ; P24.3 Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités ; P24.8 Autres syndromes néonataux d'aspiration ; P24.9 Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P20, P21, P22, P23, P25, P26, P27, P28, P29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P24/P24_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p24.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P24/.

P25 — Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P20-P29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : P25.0 Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale ; P25.1 Pneumothorax survenant pendant la période périnatale ; P25.2 Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale ; P25.3 Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale ; P25.8 Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P20, P21, P22, P23, P24, P26, P27, P28, P29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P25/P25_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p25.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P25/.

P26 — Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P20-P29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : P26.0 Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale ; P26.1 Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale ; P26.8 Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale ; P26.9 Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P20, P21, P22, P23, P24, P25, P27, P28, P29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P26/P26_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p26.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P26/.

P27 — Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P20-P29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : P27.0 Syndrome de Wilson-Mikity ; P27.1 Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale ; P27.8 Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale ; P27.9 Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P28, P29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P27/P27_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p27.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P27/.

P28 — Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P20-P29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : P28.0 Atélectasie primitive du nouveau-né ; P28.1 Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision ; P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né ; P28.3 Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né ; P28.4 Autres apnées du nouveau-né ; P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveau-né ; P28.8 Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né ; P28.9 Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P28/P28_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p28.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P28/.

P29 — Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P20-P29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : P29.0 Insuffisance cardiaque néonatale ; P29.1 Arythmie cardiaque néonatale ; P29.2 Hypertension néonatale ; P29.3 Persistance de la circulation fœtale ; P29.4 Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né ; P29.8 Autres affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale ; P29.9 Affection cardio-vasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P29/P29_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p29.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P29/.

P35 — Maladies virales congénitales (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P35-P39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : P35.0 Syndrome de rubéole congénitale ; P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus ; P35.2 Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex] ; P35.3 Hépatite virale congénitale ; P35.4 Maladie congénitale à virus Zika ; P35.8 Autres maladies virales congénitales ; P35.9 Maladie virale congénitale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P36, P37, P38, P39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P35/P35_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P35/.

P36 — Sepsis bactérien du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P35-P39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : P36.0 Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B ; P36.1 Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision ; P36.2 Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés ; P36.3 Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision ; P36.4 Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli ; P36.5 Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies ; P36.8 Autres sepsis bactériens du nouveau-né ; P36.9 Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P35, P37, P38, P39

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P36/P36_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p36.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P36/.

P37 — Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P35-P39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : P37.0 Tuberculose congénitale ; P37.1 Toxoplasmose congénitale ; P37.2 Listériose néonatale (disséminée) ; P37.3 Paludisme congénital à Plasmodium falciparum ; P37.4 Autres formes de paludisme congénital ; P37.5 Candidose néonatale ; P37.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées ; P37.9 Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P35, P36, P38, P39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P37/P37_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p37.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P37/.

P38 — Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P35-P39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P35, P36, P37, P39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P38/P38_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p38.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P38/.

P39 — Autres infections spécifiques de la période périnatale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P35-P39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : P39.0 Mastite infectieuse néonatale ; P39.1 Conjonctivite et dacryocystite néonatales ; P39.2 Infection intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs ; P39.3 Infection néonatale des voies urinaires ; P39.4 Infection néonatale de la peau ; P39.8 Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale ; P39.9 Infection spécifique de la période périnatale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P35, P36, P37, P38
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P39/P39_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p39.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P39/.

P50 — Perte de sang fœtal (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P50-P61 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (8)** : P50.0 Perte de sang fœtal due à une insertion vélamenteuse du cordon ; P50.1 Perte de sang fœtal due à une rupture du cordon ; P50.2 Perte de sang fœtal d'origine placentaire ; P50.3 Hémorragie vers un jumeau ; P50.4 Hémorragie vers la circulation maternelle ; P50.5 Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un jumeau ; P50.8 Autres pertes de sang fœtal ; P50.9 Perte de sang fœtal, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P50/P50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P50/.

P51 — Hémorragie ombilicale du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P50-P61 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (3)** : P51.0 Hémorragie ombilicale massive du nouveau-né ; P51.8 Autres hémorragies ombilicales du nouveau-né ; P51.9 Hémorragie ombilicale du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P50, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P51/P51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P51/.

P52 — Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P50-P61 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : P52.0 Hémorragie intracrânienne (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né ; P52.1 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né ; P52.2 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né ; P52.3 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision ; P52.4 Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ; P52.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ; P52.6 Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ; P52.8 Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du fœtus et du nouveau-né ; P52.9 Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P50, P51, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P52/P52_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p52.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P52/.

P53 — Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P50-P61 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P50, P51, P52, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P53/P53_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P53/.

P54 — Autres hémorragies néonatales (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P50-P61 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : P54.0 Hématémèse néonatale ; P54.1 Méléna néonatal ; P54.2 Hémorragie rectale néonatale ; P54.3 Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales ; P54.4 Hémorragie surrénalienne néonatale ; P54.5 Hémorragie cutanée néonatale ; P54.6

Hémorragie vaginale néonatale ; P54.8 Autres hémorragies néonatales précisées ; P54.9 Hémorragie néonatale, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P50, P51, P52, P53, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P54/P54_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p54.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P54/.

P55 — Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P50-P61 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : P55.0 Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né ; P55.1 Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né ; P55.8 Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né ; P55.9 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P50, P51, P52, P53, P54, P56, P57, P58, P59, P60, P61
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P55/P55_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p55.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P55/.

P56 — Anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P50-P61 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : P56.0 Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation ; P56.9 Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P50, P51, P52, P53, P54, P55, P57, P58, P59, P60, P61
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P56/P56_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p56.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P56/.

P57 — Ictère nucléaire (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P50-P61 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : P57.0 Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation ; P57.8 Autres formes précisées d'ictère nucléaire ; P57.9 Ictère nucléaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P58, P59, P60, P61
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P57/P57_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p57.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P57/.

P58 — Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P50-P61 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions ; P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement ; P58.2 Ictère néonatal dû à une infection ; P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie ; P58.4 Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né ; P58.5 Ictère néonatal dû à une déglutition de sang maternel ; P58.8 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées ; P58.9 Ictère néonatal dû à une hémolyse excessive, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P59, P60, P61
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P58/P58_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p58.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P58/.

P60 — Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P50-P61 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P61
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10.

Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/P60/P60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P60/.

P61 — Autres affections hématologiques de la période périnatale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P50-P61 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire ; P61.1 Polycythémie du nouveau-né ; P61.2 Anémie de la prématurité ; P61.3 Anémie congénitale par perte de sang fœtal ; P61.4 Autres anémies congénitales, non classées ailleurs ; P61.5 Neutropénie néonatale transitoire ; P61.6 Autres affections transitoires de la coagulation pendant la période néonatale ; P61.8 Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale ; P61.9 Affection hématologique de la période périnatale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P61/P61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P61/.

P70 — Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P70-P74 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : P70.0 Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse ; P70.1 Syndrome de l'enfant de mère diabétique ; P70.2 Diabète sucré néonatal ; P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène ; P70.4 Autres hypoglycémies néonatales ; P70.8 Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né ; P70.9 Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P71, P72, P74
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P70/P70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P70/.

P71 — Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P70-P74 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : P71.0 Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache ; P71.1 Autres hypocalcémies du nouveau-né ; P71.2 Hypomagnésémie néonatale ; P71.3 Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium ; P71.4 Hypoparathyroïdie néonatale transitoire ; P71.8 Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né ; P71.9 Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P70, P72, P74
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P71/P71_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P71/.

P72 — Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P70-P74 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (5)** : P72.0 Goitre néonatal, non classé ailleurs ; P72.1 Hyperthyroïdie transitoire néonatale ; P72.2 Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs ; P72.8 Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né ; P72.9 Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P70, P71, P74
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P72/P72_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p72.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P72/.

P74 — Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P70-P74 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (8)** : P74.0 Acidose métabolique tardive du nouveau-né ; P74.1 Déshydratation du nouveau-né ; P74.2 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né ; P74.3 Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né ; P74.4 Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né ; P74.5 Tyrosinémie transitoire du nouveau-né ; P74.8 Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né ; P74.9 Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P70, P71, P72
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et

dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/P74/P74_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p74.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P74/.

P75 — Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P75-P78 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P76, P77, P78
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P75/P75_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p75.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P75/.

P76 — Autres occlusions intestinales du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P75-P78 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : P76.0 Syndrome du bouchon méconial ; P76.1 Iléus transitoire du nouveau-né ; P76.2 Occlusion intestinale due à un lait épaissi ; P76.8 Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né ; P76.9 Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P75, P77, P78
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P76/P76_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p76.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P76/.

P77 — Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P75-P78 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P75, P76, P78
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10.

Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/P77/P77_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p77.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P77/.

P78 — Autres affections périnatales de l'appareil digestif (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P75-P78 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : P78.0 Perforation intestinale périnatale ; P78.1 Autres péritonites néonatales ; P78.2 Hématémèse et mélæna néonataux dus à une déglutition de sang maternel ; P78.3 Diarrhée non infectieuse néonatale ; P78.8 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif ; P78.9 Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P75, P76, P77
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P78/P78_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p78.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P78/.

P80 — Hypothermie du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P80-P83 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : P80.0 Syndrome hypothermique du nouveau-né ; P80.8 Autres formes d'hypothermie du nouveau-né ; P80.9 Hypothermie du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P81, P83
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P80/P80_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p80.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P80/.

P81 — Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P80-P83 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : P81.0 Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement ; P81.8 Autres troubles précisés de la régulation thermique du nouveau-né ; P81.9 Trouble de la régulation thermique du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P80, P83

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P81/P81_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p81.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P81/.

P83 — Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P80-P83 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : P83.0 Sclérème du nouveau-né ; P83.1 Érythème toxique du nouveau-né ; P83.2 Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique ; P83.3 Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du nouveau-né ; P83.4 Engorgement du sein chez le nouveau-né ; P83.5 Hydrocèle congénitale ; P83.6 Polype ombilical du nouveau-né ; P83.8 Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né ; P83.9 Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P80, P81
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P83/P83_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p83.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P83/.

P90 — Convulsions du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P90-P96 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P91, P92, P93, P94, P95, P96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P90/P90_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p90.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P90/.

P91 — Autres affections cérébrales du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P90-P96 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : P91.0 Ischémie cérébrale néonatale ; P91.1 Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né ; P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale ; P91.3 Irritabilité cérébrale du nouveau-né ; P91.4 Baisse de l'activité cérébrale du nouveau-né ; P91.5 Coma du nouveau-né ; P91.6 Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né ; P91.7 Hydrocéphalie acquise du nouveau-né ; P91.8 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né ; P91.9 Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P90, P92, P93, P94, P95, P96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P91/P91_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p91.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P91/.

P92 — Problèmes alimentaires du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P90-P96 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (8)** : P92.0 Vomissements du nouveau-né ; P92.1 Régurgitation et mérycisme du nouveau-né ; P92.2 Alimentation lente du nouveau-né ; P92.3 Sous-alimentation du nouveau-né ; P92.4 Suralimentation du nouveau-né ; P92.5 Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né ; P92.8 Autres problèmes alimentaires du nouveau-né ; P92.9 Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P90, P91, P93, P94, P95, P96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P92/P92_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p92.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P92/.

P93 — Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P90-P96 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P90, P91, P92, P94, P95, P96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P93/P93_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p93.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P93/.

P94 — Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P90-P96 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : P94.0 Myasthénie transitoire néonatale ; P94.1 Hypertonie congénitale ; P94.2 Hypotonie congénitale ; P94.8 Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né ; P94.9 Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P90, P91, P92, P93, P95, P96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P94/P94_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p94.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P94/.

P95 — Mort fœtale de cause non précisée (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P90-P96 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P90, P91, P92, P93, P94, P96
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/P95/P95_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p95.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P95/.

P96 — Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVI** · bloc P90-P96 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 175 (abnormal birth weight and prematurity), 190 (fetal problems during pregnancy), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : P96.0 Insuffisance rénale congénitale ; P96.1 Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère ; P96.2 Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né ; P96.3 Retard de fermeture des sutures crâniennes ; P96.4 Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né ; P96.5 Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs ; P96.8 Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale ; P96.9 Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : P90, P91, P92, P93, P94, P95
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Adaptation néonatale normale → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic et dépistage néonatal → 6. Prise en charge (pédiatrie suisse) → 7. Complications et pronostic → 8. Prévention, dépistage et suivi → 9. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 10.

Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 11. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/P96/P96_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/p96.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/P96/.

Z32 — Examen et test de grossesse (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z30-Z39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 176 (basic care in normal delivery and childbed), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation), 180 (problems related to lactation), 181 (process and basic care of pregnancy), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z32/Z32_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z32.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/Z32/.

Z33 — Grossesse constatée fortuitement (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z30-Z39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 176 (basic care in normal delivery and childbed), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation), 180 (problems related to lactation), 181 (process and basic care of pregnancy), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z32, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z33/Z33_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z33.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/Z33/.

Z34 — Surveillance d'une grossesse normale (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z30-Z39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 176 (basic care in normal delivery and childbed), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation), 180 (problems related to lactation), 181 (process and basic care of pregnancy), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z32, Z33, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Z34/Z34_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z34.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/Z34/.

Z35 — Surveillance d'une grossesse à haut risque (O-11-Obstétrique et néonatalogie)

· P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z30-Z39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 176 (basic care in normal delivery and childbed), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation), 180 (problems related to lactation), 181 (process and basic care of pregnancy), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Z35.0 Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité ; Z35.1 Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement ; Z35.2 Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer ; Z35.3 Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants ; Z35.4 Surveillance de grossesse avec multiparité élevée ; Z35.5 Surveillance d'une primigeste âgée ; Z35.6 Surveillance d'une primigeste très jeune ; Z35.8 Surveillance d'autres grossesses à haut risque ; Z35.9 Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z32, Z33, Z34, Z36, Z37, Z38, Z39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z35/Z35_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/Z35/.

Z36 — Dépistage prénatal (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z30-Z39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 176 (basic care in normal delivery and childbed), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation), 180 (problems related to lactation), 181 (process and basic care of pregnancy), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : Z36.0 Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques ; Z36.1 Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-fœtoprotéines ; Z36.2 Autres dépistages prénatals par amniocentèse ; Z36.3 Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques ; Z36.4 Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques ; Z36.5 Dépistage prénatal d'iso-immunisation ; Z36.8 Autres dépistages prénatals ; Z36.9 Dépistage prénatal, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z32, Z33, Z34, Z35, Z37, Z38, Z39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Z36/Z36_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z36.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/Z36/.

Z37 — Résultat de l'accouchement (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z30-Z39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 176 (basic care in normal delivery and childbed), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation), 180 (problems related to lactation), 181 (process and basic care of pregnancy), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Z37.0 Naissance unique, enfant vivant ; Z37.1 Naissance unique, enfant mort-né ; Z37.2 Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants ; Z37.3 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né ; Z37.4 Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés ; Z37.5 Autres naissances multiples, tous nés vivants ; Z37.6 Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants ; Z37.7 Autres naissances multiples, tous morts-nés ; Z37.9 Résultat de l'accouchement, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z38, Z39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z37/Z37_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z37.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/Z37/.

Z38 — Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z30-Z39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 176 (basic care in normal delivery and childbed), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation), 180 (problems related to lactation), 181 (process and basic care of pregnancy), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Z38.0 Enfant unique, né à l'hôpital ; Z38.1 Enfant unique, né hors d'un hôpital ; Z38.2 Enfant unique, lieu de naissance non précisé ; Z38.3 Jumeaux, nés à l'hôpital ; Z38.4 Jumeaux, nés hors d'un hôpital ; Z38.5 Jumeaux, lieu de naissance non précisé ; Z38.6 Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital ; Z38.7 Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital ; Z38.8 Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z39
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z38/Z38_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z38.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/Z38/.

Z39 — Soins et examens du post-partum (O-11-Obstétrique et néonatalogie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z30-Z39 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 176 (basic care in normal delivery and childbed), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation), 180 (problems related to lactation), 181 (process and basic care of pregnancy), 183 (suspicion of pregnancy, unplanned pregnancy). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : Z39.0 Soins et examens immédiatement après l'accouchement ; Z39.1 Soins et examens de l'allaitement maternel ; Z39.2 Contrôle de routine au cours du post-partum
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z39/Z39_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z39.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-11-Obstétrique et néonatalogie/travail/Z39/.

O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs

24 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 0 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : SAKK, Ligue contre le cancer, Société suisse de génétique médicale, palliative.ch ; ESMO.

C47 — Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C45-C49 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : C47.0 Tumeur maligne: Nerfs périphériques de la tête, de la face et du cou ; C47.1 Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l'épaule ; C47.2 Tumeur maligne: Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la hanche ; C47.3 Tumeur maligne: Nerfs périphériques du thorax ; C47.4 Tumeur maligne: Nerfs périphériques de l'abdomen ; C47.5 Tumeur maligne: Nerfs périphériques du pelvis ; C47.6 Tumeur maligne: Nerfs périphériques du tronc, sans précision ; C47.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux autonome ; C47.9 Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système nerveux autonome, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C48, C49
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C47/C47_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c47.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/C47/.

C48 — Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C45-C49 · difficulté **très élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : C48.0 Tumeur maligne: Rétropéritoine ; C48.1 Tumeur maligne: Parties précisées du péritoine ; C48.2 Tumeur maligne: Péritoine, sans précision ; C48.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du péritoine
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C47, C49
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C48/C48_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c48.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/C48/.

C49 — Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C45-C49 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : C49.0 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la face et du cou ; C49.1 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l'épaule ; C49.2 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche ; C49.3 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax ; C49.4 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen ; C49.5 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis ; C49.6 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision ; C49.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous ; C49.9 Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C47, C48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C49/C49_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c49.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/C49/.

C76 — Tumeur maligne de sièges autres et mal définis (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C76-C80 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (8)** : C76.0 Tumeur maligne: Tête, face et cou ; C76.1 Tumeur maligne: Thorax ; C76.2 Tumeur maligne: Abdomen ; C76.3 Tumeur maligne: Pelvis ; C76.4 Tumeur maligne: Membre supérieur ; C76.5 Tumeur maligne: Membre inférieur ; C76.7 Tumeur maligne: Autres sièges mal définis ; C76.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal définis
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C78, C79, C80
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C76/C76_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c76.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/C76/.

C78 — Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C76-C80 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (9)** : C78.0 Tumeur maligne secondaire du poumon ; C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin ; C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre ; C78.3 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés ; C78.4 Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle ; C78.5 Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum ; C78.6 Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine ; C78.7 Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques ; C78.8 Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C76, C79, C80
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C78/C78_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c78.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/C78/.

C79 — Tumeur maligne secondaire de sièges autres et non précisés (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C76-C80 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : C79.0 Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet ; C79.1 Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés ; C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau ; C79.3 Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales ; C79.4 Tumeur maligne secondaire de parties du système

nerveux, autres et non précisées ; C79.5 Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse ; C79.6 Tumeur maligne secondaire de l'ovaire ; C79.7 Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale ; C79.8 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés ; C79.9 Tumeur maligne secondaire de siège non précisé

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) :** C76, C78, C80
- **Plan :** 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables :** chapters/C79/C79_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c79.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/C79/.

C80 — Tumeur maligne de siège non précisé (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État :** vide
- **Chapitre CIM II :** bloc C76-C80 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017 :** 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (2) :** C80.0 Tumeur maligne, siège primitif inconnu, ainsi précisée ; C80.9 Tumeur maligne, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) :** C76, C78, C79
- **Plan :** 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables :** chapters/C80/C80_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c80.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/C80/.

C97 — Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs) (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État :** vide
- **Chapitre CIM II :** bloc C97-C97 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017 :** 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Plan :** 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables :** chapters/C97/C97_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c97.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/C97/.

Q85 — Phacomatoses, non classées ailleurs (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q80-Q89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : Q85.0 Neurofibromatose (non maligne) ; Q85.1 Sclérose tubéreuse ; Q85.8 Autres phacomatoses, non classées ailleurs ; Q85.9 Phacomatose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q86, Q87, Q89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q85/Q85_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q85.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Q85/.

Q86 — Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q80-Q89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : Q86.0 Syndrome d'alcoolisme fœtal (dysmorphique) ; Q86.1 Embryopathie due aux anti-épileptiques ; Q86.2 Dysmorphisme dû à la warfarine ; Q86.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q85, Q87, Q89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q86/Q86_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q86.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Q86/.

Q87 — Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q80-Q89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : Q87.0 Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face ; Q87.1 Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille ; Q87.2 Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres ; Q87.3 Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un

gigantisme néonatal ; Q87.4 Syndrome de Marfan ; Q87.5 Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette ; Q87.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q85, Q86, Q89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q87/Q87_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q87.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Q87/.

Q89 — Autres malformations congénitales, non classées ailleurs (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q80-Q89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : Q89.0 Malformations congénitales de la rate ; Q89.1 Malformations congénitales des surrénales ; Q89.2 Malformations congénitales des autres glandes endocrines ; Q89.3 Situs inversus ; Q89.4 Jumeaux soudés ; Q89.7 Malformations congénitales multiples, non classées ailleurs ; Q89.8 Autres malformations congénitales précisées ; Q89.9 Malformation congénitale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q85, Q86, Q87
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q89/Q89_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q89.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Q89/.

Q90 — Syndrome de Down (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q90-Q99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : Q90.0 Trisomie 21, non-disjonction méiotique ; Q90.1 Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ; Q90.2 Trisomie 21, translocation ; Q90.9 Syndrome de Down, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q91, Q92, Q93, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Q90/Q90_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q90.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Q90/.

Q91 — Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q90-Q99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : Q91.0 Trisomie 18, non-disjonction méiotique ; Q91.1 Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ; Q91.2 Trisomie 18, translocation ; Q91.3 Syndrome d'Edwards, sans précision ; Q91.4 Trisomie 13, non-disjonction méiotique ; Q91.5 Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ; Q91.6 Trisomie 13, translocation ; Q91.7 Syndrome de Patau, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q90, Q92, Q93, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q91/Q91_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q91.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Q91/.

Q92 — Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q90-Q99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Q92.0 Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique ; Q92.1 Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ; Q92.2 Trisomie partielle majeure ; Q92.3 Trisomie partielle mineure ; Q92.4 Duplications vues seulement à la prométaphase ; Q92.5 Duplications avec autres réarrangements complexes ; Q92.6 Chromosomes marqueurs supplémentaires ; Q92.7 Triploïdie et polyploïdie ; Q92.8 Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes ; Q92.9 Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q90, Q91, Q93, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Q92/Q92_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q92.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Q92/.

Q93 — Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q90-Q99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Q93.0 Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique ; Q93.1 Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) ; Q93.2 Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique ; Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4 ; Q93.4 Délétion du bras court du chromosome 5 ; Q93.5 Autres délétions partielles d'un chromosome ; Q93.6 Délétions vues seulement à la prométaphase ; Q93.7 Délétions avec autres réarrangements complexes ; Q93.8 Autres délétions des autosomes ; Q93.9 Délétion des autosomes, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q90, Q91, Q92, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q93/Q93_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q93.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Q93/.

Q95 — Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q90-Q99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : Q95.0 Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal ; Q95.1 Inversion chromosomique chez un sujet normal ; Q95.2 Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal ; Q95.3 Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal ; Q95.4 Sujet avec marqueur d'hétérochromatine ; Q95.5 Sujet avec site autosomique fragile ; Q95.8 Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux ; Q95.9 Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q90, Q91, Q92, Q93, Q96, Q97, Q98, Q99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q95/Q95_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q95.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Q95/.

Q96 — Syndrome de Turner (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q90-Q99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : Q96.0 Caryotype 45,X ; Q96.1 Caryotype 46,X iso (Xq) ; Q96.2 Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) ; Q96.3 Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY ; Q96.4 Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal ; Q96.8 Autres formes du syndrome de Turner ; Q96.9 Syndrome de Turner, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q90, Q91, Q92, Q93, Q95, Q97, Q98, Q99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q96/Q96_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q96.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Q96/.

Q97 — Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q90-Q99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : Q97.0 Caryotype 47,XXX ; Q97.1 Femme avec plus de trois chromosomes X ; Q97.2 Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X ; Q97.3 Femme avec un caryotype 46,XY ; Q97.8 Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin ; Q97.9 Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q90, Q91, Q92, Q93, Q95, Q96, Q98, Q99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q97/Q97_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q97.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Q97/.

Q98 — Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q90-Q99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non

officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Q98.0 Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY ; Q98.1 Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X ; Q98.2 Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX ; Q98.3 Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX ; Q98.4 Syndrome de Klinefelter, sans précision ; Q98.5 Caryotype 47,XYY ; Q98.6 Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale ; Q98.7 Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels ; Q98.8 Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin ; Q98.9 Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q90, Q91, Q92, Q93, Q95, Q96, Q97, Q99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q98/Q98_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q98.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Q98/.

Q99 — Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q90-Q99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : Q99.0 Chimère 46,XX/46,XY ; Q99.1 Hermaphrodite vrai 46,XX ; Q99.2 Chromosome X fragile ; Q99.8 Autres anomalies précisées des chromosomes ; Q99.9 Anomalie chromosomique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q90, Q91, Q92, Q93, Q95, Q96, Q97, Q98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q99/Q99_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q99.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Q99/.

Z08 — Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z00-Z13 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 225 (screening for asymptomatic conditions), 226 (shared assessment of risks and benefits of screening and treating asymptomatic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : Z08.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maligne ; Z08.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne ; Z08.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne ; Z08.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur maligne ; Z08.8 Examen de contrôle après d'autres traitements

pour tumeur maligne ; Z08.9 Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : Z12**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z08/Z08_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z08.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Z08/.

Z12 — Examen spécial de dépistage des tumeurs (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z00-Z13 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 225 (screening for asymptomatic conditions), 226 (shared assessment of risks and benefits of screening and treating asymptomatic). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Z12.0 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'estomac ; Z12.1 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin ; Z12.2 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil respiratoire ; Z12.3 Examen spécial de dépistage de tumeur du sein ; Z12.4 Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus ; Z12.5 Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate ; Z12.6 Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie ; Z12.8 Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres localisations ; Z12.9 Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : Z08**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z12/Z12_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z12.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Z12/.

Z51 — Autres soins médicaux (O-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z40-Z54 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 229 (change in treatment goals and end-of-life decisions), 230 (holistic care of the dying patient), 231 (management of refractory symptoms (pain, nausea)). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Z51.0 Séance de radiothérapie ; Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur maligne ; Z51.2 Autres formes de chimiothérapie ; Z51.3 Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic ; Z51.4 Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs ; Z51.5 Soins palliatifs ; Z51.6 Désensibilisation aux allergènes ; Z51.8 Autres formes précisées de soins médicaux ; Z51.9 Soin médical, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6.

Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/Z51/Z51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/0-09-Oncologie, génétique médicale et soins palliatifs/travail/Z51/.

N-07-Néphrologie

33 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 2 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : Société suisse de néphrologie ; ERA, KDIGO comme données.

N17 — Insuffisance rénale aiguë (N-07-Néphrologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N17-N19 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : N17.0 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire ; N17.1 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë ; N17.2 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire ; N17.8 Autres insuffisances rénales aiguës ; N17.9 Insuffisance rénale aiguë, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N18, N19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N17/N17_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n17.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N17/.

N18 — Maladie rénale chronique (N-07-Néphrologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N17-N19 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : N18.1 Maladie rénale chronique, stade 1 ; N18.2 Maladie rénale chronique, stade 2 ; N18.3 Maladie rénale chronique, stade 3 ; N18.4 Maladie rénale chronique, stade 4 ; N18.5 Maladie rénale chronique, stade 5 ; N18.8 Autre néphropathie chronique ; N18.9 Maladie rénale chronique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N17, N19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/N18/N18_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n18.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N18/.

C64 — Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C64-C68 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C65, C66
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C64/C64_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c64.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/C64/.

C65 — Tumeur maligne du bassinet (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C64-C68 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C64, C66
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C65/C65_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c65.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/C65/.

C66 — Tumeur maligne de l'uretère (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C64-C68 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C64, C65
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C66/C66_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c66.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/C66/.

N00 — Syndrome néphritique aigu (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N00-N08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : N00.0 Syndrome néphritique aigu: Anomalies glomérulaires mineures ; N00.1 Syndrome néphritique aigu: Lésions glomérulaires segmentaires et focales ; N00.2 Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse ; N00.3 Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse ; N00.4 Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse ; N00.5 Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse ; N00.6 Syndrome néphritique aigu: Maladie à dépôt dense ; N00.7 Syndrome néphritique aigu: Glomérulonéphrite diffuse en croissant ; N00.8 Syndrome néphritique aigu: Autres modifications morphologiques ; N00.9 Syndrome néphritique aigu: Type de modification morphologique non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N00/N00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N00/.

N01 — Syndrome néphritique d'évolution rapide (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N00-N08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : N01.0 Syndrome néphritique d'évolution rapide: Anomalies glomérulaires mineures ; N01.1 Syndrome néphritique d'évolution rapide: Lésions glomérulaires segmentaires et focales ; N01.2 Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse ; N01.3 Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse ; N01.4 Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse ; N01.5 Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse ; N01.6 Syndrome néphritique d'évolution rapide: Maladie à dépôt dense ; N01.7 Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite diffuse en croissant ; N01.8 Syndrome néphritique d'évolution rapide: Autres modifications morphologiques ; N01.9 Syndrome néphritique d'évolution rapide: Type de modification morphologique non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N00, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N01/N01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N01/.

N02 — Hématurie récidivante et persistante (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XIV** · bloc N00-N08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : N02.0 Hématurie récidivante et persistante: Anomalies glomérulaires mineures ; N02.1 Hématurie récidivante et persistante: Lésions glomérulaires segmentaires et focales ; N02.2 Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse ; N02.3 Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse ; N02.4 Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse ; N02.5 Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse ; N02.6 Hématurie récidivante et persistante: Maladie à dépôt dense ; N02.7 Hématurie récidivante et persistante: Glomérulonéphrite diffuse en croissant ; N02.8 Hématurie récidivante et persistante: Autres modifications morphologiques ; N02.9 Hématurie récidivante et persistante: Type de modification morphologique non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N00, N01, N03, N04, N05, N06, N07, N08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N02/N02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N02/.

N03 — Syndrome néphritique chronique (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N00-N08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : N03.0 Syndrome néphritique chronique: Anomalies glomérulaires mineures ; N03.1 Syndrome néphritique chronique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales ; N03.2 Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse ; N03.3 Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse ; N03.4 Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse ; N03.5 Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse ; N03.6 Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense ; N03.7 Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant ; N03.8 Syndrome néphritique chronique: Autres modifications morphologiques ; N03.9 Syndrome néphritique chronique: Type de modification morphologique non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N00, N01, N02, N04, N05, N06, N07, N08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N03/N03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N03/.

N04 — Syndrome néphrotique (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N00-N08 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : N04.0 Syndrome néphrotique: Anomalies glomérulaires mineures ; N04.1 Syndrome néphrotique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales ; N04.2 Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse ; N04.3 Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse ; N04.4 Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse ; N04.5 Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse ; N04.6 Syndrome néphrotique: Maladie à dépôt dense ; N04.7 Syndrome néphrotique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant ; N04.8 Syndrome néphrotique: Autres modifications morphologiques ; N04.9 Syndrome néphrotique: Type de modification morphologique non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N00, N01, N02, N03, N05, N06, N07, N08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N04/N04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N04/.

N05 — Syndrome néphritique, sans précision (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N00-N08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : N05.0 Syndrome néphritique, sans précision: Anomalies glomérulaires mineures ; N05.1 Syndrome néphritique, sans précision: Lésions glomérulaires segmentaires et focales ; N05.2 Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse ; N05.3 Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse ; N05.4 Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse ; N05.5 Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse ; N05.6 Syndrome néphritique, sans précision: Maladie à dépôt dense ; N05.7 Syndrome néphritique, sans précision: Glomérulonéphrite diffuse en croissant ; N05.8 Syndrome néphritique, sans précision: Autres modifications morphologiques ; N05.9 Syndrome néphritique, sans précision: Type de modification morphologique non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N00, N01, N02, N03, N04, N06, N07, N08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N05/N05_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N05/.

N06 — Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N00-N08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique,

non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : N06.0 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Anomalies glomérulaires mineures ; N06.1 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Lésions glomérulaires segmentaires et focales ; N06.2 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse ; N06.3 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse ; N06.4 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse ; N06.5 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse ; N06.6 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Maladie à dépôt dense ; N06.7 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Glomérulonéphrite diffuse en croissant ; N06.8 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Autres modifications morphologiques ; N06.9 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées: Type de modification morphologique non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N07, N08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N06/N06_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n06.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N06/.

N07 — Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N00-N08 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : N07.0 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Anomalies glomérulaires mineures ; N07.1 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Lésions glomérulaires segmentaires et focales ; N07.2 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse ; N07.3 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse ; N07.4 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse ; N07.5 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse ; N07.6 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Maladie à dépôt dense ; N07.7 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Glomérulonéphrite diffuse en croissant ; N07.8 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Autres modifications morphologiques ; N07.9 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs: Type de modification morphologique non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N07/N07_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n07.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N07/.

N08 — Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N00-N08 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : N08.0 Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; N08.1 Glomérulopathie au cours de maladies tumorales ; N08.2 Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire ; N08.3 Glomérulopathie au cours du diabète sucré ; N08.4 Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ; N08.5 Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif ; N08.8 Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N00, N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N08/N08_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n08.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N08/.

N10 — Néphrite tubulo-interstitielle aiguë (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N10-N16 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N11, N12, N13, N14, N15, N16
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N10/N10_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N10/.

N11 — Néphrite tubulo-interstitielle chronique (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N10-N16 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : N11.0 Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux ; N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique ; N11.8 Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques ; N11.9 Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N10, N12, N13, N14, N15, N16
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/N11/N11_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n11.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N11/.

N12 — Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N10-N16 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N10, N11, N13, N14, N15, N16
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N12/N12_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n12.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N12/.

N13 — Uropathie obstructive et par reflux (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N10-N16 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : N13.0 Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale ; N13.1 Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs ; N13.2 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale ; N13.3 Hydronéphroses, autres et sans précision ; N13.4 Hydro-uretère ; N13.5 Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose ; N13.6 Pyonéphrose ; N13.7 Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral ; N13.8 Autres uropathies obstructives et par reflux ; N13.9 Uropathie obstructive et par reflux, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N10, N11, N12, N14, N15, N16
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N13/N13_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n13.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N13/.

N14 — Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N10-N16 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : N14.0 Néphropathie due à un analgésique ; N14.1 Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques ; N14.2 Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision ; N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds ; N14.4 Néphropathie toxique, non classée ailleurs

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N10, N11, N12, N13, N15, N16
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N14/N14_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n14.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N14/.

N15 — Autres maladies rénales tubulo-interstitielles (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N10-N16 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : N15.0 Néphropathie des Balkans ; N15.1 Abscès rénal et périrénal ; N15.8 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées ; N15.9 Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N10, N11, N12, N13, N14, N16
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N15/N15_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n15.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N15/.

N16 — Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N10-N16 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : N16.0 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; N16.1 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales ; N16.2 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire ; N16.3 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques ; N16.4 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif ; N16.5 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe ; N16.8 Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N10, N11, N12, N13, N14, N15
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N16/N16_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n16.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N16/.

N19 — Insuffisance rénale, sans précision (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N17-N19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 63 (anuria, pollakiuria, oliguria, polyuria), 161 (abnormal markers of kidney function), 164 (abnormal urine sediment), 173 (proteinuria). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N17, N18
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N19/N19_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n19.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N19/.

N25 — Affections dues à une tubulopathie (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N25-N29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : N25.0 Ostéodystrophie rénale ; N25.1 Diabète insipide néphrogénique ; N25.8 Autres affections dues à une tubulopathie ; N25.9 Affection due à une tubulopathie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N26, N27, N28, N29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N25/N25_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n25.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N25/.

N26 — Rein scléreux, sans précision (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N25-N29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N25, N27, N28, N29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N26/N26_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n26.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N26/.

N27 — Petit rein de cause inconnue (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XIV** · bloc N25-N29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : N27.0 Petit rein de cause inconnue, unilatéral ; N27.1 Petit rein de cause inconnue, bilatéral ; N27.9 Petit rein de cause inconnue, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N25, N26, N28, N29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N27/N27_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n27.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N27/.

N28 — Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N25-N29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : N28.0 Ischémie et infarctus du rein ; N28.1 Kyste du rein ; N28.8 Autres affections précisées du rein et de l'uretère ; N28.9 Affection du rein et de l'uretère, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N25, N26, N27, N29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/N28/N28_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n28.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N28/.

N29 — Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIV** · bloc N25-N29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 64 (dysuria, pyuria, haematuria), 76 (urinary incontinence and enuresis), 77 (urinary retention). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : N29.0 Syphilis tardive du rein ; N29.1 Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; N29.8 Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : N25, N26, N27, N28
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/N29/N29_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/n29.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/N29/.

Q60 — Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q60-Q64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : Q60.0 Agénésie rénale, unilatérale ; Q60.1 Agénésie rénale, bilatérale ; Q60.2 Agénésie rénale, sans précision ; Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale ; Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale ; Q60.5 Hypoplasie rénale, sans précision ; Q60.6 Syndrome de Potter
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q61, Q62, Q63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q60/Q60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/Q60/.

Q61 — Maladies kystiques du rein (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q60-Q64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (8)** : Q61.0 Kyste du rein congénital (unique) ; Q61.1 Rein polykystique, autosomique récessif ; Q61.2 Rein polykystique, autosomique dominant ; Q61.3 Rein polykystique, sans précision ; Q61.4 Dysplasie rénale ; Q61.5 Kyste médullaire du rein ; Q61.8 Autres maladies kystiques du rein ; Q61.9 Maladie kystique du rein, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q60, Q62, Q63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q61/Q61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/Q61/.

Q62 — Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q60-Q64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (9)** : Q62.0 Hydronéphrose congénitale ; Q62.1 Atrésie et sténose de l'uretère ; Q62.2 Méga-uretère congénital ; Q62.3 Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère ; Q62.4 Agénésie de l'uretère ; Q62.5 Duplication de l'uretère ; Q62.6 Malposition de l'uretère ; Q62.7 Reflux vésico-urétéro-rénal congénital ; Q62.8 Autres malformations congénitales de l'uretère
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q60, Q61, Q63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q62/Q62_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/Q62/.

Q63 — Autres malformations congénitales du rein (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q60-Q64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (6)** : Q63.0 Rein surnuméraire ; Q63.1 Rein lobulé, soudé et en fer à cheval ; Q63.2 Rein ectopique ; Q63.3 Rein hyperplasique et géant ; Q63.8 Autres malformations congénitales précisées du rein ; Q63.9 Malformation congénitale du rein, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q60, Q61, Q62
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q63/Q63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/Q63/.

S37 — Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S30-S39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 106 (abdominal injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (10)** : S37.0 Lésion traumatique du rein ; S37.1 Lésion traumatique de l'uretère ; S37.2 Lésion traumatique de la vessie ; S37.3 Lésion traumatique de l'urètre ; S37.4 Lésion traumatique de l'ovaire ; S37.5 Lésion traumatique de la trompe de Fallope ; S37.6 Lésion traumatique de l'utérus ; S37.7 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires ; S37.8 Lésions traumatiques d'autres organes pelviens et urinaires ; S37.9 Lésion traumatique d'un organe pelvien ou urinaire non précisé
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/S37/S37_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s37.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/S37/.

Z49 — Surveillance d'une dialyse (N-07-Néphrologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z40-Z54 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 255 (physical and psychosocial inpatient and outpatient rehabilitation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : Z49.0 Soins préparatoires en vue d'une dialyse ; Z49.1 Dialyse extracorporelle ; Z49.2 Autres dialyses
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z49/Z49_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z49.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-07-Néphrologie/travail/Z49/.

N-05-Neurologie

104 leçons « Examen fédéral » ; 0 rédigées ; 9 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : Société suisse de neurologie ; EAN.

G20 — Maladie de Parkinson (N-05-Neurologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G20-G26 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 98 (abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : G20.0 Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger ; G20.1 Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd ; G20.2 Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap ; G20.9 Maladie de Parkinson, non précisé
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G21, G22, G23, G24, G25, G26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G20/G20_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g20.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G20/.

G30 — Maladie d'Alzheimer (N-05-Neurologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G30-G32 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 102 (memory disturbance, cognitive impairment), 139 (cognitive impairment). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : G30.0 Maladie d'Alzheimer à début précoce ; G30.1 Maladie d'Alzheimer à début tardif ; G30.8 Autres formes de la maladie d'Alzheimer ; G30.9 Maladie

d'Alzheimer, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G31, G32
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G30/G30_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G30/.

G40 — Épilepsie (N-05-Neurologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G40-G47 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 105 (twitches, convulsion, seizure), 219 (seizures). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : G40.0 Épilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal ; G40.1 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises partielles simples ; G40.2 Épilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles complexes ; G40.3 Épilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques ; G40.4 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés ; G40.5 Syndromes épileptiques particuliers ; G40.6 Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit mal) ; G40.7 Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal ; G40.8 Autres épilepsies ; G40.9 Épilepsie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G41, G43, G44, G45, G46, G47
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G40/G40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G40/.

G43 — Migraine (N-05-Neurologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G40-G47 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 101 (headache). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : G43.0 Migraine sans aura [migraine commune] ; G43.1 Migraine avec aura [migraine classique] ; G43.2 État de mal migraineux ; G43.3 Migraine compliquée ; G43.8 Autres migraines ; G43.9 Migraine, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G40, G41, G44, G45, G46, G47
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/G43/G43_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g43.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G43/.

G44 — Autres syndromes d'algies céphaliques (N-05-Neurologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G40-G47 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 101 (headache). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : G44.0 Syndrome d'algie vasculaire de la face ; G44.1 Céphalée vasculaire, non classée ailleurs ; G44.2 Céphalée dite de tension ; G44.3 Céphalée chronique post-traumatique ; G44.4 Céphalée médicamenteuse, non classée ailleurs ; G44.8 Autres syndromes précisés d'algies céphaliques
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G40, G41, G43, G45, G46, G47
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G44/G44_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g44.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G44/.

G45 — Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés (N-05-Neurologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G40-G47 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 205 (acute neurological deficits). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : G45.0 Syndrome vertébro-basilaire ; G45.1 Syndrome carotidien (hémisphérique) ; G45.2 Accident ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux ; G45.3 Amaurose fugace ; G45.4 Amnésie globale transitoire ; G45.8 Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés ; G45.9 Accident ischémique cérébral transitoire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G40, G41, G43, G44, G46, G47
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G45/G45_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g45.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G45/.

G47 — Troubles du sommeil (N-05-Neurologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G40-G47 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 11 (sleep problems), 40 (apnoea, apnoea with arousal). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : G47.0 Troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil ; G47.1 Troubles du sommeil par somnolence excessive ; G47.2 Troubles du cycle veille-sommeil ; G47.3 Apnée du sommeil ; G47.4 Narcolepsie et cataplexie ; G47.8 Autres troubles du sommeil ; G47.9 Trouble du sommeil, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G40, G41, G43, G44, G45, G46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G47/G47_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g47.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G47/.

G56 — Mononévrite du membre supérieur (N-05-Neurologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G50-G59 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (6)** : G56.0 Syndrome du canal carpien ; G56.1 Autres lésions du nerf médian ; G56.2 Lésion du nerf cubital ; G56.3 Lésion du nerf radial ; G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur ; G56.9 Mononévrite du membre supérieur, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G50, G51, G52, G53, G54, G55, G57, G58, G59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G56/G56_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g56.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G56/.

G62 — Autres polynévrites (N-05-Neurologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G60-G64 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (5)** : G62.0 Polynévrite médicamenteuse ; G62.1 Polynévrite alcoolique ; G62.2 Polynévrite due à d'autres agents toxiques ; G62.8 Autres polynévrites précisées ; G62.9 Polynévrite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G60, G61, G63, G64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G62/G62_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G62/.

C70 — Tumeur maligne des méninges (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C69-C72 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : C70.0 Tumeur maligne: Méninges cérébrales ; C70.1 Tumeur maligne: Méninges rachidiennes ; C70.9 Tumeur maligne: Méninges, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C71, C72
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C70/C70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/C70/.

C71 — Tumeur maligne de l'encéphale (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C69-C72 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : C71.0 Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules ; C71.1 Tumeur maligne: Lobe frontal ; C71.2 Tumeur maligne: Lobe temporal ; C71.3 Tumeur maligne: Lobe pariétal ; C71.4 Tumeur maligne: Lobe occipital ; C71.5 Tumeur maligne: Ventricule cérébral ; C71.6 Tumeur maligne: Cervelet ; C71.7 Tumeur maligne: Tronc cérébral ; C71.8 Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale ; C71.9 Tumeur maligne: Encéphale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C70, C72
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C71/C71_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/C71/.

C72 — Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM II** · bloc C69-C72 · difficulté **très élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 159 (abnormal histology, cytology and molecular genetic test), 227 (shared assessment of risks and protective factors for frequent life-compromising). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : C72.0 Tumeur maligne: Moelle épinière ; C72.1 Tumeur maligne: Queue de cheval ; C72.2 Tumeur maligne: Nerf olfactif [Nerf crânien I] ; C72.3 Tumeur maligne: Nerf optique [Nerf crânien II] ; C72.4 Tumeur maligne: Nerf auditif [Nerf crânien VIII] ; C72.5 Tumeur maligne: Nerfs crâniens, autres et non précisés ; C72.8 Tumeur maligne: Lésion à

localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central ; C72.9

Tumeur maligne: Système nerveux central, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : C70, C71
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et carcinogenèse → 4. Présentation clinique et signes d'alarme → 5. Diagnostic : imagerie, histologie, biologie moléculaire → 6. Stadification TNM et facteurs pronostiques → 7. Traitement multimodal, colloque pluridisciplinaire → 8. Dépistage organisé en Suisse → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/C72/C72_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/c72.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/C72/.

G00 — Méningite bactérienne, non classée ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G00-G09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : G00.0 Méningite à Haemophilus influenzae ; G00.1 Méningite à pneumocoques ; G00.2 Méningite à streptocoques ; G00.3 Méningite à staphylocoques ; G00.8 Autres méningites bactériennes ; G00.9 Méningite bactérienne, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G00/G00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G00/.

G01 — Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G00-G09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G00, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G01/G01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G01/.

G02 — Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G00-G09 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : G02.0 Méningite au cours d'infections virales classées ailleurs ; G02.1 Méningite au cours de mycoses classées ailleurs ; G02.8 Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G00, G01, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G02/G02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G02/.

G03 — Méningite due à des causes autres et non précisées (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G00-G09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : G03.0 Méningite à liquide clair ; G03.1 Méningite chronique ; G03.2 Méningite récurrente bénigne [Mollaret] ; G03.8 Méningite due à d'autres causes précisées ; G03.9 Méningite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G00, G01, G02, G04, G05, G06, G07, G08, G09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G03/G03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G03/.

G04 — Encéphalite, myélite et encéphalomyélite (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G00-G09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : G04.0 Encéphalite aiguë disséminée ; G04.1 Myélopathie associée à un virus lymphotrope des lymphocytes T humains ; G04.2 Méningo-encéphalite et méningomyélite bactériennes, non classées ailleurs ; G04.8 Autres encéphalites, myélites et encéphalomyélites ; G04.9 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G00, G01, G02, G03, G05, G06, G07, G08, G09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/G04/G04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G04/.

G05 — Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G00-G09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : G05.0 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs ; G05.1 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs ; G05.2 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; G05.8 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G00, G01, G02, G03, G04, G06, G07, G08, G09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G05/G05_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G05/.

G06 — Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G00-G09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : G06.0 Abcès et granulome intracrâniens ; G06.1 Abcès et granulome intrarachidiens ; G06.2 Abcès extra-dural et sous-dural, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G00, G01, G02, G03, G04, G05, G07, G08, G09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G06/G06_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g06.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G06/.

G07 — Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G00-G09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G00, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G08, G09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8.

Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/G07/G07_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g07.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G07/.

G08 — Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G00-G09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G00, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G08/G08_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g08.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G08/.

G09 — Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G00-G09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G00, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G09/G09_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g09.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G09/.

G21 — Syndrome parkinsonien secondaire (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G20-G26 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 98 (abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : G21.0 Syndrome malin des neuroleptiques ; G21.1 Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments ; G21.2 Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes ; G21.3 Syndrome parkinsonien post-encéphalitique ; G21.4 Maladie de Parkinson vasculaire ; G21.8 Autres syndromes parkinsoniens secondaires ; G21.9 Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G20, G22, G23, G24, G25, G26

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G21/G21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G21/.

G22 — Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G20-G26 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 98 (abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G20, G21, G23, G24, G25, G26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G22/G22_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g22.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G22/.

G23 — Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G20-G26 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 98 (abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : G23.0 Maladie de Hallervorden-Spatz ; G23.1 Ophthalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski] ; G23.2 Atrophie multisystématisée de forme Parkinson [AMS-P] ; G23.3 Atrophie multisystématisée de forme cérébelleuse [AMS-C] ; G23.8 Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux ; G23.9 Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G20, G21, G22, G24, G25, G26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G23/G23_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g23.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G23/.

G24 — Dystonie (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G20-G26 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 98 (abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas

clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : G24.0 Dystonie médicamenteuse ; G24.1 Dystonie idiopathique familiale ; G24.2 Dystonie idiopathique non familiale ; G24.3 Torticolis spasmodique ; G24.4 Dystonie bucco-faciale idiopathique ; G24.5 Blépharospasme ; G24.8 Autres dystonies ; G24.9 Dystonie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G20, G21, G22, G23, G25, G26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G24/G24_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g24.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G24/.

G25 — Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G20-G26 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 98 (abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : G25.0 Tremblement essentiel ; G25.1 Tremblement dû à des médicaments ; G25.2 Autres formes précisées de tremblement ; G25.3 Myoclonie ; G25.4 Chorée médicamenteuse ; G25.5 Autres chorées ; G25.6 Tics médicamenteux et autres tics d'origine organique ; G25.8 Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité ; G25.9 Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricité, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G20, G21, G22, G23, G24, G26
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G25/G25_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g25.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G25/.

G26 — Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G20-G26 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 98 (abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G20, G21, G22, G23, G24, G25
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G26/G26_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g26.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G26/.

G31 — Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G30-G32 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 102 (memory disturbance, cognitive impairment), 139 (cognitive impairment). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : G31.0 Atrophie cérébrale circonscrite ; G31.1 Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs ; G31.2 Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool ; G31.8 Autres affections dégénératives précisées du système nerveux ; G31.9 Affection dégénérative du système nerveux, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G30, G32
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G31/G31_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g31.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G31/.

G32 — Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G30-G32 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 102 (memory disturbance, cognitive impairment), 139 (cognitive impairment). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : G32.0 Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs ; G32.8 Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G30, G31
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G32/G32_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g32.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G32/.

G35 — Sclérose en plaques (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G35-G37 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : G35.0 Première manifestation d'une sclérose en plaques ; G35.1 Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées) ; G35.2 Sclérose en plaques progressive d'emblée (chronique, progressive primaire) ; G35.3 Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive) ; G35.9 Sclérose en plaques non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G36, G37
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6.

Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/G35/G35_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G35/.

G36 — Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G35-G37 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : G36.0 Neuromyéélite optique [Devic] ; G36.1 Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [Hurst] ; G36.8 Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées précisées ; G36.9 Affection démyélinisante aiguë disséminée, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G35, G37
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G36/G36_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g36.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G36/.

G37 — Autres affections démyélinisantes du système nerveux central (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G35-G37 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : G37.0 Sclérose cérébrale diffuse ; G37.1 Démyélinisation centrale du corps calleux ; G37.2 Myélinolyse centropontine ; G37.3 Myélite transverse aiguë au cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central ; G37.4 Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix-Alajouanine] ; G37.5 Sclérose concentrique [Baló] ; G37.8 Autres affections démyélinisantes précisées du système nerveux central ; G37.9 Affection démyélinisante du système nerveux central, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G35, G36
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G37/G37_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g37.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G37/.

G41 — État de mal épileptique (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G40-G47 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 105 (twitches, convulsion, seizure), 219 (seizures). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : G41.0 État de grand mal épileptique ; G41.1 État de petit mal épileptique ; G41.2 État de mal épileptique partiel complexe ; G41.8 Autres états de mal épileptique ; G41.9 État de mal épileptique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G40, G43, G44, G45, G46, G47
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G41/G41_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g41.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G41/.

G50 — Affections du nerf trijumeau [nerf crânien V] (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G50-G59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : G50.0 Névralgie du trijumeau ; G50.1 Algie faciale atypique ; G50.8 Autres affections du nerf trijumeau ; G50.9 Affection du nerf trijumeau, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G50/G50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G50/.

G51 — Affections du nerf facial [nerf crânien VII] (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G50-G59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : G51.0 Paralysie faciale ; G51.1 Atteinte du ganglion géniculé ; G51.2 Syndrome de Melkersson-Rosenthal ; G51.3 Hémispasme facial ; G51.4 Myokymies faciales ; G51.8 Autres affections du nerf facial ; G51.9 Affection du nerf facial, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G50, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G51/G51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G51/.

G52 — Affections des autres nerfs crâniens (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G50-G59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : G52.0 Affections du nerf olfactif [premier nerf crânien] ; G52.1 Affections du nerf glossopharyngien [nerf crânien IX] ; G52.2 Affections du nerf vagal [nerf crânien X] ; G52.3 Affections du nerf grand hypoglosse [nerf crânien XII] ; G52.7 Affections de plusieurs nerfs crâniens ; G52.8 Affections d'autres nerfs crâniens précisés ; G52.9 Affection des nerfs crâniens, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G50, G51, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G52/G52_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g52.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G52/.

G53 — Affections des nerfs crâniens au cours de maladies classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G50-G59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : G53.0 Névralgie post-zostérienne ; G53.1 Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; G53.2 Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de sarcoïdose ; G53.3 Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies tumorales ; G53.8 Autres affections des nerfs crâniens au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G50, G51, G52, G54, G55, G56, G57, G58, G59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G53/G53_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G53/.

G54 — Affections des racines et des plexus nerveux (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G50-G59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : G54.0 Affections du plexus brachial ; G54.1 Affections du plexus lombosacré ; G54.2 Affections radiculaires cervicales, non classées ailleurs ; G54.3 Affections radiculaires thoraciques, non classées ailleurs ; G54.4 Affections radiculaires lombosacrées, non classées ailleurs ; G54.5 Névralgie amyotrophique ; G54.6 Syndrome douloureux du membre fantôme ; G54.7 Syndrome du membre fantôme sans élément douloureux ; G54.8

Autres affections des racines et des plexus nerveux ; G54.9 Affection des racines et des plexus nerveux, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G50, G51, G52, G53, G55, G56, G57, G58, G59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G54/G54_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g54.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G54/.

G55 — Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G50-G59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (5)** : G55.0 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de maladies tumorales ; G55.1 Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux ; G55.2 Compression des racines et des plexus nerveux au cours de spondylarthroses ; G55.3 Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies ; G55.8 Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G50, G51, G52, G53, G54, G56, G57, G58, G59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G55/G55_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g55.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G55/.

G57 — Mononévrite du membre inférieur (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G50-G59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (9)** : G57.0 Lésion du nerf sciatique ; G57.1 Méralgie parasthésique ; G57.2 Lésion du nerf fémoral ; G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe ; G57.4 Lésion du nerf sciatique poplité interne ; G57.5 Syndrome du canal tarsien ; G57.6 Lésion du nerf plantaire ; G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur ; G57.9 Mononévrite du membre inférieur, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G58, G59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/G57/G57_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g57.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G57/.

G58 — Autres mononévrites (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G50-G59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : G58.0 Névrite intercostale ; G58.7 Mononévrite de sièges multiples ; G58.8 Autres mononévrites précisées ; G58.9 Mononévrite, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G59
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G58/G58_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g58.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G58/.

G59 — Mononévrite au cours de maladies classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G50-G59 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : G59.0 Mononévrite diabétique ; G59.8 Autres mononévrites au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G59/G59_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g59.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G59/.

G60 — Neuropathie héréditaire et idiopathique (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G60-G64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : G60.0 Neuropathie héréditaire motrice et sensorielle ; G60.1 Maladie de Refsum ; G60.2 Neuropathie associée à une ataxie héréditaire ; G60.3 Neuropathie progressive idiopathique ; G60.8 Autres neuropathies héréditaires et idiopathiques ; G60.9 Neuropathie héréditaire et idiopathique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G61, G62, G63, G64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/G60/G60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G60/.

G61 — Polynévrites inflammatoires (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G60-G64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : G61.0 Syndrome de Guillain-Barré ; G61.1 Neuropathie sérique ; G61.8 Autres polynévrites inflammatoires ; G61.9 Polynévrite inflammatoire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G60, G62, G63, G64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G61/G61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G61/.

G63 — Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G60-G64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : G63.0 Polynévrite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; G63.1 Polynévrite au cours de maladies tumorales ; G63.2 Polynévrite diabétique ; G63.3 Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et métaboliques ; G63.4 Polynévrite par carence nutritionnelle ; G63.5 Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif ; G63.6 Polynévrite au cours d'autres affections ostéo-articulaires et des muscles ; G63.8 Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G60, G61, G62, G64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G63/G63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G63/.

G64 — Autres affections du système nerveux périphérique (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G60-G64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G60, G61, G62, G63

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G64/G64_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g64.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G64/.

G70 — Myasthénie et autres affections neuromusculaires (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G70-G73 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : G70.0 Myasthénie ; G70.1 Affections neuromusculaires toxiques ; G70.2 Myasthénie congénitale et au cours du développement ; G70.8 Autres affections neuromusculaires précisées ; G70.9 Affection neuromusculaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G71, G72, G73
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G70/G70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G70/.

G71 — Affections musculaires primitives (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G70-G73 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : G71.0 Dystrophie musculaire ; G71.1 Affections myotoniques ; G71.2 Myopathies congénitales ; G71.3 Myopathie mitochondriale, non classée ailleurs ; G71.8 Autres affections musculaires primitives ; G71.9 Affection musculaire primitive, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G70, G72, G73
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G71/G71_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G71/.

G72 — Autres myopathies (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G70-G73 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de

l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : G72.0 Myopathie médicamenteuse ; G72.1 Myopathie alcoolique ; G72.2 Myopathie due à d'autres agents toxiques ; G72.3 Paralysies périodiques ; G72.4 Myopathie inflammatoire, non classée ailleurs ; G72.8 Autres myopathies précisées ; G72.9 Myopathie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G70, G71, G73
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G72/G72_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g72.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G72/.

G73 — Affections musculaires et neuromusculaires au cours de maladies classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G70-G73 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 194 (low muscle tone and hypotonia). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (8)** : G73.0 Syndrome myasthénique au cours de maladies endocriniennes ; G73.1 Syndrome de Lambert-Eaton ; G73.2 Autres syndromes myasthéniques au cours de maladies tumorales ; G73.3 Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies classées ailleurs ; G73.4 Myopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; G73.5 Myopathie au cours de maladies endocriniennes ; G73.6 Myopathie au cours de maladies métaboliques ; G73.7 Myopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G70, G71, G72
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G73/G73_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g73.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G73/.

G80 — Infirmité motrice cérébrale (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G80-G83 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (7)** : G80.0 Paralysie cérébrale spastique quadriplégique ; G80.1 Paralysie cérébrale spastique diploplégique ; G80.2 Infirmité motrice cérébrale, forme spastique hémiploplégique ; G80.3 Paralysie cérébrale dyskinétique ; G80.4 Paralysie cérébrale ataxique ; G80.8 Autres infirmités motrices cérébrales ; G80.9 Paralysie cérébrale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G81, G82, G83
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12.

Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/G80/G80_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g80.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G80/.

G81 — Hémiparésie et hémiplégie (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G80-G83 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : G81.0 Hémiparésie ou hémiplégie flasque ; G81.1 Hémiparésie ou hémiplégie spastique ; G81.9 Hémiparésie ou hémiplégie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G80, G82, G83
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G81/G81_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g81.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G81/.

G82 — Paraparésie et paraplégie, tétraparésie et tétraplégie (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G80-G83 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : G82.0 Paraparésie et paraplégie flasque ; G82.1 Paraparésie et paraplégie spastique ; G82.2 Paraparésie et paraplégie, sans précision ; G82.3 Tétraparésie et tétraplégie flasque ; G82.4 Tétraparésie et tétraplégie spastique ; G82.5 Tétraparésie et tétraplégie, sans précision ; G82.6 Hauteur fonctionnelle de la lésion de la moelle épinière
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G80, G81, G83
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G82/G82_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g82.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G82/.

G83 — Autres syndromes paralytiques (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G80-G83 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : G83.0 Diparésie et diplégie des membres supérieurs ; G83.1 Monoplégie d'un membre inférieur ; G83.2 Monoparésie et monoplégie d'un membre supérieur ; G83.3 Monoparésie et monoplégie, sans précision ; G83.4 Syndrome de la queue de cheval ; G83.5 Locked-in syndrome [syndrome de déafférentation motrice] ; G83.6 Paralysie faciale centrale ; G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés ; G83.9 Syndrome paralytique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G80, G81, G82

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G83/G83_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g83.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G83/.

G90 — Affections du système nerveux autonome (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G90-G99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : G90.0 Neuropathie autonome périphérique idiopathique ; G90.1 Dysautonomie familiale [Riley-Day] ; G90.2 Syndrome de Claude Bernard-Horner ; G90.4 Dysrèflexie autonome ; G90.5 Syndrome douloureux régional complexe, type I ; G90.6 Syndrome douloureux régional complexe, type II ; G90.7 Syndrome douloureux régional complexe, autre type et type non précisé ; G90.8 Autres affections du système nerveux autonome ; G90.9 Affection du système nerveux autonome, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G90/G90_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g90.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G90/.

G91 — Hydrocéphalie (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G90-G99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : G91.0 Hydrocéphalie communicante ; G91.1 Hydrocéphalie obstructive (non communicante) ; G91.2 Hydrocéphalie à pression normale ; G91.3 Hydrocéphalie post-traumatique, sans précision ; G91.8 Autres hydrocéphalies ; G91.9 Hydrocéphalie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G90, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G91/G91_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g91.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G91/.

G92 — Encéphalopathie toxique (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G90-G99 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : G92.0 Encéphalopathie toxique sous immunothérapie ; G92.9 Encéphalopathie toxique, autres et sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G90, G91, G93, G94, G95, G96, G97, G98, G99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G92/G92_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g92.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G92/.

G93 — Autres affections du cerveau (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G90-G99 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : G93.0 Kystes cérébraux ; G93.1 Lésion cérébrale anoxique, non classée ailleurs ; G93.2 Hypertension intracrânienne bénigne [hypertension intracrânienne idiopathique] ; G93.3 Syndrome de fatigue chronique [Chronic fatigue syndrome] ; G93.4 Encéphalopathie, sans précision ; G93.5 Compression du cerveau ; G93.6 Œdème cérébral ; G93.7 Syndrome de Reye ; G93.8 Autres affections précisées du cerveau ; G93.9 Affection du cerveau, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G90, G91, G92, G94, G95, G96, G97, G98, G99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G93/G93_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g93.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G93/.

G94 — Autres affections du cerveau au cours de maladies classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G90-G99 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : G94.0 Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ; G94.1 Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales ; G94.2 Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées ailleurs ; G94.3 Encéphalopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs ; G94.8 Autres affections précisées du cerveau au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G90, G91, G92, G93, G95, G96, G97, G98, G99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/G94/G94_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g94.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G94/.

G95 — Autres affections de la moelle épinière (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G90-G99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : G95.0 Syringomyélie et syringobulbie ; G95.1 Myélopathies vasculaires ; G95.2 Compression médullaire, sans précision ; G95.8 Autres affections précisées de la moelle épinière ; G95.9 Affection de la moelle épinière, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G90, G91, G92, G93, G94, G96, G97, G98, G99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G95/G95_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g95.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G95/.

G96 — Autres affections de système nerveux central (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G90-G99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : G96.0 Écoulement de liquide céphalorachidien ; G96.1 Affection des méninges, non classée ailleurs ; G96.8 Autres affections précisées du système nerveux central ; G96.9 Affection du système nerveux central, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G90, G91, G92, G93, G94, G95, G97, G98, G99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/G96/G96_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/g96.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G96/.

G97 — Affections du système nerveux après des actes médicaux, non classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G90-G99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : G97.0 Écoulement de liquide céphalorachidien après rachicentèse ; G97.1 Autre réaction secondaire à une rachicentèse ; G97.2 Hypotension intracrânienne suite à un pontage ventriculaire ; G97.8 Autres affections du système nerveux après

des actes médicaux ; G97.9 Affection du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G98, G99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/G97/G97_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/g97.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G97/](#).

G98 — Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs (N-05-Neurologie)

• P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G90-G99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/G98/G98_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/g98.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G98/](#).

G99 — Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs (N-05-Neurologie) • P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM VI** · bloc G90-G99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 104 (sensory loss, changes in various forms of sensation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : G99.0 Neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques ; G99.1 Autres affections du système nerveux autonome au cours d'autres maladies classées ailleurs ; G99.2 Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs ; G99.8 Autres affections précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G97, G98
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/G99/G99_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/g99.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/G99/](#).

I60 — Hémorragie sous-arachnoïdienne (N-05-Neurologie) • P2

- **État** : vide

- **Chapitre CIM IX** · bloc I60-I69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 205 (acute neurological deficits).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : I60.0 Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien ; I60.1 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère cérébrale moyenne ; I60.2 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante antérieure ; I60.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère communicante postérieure ; I60.4 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère basilaire ; I60.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère vertébrale ; I60.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres artères intracrâniennes ; I60.7 Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère intracrânienne, sans précision ; I60.8 Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes ; I60.9 Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68, I69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I60/I60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/I60/.

I61 — Hémorragie intracérébrale (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I60-I69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 205 (acute neurological deficits).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : I61.0 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale ; I61.1 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale ; I61.2 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée ; I61.3 Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral ; I61.4 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse ; I61.5 Hémorragie intracérébrale intraventriculaire ; I61.6 Hémorragie intracérébrale, localisations multiples ; I61.8 Autres hémorragies intracérébrales ; I61.9 Hémorragie intracérébrale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I60, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68, I69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I61/I61_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i61.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/I61/.

I62 — Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I60-I69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 205 (acute neurological deficits).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : I62.0 Hémorragie sous-durale non traumatique ; I62.1 Hémorragie extra-durale non traumatique ; I62.9 Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I60, I61, I63, I64, I65, I66, I67, I68, I69

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I62/I62_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i62.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/I62/.

I63 — Infarctus cérébral (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I60-I69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 205 (acute neurological deficits). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : I63.0 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales ; I63.1 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales ; I63.2 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé ; I63.3 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales ; I63.4 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales ; I63.5 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé ; I63.6 Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène ; I63.8 Autres infarctus cérébraux ; I63.9 Infarctus cérébral, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I60, I61, I62, I64, I65, I66, I67, I68, I69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I63/I63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/I63/.

I64 — Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I60-I69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 205 (acute neurological deficits). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I60, I61, I62, I63, I65, I66, I67, I68, I69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I64/I64_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i64.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/I64/.

I65 — Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I60-I69 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 205 (acute neurological deficits).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : I65.0 Occlusion et sténose de l'artère vertébrale ; I65.1 Occlusion et sténose de l'artère basilaire ; I65.2 Occlusion et sténose de l'artère carotide ; I65.3 Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales ; I65.8 Occlusion et sténose d'une autre artère précérébrale ; I65.9 Occlusion et sténose d'une artère précérébrale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I60, I61, I62, I63, I64, I66, I67, I68, I69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I65/I65_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i65.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/I65/.

I66 — Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I60-I69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 205 (acute neurological deficits).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : I66.0 Occlusion et sténose de l'artère cérébrale moyenne ; I66.1 Occlusion et sténose de l'artère cérébrale antérieure ; I66.2 Occlusion et sténose de l'artère cérébrale postérieure ; I66.3 Occlusion et sténose des artères cérébelleuses ; I66.4 Occlusion et sténose des artères cérébrales, multiples et bilatérales ; I66.8 Occlusion et sténose d'une autre artère cérébrale ; I66.9 Occlusion et sténose d'une artère cérébrale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I60, I61, I62, I63, I64, I65, I67, I68, I69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I66/I66_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i66.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/I66/.

I67 — Autres maladies cérébrovasculaires (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I60-I69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 205 (acute neurological deficits).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : I67.0 Dissection d'artères cérébrales ; I67.1 Anévrisme cérébral et fistule artério-veineuse cérébrale ; I67.2 Athérosclérose cérébrale ; I67.3 Leucoencéphalopathie vasculaire progressive ; I67.4 Encéphalopathie hypertensive ; I67.5 Maladie de Moyamoya ; I67.6 Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien ; I67.7 Artérite cérébrale, non classée ailleurs ; I67.8 Autres maladies cérébrovasculaires précisées ; I67.9 Maladie cérébrovasculaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I68, I69

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I67/I67_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i67.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/I67/.

I68 — Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I60-I69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 205 (acute neurological deficits). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale ; I68.1 Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et parasitaires ; I68.2 Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs ; I68.8 Autres troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I69
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I68/I68_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i68.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/I68/.

I69 — Séquelles de maladies cérébrovasculaires (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I60-I69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 103 (paresis, paralysis), 205 (acute neurological deficits). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : I69.0 Séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne ; I69.1 Séquelles d'hémorragie intracérébrale ; I69.2 Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques ; I69.3 Séquelles d'infarctus cérébral ; I69.4 Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus ; I69.8 Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et non précisées
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I69/I69_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i69.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/I69/.

Q00 — Anencéphalie et malformations similaires (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide

- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q00-Q07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : Q00.0 Anencéphalie ; Q00.1 Cranio-rachischisis ; Q00.2 Iniencephalie
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q00/Q00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/Q00/.

Q01 — Encéphalocèle (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q00-Q07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : Q01.0 Encéphalocèle frontale ; Q01.1 Encéphalocèle naso-frontale ; Q01.2 Encéphalocèle occipitale ; Q01.8 Encéphalocèle d'autres localisations ; Q01.9 Encéphalocèle, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q00, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q01/Q01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/Q01/.

Q02 — Microcéphalie (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q00-Q07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q00, Q01, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q02/Q02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/Q02/.

Q03 — Hydrocéphalie congénitale (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q00-Q07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : Q03.0 Malformations de l'aqueduc de Sylvius ; Q03.1 Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie ; Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales ; Q03.9 Hydrocéphalie congénitale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q00, Q01, Q02, Q04, Q05, Q06, Q07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q03/Q03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/Q03/.

Q04 — Autres malformations congénitales de l'encéphale (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q00-Q07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Q04.0 Malformations congénitales du corps calleux ; Q04.1 Arhinencéphalie ; Q04.2 Holoprosencéphalie ; Q04.3 Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale ; Q04.4 Dysplasie du septum et des voies optiques ; Q04.5 Mégalencéphalie ; Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux ; Q04.8 Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale ; Q04.9 Malformation congénitale de l'encéphale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q00, Q01, Q02, Q03, Q05, Q06, Q07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q04/Q04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/Q04/.

Q05 — Spina bifida (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q00-Q07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Q05.0 Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie ; Q05.1 Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie ; Q05.2 Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie ; Q05.3 Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie ; Q05.4 Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision ; Q05.5 Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie ; Q05.6 Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie ; Q05.7 Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie ; Q05.8 Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie ; Q05.9 Spina bifida, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q00, Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q05/Q05_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/Q05/.

Q06 — Autres malformations congénitales de la moelle épinière (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q00-Q07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : Q06.0 Amyélie ; Q06.1 Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière ; Q06.2 Diastématomyélie ; Q06.3 Autres malformations congénitales de la queue de cheval ; Q06.4 Hydromyélie ; Q06.8 Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière ; Q06.9 Malformation congénitale de la moelle épinière, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q00, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q06/Q06_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q06.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/Q06/.

Q07 — Autres malformations congénitales du système nerveux (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q00-Q07 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : Q07.0 Syndrome d'Arnold-Chiari ; Q07.8 Autres malformations congénitales précisées du système nerveux ; Q07.9 Malformation congénitale du système nerveux, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Q00, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Génétique et conseil génétique → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q07/Q07_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q07.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/Q07/.

R25 — Mouvements involontaires anormaux (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R25-R29 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 96 (abnormal sense of balance, falls), 97 (abnormal gait), 98 (abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination), 103 (paresis, paralysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : R25.0 Mouvements anormaux de la tête ; R25.1 Tremblement, sans précision ; R25.2 Crampes et spasmes ; R25.3 Fasciculation ; R25.8 Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R26, R27, R29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/R25/R25_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/r25.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/R25/](#).

R26 — Anomalies de la démarche et de la motilité (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R25-R29 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 96 (abnormal sense of balance, falls), 97 (abnormal gait), 98 (abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination), 103 (paresis, paralysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : R26.0 Démarche ataxique ; R26.1 Démarche paralytique ; R26.2 Difficulté à la marche, non classée ailleurs ; R26.3 Immobilité ; R26.8 Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R25, R27, R29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/R26/R26_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/r26.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/R26/](#).

R27 — Autres troubles de la coordination (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R25-R29 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 96 (abnormal sense of balance, falls), 97 (abnormal gait), 98 (abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination), 103 (paresis, paralysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : R27.0 Ataxie, sans précision ; R27.8 Troubles de la coordination, autres et non précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R25, R26, R29
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/R27/R27_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r27.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/R27/.

R29 — Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R25-R29 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 96 (abnormal sense of balance, falls), 97 (abnormal gait), 98 (abnormal involuntary movements, tremor, tic, lack of coordination), 103 (paresis, paralysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : R29.0 Tétanie ; R29.1 Méningisme ; R29.2 Réflexes anormaux ; R29.3 Posture anormale ; R29.4 Hanche «à ressort» ; R29.5 Négligence neurologique ; R29.6 Chutes à répétition, non classées ailleurs ; R29.8 Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R25, R26, R27
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R29/R29_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r29.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/R29/.

R40 — Somnolence, stupeur et coma (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R40-R46 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 145 (impairment or loss of consciousness, coma), 217 (syncope, loss of consciousness). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : R40.0 Somnolence ; R40.1 Stupeur ; R40.2 Coma, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R41, R42, R43, R44, R45, R46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R40/R40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/R40/.

R41 — Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R40-R46 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 102 (memory disturbance, cognitive impairment), 126 (mental confusion, delirium), 139 (cognitive impairment). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : R41.0 Désorientation, sans précision ; R41.1 Amnésie antérograde ; R41.2 Amnésie rétrograde ; R41.3 Autres formes d'amnésie ; R41.8 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R40, R42, R43, R44, R45, R46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux

rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/R41/R41_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r41.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/R41/.

R42 — Étourdissements et éblouissements (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R40-R46 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 100 (dizziness, vertigo). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R40, R41, R43, R44, R45, R46
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R42/R42_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r42.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/R42/.

R47 — Troubles du langage, non classés ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R47-R49 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 99 (disorders of speech or language). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : R47.0 Dysphasie et aphasie ; R47.1 Dysarthrie et anarthrie ; R47.8 Troubles du langage, autres et non précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R48, R49
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R47/R47_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r47.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/R47/.

R48 — Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R47-R49 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 99 (disorders of speech or language). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : R48.0 Dyslexie et alexie ; R48.1 Agnosie ; R48.2 Apraxie ; R48.8 Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R47, R49
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/R48/R48_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r48.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/R48/.

R49 — Troubles de la voix (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R47-R49 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 19 (alteration of voice (hoarseness, aphonia, dysphonia)), 99 (disorders of speech or language). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : R49.0 Dysphonie ; R49.1 Aphonie ; R49.2 Hypernasalité et hyponasalité ; R49.8 Troubles de la voix, autres et non précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R47, R48
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R49/R49_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r49.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/R49/.

S04 — Lésion traumatique des nerfs crâniens (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S00-S09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 112 (head and brain injuries and trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : S04.0 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques ; S04.1 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun ; S04.2 Lésion traumatique du nerf pathétique ; S04.3 Lésion traumatique du nerf trijumeau ; S04.4 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe ; S04.5 Lésion traumatique du nerf facial ; S04.6 Lésion traumatique du nerf auditif ; S04.7 Lésion traumatique du nerf spinal ; S04.8 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens ; S04.9 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S06
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S04/S04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/S04/.

S06 — Lésion traumatique intracrânienne (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S00-S09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 112 (head and brain injuries and trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : S06.0 Commotion ; S06.1 Œdème cérébral traumatique ; S06.2 Lésion traumatique cérébrale diffuse ; S06.3 Lésion traumatique cérébrale en foyer ; S06.4 Hémorragie épidurale ; S06.5 Hémorragie sous-durale traumatique ; S06.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique ; S06.7 Perte de connaissance lors de traumatisme cranio-cérébral ; S06.8 Autres lésions traumatiques intracrâniennes ; S06.9 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : S04

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S06/S06_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s06.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/S06/](#).

S14 — Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S10-S19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 115 (spine injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : S14.0 Contusion et œdème de la moelle cervicale ; S14.1 Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées ; S14.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical ; S14.3 Lésion traumatique du plexus brachial ; S14.4 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou ; S14.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux ; S14.6 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés ; S14.7 Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S14/S14_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s14.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/S14/](#).

S24 — Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S20-S29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 116 (thoracic injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : S24.0 Contusion et œdème de la moelle dorsale ; S24.1 Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale ; S24.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal ; S24.3 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax ; S24.4 Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax ; S24.5 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax ; S24.6 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax ; S24.7 Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S24/S24_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s24.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/S24/](#).

S34 — Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S30-S39 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 106 (abdominal injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : S34.0 Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris] ; S34.1 Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire ; S34.2 Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré ; S34.3 Lésion traumatique de la queue de cheval ; S34.4 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré ; S34.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin ; S34.6 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin ; S34.7 Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée ; S34.8 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S34/S34_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s34.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/S34/.

S44 — Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S40-S49 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : S44.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras ; S44.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras ; S44.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras ; S44.3 Lésion traumatique du nerf axillaire ; S44.4 Lésion traumatique du nerf musculo-cutané ; S44.5 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras ; S44.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et du bras ; S44.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras ; S44.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S44/S44_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s44.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/S44/.

S54 — Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S50-S59 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : S54.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras ; S54.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras ; S54.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras ; S54.3 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras ; S54.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras ; S54.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras ; S54.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et

bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/S54/S54_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s54.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/S54/](#).

S64 — Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S60-S69 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : S64.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main ; S64.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main ; S64.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main ; S64.3 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce ; S64.4 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt ; S64.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main ; S64.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main ; S64.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S64/S64_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s64.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/S64/](#).

S74 — Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S70-S79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S74.0 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse ; S74.1 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse ; S74.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse ; S74.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse ; S74.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse ; S74.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/S74/S74_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/s74.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/S74/](#).

S84 — Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S80-S89 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S84.0 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée interne au niveau de la jambe ; S84.1 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée externe au niveau de la jambe ; S84.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe ; S84.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe ; S84.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe ; S84.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S84/S84_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s84.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/S84/.

S94 — Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied (N-05-Neurologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S90-S99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : S94.0 Lésion traumatique du nerf plantaire externe ; S94.1 Lésion traumatique du nerf plantaire interne ; S94.2 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied ; S94.3 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied ; S94.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et du pied ; S94.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied ; S94.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Complications et pronostic → 9. Prévention, dépistage et suivi → 10. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 11. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 12. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S94/S94_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s94.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/N-05-Neurologie/travail/S94/.

I-03-Infectiologie

51 leçons « Examen fédéral » ; 5 rédigées ; 4 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : SSI, OFSP ; ESCMID, ECDC.

A04 — Autres infections intestinales bactériennes (I-03-Infectiologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A00-A09 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 59 (diarrhoea), 157 (abnormal faecal analyses, occult blood, parasites). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : A04.0 Infection entéropathogène à Escherichia coli ; A04.1 Infection entérotoxigène à Escherichia coli ; A04.2 Infection entéro-invasive à Escherichia coli ; A04.3 Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli ; A04.4 Autres infections intestinales à Escherichia coli ; A04.5 Entérite à Campylobacter ; A04.6 Entérite à Yersinia enterocolitica ; A04.7

Entérocolite à Clostridium difficile ; A04.8 Autres infections intestinales bactériennes précisées ; A04.9 Infection intestinale bactérienne, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A00, A01, A02, A03, A05, A06, A07, A08, A09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A04/A04_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a04.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A04/.

A09 — Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse et non précisée (I-03-Infectiologie) · P1

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A00-A09 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 59 (diarrhoea), 157 (abnormal faecal analyses, occult blood, parasites). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : A09.0 Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse ; A09.9 Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A09/A09_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a09.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A09/.

A00 — Choléra (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A00-A09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 59 (diarrhoea), 157 (abnormal faecal analyses, occult blood, parasites). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : A00.0 A Vibrio cholerae 01, biovar cholerae ; A00.1 A Vibrio cholerae 01, biovar El Tor ; A00.9 Choléra, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A00/A00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A00/.

A01 — Fièvres typhoïde et paratyphoïde (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A00-A09 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 59 (diarrhoea), 157 (abnormal faecal analyses, occult blood, parasites). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : A01.0 Fièvre typhoïde ; A01.1 Paratyphoïde A ; A01.2 Paratyphoïde B ; A01.3 Paratyphoïde C ; A01.4 Paratyphoïde, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A00, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A01/A01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A01/.

A02 — Autres infections à Salmonella (I-03-Infectiologie) • P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** : bloc A00-A09 • difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 59 (diarrhoea), 157 (abnormal faecal analyses, occult blood, parasites). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : A02.0 Entérite à Salmonella ; A02.1 Septicémie à Salmonella ; A02.2 Infection localisée à Salmonella ; A02.8 Autres infections précisées à Salmonella ; A02.9 Infection à Salmonella, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A02/A02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A02/.

A03 — Shigellose (I-03-Infectiologie) • P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** : bloc A00-A09 • difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 59 (diarrhoea), 157 (abnormal faecal analyses, occult blood, parasites). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : A03.0 Shigellose à Shigella dysenteriae ; A03.1 Shigellose à Shigella flexneri ; A03.2 Shigellose à Shigella boydii ; A03.3 Shigellose à Shigella sonnei ; A03.8 Autres shigelloses ; A03.9 Shigellose, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A00, A01, A02, A04, A05, A06, A07, A08, A09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A03/A03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A03/.

A05 — Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire, non classées ailleurs (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A00-A09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 59 (diarrhoea), 157 (abnormal faecal analyses, occult blood, parasites). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : A05.0 Intoxication alimentaire à staphylocoques ; A05.1 Botulisme ; A05.2 Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii] ; A05.3 Intoxication alimentaire à Vibrio parahaemolyticus ; A05.4 Intoxication alimentaire à Bacillus cereus ; A05.8 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées ; A05.9 Intoxication bactérienne d'origine alimentaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A00, A01, A02, A03, A04, A06, A07, A08, A09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A05/A05_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a05.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A05/.

A06 — Amibiase (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A00-A09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 59 (diarrhoea), 157 (abnormal faecal analyses, occult blood, parasites). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : A06.0 Dysenterie amibienne aiguë ; A06.1 Amibiase intestinale chronique ; A06.2 Colite amibienne non dysentérique ; A06.3 Amœbome de l'intestin ; A06.4 Abscès amibien du foie ; A06.5 Abscès amibien du poumon ; A06.6 Abscès amibien du cerveau ; A06.7 Amibiase cutanée ; A06.8 Autres localisations d'une infection amibienne ; A06.9 Amibiase, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A00, A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A06/A06_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a06.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A06/.

A07 — Autres maladies intestinales à protozoaires (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A00-A09 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 59 (diarrhoea), 157 (abnormal faecal analyses, occult blood, parasites). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : A07.0 Balantidiose ; A07.1 Giardiase [lamblia] ; A07.2 Cryptosporidiose ; A07.3 Infection à Isospora ; A07.8 Autres maladies intestinales précisées, à protozoaires ; A07.9 Maladie intestinale à protozoaires, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A08, A09

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A07/A07_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a07.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A07/.

A08 — Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A00-A09 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 59 (diarrhoea), 157 (abnormal faecal analyses, occult blood, parasites). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : A08.0 Entérite à rotavirus ; A08.1 Gastroentérite aiguë à norovirus ; A08.2 Entérite à adénovirus ; A08.3 Autres entérites virales ; A08.4 Infections intestinales virales, sans précision ; A08.5 Autres infections intestinales précisées
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A09
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A08/A08_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a08.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A08/.

A15 — Tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A15-A19 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 45 (cough, expectoration, haemoptysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : A15.0 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ; A15.1 Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement ; A15.2 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique ; A15.3 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non précisé ; A15.4 Tuberculose des ganglions intrathoraciques, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ; A15.5 Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ; A15.6 Pleurésie tuberculeuse, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ; A15.7 Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ; A15.8 Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ; A15.9 Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A16, A17, A18, A19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications

et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/A15/A15_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a15.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A15/.

A16 — Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A15-A19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 45 (cough, expectoration, haemoptysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : A16.0 Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ; A16.1 Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique ; A16.2 Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ; A16.3 Tuberculose des ganglions intrathoraciques, sans mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ; A16.4 Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ; A16.5 Pleurésie tuberculeuse, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ; A16.7 Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ; A16.8 Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ; A16.9 Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A15, A17, A18, A19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A16/A16_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a16.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A16/.

A17 — Tuberculose du système nerveux (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A15-A19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 45 (cough, expectoration, haemoptysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : A17.0 Méningite tuberculeuse ; A17.1 Tuberculome méningé ; A17.8 Autres formes de tuberculose du système nerveux ; A17.9 Tuberculose du système nerveux, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A15, A16, A18, A19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A17/A17_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a17.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A17/.

A18 — Tuberculose d'autres organes (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A15-A19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 45 (cough, expectoration, haemoptysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : A18.0 Tuberculose des os et des articulations ; A18.1 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire ; A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique ; A18.3 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques ; A18.4 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ; A18.5 Tuberculose de l'œil ; A18.6 Tuberculose de l'oreille ; A18.7 Tuberculose des surrénales ; A18.8 Tuberculose d'autres organes précisés
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A15, A16, A17, A19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A18/A18_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a18.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A18/.

A19 — Tuberculose miliaire (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A15-A19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 45 (cough, expectoration, haemoptysis). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : A19.0 Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée ; A19.1 Tuberculose miliaire aiguë, sièges multiples ; A19.2 Tuberculose miliaire aiguë, sans précision ; A19.8 Autres tuberculoses miliaires ; A19.9 Tuberculose miliaire, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A15, A16, A17, A18
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A19/A19_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a19.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A19/.

A40 — Septicémie à streptocoques (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A30-A49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 214 (severe hypertension, severe hypotension). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : A40.0 Septicémie à streptocoques, groupe A ; A40.1 Septicémie à streptocoques, groupe B ; A40.2 Septicémie à streptocoques, groupe D, et entérocoques ; A40.3 Septicémie à Streptococcus pneumoniae ; A40.8 Autres septicémies à streptocoques ; A40.9 Septicémie à streptocoques, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A41, A42, A43, A44, A46, A48, A49
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5.

Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/A40/A40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A40/.

A55 — Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A50-A64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A53, A54, A56, A57, A58, A59, A60, A63, A64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A55/A55_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a55.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A55/.

A56 — Autres infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A50-A64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : A56.0 Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire ; A56.1 Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires ; A56.2 Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision ; A56.3 Infection à Chlamydia de l'anus et du rectum ; A56.4 Infection à Chlamydia du pharynx ; A56.8 Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A53, A54, A55, A57, A58, A59, A60, A63, A64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A56/A56_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a56.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A56/.

A57 — Chancre mou (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A50-A64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A53, A54, A55, A56, A58, A59, A60, A63, A64

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A57/A57_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a57.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A57/.

A58 — Granulome inguinal (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** : bloc A50-A64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A53, A54, A55, A56, A57, A59, A60, A63, A64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A58/A58_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a58.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A58/.

A59 — Trichomonase (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** : bloc A50-A64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : A59.0 Trichomonase uro-génitale ; A59.8 Autres localisations de trichomonase ; A59.9 Trichomonase, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A53, A54, A55, A56, A57, A58, A60, A63, A64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A59/A59_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a59.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A59/.

A60 — Infection ano-génitale par le virus de l'herpès [herpes simplex] (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** : bloc A50-A64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : A60.0 Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès ; A60.1 Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès ; A60.9 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A63, A64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A60/A60_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a60.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A60/.

A63 — Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A50-A64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens) ; A63.8 Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A63/A63_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a63.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A63/.

A64 — Maladie sexuellement transmise, sans précision (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A50-A64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A63
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A64/A64_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a64.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A64/.

A80 — Poliomyélite aiguë (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A80-A89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : A80.0 Poliomyélite paralytique aiguë, associée au virus vaccinal ; A80.1 Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage importé ; A80.2 Poliomyélite

paralytique aiguë, virus sauvage indigène ; A80.3 Poliomyélites paralytiques aiguës, autres et sans précision ; A80.4 Poliomyélite aiguë non paralytique ; A80.9 Poliomyélite aiguë, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/A80/A80_a.m.d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/a80.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A80/](#).

A81 — Infections atypiques à virus, du système nerveux central (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A80-A89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : A81.0 Maladie de Creutzfeldt-Jakob ; A81.1 Panencéphalite sclérosante subaiguë ; A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale progressive ; A81.8 Autres infections atypiques à virus, du système nerveux central ; A81.9 Infection atypiques à virus, du système nerveux central, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A80, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/A81/A81_a.m.d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/a81.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A81/](#).

A82 — Rage (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A80-A89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : A82.0 Rage sylvatique ; A82.1 Rage des rues [rage citadine] ; A82.9 Rage, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A80, A81, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/A82/A82_a.m.d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/a82.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A82/](#).

A83 — Encéphalite virale transmise par des moustiques (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide

- **Chapitre CIM I** · bloc A80-A89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : A83.0 Encéphalite japonaise ; A83.1 Encéphalite équine occidentale ; A83.2 Encéphalite équine orientale ; A83.3 Encéphalite de Saint-Louis ; A83.4 Encéphalite australienne ; A83.5 Encéphalite de Californie ; A83.6 Maladie à virus de Rocio ; A83.8 Autres encéphalites virales transmises par des moustiques ; A83.9 Encéphalite virale transmise par des moustiques, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A80, A81, A82, A84, A85, A86, A87, A88, A89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A83/A83_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a83.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A83/.

A84 — Encéphalite virale transmise par des tiques (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A80-A89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : A84.0 Encéphalite de la taïga [encéphalite verno-estivale russe] ; A84.1 Encéphalite d'Europe centrale transmise par des tiques ; A84.8 Autres encéphalites virales transmises par des tiques ; A84.9 Encéphalite virale transmise par des tiques, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A80, A81, A82, A83, A85, A86, A87, A88, A89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A84/A84_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a84.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A84/.

A85 — Autres encéphalites virales, non classées ailleurs (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A80-A89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : A85.0 Encéphalite à entérovirus ; A85.1 Encéphalite à adénovirus ; A85.2 Encéphalite virale transmise par des arthropodes, sans précision ; A85.8 Autres encéphalites virales précisées
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A80, A81, A82, A83, A84, A86, A87, A88, A89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant,

sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/A85/A85_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a85.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A85/.

A86 — Encéphalite virale, sans précision (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A80-A89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A80, A81, A82, A83, A84, A85, A87, A88, A89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A86/A86_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a86.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A86/.

A87 — Méningite virale (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A80-A89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : A87.0 Méningite à entérovirus ; A87.1 Méningite à adénovirus ; A87.2 Chorioméningite lymphocytaire ; A87.8 Autres méningites virales ; A87.9 Méningite virale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A88, A89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A87/A87_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a87.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A87/.

A88 — Autres infections virales du système nerveux central, non classées ailleurs (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A80-A89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : A88.0 Fièvre exanthématique à entérovirus [exanthème de Boston] ; A88.1 Vertige épidémique ; A88.8 Autres infections virales précisées du système nerveux central
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle

suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/A88/A88_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a88.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A88/.

A89 — Infection virale du système nerveux central, sans précision (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc A80-A89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 101 (headache), 207 (acute severe headache, meningism). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A89/A89_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a89.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A89/.

B15 — Hépatite aiguë A (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc B15-B19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 91 (jaundice (icterus)), 160 (abnormal liver enzymes). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : B15.0 Hépatite A avec coma hépatique ; B15.9 Hépatite A sans coma hépatique
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : B16, B17, B18, B19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/B15/B15_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/b15.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/B15/.

B16 — Hépatite aiguë B (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc B15-B19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 91 (jaundice (icterus)), 160 (abnormal liver enzymes). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : B16.0 Hépatite aiguë B avec agent delta, avec coma hépatique ; B16.1 Hépatite aiguë B avec agent delta, sans coma hépatique ; B16.2 Hépatite aiguë B sans agent delta, avec coma hépatique ; B16.9 Hépatite aiguë B, sans agent delta et sans coma hépatique
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : B15, B17, B18, B19

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/B16/B16_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/b16.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/B16/.

B17 — Autres hépatites virales aiguës (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc B15-B19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 91 (jaundice (icterus)), 160 (abnormal liver enzymes).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : B17.0 (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B ; B17.1 Hépatite aiguë C ; B17.2 Hépatite aiguë E ; B17.8 Autres hépatites virales aiguës précisées ; B17.9 Hépatite virale aiguë, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : B15, B16, B18, B19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/B17/B17_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/b17.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/B17/.

B19 — Hépatite virale, sans précision (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc B15-B19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 91 (jaundice (icterus)), 160 (abnormal liver enzymes).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : B19.0 Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique ; B19.9 Hépatite virale, sans précision, sans coma hépatique
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : B15, B16, B17, B18
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/B19/B19_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/b19.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/B19/.

B50 — Paludisme à Plasmodium falciparum (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc B50-B64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 242 (consultation before or after trip to foreign (tropical) country). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours (3)** : B50.0 Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales ; B50.8 Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum ; B50.9 Paludisme à Plasmodium falciparum, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B60, B64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/B50/B50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/b50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/B50/.

B51 — Paludisme à Plasmodium vivax (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc B50-B64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 242 (consultation before or after trip to foreign (tropical) country). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (3)** : B51.0 Paludisme à Plasmodium vivax, avec rupture de la rate ; B51.8 Paludisme à Plasmodium vivax, avec autres complications ; B51.9 Paludisme à Plasmodium vivax, sans complication
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : B50, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B60, B64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/B51/B51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/b51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/B51/.

B52 — Paludisme à Plasmodium malariae (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc B50-B64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 242 (consultation before or after trip to foreign (tropical) country). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours (3)** : B52.0 Paludisme à Plasmodium malariae, avec atteinte rénale ; B52.8 Paludisme à Plasmodium malariae, avec autres complications ; B52.9 Paludisme à Plasmodium malariae, sans complication
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : B50, B51, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B60, B64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/B52/B52_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/b52.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/B52/.

B53 — Autres paludismes confirmés par examen parasitologique (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc B50-B64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 242 (consultation before or after trip to foreign (tropical) country). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : B53.0 Paludisme à Plasmodium ovale ; B53.1 Paludisme à plasmodies simiennes ; B53.8 Autres paludismes, confirmés par examen parasitologique, non classés ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : B50, B51, B52, B54, B55, B56, B57, B58, B60, B64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/B53/B53_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/b53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/B53/.

B54 — Paludisme, sans précision (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM I** · bloc B50-B64 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 242 (consultation before or after trip to foreign (tropical) country). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : B50, B51, B52, B53, B55, B56, B57, B58, B60, B64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/B54/B54_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/b54.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/B54/.

Z20 — Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z20-Z29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : Z20.0 Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses intestinales ; Z20.1 Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose ; Z20.2 Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel ; Z20.3 Sujets en contact avec et exposés à la rage ; Z20.4 Sujets en contact avec et exposés à la rubéole ; Z20.5 Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale ; Z20.6 Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ; Z20.7 Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations ; Z20.8 Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies transmissibles ; Z20.9 Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z21, Z22

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Microbiologie → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z20/Z20_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z20.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/Z20/.

Z21 — Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z20-Z29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z20, Z22
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Microbiologie → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z21/Z21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/Z21/.

Z22 — Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse (I-03-Infectiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XXI** · bloc Z20-Z29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : Z22.0 Sujet porteur de typhoïde ; Z22.1 Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses ; Z22.2 Sujet porteur de diphtérie ; Z22.3 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées ; Z22.4 Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel ; Z22.6 Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1] ; Z22.7 Tuberculose latente ; Z22.8 Sujet porteur d'autres maladies infectieuses ; Z22.9 Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : Z20, Z21
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Microbiologie → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Z22/Z22_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/z22.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/Z22/.

A53 — Syphilis (I-03-Infectiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM I** · bloc A50-A64 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)

- **Situations PROFILES 2017** : 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : A53.0 Syphilis latente, non précisée précoce ou tardive ; A53.9 Syphilis, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A63, A64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A53/A53_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a53.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A53/.

A54 — Infection gonococcique (I-03-Infectiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM I** · bloc A50-A64 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : A54.0 Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes ; A54.1 Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes ; A54.2 Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques ; A54.3 Infection gonococcique de l'œil ; A54.4 Infection gonococcique du système ostéo-articulaire et des muscles ; A54.5 Pharyngite gonococcique ; A54.6 Infection gonococcique de l'anus et du rectum ; A54.8 Autres infections gonococciques ; A54.9 Infection gonococcique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A53, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A63, A64
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A54/A54_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a54.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A54/.

A41 — Sepsis et choc septique de l'adulte (I-03-Infectiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM I** · bloc A30-A49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 6 (fever, chills, hyperthermia), 214 (severe hypertension, severe hypotension). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : A41.0 Septicémie à staphylocoques dorés ; A41.1 Septicémie à d'autres staphylocoques précisés ; A41.2 Septicémie à staphylocoques non précisés ; A41.3 Septicémie à Haemophilus influenzae ; A41.4 Septicémie à micro-organismes anaérobies ; A41.5 Septicémie à d'autres micro-organismes Gram négatif ; A41.8 Autres septicémies précisées ; A41.9 Septicémie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A42, A43, A44, A46, A48, A49

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/A41/A41_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/a41.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/A41/.

B18 — Hépatite virale chronique (I-03-Infectiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM I** · bloc B15-B19 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 91 (jaundice (icterus)), 160 (abnormal liver enzymes). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : B18.0 Hépatite virale chronique B avec agent delta ; B18.1 Hépatite virale chronique B sans agent delta ; B18.2 Hépatite virale chronique C ; B18.8 Autres hépatites virales chroniques ; B18.9 Hépatite virale chronique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : B15, B16, B17, B19
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/B18/B18_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/b18.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/B18/.

B24 — Infection par le VIH et maladie à VIH de l'adulte (I-03-Infectiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM I** · bloc B20-B24 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 253 (patient with sexually transmitted infection). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Agent pathogène, réservoir et transmission → 4. Présentation clinique → 5. Diagnostic microbiologique et différentiel → 6. Traitement anti-infectieux (information professionnelle suisse) → 7. Hygiène, déclaration obligatoire OFSP, vaccination → 8. Microbiologie → 9. Complications et pronostic → 10. Prévention, dépistage et suivi → 11. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 12. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 13. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/B24/B24_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/b24.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/I-03-Infectiologie/travail/B24/.

C-01-Cardiologie

43 leçons « Examen fédéral » ; 22 rédigées ; 8 fréquentes. Sources de départ (à lire et dater réellement) : Société suisse de cardiologie ; ESC.

I73 — Autres maladies vasculaires périphériques (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I70-I79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 144 (gangrene). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas

clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : I73.0 Syndrome de Raynaud ; I73.1 Thrombo-angéite oblitérante [Buerger] ; I73.8 Autres maladies vasculaires périphériques précisées ; I73.9 Maladie vasculaire périphérique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I70, I71, I77, I78, I79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I73/I73_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i73.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I73/.

I77 — Autres atteintes des artères et artérioles (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I70-I79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 144 (gangrene). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : I77.0 Fistule artério-veineuse, acquise ; I77.1 Sténose d'une artère ; I77.2 Rupture d'une artère ; I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle ; I77.4 Syndrome de compression de l'artère coeliaque ; I77.5 Nécrose d'une artère ; I77.6 Artérite, sans précision ; I77.8 Autres atteintes précisées des artères et artérioles ; I77.9 Atteinte des artères et artérioles, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I70, I71, I73, I78, I79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I77/I77_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i77.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I77/.

I78 — Maladies des capillaires (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I70-I79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 144 (gangrene). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : I78.0 Télangiectasie hémorragique héréditaire ; I78.1 Nævus, non néoplasique ; I78.8 Autres maladies des capillaires ; I78.9 Maladie des capillaires, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I70, I71, I73, I77, I79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières

(grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : [chapters/I78/I78_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/i78.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I78/](#).

I79 — Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I70-I79 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 144 (gangrene). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : I79.0 Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées ailleurs ; I79.1 Aortite au cours de maladies classées ailleurs ; I79.2 Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs ; I79.8 Autres atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I70, I71, I73, I77, I78
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/I79/I79_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/i79.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I79/](#).

I85 — Varices œsophagiennes (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I80-I89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 12 (swelling, oedema (diffuse or local)), 146 (oedema). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : I85.0 Varices œsophagiennes hémorragiques ; I85.9 Varices œsophagiennes, non hémorragiques
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I80, I83, I86, I88, I89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : [chapters/I85/I85_a...d.html](#), [_pop1](#), [_pop2](#), [glossary/i85.py](#), rapports auteur et relecture dans [livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I85/](#).

I86 — Varices d'autres localisations (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I80-I89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 12 (swelling, oedema (diffuse or local)), 146 (oedema). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : I86.0 Varices sublinguales ; I86.1 Varices scrotales ; I86.2 Varices pelviennes ; I86.3 Varices vulvaires ; I86.4 Varices gastriques ; I86.8 Varices d'autres

localisations précisées

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I80, I83, I85, I88, I89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I86/I86_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i86.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I86/.

I88 — Lymphadénite non spécifique (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I80-I89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 12 (swelling, oedema (diffuse or local)), 146 (oedema). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : I88.0 Lymphadénite mésentérique non spécifique ; I88.1 Lymphadénite chronique, sauf mésentérique ; I88.8 Autres lymphadénites non spécifiques ; I88.9 Lymphadénite non spécifique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I80, I83, I85, I86, I89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I88/I88_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i88.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I88/.

I89 — Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I80-I89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 12 (swelling, oedema (diffuse or local)), 146 (oedema). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : I89.0 Lymphœdème, non classé ailleurs ; I89.1 Lymphangite ; I89.8 Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques ; I89.9 Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I80, I83, I85, I86, I88
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I89/I89_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i89.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I89/.

I95 — Hypotension (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM IX** · bloc I95-I99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 131 (abnormal blood pressure), 214 (severe hypertension, severe hypotension). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : I95.0 Hypotension idiopathique ; I95.1 Hypotension orthostatique ; I95.2 Hypotension médicamenteuse ; I95.8 Autres hypotensions ; I95.9 Hypotension, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I97, I98, I99
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I95/I95_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i95.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I95/.

R00 — Anomalies du rythme cardiaque (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R00-R09 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 137 (bradycardia, tachycardia, irregular pulse). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : R00.0 Tachycardie, sans précision ; R00.1 Bradycardie, sans précision ; R00.2 Palpitations ; R00.3 Activité électrique sans poulx, non classée ailleurs ; R00.8 Anomalies du rythme cardiaque, autres et non précisées
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R01, R02, R03
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R00/R00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/R00/.

R01 — Souffles et autres bruits cardiaques (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R00-R09 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 133 (abnormal findings upon auscultation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins ; R01.1 Souffle cardiaque, sans précision ; R01.2 Autres bruits cardiaques
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R00, R02, R03
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations

particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/R01/R01_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r01.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/R01/.

R02 — Gangrène, non classée ailleurs (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R00-R09 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 144 (gangrene). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : R02.0 Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs ; R02.8 Autre gangrène et gangrène non précisée, non classée ailleurs
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R00, R01, R03
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R02/R02_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r02.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/R02/.

R03 — Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XVIII** · bloc R00-R09 · difficulté **moyenne**
- **Situations PROFILES 2017** : 131 (abnormal blood pressure). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : R03.0 Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension ; R03.1 Constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : R00, R01, R02
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Physiologie du symptôme → 4. Anamnèse et examen orientés → 5. Drapeaux rouges → 6. Démarche diagnostique étagée → 7. Diagnostics différentiels à ne pas manquer → 8. Prise en charge symptomatique → 9. Imagerie et explorations fonctionnelles → 10. Classification et scores → 11. Complications et pronostic → 12. Prévention, dépistage et suivi → 13. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 14. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 15. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/R03/R03_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/r03.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/R03/.

S26 — Lésion traumatique du cœur (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S20-S29 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 116 (thoracic injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : S26.0 Hémopéricarde traumatique ; S26.8 Autres lésions traumatiques du cœur ; S26.9 Lésion traumatique du cœur, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations

particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/S26/S26_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s26.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/S26/.

S35 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S30-S39 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 106 (abdominal injuries). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : S35.0 Lésion traumatique de l'aorte abdominale ; S35.1 Lésion traumatique de la veine cave inférieure ; S35.2 Lésion traumatique de l'artère coéliquale ou mésentérique ; S35.3 Lésion traumatique de la veine porte ou splénique ; S35.4 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein ; S35.5 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques ; S35.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin ; S35.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin ; S35.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S35/S35_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/S35/.

S45 — Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S40-S49 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : S45.0 Lésion traumatique de l'artère axillaire ; S45.1 Lésion traumatique de l'artère brachiale ; S45.2 Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale ; S45.3 Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras ; S45.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras ; S45.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras ; S45.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S45/S45_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s45.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/S45/.

S55 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S50-S59 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S55.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras ; S55.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras ; S55.2 Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras ; S55.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras ; S55.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras ; S55.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S55/S55_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s55.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/S55/.

S65 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S60-S69 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : S65.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main ; S65.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main ; S65.2 Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel ; S65.3 Lésion traumatique de l'arc palmaire profond ; S65.4 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce ; S65.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt ; S65.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main ; S65.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main ; S65.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S65/S65_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s65.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/S65/.

S75 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S70-S79 · difficulté élevée
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S75.0 Lésion traumatique de l'artère fémorale ; S75.1 Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse ; S75.2 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la hanche et de la cuisse ; S75.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse ; S75.8 Lésion

traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse ; S75.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse

- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S75/S75_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s75.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/S75/.

S85 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S80-S89 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : S85.0 Lésion traumatique de l'artère poplitée ; S85.1 Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure) ; S85.2 Lésion traumatique de l'artère péronière ; S85.3 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la jambe ; S85.4 Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la jambe ; S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée ; S85.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe ; S85.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe ; S85.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/S85/S85_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s85.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/S85/.

S95 — Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied (C-01-Cardiologie) · P2

- **État** : vide
- **Chapitre CIM XIX** · bloc S90-S99 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 113 (injuries of the extremities), 220 (uncomplicated common trauma). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : S95.0 Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied ; S95.1 Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied ; S95.2 Lésion traumatique de la veine dorsale du pied ; S95.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied ; S95.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied ; S95.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Mécanisme lésionnel → 4. Évaluation initiale et gravité (ABCDE) → 5. Imagerie et bilan lésionnel → 6. Traitement d'urgence puis définitif → 7. Rééducation, reprise du travail, assurance accidents (LAA, Suva) → 8. Imagerie et explorations fonctionnelles → 9. Classification et scores → 10. Complications et pronostic → 11. Prévention, dépistage et suivi → 12. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 13. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 14. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/S95/S95_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/s95.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/S95/.

I10 — Hypertension artérielle (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I10-I15 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 131 (abnormal blood pressure), 214 (severe hypertension, severe hypotension). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : I10.0 Hypertension essentielle bénigne ; I10.1 Hypertension essentielle maligne ; I10.9 Hypertension essentielle, non précisée
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I10/I10_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i10.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I10/.

I21 — Syndromes coronariens aigus et infarctus du myocarde (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I20-I25 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 44 (chest pain), 151 (abnormal cardiac enzymes), 204 (acute chest; epigastric, arm, jaw, tooth pain). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : I21.0 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure ; I21.1 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure ; I21.2 Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations ; I21.3 Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée ; I21.4 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde ; I21.9 Infarctus aigu du myocarde, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I25
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I21/I21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I21/.

I25 — Syndromes coronariens chroniques et angor (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I20-I25 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 44 (chest pain), 151 (abnormal cardiac enzymes), 204 (acute chest; epigastric, arm, jaw, tooth pain). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : I25.0 Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi ; I25.1 Cardiopathie artérioscléreuse ; I25.2 Infarctus du myocarde, ancien ; I25.3 Anévrisme (pariétal) du cœur ; I25.4 Anévrisme d'une artère coronaire ; I25.5 Myocardiopathie ischémique ; I25.6

Ischémie myocardique asymptomatique ; I25.8 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique ; I25.9 Cardiopathie ischémique chronique, sans précision

- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : I21**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I25/I25_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i25.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I25/.

I48 — Fibrillation et flutter auriculaires (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I30-I52 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 50 (palpitations), 137 (bradycardia, tachycardia, irregular pulse), 155 (abnormal ECG), 218 (cardiorespiratory disturbances and arrest). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : I48.0 Fibrillation auriculaire, paroxystique ; I48.1 Fibrillation auriculaire, persistante ; I48.2 Fibrillation auriculaire, permanente ; I48.3 Flutter auriculaire, typique ; I48.4 Flutter auriculaire, atypique ; I48.9 Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : I30, I33, I34, I35, I40, I42, I44, I46, I47, I49, I50, I51**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I48/I48_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i48.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I48/.

I50 — Insuffisance cardiaque (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I30-I52 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 12 (swelling, oedema (diffuse or local)), 46 (dyspnoea), 146 (oedema). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : I50.0 Insuffisance cardiaque droite ; I50.1 Insuffisance cardiaque gauche ; I50.9 Insuffisance cardiaque, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper) : I30, I33, I34, I35, I40, I42, I44, I46, I47, I48, I49, I51**
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/I50/I50_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i50.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I50/.

I70 — Athérosclérose périphérique, artériopathie des membres inférieurs et ischémie aiguë (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I70-I79 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 144 (gangrene). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : I70.0 Athérosclérose de l'aorte ; I70.1 Athérosclérose de l'artère rénale ; I70.2 Athérosclérose des artères distales ; I70.8 Athérosclérose d'autres artères ; I70.9 Athérosclérose généralisée et sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I71, I73, I77, I78, I79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I70/I70_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i70.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I70/.

I80 — Thrombose veineuse profonde et thromboses veineuses (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I80-I89 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)
- **Situations PROFILES 2017** : 12 (swelling, oedema (diffuse or local)), 146 (oedema). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (6) : I80.0 Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines superficielles des membres inférieurs ; I80.1 Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale ; I80.2 Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs ; I80.3 Thrombose, phlébite et thrombophlébite des membres inférieurs, sans précision ; I80.8 Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres localisations ; I80.9 Thrombose, phlébite et thrombophlébite de localisation non précisée
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I83, I85, I86, I88, I89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I80/I80_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i80.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I80/.

I83 — Varices des membres inférieurs (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I80-I89 · difficulté **élevée** · **pathologie fréquente** (sélection éditoriale à confirmer par une source suisse de fréquence)

- **Situations PROFILES 2017** : 12 (swelling, oedema (diffuse or local)), 146 (oedema).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : I83.0 Varices ulcérées des membres inférieurs ; I83.1 Varices des membres inférieurs, avec inflammation ; I83.2 Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation ; I83.9 Varices des membres inférieurs sans ulcère ou inflammation
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I80, I85, I86, I88, I89
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I83/I83_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i83.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I83/.

I00 — Rhumatisme articulaire aigu (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I00-I02 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 44 (chest pain), 133 (abnormal findings upon auscultation).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I00/I00_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i00.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I00/.

I30 — Péricardites, épanchement péricardique, tamponnade et constriction (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I30-I52 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 44 (chest pain), 133 (abnormal findings upon auscultation).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : I30.0 Péricardite idiopathique aiguë non spécifique ; I30.1 Péricardite infectieuse ; I30.8 Autres formes de péricardite aiguë ; I30.9 Péricardite aiguë, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I33, I34, I35, I40, I42, I44, I46, I47, I48, I49, I50, I51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I30/I30_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i30.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I30/.

I33 — Endocardite infectieuse (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I30-I52 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 44 (chest pain), 133 (abnormal findings upon auscultation).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (2) : I33.0 Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë ; I33.9 Endocardite aiguë, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I30, I34, I35, I40, I42, I44, I46, I47, I48, I49, I50, I51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I33/I33_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i33.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I33/.

I34 — Valvulopathies mitrales, tricuspides et pulmonaires (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I30-I52 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 44 (chest pain), 133 (abnormal findings upon auscultation).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale ; I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral(e) ; I34.2 Sténose non rhumatismale (de la valvule) mitrale ; I34.8 Autres atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale ; I34.9 Atteinte non rhumatismale de la valvule mitrale, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I30, I33, I35, I40, I42, I44, I46, I47, I48, I49, I50, I51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I34/I34_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i34.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I34/.

I35 — Valvulopathies aortiques (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I30-I52 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 44 (chest pain), 133 (abnormal findings upon auscultation).
Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (5) : I35.0 Sténose (de la valvule) aortique ; I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique ; I35.2 Sténose (de la valvule) aortique avec insuffisance ; I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique ; I35.9 Atteinte de la valvule aortique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I30, I33, I34, I40, I42, I44, I46, I47, I48, I49, I50, I51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères

d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/I35/I35_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i35.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I35/.

I40 — Myocardites (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I30-I52 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 44 (chest pain), 133 (abnormal findings upon auscultation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : I40.0 Myocardite infectieuse ; I40.1 Myocardite isolée ; I40.8 Autres myocardites aiguës ; I40.9 Myocardite aiguë, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I30, I33, I34, I35, I42, I44, I46, I47, I48, I49, I50, I51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I40/I40_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i40.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I40/.

I42 — Cardiomyopathies (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I30-I52 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 44 (chest pain), 133 (abnormal findings upon auscultation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : I42.0 Myocardiopathie avec dilatation ; I42.1 Myocardiopathie obstructive hypertrophique ; I42.2 Autres myocardiopathies hypertrophiques ; I42.3 Maladie endomyocardique (éosinophilique) ; I42.4 Fibroélastose endocardique ; I42.5 Autres myocardiopathies restrictives ; I42.6 Myocardiopathie alcoolique ; I42.7 Myocardiopathie due à des médicaments et d'autres causes externes ; I42.8 Autres myocardiopathies ; I42.9 Myocardiopathie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I30, I33, I34, I35, I40, I44, I46, I47, I48, I49, I50, I51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I42/I42_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i42.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I42/.

I44 — Troubles de la conduction et bradycardies (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I30-I52 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 50 (palpitations), 137 (bradycardia, tachycardia, irregular pulse), 155 (abnormal ECG), 218 (cardiorespiratory disturbances and arrest). Correspondance pédagogique, non

officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.

- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : I44.0 Bloc auriculoventriculaire du premier degré ; I44.1 Bloc auriculoventriculaire du second degré ; I44.2 Bloc auriculoventriculaire complet ; I44.3 Blocs auriculoventriculaires, autres et sans précision ; I44.4 Bloc fasciculaire antérieur gauche ; I44.5 Bloc fasciculaire postérieur gauche ; I44.6 Blocs fasciculaires, autres et sans précision ; I44.7 Bloc de branche gauche, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I30, I33, I34, I35, I40, I42, I46, I47, I48, I49, I50, I51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I44/I44_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i44.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I44/.

I46 — Arrêt cardiaque (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I30-I52 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 50 (palpitations), 137 (bradycardia, tachycardia, irregular pulse), 155 (abnormal ECG), 218 (cardiorespiratory disturbances and arrest). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (3) : I46.0 Arrêt cardiaque réanimé avec succès ; I46.1 Mort cardiaque subite, décrite ainsi ; I46.9 Arrêt cardiaque, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I30, I33, I34, I35, I40, I42, I44, I47, I48, I49, I50, I51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I46/I46_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i46.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I46/.

I47 — Tachycardies paroxystiques supraventriculaires et ventriculaires (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I30-I52 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 50 (palpitations), 137 (bradycardia, tachycardia, irregular pulse), 155 (abnormal ECG), 218 (cardiorespiratory disturbances and arrest). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (4) : I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée ; I47.1 Tachycardie supraventriculaire ; I47.2 Tachycardie ventriculaire ; I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I30, I33, I34, I35, I40, I42, I44, I46, I48, I49, I50, I51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières

(grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision

- **Livrables** : chapters/I47/I47_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i47.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I47/.

I49 — Extrasystoles et autres arythmies (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I30-I52 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 50 (palpitations), 137 (bradycardia, tachycardia, irregular pulse), 155 (abnormal ECG), 218 (cardiorespiratory disturbances and arrest). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (8) : I49.0 Fibrillation et flutter ventriculaires ; I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée ; I49.2 Dépolarisation jonctionnelle prématurée ; I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée ; I49.4 Dépolarisations prématurées, autres et sans précision ; I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal ; I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées ; I49.9 Arythmie cardiaque, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I30, I33, I34, I35, I40, I42, I44, I46, I47, I48, I50, I51
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I49/I49_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i49.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I49/.

I51 — Complications des cardiopathies et atteintes cardiaques au cours d'autres maladies (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I30-I52 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 12 (swelling, oedema (diffuse or local)), 46 (dyspnoea), 146 (oedema). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (10) : I51.0 Anomalie d'un septum cardiaque, acquise ; I51.1 Rupture des cordages tendineux, non classée ailleurs ; I51.2 Rupture du muscle papillaire, non classée ailleurs ; I51.3 Thrombose intracardiaque, non classée ailleurs ; I51.4 Myocardite, sans précision ; I51.5 Dégénérescence du myocarde ; I51.6 Maladie cardio-vasculaire, sans précision ; I51.7 Cardiomégalie ; I51.8 Autres cardiopathies mal définies ; I51.9 Cardiopathie, sans précision
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I30, I33, I34, I35, I40, I42, I44, I46, I47, I48, I49, I50
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I51/I51_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i51.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I51/.

I71 — Anévrismes et dissections artérielles (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM IX** · bloc I70-I79 · difficulté **élevée**

- **Situations PROFILES 2017** : 85 (pain, burning, cramp, numbness in the extremities), 144 (gangrene). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (9) : I71.0 Dissection de l'aorte ; I71.1 Anévrisme aortique thoracique, rompu ; I71.2 Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture ; I71.3 Anévrisme aortique abdominal, rompu ; I71.4 Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture ; I71.5 Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), rompu ; I71.6 Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), sans mention de rupture ; I71.8 Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu ; I71.9 Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture
- **Même bloc (renvois, ne pas redévelopper)** : I70, I73, I77, I78, I79
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Complications et pronostic → 13. Prévention, dépistage et suivi → 14. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 15. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 16. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/I71/I71_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/i71.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/I71/.

Q21 — Cardiopathies congénitales de l'adulte (C-01-Cardiologie) · P0

- **État** : rédigé ; cours existant : relecture seulement.
- **Chapitre CIM XVII** · bloc Q20-Q28 · difficulté **élevée**
- **Situations PROFILES 2017** : 70 (request for genetic counselling), 177 (basic pre- and post-conception screening for genetic disease and malformation). Correspondance pédagogique, non officielle : chaque SSP doit se retrouver dans le cas clinique de l'îlot 0 ou dans un quiz.
- **Sous-codes à traiter dans ce cours** (7) : Q21.0 Communication interventriculaire ; Q21.1 Communication interauriculaire ; Q21.2 Communication auriculo-ventriculaire ; Q21.3 Tétralogie de Fallot ; Q21.4 Communication aorto-pulmonaire ; Q21.8 Autres malformations congénitales des cloisons cardiaques ; Q21.9 Malformation congénitale d'une cloison cardiaque, sans précision
- **Plan** : 0. Définition et classification → 1. Épidémiologie (Suisse, puis Europe) → 2. Physiopathologie et mécanismes → 3. Facteurs de risque et étiologie → 4. Anamnèse → 5. Examen clinique → 6. Examens complémentaires et diagnostic différentiel → 7. Traitement non médicamenteux → 8. Traitement médicamenteux (information professionnelle suisse) → 9. Urgences et critères d'hospitalisation → 10. Imagerie et explorations fonctionnelles → 11. Classification et scores → 12. Génétique et conseil génétique → 13. Complications et pronostic → 14. Prévention, dépistage et suivi → 15. Situations particulières (grossesse, enfant, sujet âgé) → 16. Critères formels du diagnostic (div.alert) puis paramètres clés (div.key) → 17. Pareto : ce qui fait 80 % de la décision
- **Livrables** : chapters/Q21/Q21_a...d.html, _pop1, _pop2, glossary/q21.py, rapports auteur et relecture dans livraisons/Livraison Claude/C-01-Cardiologie/travail/Q21/.